

2019



SE PRÉPARER
À PASSER
UN CONCOURS

JE RÉUSSIS MON CONCOURS !

Je prépare

2ÈME ÉDITION

Banque de questions en santé publique (Toutes les options)

Concours de recrutement
Examens d'aptitude professionnelle
CHUs

DE 2015 À 2019

JNAINI Hamza
Orthoptiste au CHP HASSAN II
Settat



« Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. »

Feu-Hassan II

Sommaire :

<u>INTRODUCTION</u>	01
<u>2019</u>	02 à 21
1) Concours de recrutement (Session du 3 Mars 2019)	02
<u>2018</u>	22 à 207
1) EAP (Session de 16 Decembre 2018)	22 à 93
○ 1 ^{ère} Épreuve (Rééducation et réhabilitation)	22
○ 1 ^{ère} Épreuve (Techniciens de santé)	40
○ 1 ^{ère} Épreuve (Infirmiers)	58
○ 1 ^{ère} Épreuve (Sage-femmes)	76
2) Concours de recrutement (Session de 10 Juin 2018)	94
3) Concours de recrutement (Session de 18 Mars 2018)	108
4) Concours de recrutement CHU Mohamed VI - Oujda (Session de 09 Decembre 2018)	122
5) Concours de recrutement CHU Mohamed VI - Marrakech (Session de 25 Novembre 2018)	140
6) Concours de recrutement CHU Ibn Rochd - Casa (Session de 22 Avril 2018)	158
7) Concours de recrutement CHU Ibn sina - Rabat (Session de 29 Avril 2018)	168
8) Concours de recrutement CHU Ibn sina - Rabat (Session de 22 Avril 2018)	178
9) Concours de recrutement CHU - Fes (Session de 18 Mars 2018)	190
<u>2017</u>	208 à 271
1) EAP - 1 ^{er} Grade (Session de 22 Octobre 2017)	208
2) Examen de Master - ISPITS (Session de 24 Septembre 2017)	234
3) Concours de recrutement (Session de 28 Mai 2017)	260
4) Concours de recrutement (Session de 12 Fevrier 2017)	266
<u>2016</u>	272 à 307
1) EAP - 1er Grade (Session de 09 Octobre 2016)	272
2) Concours de recrutement (Session de 25 Septembre 2016)	298
<u>2015</u>	308 à 347
1) EAP - 1er Grade (Session de 04 Octobre 2015)	308
2) Concours de recrutement (Session de 29 Novembre 2015)	342

Introduction

Conformément, aux nouveaux changements du ministère de la santé et au programme des études des professions infirmières et techniques de santé, "**Je prépare**" ouvre une nouvelle édition qui a pour ambition d'accompagner les lauréats et les lauréates de l'institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé dans leur parcours de préparation aux concours de recrutement de la fonction publique (État, CHUs et EAP).

"**Je prépare**" est une série de documents qui va vous aider à mieux vous préparer et de vous orienter afin de trouver une méthode générale de préparation pour réussir votre concours.

A cet effet, "**je prépare**" (*Banque de questions en santé publique*) regroupe un ensemble de questionnaires à choix multiples et examens corrigés conformes aux nouveaux changements induits par le ministère de santé, ainsi que des exemples de concours de recrutement et d'échelle en conformité avec les actualités.

Son objectif est de :

- Préparer efficacement les lauréats aux concours de recrutement ;
- Faciliter l'accès à de nombreux QCM en matière de santé publique.

Pour des résultats à la mesure de vos ambitions, n'hésitez pas à consulter ce document vigilement puisqu'il vous est servi comme complément à la première édition.



2019

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 03 مارس 2019)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les ressources humaines au Maroc sont caractérisées par :

A) La densité médicale et paramédicale est de 1,64 pour 1000 habitants ;	☐
B) La norme internationale de densité des soignants selon l'OMS est 2 pour 1000 habitants ;	☐
C) Seulement 9 % des professionnels non médicaux sont des sages-femmes ;	☐
D) Les pédiatres et les gynécologues représentent 14% des cadres médicaux ;	☐
E) Toutes les propositions sont correctes.	☐

2) L'offre de soins est partiellement conditionnée par :

A) La demande des professionnels ;	☐
B) Les besoins des professionnels ;	☐
C) L'environnement historique et actuel ;	☐
D) Les besoins de la population ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

3) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions d'un système de santé sont :

A) Réceptivité aux attentes de la population ;	☐
B) Protection contre les risques financiers et sociaux ;	☐
C) Ressources humaines ;	☐
D) Production des prestations de services ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

4) En pratique, il est considéré comme des substituts du Lait Maternel :

A) Les laits artificiels maternisés ;	☐
B) Les tisanes, eaux minérales et jus ;	☐
C) Les aliments de compléments autorisés avant Six mois ;	☐
D) Les biberons et tétines ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

5) La situation nutritionnelle au Maroc s'est améliorée grâce trois facteurs :

A) Le développement économique ;	☐
B) Le développement de l'éducation ;	☐
C) La régression du modèle alimentaire méditerranéen ;	☐
D) La promotion de l'activité physique ;	☐
E) L'amélioration des services de santé.	☐

6) En 2016, le Ratio de mortalité maternelle au Maroc est de :

A) 78 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
B) 75,2 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
C) 72,6 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
D) 71,2 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
E) 70,6 pour 100.000 Naissances vivantes.	☐

7) Les déterminants de la santé ou de la maladie sont des facteurs :

A) Biologiques ;	☐
B) Difficiles à être tous contrôlés par les systèmes de santé ;	☐
C) Lies à la politique générale d'un pays ;	☐
D) Ils en existent ceux d'ordre psychosocial ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

8) La déclaration internationale d'Alma Ata faite en 1978 a concerné :

A) Le renforcement des soins hospitaliers ;	☐
B) La promotion des Soins de Santé primaires ;	☐
C) La définition de la dimension qualité des soins ;	☐
D) La définition d'une politique internationale pour limiter les naissances ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

9) Le concept de « santé reproductive » :

A) Concerne le bien social, physique et mental relatif à l'appareil génital chez la femme ;	☐
B) Est apparu la première fois en 1994 à la Conférence Internationale sur la population et le développement au Caire ;	☐
C) Intéresse seulement santé maternelle et infantile ;	☐
D) Parmi ses buts c'est d'assurer la liberté et la sécurité de se procréer ;	☐
E) La santé sexuelle est une de ses composantes essentielles.	☐

10) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le Code de Commercialisation des substituts du Lait Maternel a but de :

www.ispifs.net

A) Interdire l'utilisation de substituts du lait maternel ;	☐
B) Protéger la pratique de l'allaitement maternel ;	☐
C) Promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel maternisés ;	☐
D) Interdire la publicité et le don gratuit d'échantillon ;	☐
E) Contrôler la qualité de ces produits notamment l'étiquetage.	☐

11) La stratégie nationale de nutrition 2011-2019 :

A) S'inscrit dans les cibles mondiales de nutrition pour 2025 ;	☐
B) Recommande de prévenir les carences en micronutriments ;	☐
C) Vise l'augmentation du d'allaitement maternel au moins 50% ;	☐
D) Contribue à la promotion de l'alimentation des adultes ayant des maladies chroniques ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

12) La mortalité maternelle est définie comme tout décès :

A) Fortuit survenu au cours de grossesse ;	☐
B) Accidentellement survenu pendant les suites de couches ;	☐
C) Survient au cours de la grossesse et ses suites une cause aggravée ou ;	☐
D) Causé par des soins obstétricaux ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

13) Les principales causes de décès au Maroc sont :

A) Les maladies infectieuses ;	☐
B) Les maladies de l'appareil circulatoire ;	☐
C) Les cancers ;	☐
D) La maternité ;	☐
E) Les maladies de l'appareil respiratoire.	☐

14) La stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale comme objectifs de réduire :

A) La mortalité maternelle à 50 décès / 100.000 NV ;	☐
B) La mortalité infantile à 20 décès / 1000 NV ;	☐
C) La mortalité néonatale à 15 décès / 1000 NV ;	☐
D) La mortalité infanto-juvénile à 28 décès / 1000 NV ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

15) Les principales causes directes de mortalité maternelle au Maroc sont :

A) L'hémorragie, l'éclampsie puis l'infection ;	☐
B) L'éclampsie, l'hémorragie puis l'infection ;	☐
C) L'hémorragie, l'éclampsie puis les avortements compliqués ;	☐
D) L'éclampsie, l'hémorragie puis les avortements compliqués ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

16) Les principales Causes directes de mortalité néonatale au Maroc sont :

A) La prématurité, l'asphyxie et l'infection ;	☐
B) L'infection, le RCIU et l'asphyxie ;	☐
C) La prématurité et le faible poids de naissance ;	☐
D) La prématurité et L'hypothyroïdie congénitale ;	☐
E) La prématurité et la chorioamniotite.	☐

17) Les objectifs de l'économie de santé sont :

A) Réduire les dépenses en santé ;	☐
B) Contrôler les agents économiques ;	☐
C) Optimiser l'utilisation ressources ;	☐
D) Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé ;	☐
E) Assurer l'efficacité du système de santé.	☐

18) Parmi les sources de financement du système de santé au Maroc, on cite :

A) Recettes fiscales de L'Etat ;	☐
B) La contribution directe des ménages ;	☐
C) La coopération internationale ;	☐
D) Le RAMED ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

19) Le secteur public offre :

A) 68 % de la capacité litière hospitalière nationale ;	☐
B) 55 % de la capacité litière hospitalière nationale ;	☐
C) 50 % du personnel infirmier ;	☐
D) 80 % des médecins ;	☐
E) 60 % des médecins.	☐

20) Parmi les propositions suivantes, choisir les fonctions de l'hôpital :

A) Le développement professionnel ;	☐
B) Gestion des productions ;	☐
C) L'appui au réseau de soins de santé primaires ;	☐
D) Le soin ;	☐
E) Diagnostic.	☐

21) Le Ratio établissement de soins de santé primaire par habitant est de :

A) 1 établissement pour 29.700 habitants ;	☐
B) 1 établissement pour 21.000 habitants ;	☐
C) 1 établissement pour 18.000 habitants ;	☐
D) 1 établissement pour 15.000 habitants ;	☐
E) 1 établissement pour 12.000 habitants.	☐

22) Le RAMED se fonde sur :

A) Le principe de l'assurance sociale au profit des ayant une activité lucrative ;	☐
B) Le principe d'assistance sociale au profit des démunis ;	☐
C) Seul le financement par l'Etat et les cotisations des bénéficiaires ;	☐
D) Le principe de solidarité nationale ;	☐
E) L'investissement pour se financer.	☐

23) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) est :

A) Un moyen d'organisation et de projection de l'offre de soins ;	☐
B) Un outil de planification et de régulation de l'offre de soins au niveau régional ;	☐
C) Basé sur une approche globale. Rationnelle, participative et équitable ;	☐
D) Elaboré par les services centraux du ministère de la santé et destiné aux régions sanitaires ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

24) Choisir les prestations offertes par le centre de santé rural de premier niveau :

A) Les consultations de médecine générale ;	☐
B) Une permanence pour les urgences ;	☐
C) Le suivi des maladies chroniques ;	☐
D) Les médicaments de bases ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

25) Le système de santé marocain se compose de :

A) Secteur publique et secteur privé ;	☐
B) Secteur publique, secteur privé à but non lucratif et secteur privé à but lucratif ;	☐
C) Secteur publique, Secteur privé et traditionnel ;	☐
D) Installation de santé et d'établissements médico-sociaux ;	☐
E) Secteur de soins ambulatoire et hospitalier.	☐

26) Les stratégies de couverture pour répondre aux besoins de la population :

A) Visites à domicile (VD) ;	☐
B) Unités médicales mobiles (UMM) ;	☐
C) Caravanes médicales spécialisées (CMS) ;	☐
D) Les fondations et les associations œuvrant dans le Secteur de la santé ;	☐
E) Hôpitaux mobiles (HM).	☐

27) L'offre publique de soins est composée de quatre réseaux :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) ;	☐
B) Le réseau hospitalier (RH) ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM) ;	☐
D) Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS) ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

28) La santé communautaire est caractérisée par :

A) Les besoins sont déterminés par les professionnels de santé ;	☐
B) La participation de la communauté la gestion de la santé individuelle et collective ;	☐
C) Le diagnostic communautaire ;	☐
D) Débouche sur une politique de santé nationale ;	☐
E) Où la population subit la décision nationale.	☐

29) Le taux des nouvelles infections par le VIH parmi les populations les plus exposées est :

A) 33 % ;	☐
B) 43 % ;	☐
C) 50 % ;	☐
D) 67 % ;	☐
E) 73 %.	☐

30) Actuellement, L'influenza H1N1 est un sous-type du virus de la grippe de :

A) A ;	☐
B) B ;	☐
C) Z ;	☐
D) C ;	☐
E) Aucune des propositions précédentes.	☐

31) En 2015, le Taux d'occupation Moyenne des lits des hôpitaux marocains est :

A) 55% ;	☐
B) 63,8% ;	☐
C) 68.3% ;	☐
D) 71% ;	☐
E) 71%.	☐

32) Le taux de couverture par le programme de planification familiale est :

A) 71,5 % ;	☐
B) 69,3 % ;	☐
C) 67,4 % ;	☐
D) 63,0 % ;	☐
E) 61,7 %.	☐

33) En 2016, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 1,1 enfant par femme ;	☐
B) 1,2 enfant par femme ;	☐
C) 2,2 enfants par femme ;	☐
D) 2,5 enfants par femme ;	☐
E) 2,7 enfants par femme.	☐

34) Le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est :

A) 84 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
B) 87 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
C) 97 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
D) 98 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
E) 103 nouveaux épisodes pour 100000 habitants.	☐

35) L'objectif général à l'an 2021 pour le contrôle et la prévention de la tuberculose est de réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de :

A) 75% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;	☐
B) 50% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;	☐
C) 40% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;	☐
D) 45% en 2021 par rapport à l'année 2010 ;	☐
E) 40% en 2021 par rapport à l'année 2000.	☐

36) Au Maroc, l'Espérance de vie à la naissance est de :

A) 76,9 ans ;	☐
B) 77,8 ans ;	☐
C) 78,6 ans ;	☐
D) 79,8 ans ;	☐
E) Aucune des propositions précédentes n'est justes.	☐

37) La prévalence du VIH/SIDA parmi la population générale est de :

A) 0, 1 % ;	☐
B) 0,8 % ;	☐
C) 0,01 % ;	☐
D) 0,08 % ;	☐
E) 0,03%.	☐

38) Les objectifs du plan national de lutte contre le Sida 2017 - 2021 sont :

A) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 75 % ;	☐
B) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 50 % ;	☐
C) Eliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant ;	☐
D) Réduire le taux des cas au stade asymptomatiques de 50 % ;	☐
E) Réduire la mortalité liée au VIH de 75%.	☐

39) Parmi les populations suivantes, quelles sont celles à haut risque de complications de l'influenza H1N1 :

A) Personnes âgées plus de 60 ans ;	☐
B) Femmes enceintes ;	☐
C) Personnes atteintes de maladies chroniques ;	☐
D) Enfants âgés de moins de 5 ans ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

40) La vaccination antigrippale est une mesure préventive qui est recommandée pour :

A) Toute la population ;	☐
B) Les femmes enceintes que ce soit l'âge la grossesse ;	☐
C) Tous les enfants âgés de moins de 5 ans ;	☐
D) Les professionnels de la santé ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 03 مارس 2019)

www.ispits.net

Correction proposée :

1) Les ressources humaines au Maroc sont caractérisées par :

A) <u>La densité médicale et paramédicale est de 1,64 pour 1000 habitants ;</u>	☒
B) La norme internationale de densité des soignants selon l'OMS est 2 pour 1000 habitants ;	☐
C) <u>Seulement 9 % des professionnels non médicaux sont des sages-femmes ;</u>	☒
D) Les pédiatres et les gynécologues représentent 14% des cadres médicaux ;	☐
E) Toutes les propositions sont correctes.	☐

2) L'offre de soins est partiellement conditionnée par :

A) La demande des professionnels ;	☐
B) <u>Les besoins des professionnels ;</u>	☒
C) <u>L'environnement historique et actuel ;</u>	☒
D) <u>Les besoins de la population ;</u>	☒
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

3) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions d'un système de santé sont :

A) Réceptivité aux attentes de la population ;	☐
B) Protection contre les risques financiers et sociaux ;	☐
C) Ressources humaines ;	☐
D) Production des prestations de services ;	☐
E) <u>Toutes les propositions précédentes sont correctes.</u>	☒

4) En pratique, il est considéré comme des substituts du Lait Maternel :

A) <u>Les laits artificiels maternisés ;</u>	☒
B) Les tisanes, eaux minérales et jus ;	☐
C) Les aliments de compléments autorisés avant Six mois ;	☐
D) Les biberons et tétines ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

5) La situation nutritionnelle au Maroc s'est améliorée grâce trois facteurs :

A) <u>Le développement économique ;</u>	☒
B) <u>Le développement de l'éducation ;</u>	☒
C) La régression du modèle alimentaire méditerranéen ;	☐
D) La promotion de l'activité physique ;	☐
E) <u>L'amélioration des services de santé.</u>	☒

6) En 2016, le Ratio de mortalité maternelle au Maroc est de :

A) 78 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
B) 75,2 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
C) <u>72,6 pour 100.000 Naissances vivantes ;</u>	☒
D) 71,2 pour 100.000 Naissances vivantes ;	☐
E) 70,6 pour 100.000 Naissances vivantes.	☐

7) Les déterminants de la santé ou de la maladie sont des facteurs :

A) Biologiques ;	☐
B) Difficiles à être tous contrôlés par les systèmes de santé ;	☐
C) Lies à la politique générale d'un pays ;	☐
D) Ils en existent ceux d'ordre psychosocial ;	☐
E) <u>Toutes les propositions précédentes sont correctes.</u>	☒

8) La déclaration internationale d'Alma Ata faite en 1978 a concerné :

A) Le renforcement des soins hospitaliers ;	☐
B) <u>La promotion des Soins de Santé primaires ;</u>	☒
C) La définition de la dimension qualité des soins ;	☐
D) La définition d'une politique internationale pour limiter les naissances ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

9) Le concept de « santé reproductive » :

A) <u>Concerne le bien social, physique et mental relatif à l'appareil génital chez la femme ;</u>	☒
B) <u>Est apparu la première fois en 1994 à la Conférence Internationale sur la population et le développement au Caire ;</u>	☒
C) Intéresse seulement santé maternelle et infantile ;	☐
D) <u>Parmi ses buts c'est d'assurer la liberté et la sécurité de se procréer ;</u>	☒
E) <u>La santé sexuelle est une de ses composantes essentielles.</u>	☒

10) Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le Code de Commercialisation des substituts du Lait Maternel a but de :

A) Interdire l'utilisation de substituts du lait maternel ;	☐
B) <u>Protéger la pratique de l'allaitement maternel ;</u>	☒
C) Promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel maternisés ;	☐
D) <u>Interdire la publicité et le don gratuit d'échantillon ;</u>	☒
E) <u>Contrôler la qualité de ces produits notamment l'étiquetage.</u>	☒

11) La stratégie nationale de nutrition 2011-2019 :

A) S'inscrit dans les cibles mondiales de nutrition pour 2025 ;	☐
B) <u>Recommande de prévenir les carences en micronutriments ;</u>	☒
C) Vise l'augmentation du d'allaitement maternel au moins 50% ;	☐
D) <u>Contribue à la promotion de l'alimentation des adultes ayant des maladies chroniques ;</u>	☒
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

12) La mortalité maternelle est définie comme tout décès :

A) Fortuit survenu au cours de grossesse ;	☐
B) Accidentellement survenu pendant les suites de couches ;	☐
C) Survient au cours de la grossesse et ses suites une cause aggravée pu ;	☐
D) Causé par des soins obstétricaux ;	☐
E) <u>Toutes les propositions précédentes sont correctes.</u>	☒

13) Les principales causes de décès au Maroc sont :

A) Les maladies infectieuses ;	☐
B) <u>Les maladies de l'appareil circulatoire ;</u>	☒
C) Les cancers ;	☐
D) La maternité ;	☐
E) Les maladies de l'appareil respiratoire.	☐

14) La stratégie nationale de la santé maternelle et néonatale comme objectifs de réduire :

A) <u>La mortalité maternelle à 50 décès / 100.000 NV ;</u>	☒
B) La mortalité infantile à 20 décès / 1000 NV ;	☐
C) <u>La mortalité néonatale à 15 décès / 1000 NV ;</u>	☒
D) La mortalité infanto-juvénile à 28 décès / 1000 NV ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

15) Les principales causes directes de mortalité maternelle au Maroc sont :

A) <u>L'hémorragie, l'éclampsie puis l'infection ;</u>	☒
B) L'éclampsie, l'hémorragie puis l'infection ;	☐
C) L'hémorragie, l'éclampsie puis les avortements compliqués ;	☐
D) L'éclampsie, l'hémorragie puis les avortements compliqués ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

16) Les principales Causes directes de mortalité néonatale au Maroc sont :

A) La prématurité, l'asphyxie et l'infection ;	☐
B) L'infection, le RCIU et l'asphyxie ;	☐
C) <u>La prématurité et le faible poids de naissance ;</u>	☒
D) La prématurité et L'hypothyroïdie congénitale ;	☐
E) La prématurité et la chorioamniotite.	☐

17) Les objectifs de l'économie de santé sont :

A) Réduire les dépenses en santé ;	☐
B) Contrôler les agents économiques ;	☐
C) <u>Optimiser l'utilisation ressources ;</u>	☒
D) <u>Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé ;</u>	☒
E) Assurer l'efficacité du système de santé.	☐

18) Parmi les sources de financement du système de santé au Maroc, on cite :

A) Recettes fiscales de L'Etat ;	☐
B) La contribution directe des ménages ;	☐
C) La coopération internationale ;	☐
D) Le RAMED ;	☐
E) <u>Toutes les propositions précédentes sont correctes.</u>	☒

19) Le secteur public offre :

A) <u>68 % de la capacité litière hospitalière nationale ;</u>	☒
B) 55 % de la capacité litière hospitalière nationale ;	☐
C) 50 % du personnel infirmier ;	☐
D) 80 % des médecins ;	☐
E) <u>60 % des médecins.</u>	☒

20) Parmi les propositions suivantes, choisir les fonctions de l'hôpital :

A) <u>Le développement professionnel ;</u>	☒
B) <u>Gestion des productions ;</u>	☒
C) <u>L'appui au réseau de soins de santé primaires ;</u>	☒
D) <u>Le soin ;</u>	☒
E) <u>Diagnostic.</u>	☒

21) Le Ratio établissement de soins de santé primaire par habitant est de :

A) 1 établissement pour 29.700 habitants ;	☐
B) 1 établissement pour 21.000 habitants ;	☐
C) 1 établissement pour 18.000 habitants ;	☐
D) 1 établissement pour 15.000 habitants ;	☐
E) <u>1 établissement pour 12.000 habitants.</u>	☒

22) Le RAMED se fonde sur :

A) Le principe de l'assurance sociale au profit des ayant une activité lucrative ;	☐
B) <u>Le principe d'assistance sociale au profit des démunis ;</u>	☒
C) Seul le financement par l'Etat et les cotisations des bénéficiaires ;	☐
D) <u>Le principe de solidarité nationale ;</u>	☒
E) L'investissement pour se financer.	☐

23) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins (SROS) est :

A) Un moyen d'organisation et de projection de l'offre de soins ;	☐
B) <u>Un outil de planification et de régulation de l'offre de soins au niveau régional ;</u>	☒
C) <u>Basé sur une approche globale. Rationnelle, participative et équitable ;</u>	☒
D) Elaboré par les services centraux du ministère de la santé et destiné aux régions sanitaires ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

24) Choisir les prestations offertes par le centre de santé rural de premier niveau :

A) <u>Les consultations de médecine générale ;</u>	☒
B) Une permanence pour les urgences ;	☐
C) <u>Le suivi des maladies chroniques ;</u>	☒
D) <u>Les médicaments de bases ;</u>	☒
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐

25) Le système de santé marocain se compose de :

A) Secteur publique et secteur privé ;	☐
B) Secteur publique, secteur privé à but non lucratif et secteur privé à but lucratif ;	☐
C) <u>Secteur publique, Secteur privé et traditionnel ;</u>	☒
D) Installation de santé et d'établissements médico-sociaux ;	☐
E) Secteur de soins ambulatoire et hospitalier.	☐

26) Les stratégies de couverture pour répondre aux besoins de la population :

A) <u>Visites à domicile (VD) ;</u>	☒
B) <u>Unités médicales mobiles (UMM) ;</u>	☒
C) <u>Caravanes médicales spécialisées (CMS) ;</u>	☒
D) <u>Les fondations et les associations œuvrant dans le Secteur de la santé ;</u>	☒
E) <u>Hôpitaux mobiles (HM).</u>	☒

27) L'offre publique de soins est composée de quatre réseaux :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) ;	☐
B) Le réseau hospitalier (RH) ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM) ;	☐
D) Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS) ;	☐
E) <u>Toutes les propositions précédentes sont correctes.</u>	☒

28) La santé communautaire est caractérisée par :

A) Les besoins sont déterminés par les professionnels de santé ;	☐
B) <u>La participation de la communauté la gestion de la santé individuelle et collective ;</u>	☐
C) Le diagnostic communautaire ;	☐
D) Débouche sur une politique de santé nationale ;	☐
E) Où la population subit la décision nationale.	☐

29) Le taux des nouvelles infections par le VIH parmi les populations les plus exposées est :

A) <u>33 % ;</u>	☒
B) 43 % ;	☐
C) 50 % ;	☐
D) 67 % ;	☐
E) 73 %.	☐

30) Actuellement, L'influenza H1N1 est un sous-type du virus de la grippe de :

A) A ;	☒
B) B ;	☐
C) Z ;	☐
D) C ;	☐
E) Aucune des propositions précédentes.	☐

31) En 2015, le Taux d'occupation Moyenne des lits des hôpitaux marocains est :

A) 55% ;	☐
B) <u>63,8%</u> ;	☒
C) 68.3% ;	☐
D) 71% ;	☐
E) 71%.	☐

32) Le taux de couverture par le programme de planification familiale est :

A) 71,5 % ;	☐
B) 69,3 % ;	☐
C) <u>67,4 %</u> ;	☒
D) 63,0 % ;	☐
E) 61,7 %.	☐

33) En 2016, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 1,1 enfant par femme ;	☐
B) 1,2 enfant par femme ;	☐
C) <u>2,2 enfants par femme</u> ;	☒
D) 2,5 enfants par femme ;	☐
E) 2,7 enfants par femme.	☐

34) Le taux d'incidence de la tuberculose au Maroc est :

A) <u>84 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;</u>	☒
B) 87 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
C) 97 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
D) 98 nouveaux épisodes pour 100000 habitants ;	☐
E) 103 nouveaux épisodes pour 100000 habitants.	☐

35) L'objectif général à l'an 2021 pour le contrôle et la prévention de la tuberculose est de réduire le nombre de décès liés à la tuberculose de :

A) 75% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;	☐
B) 50% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;	☐
C) <u>40% en 2021 par rapport à l'année 2015 ;</u>	☒
D) 45% en 2021 par rapport à l'année 2010 ;	☐
E) 40% en 2021 par rapport à l'année 2000.	☐

36) Au Maroc, l'Espérance de vie à la naissance est de :

A) 76,9 ans ;	☐
B) 77,8 ans ;	☐
C) 78,6 ans ;	☐
D) 79,8 ans ;	☐
E) <u>Aucune des propositions précédentes n'est justes.</u>	☒

37) La prévalence du VIH/SIDA parmi la population générale est de :

A) <u>0,1 % ;</u>	☒
B) 0,8 % ;	☐
C) 0,01 % ;	☐
D) 0,08 % ;	☐
E) 0,03%.	☐

38) Les objectifs du plan national de lutte contre le Sida 2017 - 2021 sont :

A) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 75 % ;	☒
B) Réduire les nouvelles infections par le VIH/SIDA de 50 % ;	☐
C) Eliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant ;	☐
D) Réduire le taux des cas au stade asymptomatiques de 50 % ;	☐
E) Réduire la mortalité liée au VIH de 75%.	☒

39) Parmi les populations suivantes, quelles sont celles à haut risque de complications de l'influenza H1N1 :

A) Personnes âgées plus de 60 ans ;	☐
B) Femmes enceintes ;	☐
C) Personnes atteintes de maladies chroniques ;	☐
D) Enfants âgés de moins de 5 ans ;	☐
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☒

40) La vaccination antigrippale est une mesure préventive qui est recommandée pour :

A) Toute la population ;	☐
B) Les femmes enceintes que ce soit l'âge la grossesse ;	☐
C) Tous les enfants âgés de moins de 5 ans ;	☒
D) Les professionnels de la santé ;	☒
E) Toutes les propositions précédentes sont correctes.	☐



2018

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة : ساعتان المعامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018) www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) L'handicap moteur est caractérisé par une capacité limitée pour un individu de :

A) Se déplacer ;	☐
B) Réaliser des gestes ;	☐
C) Bouger certains membres ;	☐
D) Réfléchir.	☐

2) L'handicap sensoriel comprend :

A) Handicap visuel ;	☐
B) Handicap moteur ;	☐
C) Handicap psychomoteur ;	☐
D) Handicap auditif.	☐

3) L'handicap psychique entraine :

A) Troubles mentaux ;	☐
B) Troubles affectifs et émotionnels ;	☐
C) Perturbation dans la personnalité ;	☐
D) Conséquences sur les fonctions intellectuelles.	☐

4) La déficience selon l'OMS est définie comme :

A) Une altération de l'aspect psychologique, physiologique ou anatomique ;	☐
B) Réduction partielle ou totale d'une capacité ;	☐
C) Désavantage social ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

5) La trisomie 21 est une pathologie qui a comme conséquences :

A) Retard de langage ;	☐
B) Strabisme ;	☐
C) Trouble psychomoteur ;	☐
D) Trouble de l'équilibre.	☐

6) La correction et amélioration d'une déficience à installation récente correspond à :

A) Dépistage ;	☐
B) Réhabilitation ;	☐
C) Réadaptation ;	☐
D) Rééducation.	☐

7) Parmi les objectifs de la réhabilitation, on trouve :

A) S'adapter aux incapacités stabilisées et persistances d'un patient ;	☐
B) Réduire totalement les incapacités d'un patient ;	☐
C) Réduire partiellement les incapacités d'un patient ;	☐
D) Prévenir les incapacités d'un patient.	☐

8) L'approche de diagnostic en rééducation-réhabilitation se base sur :

A) Interrogatoire ou anamnèse ;	☐
B) L'observation ;	☐
C) Bilan spécifique ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

9) La prise en charge du handicap selon le dernier rapport de la coopération internationale en santé concerne :

A) Elaboration de guide de conseils à domicile des personnes en situation d'handicap, mental, neurosensoriel et moteur ;	☐
B) Développement de référentiels et filière des soins de réhabilitation pour les personnes en situation de handicap ;	☐
C) Elaboration d'un plan d'action pour le renforcement des activités des prises en charge de l'autisme ;	☐
D) Evaluation des besoins en santé mentale et soutien psychosocial des migrants.	☐

10) On peut définir le dépistage comme :

A) Examen d'individu symptomatique ;	☐
B) Examen d'individu asymptomatique ;	☐
C) Prévention secondaire d'une pathologie ;	☐
D) Prévention primaire d'une pathologie.	☐

11) Le pronostic en rééducation dépend de :

A) Diagnostic de la maladie ;	☐
B) Evolution de la maladie ;	☐
C) Implication du patient ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

12) Le diagnostic différentiel peut être défini comme :

A) Dépistage de signe secondaire ;	☐
B) Méthode de différenciation de pathologies ;	☐
C) Identification par comparaison des symptômes ;	☐
D) Listing des symptômes similaires.	☐

13) La prévention en santé qui concerne les actes de rééducation sont considérés comme :

A) Prévention primaire ;	☐
B) Prévention secondaire ;	☐
C) Prévention tertiaire ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

14) Les objectifs de développement durable ODD 2030 qui concerne l'handicap est :

A) ODD 2 ;	☐
B) ODD 4 ;	☐
C) ODD 6 ;	☐
D) ODD 8.	☐

15) L'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé qui concerne l'handicap est :

A) OIM ;	☐
B) PNUD ;	☐
C) FAO ;	☐
D) UNICEF.	☐

16) La prévention au niveau du système de santé est basée sur :

A) Education ;	☐
B) Planification ;	☐
C) Communication ;	☐
D) Information.	☐

17) Le dernier décret portant sur le statut du cadre de rééducation est le :

A) N°2-17-586 (12 Octobre 2017) ;	☐
B) N°1-17-535 (12 Octobre 2016) ;	☐
C) N°2-17-535 (12 Septembre 2017) ;	☐
D) N°2-17-586 (12 Septembre 2017).	☐

18) Les instances prévues par la loi 34-09 pour améliorer la gouvernance du système de santé :

A) Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;	☐
B) Un comité national éthique et de recherche ;	☐
C) Des commissions régionales et provinciales de l'offre de soins ;	☐
D) Un comité national de veille et de sécurité sanitaire.	☐

19) Le nombre de paramédicaux selon la carte sanitaire 2018 est de :

A) 19.738 ;	☐
B) 29.738 ;	☐
C) 11.738 ;	☐
D) 39.738.	☐

20) La priorité stratégique et domaine d'action pour la stratégie de coopération Maroc/OMS 2017/2021 qui concerne l'handicap est :

A) Renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la sécurité sanitaire ;	☐
B) Accompagner la dynamique de la régionalisation avancée et renforcer la gouvernance du Secteur de la santé ;	☐
C) Renforcer l'accès équitable des populations à des services de qualité à un coût abordable en vue de tendre vers la couverture sanitaire universelle ;	☐
D) Contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment la réduction des inégalités en santé et de la charge de morbidité et de mortalité.	☐

21) La responsabilité de l'état en matière de santé :

A) L'information de la population sur les risques liés à la santé ;	☐
B) Respect des droits du patient à l'information relative à sa maladie ;	☐
C) Respect de la personne de son intégrité physique, dignité, intimité ;	☐
D) Imposer les modalités de prise en charge à la population.	☐

22) La vision du ministère de la santé 2025 est basée sur les valeurs suivantes :

A) Equité ;	☐
B) Redevabilité ;	☐
C) Accessibilité ;	☐
D) Solidarité.	☐

23) Le plan d'action de la santé 2025 est basé Sur :

A) 3 Piliers ;	☐
B) 5 Piliers ;	☐
C) 7 Piliers ;	☐
D) 11 Piliers.	☐

24) Les niveaux la planification sont :

A) La stratégie générale de l'entreprise ;	☐
B) Des valeurs, les objectifs et le plan d'action de l'entreprise ;	☐
C) Des éléments de protection sociale favorables aux salariés ;	☐
D) Une réflexion sur le passé de l'entreprise.	☐

25) Quelles sont les spécialités qui relèvent du cadre rééducation-réhabilitation au Maroc :

A) Ergothérapie et optique ;	☐
B) Orthoptie et kinésithérapie ;	☐
C) Diététique et Orthophonie ;	☐
D) Psychomotricité et santé mentale.	☐

26) Parmi les objectifs spécifiques des stratégies et plans d'action 2025 concernant la population en situation d'handicap est de :

A) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 15%	☐
B) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 25%	☐
C) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 35%	☐
D) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 45%	☐

27) Parmi les objectifs spécifiques des stratégies et plans d'action 2025 Concernant la population en situation d'handicap est de :

A) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 50% ;	☐
B) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 30% ;	☐
C) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 90% ;	☐
D) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 60%.	☐

28) Le pourcentage de personne en situation d'handicap qui bénéficient d'un régime d'assurance maladie est de :

A) 32,1% ;	☐
B) 34,1% ;	☐
C) 36,1% ;	☐
D) 38,1%.	☐

29) Selon l’OMS, la densité des professionnels de santé l’horizon 2021, devrait être portée à :

A) 2,45 pour 1000 habitants ;	☐
B) 4,45 pour 1000 habitants ;	☐
C) 10,45 pour 1000 habitants ;	☐
D) 12,45 pour 1000 habitants.	☐

30) Vous êtes sollicité(e) pour instaurer une approche qualité au niveau de l’unité de soins. Quels sont les principes de démarche qualité que vous privilégiez :

A) L’analyse du processus, le leadership et la sanction des responsables du dysfonctionnement ;	☐
B) La satisfaction du client, le travail en équipe et la prise de décisions basée sur les données ;	☐
C) Le leadership et l’analyse du processus ;	☐
D) La documentation des événements, la recherche des causes et l’application des solutions.	☐

31) Pour une amélioration de la gestion des équipes soignantes, vous envisager :

A) L’identification des mesures de suivi des activités du personnel ;	☐
B) La réalisation des enquêtes de satisfaction du personnel ;	☐
C) La réalisation du bilan social ;	☐
D) L’inspection inopinée du personnel.	☐

32) La loi cadre relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap est la loi :

A) 87-13 ;	☐
B) 67-13 ;	☐
C) 77-13 ;	☐
D) 97-13.	☐

33) L’évaluation du système d’information d’une unité de rééducation Sert pour :

A) Assurer une meilleure communication au sein de l’équipe ;	☐
B) Garantir le partage d’information entre professionnels ;	☐
C) Partager l’information avec le patient ;	☐
D) Améliorer l’efficacité du travail interdisciplinaire.	☐

34) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) :

A) Est un outil de planification, de management participatif et de mobilisation de ressources ;	☐
B) Est un document de travail, de traçabilité et bilan des activités de l'hôpital ;	☐
C) Est un cadre de référence, et de plaidoyer ;	☐
D) Est un outil de planification, de gestion des conflits, et de transmission de l'information.	☐

35) Pour assurer le suivi des activités d'amélioration continue de la qualité, vous envisagez :

A) L'élaboration des indicateurs d'appréciation des activités ;	☐
B) La réduction des directives consignant les mesures de motivation du personnel ;	☐
C) La mise en place d'un dispositif d'écoute client ;	☐
D) L'élaboration de tableaux de bord.	☐

36) Vous participer au processus de planification sanitaire, l'étude de la faisabilité d'une intervention doit prendre en considération :

A) La faisabilité légale, et politique ;	☐
B) La faisabilité économique ;	☐
C) La faisabilité internationale ;	☐
D) La faisabilité socioculturelle et éthique.	☐

37) Le management stratégique consiste à :

A) Définir les prévisions ;	☐
B) Définir les objectifs atteindre ;	☐
C) Contrôler le travail ;	☐
D) Intégrer les changements possibles.	☐

38) Quelles sont parmi les propositions suivantes celles qui sont justes :

A) L'indicateur de structure renseigne sur les moyens et ressources utilisés ;	☐
B) L'indicateur de processus renseigne sur l'atteinte des objectifs fixés ;	☐
C) L'indicateur de satisfaction renseigne sur le niveau de qualité perçue ;	☐
D) L'indicateur de résultat renseigne sur les activités au service d'un objectif.	☐

39) La recherche scientifique dans le domaine de la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle est :

A) Un processus rationnel visant l'acquisition et le développement de la théorie et la pratique ;	☐
B) Une démarche spécifique aux études quantitatives ;	☐
C) Un processus spécifique aux études expérimentales ;	☐
D) Un processus systématique de collecte de données en vue de réaliser tous les types d'études.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة: ساعتان المعامل: 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

www.ispits.net

Correction proposée :

1) L'handicap moteur est caractérisé par une capacité limitée pour un individu de :

A) <u>Se déplacer ;</u>	☒
B) <u>Réaliser des gestes ;</u>	☒
C) <u>Bouger certains membres ;</u>	☒
D) Réfléchir.	☐

2) L'handicap sensoriel comprend :

A) <u>Handicap visuel ;</u>	☒
B) Handicap moteur ;	☐
C) Handicap psychomoteur ;	☐
D) <u>Handicap auditif.</u>	☒

3) L'handicap psychique entraine :

A) <u>Troubles mentaux ;</u>	☒
B) Troubles affectifs et émotionnels ;	☐
C) <u>Perturbation dans la personnalité ;</u>	☒
D) <u>Conséquences sur les fonctions intellectuelles.</u>	☒

4) La déficience selon l'OMS est définie comme :

A) <u>Une altération de l'aspect psychologique, physiologique ou anatomique ;</u>	☒
B) Réduction partielle ou totale d'une capacité ;	☐
C) Désavantage social ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

5) La trisomie 21 est une pathologie qui a comme conséquences :

A) <u>Retard de langage ;</u>	☒
B) <u>Strabisme ;</u>	☒
C) <u>Trouble psychomoteur ;</u>	☒
D) <u>Trouble de l'équilibre.</u>	☒

6) La correction et amélioration d'une déficience à installation récente correspond à :

A) <u>Dépistage ;</u>	☒
B) Réhabilitation ;	☐
C) Réadaptation ;	☐
D) <u>Rééducation.</u>	☒

7) Parmi les objectifs de la réhabilitation, on trouve :

A) <u>S'adapter aux incapacités stabilisées et persistances d'un patient ;</u>	☒
B) Réduire totalement les incapacités d'un patient ;	☐
C) Réduire partiellement les incapacités d'un patient ;	☐
D) Prévenir les incapacités d'un patient.	☐

8) L'approche de diagnostic en rééducation-réhabilitation se base sur :

A) <u>Interrogatoire ou anamnèse ;</u>	☒
B) <u>L'observation ;</u>	☒
C) <u>Bilan spécifique ;</u>	☒
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

9) La prise en charge du handicap selon le dernier rapport de la coopération internationale en santé concerne :

A) <u>Elaboration de guide de conseils à domicile des personnes en situation d'handicap, mental, neurosensoriel et moteur ;</u>	☒
B) <u>Développement de référentiels et filière des soins de réhabilitation pour les personnes en situation de handicap ;</u>	☒
C) <u>Elaboration d'un plan d'action pour le renforcement des activités des prises en charge de l'autisme ;</u>	☒
D) <u>Evaluation des besoins en santé mentale et soutien psychosocial des migrants.</u>	☒

10) On peut définir le dépistage comme :

A) Examen d'individu symptomatique ;	☐
B) <u>Examen d'individu asymptomatique ;</u>	☒
C) <u>Prévention secondaire d'une pathologie ;</u>	☒
D) Prévention primaire d'une pathologie.	☐

11) Le pronostic en rééducation dépend de :

A) <u>Diagnostic de la maladie ;</u>	☒
B) <u>Evolution de la maladie ;</u>	☒
C) <u>Implication du patient ;</u>	☒
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

12) Le diagnostic différentiel peut être défini comme :

A) <u>Dépistage de signe secondaire ;</u>	☒
B) <u>Méthode de différentiation de pathologies ;</u>	☒
C) <u>Identification par comparaison des symptômes ;</u>	☒
D) <u>Listing des symptômes similaires.</u>	☒

13) La prévention en santé qui concerne les actes de rééducation sont considérés comme :

A) Prévention primaire ;	☐
B) Prévention secondaire ;	☐
C) <u>Prévention tertiaire ;</u>	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

14) Les objectifs de développement durable ODD 2030 qui concerne l'handicap est :

A) ODD 2 ;	☐
B) <u>ODD 4 ;</u>	☒
C) ODD 6 ;	☐
D) <u>ODD 8.</u>	☒

15) L'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé qui concerne l'handicap est :

A) OIM ;	☐
B) PNUD ;	☐
C) FAO ;	☐
D) <u>UNICEF.</u>	☒

16) La prévention au niveau du système de santé est basée sur :

A) <u>Education ;</u>	☒
B) Planification ;	☐
C) Communication ;	☐
D) <u>Information.</u>	☒

17) Le dernier décret portant sur le statut du cadre de rééducation est le :

A) N°2-17-586 (12 Octobre 2017) ;	☐
B) N°1-17-535 (12 Octobre 2016) ;	☐
C) <u>N°2-17-535 (12 Septembre 2017) ;</u>	☒
D) N°2-17-586 (12 Septembre 2017).	☐

18) Les instances prévues par la loi 34-09 pour améliorer la gouvernance du système de santé :

A) <u>Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;</u>	☒
B) Un comité national éthique et de recherche ;	☐
C) Des commissions régionales et provinciales de l'offre de soins ;	☐
D) <u>Un comité national de veille et de sécurité sanitaire.</u>	☒

19) Le nombre de paramédicaux selon la carte sanitaire 2018 est de :

A) 19.738 ;	☐
B) <u>29.738 ;</u>	☒
C) 11.738 ;	☐
D) 39.738.	☐

20) La priorité stratégique et domaine d'action pour la stratégie de coopération Maroc/OMS 2017/2021 qui concerne l'handicap est :

A) Renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la sécurité sanitaire ;	☒
B) Accompagner la dynamique de la régionalisation avancée et renforcer la gouvernance du Secteur de la santé ;	☒
C) Renforcer l'accès équitable des populations à des services de qualité à un coût abordable en vue de tendre vers la couverture sanitaire universelle ;	☒
D) Contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment la réduction des inégalités en santé et de la charge de morbidité et de mortalité.	☒

21) La responsabilité de l'état en matière de santé :

A) L'information de la population sur les risques liés à la santé ;	☒
B) Respect des droits du patient à l'information relative à sa maladie ;	☒
C) Respect de la personne de son intégrité physique, dignité, intimité ;	☒
D) Imposer les modalités de prise en charge à la population.	☐

22) La vision du ministère de la santé 2025 est basée sur les valeurs suivantes :

A) Equité ;	☐
B) Redevabilité ;	☒
C) Accessibilité ;	☐
D) Solidarité.	☒

23) Le plan d'action de la santé 2025 est basé Sur :

A) 3 Piliers ;	☒
B) 5 Piliers ;	☐
C) 7 Piliers ;	☐
D) 11 Piliers.	☐

24) Les niveaux la planification sont :

A) La stratégie générale de l'entreprise ;	☒
B) Des valeurs, les objectifs et le plan d'action de l'entreprise ;	☒
C) Des éléments de protection sociale favorables aux salariés ;	☐
D) Une réflexion sur le passé de l'entreprise.	☐

25) Quelles sont les spécialités qui relèvent du cadre rééducation-réhabilitation au Maroc :

A) Ergothérapie et optique ;	☐
B) <u>Orthoptie et kinésithérapie ;</u>	☒
C) Diététique et Orthophonie ;	☐
D) Psychomotricité et santé mentale.	☐

26) Parmi les objectifs spécifiques des stratégies et plans d'action 2025 concernant la population en situation d'handicap est de :

A) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 15%	☐
B) <u>Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 25%.</u>	☒
C) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 35%	☐
D) Réduire la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 45%	☐

27) Parmi les objectifs spécifiques des stratégies et plans d'action 2025 Concernant la population en situation d'handicap est de :

A) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 50% ;	☐
B) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 30% ;	☐
C) <u>Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 90% ;</u>	☒
D) Augmenter la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 60%.	☐

28) Le pourcentage de personne en situation d'handicap qui bénéficient d'un régime d'assurance maladie est de :

A) 32,1% ;	☐
B) <u>34,1% ;</u>	☒
C) 36,1% ;	☐
D) 38,1%.	☐

29) Selon l’OMS, la densité des professionnels de santé l’horizon 2021, devrait être portée à :

A) 2,45 pour 1000 habitants ;	☐
B) <u>4,45 pour 1000 habitants ;</u>	☒
C) 10,45 pour 1000 habitants ;	☐
D) 12,45 pour 1000 habitants.	☐

30) Vous êtes sollicité(e) pour instaurer une approche qualité au niveau de l’unité de soins. Quels sont les principes de démarche qualité que vous privilégiez :

A) L’analyse du processus, le leadership et la sanction des responsables du dysfonctionnement ;	☐
B) <u>La satisfaction du client, le travail en équipe et la prise de décisions basée sur les données ;</u>	☒
C) <u>Le leadership et l’analyse du processus ;</u>	☒
D) <u>La documentation des événements, la recherche des causes et l’application des solutions.</u>	☒

31) Pour une amélioration de la gestion des équipes soignantes, vous envisager :

A) <u>L’identification des mesures de suivi des activités du personnel ;</u>	☒
B) <u>La réalisation des enquêtes de satisfaction du personnel ;</u>	☒
C) La réalisation du bilan social ;	☐
D) <u>L’inspection inopinée du personnel.</u>	☒

32) La loi cadre relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap est la loi :

A) 87-13 ;	☐
B) 67-13 ;	☐
C) 77-13 ;	☐
D) <u>97-13.</u>	☒

33) L’évaluation du système d’information d’une unité de rééducation Sert pour :

A) <u>Assurer une meilleure communication au sein de l’équipe ;</u>	☒
B) <u>Garantir le partage d’information entre professionnels ;</u>	☒
C) <u>Partager l’information avec le patient ;</u>	☒
D) <u>Améliorer l’efficacité du travail interdisciplinaire.</u>	☒

34) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) :

A) <u>Est un outil de planification, de management participatif et de mobilisation de ressources ;</u>	☒
B) <u>Est un document de travail, de traçabilité et bilan des activités de l'hôpital ;</u>	☒
C) <u>Est un cadre de référence, et de plaidoyer ;</u>	☒
D) Est un outil de planification, de gestion des conflits, et de transmission de l'information.	☐

35) Pour assurer le suivi des activités d'amélioration continue de la qualité, vous envisagez :

A) <u>L'élaboration des indicateurs d'appréciation des activités ;</u>	☒
B) La réduction des directives consignant les mesures de motivation du personnel ;	☐
C) <u>La mise en place d'un dispositif d'écoute client ;</u>	☒
D) <u>L'élaboration de tableaux de bord.</u>	☒

36) Vous participer au processus de planification sanitaire, l'étude de la faisabilité d'une intervention doit prendre en considération :

A) <u>La faisabilité légale, et politique ;</u>	☒
B) <u>La faisabilité économique ;</u>	☒
C) La faisabilité internationale ;	☐
D) La faisabilité socioculturelle et éthique.	☐

37) Le management stratégique consiste à :

A) <u>Définir les prévisions ;</u>	☒
B) <u>Définir les objectifs atteindre ;</u>	☒
C) Contrôler le travail ;	☐
D) Intégrer les changements possibles.	☐

38) Quelles sont parmi les propositions suivantes celles qui sont justes :

A) <u>L'indicateur de structure renseigne sur les moyens et ressources utilisés ;</u>	☒
B) L'indicateur de processus renseigne sur l'atteinte des objectifs fixés ;	☐
C) <u>L'indicateur de satisfaction renseigne sur le niveau de qualité perçue ;</u>	☒
D) L'indicateur de résultat renseigne sur les activités au service d'un objectif.	☐

39) La recherche scientifique dans le domaine de la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle est :

A) Un processus rationnel visant l'acquisition et le développement de la théorie et la pratique ;	☐
B) Une démarche spécifique aux études quantitatives ;	☐
C) Un processus spécifique aux études expérimentales ;	☐
D) <u>Un processus systématique de collecte de données en vue de réaliser tous les types d'études.</u>	☒

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

الإطار: تقني الصحة الاختبار الأول المدة: ساعتان العامل: 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Pour réussir l'étape de contrôle de gestion il faut :

A) S'assurer que le travail réalisé est conforme aux normes ;	☐
B) Avoir des indicateurs fiables pour mesurer les écarts ;	☐
C) Faire des mesures correctives ;	☐
D) Communiquer les résultats aux personnels et aux responsables.	☐

2) Le processus de la planification est composé de :

A) L'analyse de la situation actuelle ;	☐
B) La mise en place des mesures correctives ;	☐
C) La définition des priorités et des axes d'amélioration ;	☐
D) La formulation des objectifs à atteindre.	☐

3) L'infirmier chef de l'unité de soin est responsable envers l'administration :

A) De la conservation du matériel et des fournitures diverses ;	☐
B) De la tenue du carnet d'inventaire du service ;	☐
C) De la comptabilisation et du suivi des comptes fournisseurs ;	☐
D) Du contrôle de l'état de fonctionnement des installations techniques de service.	☐

4) Le chef d'unité de soin ou de service est chargé de :

A) Planifier et superviser le travail des infirmiers et de tout autre personnel de soutien ;	☐
B) S'assurer que les soins requis sont dispensés ;	☐
C) Planifier et gérer les ressources matérielles et financières ;	☐
D) Evaluer les besoins de l'unité de soin ou de service.	☐

5) La fonction de la gestion de l'approvisionnement comprend :

A) L'expression des besoins ;	☐
B) La gestion des stocks ;	☐
C) Le paiement des fournisseurs ;	☐
D) La réception, l'entreposage et la distribution.	☐

6) L'épidémiologie consiste à explorer les questions :

A) Qui, Où, Quand et Quoi ;	☐
B) Qui, Où, Quand, Quoi, Comment et Pourquoi ;	☐
C) Qui, Quand, Quoi, Comment et Pourquoi ;	☐
D) Qui, Où, Quand.	☐

7) Dans une étude, des bébés âgés de 18 mois ont été choisis aléatoirement. Chaque bébé a reçu aléatoirement l'un des deux types de vaccin contre « Haemophilus influenzae ». Les parents ont été invités à enregistrer tous les effets secondaires sur une carte et à la renvoyer après deux semaines aux investigateurs de l'étude. Cette étude est :

A) Une étude expérimentale ;	☐
B) Une étude de type cohorte observationnelle ;	☐
C) Une étude de type cas-témoins ;	☐
D) Une étude non épidémiologique.	☐

8) Les deux échantillons pour une étude de cohorte sont :

A) Malade / Exposé ;	☐
B) Malade / Non Malade ;	☐
C) Exposé/ Non Exposé ;	☐
D) Exposé/ Non Malade.	☐

9) Les deux échantillons pour une étude de cas-témoins sont :

A) Malade / Exposé ;	☐
B) Malade / Non Malade ;	☐
C) Exposé/ Non Exposé ;	☐
D) Exposé/ Non Malade.	☐

10) Dans une enquête qui a duré 2 ans et qui porte sur l'étude d'une maladie M au sein d'une population stable de 50.000 personnes, on a observé 10 cas de cette maladie sur toute la période de l'étude. Cette étude est :

A) Une étude expérimentale ;	☐
B) Une étude de type cohorte observationnelle ;	☐
C) Une étude de type cas-témoins ;	☐
D) Une étude non épidémiologique.	☐

11) Dans la conception du Plan « Santé 2025 », une démarche participative a été adoptée en se basant sur les niveaux de référence suivants :

A) Les Hautes Orientations Royales ;	☐
B) Les tendances sanitaires mondiales actuelles ;	☐
C) Les engagements « santé » dans le Programme gouvernemental 2016-2021 ;	☐
D) Les principes de la régionalisation.	☐

12) Le plan « Santé 2025 » englobe les piliers suivants :

A) Pilier 1 : Organiser et développer l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;	☐
B) Pilier 2 : Renforcer les programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;	☐
C) Pilier 3 : Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des Ressources ;	☐
D) Pilier 4 : Renforcer les programmes de formation initiale et continue.	☐

13) La recherche en techniques de santé vise :

A) L'amélioration de la pratique professionnelle ;	☐
B) La remise des prix aux meilleurs travaux de recherche ;	☐
C) La remise en question des pratiques professionnelles ;	☐
D) Le développement de la carrière professionnelle.	☐

14) Le management opérationnel consiste à :

A) Assurer la gestion de l'organisation ;	☐
B) Manager et motiver l'équipe ;	☐
C) Maîtriser l'environnement externe ;	☐
D) Organiser le travail au sein de l'équipe.	☐

15) Le plan santé 2025 vise à renforcer l'accès au réseau hospitalier et au réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires entre autres, par :

A) Le développement des soins tertiaires et de la médecine hospitalo-universitaire ;	☐
B) La promotion de la prise des RDV à distance dans les établissements de soins ;	☐
C) Le développement des compétences du personnel ;	☐
D) L'informatisation des actes administratifs.	☐

16) Le plan santé 2025 vise à renforcer la veille et la sécurité sanitaires via :

A) Le lancement et la mise en œuvre du plan national de sécurité sanitaire ;	☐
B) Le développement des programmes de santé publique ;	☐
C) Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières ;	☐
D) La création des centres de santé communautaire.	☐

17) Le plan santé 2025 vise à améliorer les conditions de travail et à motiver les professionnels de santé par :

A) La promotion du dialogue social ;	☐
B) La publication et la mise en œuvre de la « stratégie sectorielle de formation continue » ;	☐
C) L'augmentation de la capacité de formation en « médecine de famille » via e-learning ;	☐
D) L'augmentation des effectifs d'admission pour la formation au niveau des ISPITS.	☐

18) Les critères d'évaluation à adopter par les gestionnaires de la formation continue en post-formation sont :

A) Le taux de satisfaction des participants ;	☐
B) La concordance entre les objectifs de la formation et les résultats atteints ;	☐
C) L'employabilité sur le terrain des compétences acquises ;	☐
D) Le taux de présence des participants.	☐

19) La recherche qualitative :

A) Vise à obtenir des réponses sur ce que les individus pensent et ressentent ;	☐
B) Consiste en l'étude des croyances et des comportements de la population ;	☐
C) Cherche à étudier les variables continues ;	☐
D) Est un processus qui englobe la démarche qualité.	☐

20) Les principales méthodes de collecte des données augmentant la subjectivité sont :

A) L'enquête par questionnaire ;	☐
B) Le focus groupe ;	☐
C) L'observation ;	☐
D) Les investigations biologiques et radiologiques.	☐

21) L'action de formation doit être axée sur les éléments suivants :

A) Rendre explicites les liens entre le monde réel et le contenu de la formation ;	☐
B) Donner toute l'autonomie à l'apprenant ;	☐
C) Centrer le processus d'apprentissage sur le participant ;	☐
D) Offrir des occasions de partage et d'échange d'idées et d'expériences.	☐

22) Lors de l'encadrement des participants à une formation, vous êtes amené à :

A) Préparer les activités d'apprentissage selon les objectifs fixés ;	☐
B) Suivre l'évolution des participants, individuellement et en groupe ;	☐
C) Procéder par résolution de problèmes ;	☐
D) Amener les participants à tirer les enseignements et à planifier leur application.	☐

23) La ou les méthodes que vous privilégiez pour animer une session de formation visant le développement du savoir être est/sont :

A) La démonstration ;	☐
B) L'exposé ;	☐
C) Le jeu de rôle ;	☐
D) L'étude de cas.	☐

24) Dans une formation, qu'appelle-t-on « effet de groupe » ?

A) La présence d'un leader qui influence le groupe ;	☐
B) L'importance de l'effectif du groupe affectant la cohérence et l'efficacité du travail ;	☐
C) L'influence des attitudes de chacun des participants par la discussion du groupe ;	☐
D) Les résultats des discussions du groupe.	☐

25) L'évaluation au terme d'un stage effectué par des étudiants peut être de nature :

A) Diagnostique ;	☐
B) Qualitative ;	☐
C) Formative ;	☐
D) Sommative.	☐

26) Les qualités requises pour le gestionnaire d'un service de santé sont :

A) Avoir l'aptitude de gérer l'environnement du service ;	☐
B) Avoir des aptitudes pour la gestion administrative, financière et comptable ;	☐
C) Avoir des compétences techniques en matière de prestations assurées au niveau du service géré ;	☐
D) Pouvoir travailler dans un milieu qui change continuellement.	☐

27) Dans le processus de planification, l'analyse de l'environnement externe concerne :

A) Les opportunités ;	☐
B) Les forces ;	☐
C) Les menaces ;	☐
D) Les faiblesses.	☐

28) La responsabilité professionnelle peut être :

A) Religieuse ;	☐
B) Morale ;	☐
C) Légale ;	☐
D) Personnelle.	☐

29) Le Décret portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé date du :

A) 28 Septembre 2011 ;	☐
B) 28 Septembre 2013 ;	☐
C) 28 Septembre 2015 ;	☐
D) 28 Septembre 2017.	☐

30) Au Maroc, quelles sont les spécialités qui relèvent du cadre « techniques de santé :

A) Santé - environnement et Diététique-Nutrition ;	☐
B) Préparateurs en Pharmacie et Radiologie et Kinésithérapie ;	☐
C) Laboratoire, Statistiques Sanitaires et Maintenance Biomédicale ;	☐
D) Ergothérapie et Orthoptie et Laboratoire.	☐

31) Parmi les composantes d'un Projet d'Etablissement Hospitalier, on cite :

A) Un projet managérial ;	☐
B) Un projet « soins infirmiers » ;	☐
C) Un plan de développement informatique ;	☐
D) Un plan d'équipement et de maintenance.	☐

32) Parmi les buts de l'évaluation dans le domaine sanitaire, on cite :

A) Aider à la planification et à l'élaboration d'une intervention ;	☐
B) Fournir de l'information pour améliorer et modifier la gestion de l'intervention ;	☐
C) Elaborer le projet d'établissement hospitalier ;	☐
D) Contribuer à l'avancement des connaissances.	☐

33) La norme ISO signifie :

A) Norme Internationale d'Organisation et de Standardisation ;	☐
B) Institution de Standardisation et d'Organisation ;	☐
C) Organisation Internationale de Standardisation et de normalisation ;	☐
D) International Organisme de Standardisation.	☐

34) Les principes fondamentaux de l'assurance qualité sont :

A) Répondre aux besoins et attentes des clients ;	☐
B) Encourager la formation des groupes pour l'amélioration de la qualité ;	☐
C) Se concentrer sur les processus et les systèmes ;	☐
D) Utiliser les données pour prendre les décisions.	☐

35) Devant une non-conformité, un organisme accrédité doit :

A) Corriger la non-conformité ;	☐
B) Informer le client ;	☐
C) Sanctionner la personne qui a fait la non-conformité ;	☐
D) Obtenir une autorisation d'acceptation par dérogation.	☐

36) Les enjeux de la qualité peuvent être :

A) Politiques ;	☐
B) Economiques ;	☐
C) Juridiques ;	☐
D) Sociaux.	☐

37) Parmi les conséquences des infections nosocomiales :

A) L'augmentation de la durée de séjour d'hospitalisation ;	☐
B) Des dépenses en moins ;	☐
C) La baisse de l'image de marque de l'établissement ;	☐
D) L'augmentation du taux des décès.	☐

38) Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en Œuvre des activités sanitaires sont :

A) Les objectifs, les ressources, et les indicateurs d'évaluation ;	☐
B) Les besoins, les ressources, et les méthodes d'évaluation ;	☐
C) La vision, les stratégies, les ressources, et les critères de performance ;	☐
D) Les stratégies, les ressources, l'évaluation et le suivi.	☐

39) En tant que cadre impliqué dans le processus de régionalisation, la déconcentration signifie :

A) Délégation de signature, de pouvoirs ou d'attributions du pouvoir central vers les représentants de l'Etat dans un souci d'efficacité et de proximité ;	☐
B) Election des représentants de la population qui constitue le mode de désignation des responsabilités ;	☐
C) Transfert de compétences de l'Etat vers des collectivités publiques (des personnes morales de Droit Public) dans un souci de démocratie locale et participative ;	☐
D) Pouvoir hiérarchique dont l'objectif ultime est le rapprochement de l'administration des citoyens.	☐

40) Vous êtes sollicité(e) pour la mise en œuvre d'une évaluation du système d'information d'une unité de soins. Les éléments clefs sur lesquels vous vous basez sont :

A) L'accessibilité au dossier du patient dans le temps et dans l'espace ;	☐
B) La disponibilité de l'information nécessaire à la prise de décision ;	☐
C) La transmission de l'information pertinente dans l'établissement selon la trajectoire du patient ;	☐
D) L'organisation des modalités de permanence au niveau de l'unité.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

الإطار: تقني الصحة الاختبار الأول المدة: ساعتان العامل: 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

Correction proposée :

1) Pour réussir l'étape de contrôle de gestion il faut :

A) <u>S'assurer que le travail réalisé est conforme aux normes ;</u>	☒
B) <u>Avoir des indicateurs fiables pour mesurer les écarts ;</u>	☒
C) <u>Faire des mesures correctives ;</u>	☒
D) Communiquer les résultats aux personnels et aux responsables.	☐

2) Le processus de la planification est composé de :

A) <u>L'analyse de la situation actuelle ;</u>	☒
B) La mise en place des mesures correctives ;	☐
C) <u>La définition des priorités et des axes d'amélioration ;</u>	☒
D) <u>La formulation des objectifs à atteindre.</u>	☒

3) L'infirmier chef de l'unité de soin est responsable envers l'administration :

A) <u>De la conservation du matériel et des fournitures diverses ;</u>	☒
B) <u>De la tenue du carnet d'inventaire du service ;</u>	☒
C) De la comptabilisation et du suivi des comptes fournisseurs ;	☐
D) <u>Du contrôle de l'état de fonctionnement des installations techniques de service.</u>	☒

4) Le chef d'unité de soin ou de service est chargé de :

A) <u>Planifier et superviser le travail des infirmiers et de tout autre personnel de soutien ;</u>	☒
B) <u>S'assurer que les soins requis sont dispensés ;</u>	☒
C) Planifier et gérer les ressources matérielles et financières ;	☐
D) <u>Evaluer les besoins de l'unité de soin ou de service.</u>	☒

5) La fonction de la gestion de l'approvisionnement comprend :

A) <u>L'expression des besoins ;</u>	☒
B) <u>La gestion des stocks ;</u>	☒
C) Le paiement des fournisseurs ;	☐
D) <u>La réception, l'entreposage et la distribution.</u>	☒

6) L'épidémiologie consiste à explorer les questions :

A) <u>Qui, Où, Quand et Quoi ;</u>	☒
B) Qui, Où, Quand, Quoi, Comment et Pourquoi ;	☐
C) Qui, Quand, Quoi, Comment et Pourquoi ;	☐
D) Qui, Où, Quand.	☐

7) Dans une étude, des bébés âgés de 18 mois ont été choisis aléatoirement. Chaque bébé a reçu aléatoirement l'un des deux types de vaccin contre « Haemophilus influenzae ». Les parents ont été invités à enregistrer tous les effets secondaires sur une carte et à la renvoyer après deux semaines aux investigateurs de l'étude. Cette étude est :

A) Une étude expérimentale ;	☐
B) <u>Une étude de type cohorte observationnelle ;</u>	☒
C) Une étude de type cas-témoins ;	☐
D) Une étude non épidémiologique.	☐

8) Les deux échantillons pour une étude de cohorte sont :

A) Malade / Exposé ;	☐
B) Malade / Non Malade ;	☐
C) <u>Exposé/ Non Exposé ;</u>	☒
D) Exposé/ Non Malade.	☐

9) Les deux échantillons pour une étude de cas-témoins sont :

A) Malade / Exposé ;	☐
B) <u>Malade / Non Malade ;</u>	☒
C) Exposé/ Non Exposé ;	☐
D) Exposé/ Non Malade.	☐

10) Dans une enquête qui a duré 2 ans et qui porte sur l'étude d'une maladie M au sein d'une population stable de 50.000 personnes, on a observé 10 cas de cette maladie sur toute la période de l'étude. Cette étude est :

A) Une étude expérimentale ;	☐
B) <u>Une étude de type cohorte observationnelle ;</u>	☒
C) Une étude de type cas-témoins ;	☐
D) Une étude non épidémiologique.	☐

11) Dans la conception du Plan « Santé 2025 », une démarche participative a été adoptée en se basant sur les niveaux de référence suivants :

A) <u>Les Hautes Orientations Royales ;</u>	☒
B) <u>Les tendances sanitaires mondiales actuelles ;</u>	☒
C) <u>Les engagements « santé » dans le Programme gouvernemental 2016-2021 ;</u>	☒
D) Les principes de la régionalisation.	☐

12) Le plan « Santé 2025 » englobe les piliers suivants :

A) <u>Pilier 1 : Organiser et développer l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;</u>	☒
B) <u>Pilier 2 : Renforcer les programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;</u>	☒
C) <u>Pilier 3 : Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des Ressources ;</u>	☒
D) Pilier 4 : Renforcer les programmes de formation initiale et continue.	☐

13) La recherche en techniques de santé vise :

A) <u>L'amélioration de la pratique professionnelle ;</u>	☒
B) La remise des prix aux meilleurs travaux de recherche ;	☐
C) <u>La remise en question des pratiques professionnelles ;</u>	☒
D) <u>Le développement de la carrière professionnelle.</u>	☒

14) Le management opérationnel consiste à :

A) Assurer la gestion de l'organisation ;	☐
B) <u>Manager et motiver l'équipe ;</u>	☒
C) Maîtriser l'environnement externe ;	☐
D) <u>Organiser le travail au sein de l'équipe.</u>	☒

15) Le plan santé 2025 vise à renforcer l'accès au réseau hospitalier et au réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires entre autres, par :

A) <u>Le développement des soins tertiaires et de la médecine hospitalo-universitaire ;</u>	☒
B) <u>La promotion de la prise des RDV à distance dans les établissements de soins ;</u>	☒
C) <u>Le développement des compétences du personnel ;</u>	☒
D) <u>L'informatisation des actes administratifs.</u>	☒

16) Le plan santé 2025 vise à renforcer la veille et la sécurité sanitaires via :

A) <u>Le lancement et la mise en œuvre du plan national de sécurité sanitaire ;</u>	☒
B) Le développement des programmes de santé publique ;	☐
C) <u>Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières ;</u>	☒
D) La création des centres de santé communautaire.	☐

17) Le plan santé 2025 vise à améliorer les conditions de travail et à motiver les professionnels de santé par :

A) <u>La promotion du dialogue social ;</u>	☒
B) <u>La publication et la mise en œuvre de la « stratégie sectorielle de formation continue » ;</u>	☒
C) <u>L'augmentation de la capacité de formation en « médecine de famille » via e-learning ;</u>	☒
D) <u>L'augmentation des effectifs d'admission pour la formation au niveau des ISPITS.</u>	☒

18) Les critères d'évaluation à adopter par les gestionnaires de la formation continue en post-formation sont :

A) <u>Le taux de satisfaction des participants ;</u>	☒
B) <u>La concordance entre les objectifs de la formation et les résultats atteints ;</u>	☒
C) <u>L'employabilité sur le terrain des compétences acquises ;</u>	☒
D) Le taux de présence des participants.	☐

19) La recherche qualitative :

A) <u>Vise à obtenir des réponses sur ce que les individus pensent et ressentent ;</u>	☒
B) <u>Consiste en l'étude des croyances et des comportements de la population ;</u>	☒
C) Cherche à étudier les variables continues ;	☐
D) Est un processus qui englobe la démarche qualité.	☐

20) Les principales méthodes de collecte des données augmentant la subjectivité sont :

A) <u>L'enquête par questionnaire ;</u>	☒
B) <u>Le focus groupe ;</u>	☒
C) <u>L'observation ;</u>	☒
D) Les investigations biologiques et radiologiques.	☐

21) L'action de formation doit être axée sur les éléments suivants :

A) <u>Rendre explicites les liens entre le monde réel et le contenu de la formation ;</u>	☒
B) <u>Donner toute l'autonomie à l'apprenant ;</u>	☒
C) <u>Centrer le processus d'apprentissage sur le participant ;</u>	☒
D) <u>Offrir des occasions de partage et d'échange d'idées et d'expériences.</u>	☒

22) Lors de l'encadrement des participants à une formation, vous êtes amené à :

A) <u>Préparer les activités d'apprentissage selon les objectifs fixés ;</u>	☒
B) <u>Suivre l'évolution des participants, individuellement et en groupe ;</u>	☒
C) <u>Procéder par résolution de problèmes ;</u>	☒
D) <u>Amener les participants à tirer les enseignements et à planifier leur application.</u>	☒

23) La ou les méthodes que vous privilégiez pour animer une session de formation visant le développement du savoir être est/sont :

A) <u>La démonstration ;</u>	☒
B) <u>L'exposé ;</u>	☒
C) <u>Le jeu de rôle ;</u>	☒
D) <u>L'étude de cas.</u>	☒

24) Dans une formation, qu'appelle-t-on « effet de groupe » ?

A) La présence d'un leader qui influence le groupe ;	☐
B) L'importance de l'effectif du groupe affectant la cohérence et l'efficacité du travail ;	☐
C) <u>L'influence des attitudes de chacun des participants par la discussion du groupe ;</u>	☒
D) <u>Les résultats des discussions du groupe.</u>	☒

25) L'évaluation au terme d'un stage effectué par des étudiants peut être de nature :

A) <u>Diagnostic ;</u>	☒
B) Qualitative ;	☐
C) <u>Formative ;</u>	☒
D) <u>Sommative.</u>	☒

26) Les qualités requises pour le gestionnaire d'un service de santé sont :

A) <u>Avoir l'aptitude de gérer l'environnement du service ;</u>	☒
B) Avoir des aptitudes pour la gestion administrative, financière et comptable ;	☐
C) <u>Avoir des compétences techniques en matière de prestations assurées au niveau du service géré ;</u>	☒
D) <u>Pouvoir travailler dans un milieu qui change continuellement.</u>	☒

27) Dans le processus de planification, l'analyse de l'environnement externe concerne :

A) <u>Les opportunités ;</u>	☒
B) Les forces ;	☐
C) <u>Les menaces ;</u>	☒
D) Les faiblesses.	☐

28) La responsabilité professionnelle peut être :

A) Religieuse ;	☐
B) Morale ;	☐
C) <u>Légale ;</u>	☒
D) Personnelle.	☐

29) Le Décret portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé date du :

A) 28 Septembre 2011 ;	☐
B) 28 Septembre 2013 ;	☐
C) 28 Septembre 2015 ;	☐
D) <u>28 Septembre 2017.</u>	☒

30) Au Maroc, quelles sont les spécialités qui relèvent du cadre « techniques de santé :

A) <u>Santé - environnement et Diététique-Nutrition ;</u>	☒
B) Préparateurs en Pharmacie et Radiologie et Kinésithérapie ;	☐
C) <u>Laboratoire, Statistiques Sanitaires et Maintenance Biomédicale ;</u>	☒
D) Ergothérapie et Orthoptie et Laboratoire.	☐

31) Parmi les composantes d'un Projet d'Etablissement Hospitalier, on cite :

A) <u>Un projet managérial ;</u>	☒
B) <u>Un projet « soins infirmiers » ;</u>	☒
C) Un plan de développement informatique ;	☐
D) <u>Un plan d'équipement et de maintenance.</u>	☒

32) Parmi les buts de l'évaluation dans le domaine sanitaire, on cite :

A) <u>Aider à la planification et à l'élaboration d'une intervention ;</u>	☒
B) <u>Fournir de l'information pour améliorer et modifier la gestion de l'intervention ;</u>	☒
C) Elaborer le projet d'établissement hospitalier ;	☐
D) <u>Contribuer à l'avancement des connaissances.</u>	☒

33) La norme ISO signifie :

A) Norme Internationale d'Organisation et de Standardisation ;	☐
B) Institution de Standardisation et d'Organisation ;	☐
C) <u>Organisation Internationale de Standardisation et de normalisation ;</u>	☒
D) International Organisme de Standardisation.	☐

34) Les principes fondamentaux de l'assurance qualité sont :

A) <u>Répondre aux besoins et attentes des clients ;</u>	☒
B) <u>Encourager la formation des groupes pour l'amélioration de la qualité ;</u>	☒
C) <u>Se concentrer sur les processus et les systèmes ;</u>	☒
D) <u>Utiliser les données pour prendre les décisions.</u>	☒

35) Devant une non-conformité, un organisme accrédité doit :

A) <u>Corriger la non-conformité ;</u>	☒
B) <u>Informer le client ;</u>	☒
C) Sanctionner la personne qui a fait la non-conformité ;	☐
D) <u>Obtenir une autorisation d'acceptation par dérogation.</u>	☒

36) Les enjeux de la qualité peuvent être :

A) <u>Politiques ;</u>	☒
B) Economiques ;	☐
C) Juridiques ;	☐
D) <u>Sociaux.</u>	☒

37) Parmi les conséquences des infections nosocomiales :

A) <u>L'augmentation de la durée de séjour d'hospitalisation ;</u>	☒
B) Des dépenses en moins ;	☐
C) <u>La baisse de l'image de marque de l'établissement ;</u>	☒
D) <u>L'augmentation du taux des décès.</u>	☒

38) Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en Œuvre des activités sanitaires sont :

A) <u>Les objectifs, les ressources, et les indicateurs d'évaluation ;</u>	☒
B) Les besoins, les ressources, et les méthodes d'évaluation ;	☐
C) La vision, les stratégies, les ressources, et les critères de performance ;	☐
D) Les stratégies, les ressources, l'évaluation et le suivi.	☐

39) En tant que cadre impliqué dans le processus de régionalisation, la déconcentration signifie :

A) <u>Délégation de signature, de pouvoirs ou d'attributions du pouvoir central vers les représentants de l'Etat dans un souci d'efficacité et de proximité ;</u>	☒
B) Election des représentants de la population qui constitue le mode de désignation des responsabilités ;	☐
C) Transfert de compétences de l'Etat vers des collectivités publiques (des personnes morales de Droit Public) dans un souci de démocratie locale et participative ;	☐
D) <u>Pouvoir hiérarchique dont l'objectif ultime est le rapprochement de l'administration des citoyens.</u>	☒

40) Vous êtes sollicité(e) pour la mise en œuvre d'une évaluation du système d'information d'une unité de soins. Les éléments clefs sur lesquels vous vous basez sont :

A) <u>L'accessibilité au dossier du patient dans le temps et dans l'espace ;</u>	☒
B) <u>La disponibilité de l'information nécessaire à la prise de décision ;</u>	☒
C) <u>La transmission de l'information pertinente dans l'établissement selon la trajectoire du patient ;</u>	☒
D) L'organisation des modalités de permanence au niveau de l'unité.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة: ساعتان العامل : 2

(دورة 16 دجنبر 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les avantages de la démarche de soins infirmiers (DSI) sont :

A) Uniformisation du vocabulaire technique employé par le personnel infirmier ;	☐
B) Renforcement de la sécurité du patient ;	☐
C) Évaluation et amélioration de la qualité des soins prodigués ;	☐
D) Amélioration de l'encodage informatisé des données de santé.	☐

2) Le diagnostic infirmier :

A) Signifie l'énoncé d'un jugement clinique ;	☐
B) Est un outil de suivi thérapeutique ;	☐
C) Sert de base pour choisir les interventions de soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de l'efficacité des soins.	☐

3) Le projet de soins :

A) Fait suite à l'analyse des données recueillies sur un patient ;	☐
B) Consiste à établir un plan d'actions formalisé par un plan de soins ;	☐
C) Est synonyme de la planification des soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de la démarche des soins.	☐

4) Le plan de soins est un outil qui permet de communiquer :

A) Les problèmes diagnostiqués chez le patient ;	☐
B) Les objectifs d'interventions infirmières ;	☐
C) La démarche de l'évaluation des soins ;	☐
D) Les modalités d'amélioration de la qualité des soins.	☐

5) La méthode des soins infirmiers :

A) Englobe les techniques et les procédures de soins infirmiers ;	☐
B) Fournit les consignes précises pour l'application d'une activité de soins ;	☐
C) Décrit la technique à suivre et les ressources pour appliquer l'activité de soins ;	☐
D) Déterminer les conditions à respecter pour l'accomplissement de l'activité de soins.	☐

6) Le protocole des soins infirmiers a pour but de :

A) Assurer une intervention appropriée face aux problèmes relevant des soins ;	☐
B) Encadrer la pratique clinique infirmière ;	☐
C) Déterminer une conduite à tenir pour résoudre un problème de soins ;	☐
D) Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants en soins.	☐

7) Critères de gravités des accidents d'exposition au sang sont :

A) La blessure cutanée secondaire à l'accident est profonde ;	☐
B) La charge virale du patient source au moment de l'accident est élevée ;	☐
C) L'aiguille est de gros calibre ;	☐
D) Le contact avec le sang est de courte durée.	☐

8) L'intérêt d'une centralisation de la stérilisation est de :

A) Assurer la continuité et la reproductivité des procédures ;	☐
B) Regrouper les moyens et les compétences ;	☐
C) Assurer l'efficacité de la stérilisation ;	☐
D) Organiser les locaux et les circuits de manière rationnelle.	☐

9) Le bilan biologique de suivi des accidents d'exposition au sang avec exposition aux VIH, VHB, VHC est fait :

A) Immédiatement après l'accident ;	☐
B) Après 15 jours de l'accident ;	☐
C) Au 20 ^{ème} jour après l'accident ;	☐
D) Pendant le 3 ^{ème} mois.	☐

10) Les principaux facteurs favorisant les infections associées aux soins sont :

A) Le climat ;	☐
B) Le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène ;	☐
C) Une architecture non adaptée ;	☐
D) Une mauvaise organisation du travail.	☐

11) Quel est le moment idéal de prise de la chimioprophylaxie après un accident d'exposition au sang :

A) 5 minutes ;	☐
B) 4 heures ;	☐
C) 48 heures ;	☐
D) 7 jours.	☐

12) L'isolement septique :

A) Vise à protéger les autres patients du service ;	☐
B) Vise à protéger les patients immunodéprimés ;	☐
C) Exige une chambre individuelle ;	☐
D) Peut se faire en salle commune.	☐

13) Les différentes branches de l'épidémiologie sont :

A) L'épidémiologie descriptive ;	☐
B) L'épidémiologie étiologique ;	☐
C) L'épidémiologie analytique ;	☐
D) L'épidémiologie d'évaluation.	☐

14) Les études épidémiologiques :

A) Ont pour objectif la prévention des problèmes de santé ;	☐
B) S'intéressent à un groupe d'individu ;	☐
C) S'intéressent à l'individu ;	☐
D) Sont souvent réalisées sur un échantillon de la population cible.	☐

15) Les champs d'application des études épidémiologiques sont :

A) L'épidémiologie de la population ;	☐
B) L'épidémiologie clinique ;	☐
C) L'épidémiologie thérapeutique ;	☐
D) L'épidémiologie opérationnelle.	☐

16) Les objectifs de l'épidémiologie sont :

A) La surveillance ;	☐
B) L'investigation ;	☐
C) La recherche ;	☐
D) L'évaluation.	☐

17) Les différents types d'étude épidémiologiques sont :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) Les études analytiques ;	☐
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études cas témoin.	☐

18) Les études de prévalence et de l'incidence font partie de :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) Les études non expérimentales ;	☐
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études analytiques.	☐

19) L'article 24 de la loi cadre n°34-09, stipule que le SROS détermine par province ou préfecture, entre autre :

A) L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
B) L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
C) La projection des équipements biomédicaux lourds ainsi que leur répartition territoriale ;	☐
D) Les projections des effectifs des ressources humaines.	☐

20) L'éthique est basée sur les valeurs suivantes :

A) La dignité ;	☐
B) La liberté ;	☐
C) L'autonomie ;	☐
D) L'honnêteté intellectuelle.	☐

21) Les principes de l'éthique sont :

A) La bienfaisance ;	☐
B) La non-malfaisance ;	☐
C) L'autonomie ;	☐
D) La solidarité.	☐

22) Les différents types de la douleur sont :

A) La douleur nociceptive ;	☐
B) La douleur neurogène ;	☐
C) La douleur psychogène ;	☐
D) La douleur mixte.	☐

23) Les bénéfices du leadership sont :

A) Meilleure coordination des processus de l'établissement ;	☐
B) Amélioration de la communication au de l'établissement ;	☐
C) Développement et amélioration de la capacité de fournir les résultats escomptés ;	☐
D) Amélioration de l'image de l'établissement.	☐

24) L'article 3 de la loi cadre n°34-09, stipule que les actions de l'Etat en matière de santé portent sur :

A) Les domaines de préventions contre les risques menaçant la santé ;	☐
B) La promotion de modes de vie sains ;	☐
C) L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;	☐
D) Le contrôle sanitaire.	☐

25) Les échelles unidimensionnelles de l'évaluation de la douleur sont :

A) Echelle verbale simple ;	☐
B) Echelle numérique ;	☐
C) Echelle visuelle analogique ;	☐
D) Echelle comportementale.	☐

26) La classification des antalgiques selon l'OMS se fait en :

A) Deux paliers ;	☐
B) Trois paliers ;	☐
C) Quatre paliers ;	☐
D) Cinq paliers.	☐

27) Selon la classification de l'OMS, les anti-inflammatoire non-stéroïdiens sont classés :

A) Le palier un ;	☐
B) Le palier cinq ;	☐
C) Le palier quatre ;	☐
D) Aucun de ces paliers.	☐

28) Parmi les principes de management de la qualité il y a :

A) Orientation du patient ;	☐
B) Implication du patient ;	☐
C) Prise de décision fondée sur des preuves ;	☐
D) Management des relations avec les parties intéressées.	☐

29) L'accès à la couverture sanitaire universelle repose sur les dimensions suivantes :

A) L'accessibilité physique ;	☐
B) L'efficacité des services ;	☐
C) L'acceptabilité ;	☐
D) L'accès financière.	☐

30) L'amélioration au sein d'un établissement de santé permet de :

A) Conserver les niveaux de performance actuels ;	☐
B) Réagir à toute variation du contexte interne et externe ;	☐
C) Créer de nouvelles opportunités ;	☐
D) Assurer la confiance des parties intéressées.	☐

31) Le SROS est un outil de :

A) Planification de l'offre de soins ;	☐
B) Organisation de l'offre de soins ;	☐
C) Accréditation de l'offre de soins ;	☐
D) Evaluation de l'offre de soins.	☐

32) Le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

33) Le centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

34) Le plan santé 2025 prévoit :

A) L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;	☐
B) Le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;	☐
C) Le renforcement du système de sécurité ;	☐
D) L'amélioration de la gouvernance, l'optimisation et l'utilisation des ressources.	☐

35) L'Institut National d'Hygiène relève de :

A) La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
B) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
C) La direction médicaments et la pharmacie ;	☐
D) La direction de la population.	☐

36) Les niveaux la planification sont :

A) Le niveau normatif ;	☐
B) Le niveau stratégique ;	☐
C) Le niveau tactique ;	☐
D) Le niveau intermédiaire.	☐

37) La planification normative :

A) C'est l'orientation générale d'un organisme ;	☐
B) Représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs ;	☐
C) Vise le changement de valeurs pour atteindre certains grands objectifs ;	☐
D) Porte sur le long terme.	☐

38) Le but de la planification en santé est de :

A) Faire le diagnostic organisationnel ;	☐
B) Assurer l'adéquation entre l'offre et le besoin ;	☐
C) Réguler l'offre de soins sur le territoire national ;	☐
D) Mettre en œuvre une politique sanitaire.	☐

39) Les prévisions du plan santé 2025, on note :

A) La stratégie nationale de la santé des personnes âgées et des migrants ;	☐
B) Le plan « Maroc sans hépatite virale B » ;	☐
C) Le plan national de procréation médicalement assistée ;	☐
D) Le programme national des maladies rares et orphelines.	☐

40) Parmi les priorités du Ministère de la Santé, décrite dans le plan santé 2025, on cite :

A) L'augmentation de la capacité litière nationale ;	☐
B) Le réaménagement des structures hospitalières existantes ;	☐
C) Dotation des hôpitaux en équipements lourds ;	☐
D) L'encouragement de nouveaux modes d'hospitalisation non-conventionnelle.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: الممرضين الاختبار الأول المدة: ساعتان العامل : 2
(دورة 16 دجنبر 2018)

Correction proposée :

1) Les avantages de la démarche de soins infirmiers (DSI) sont :

A) <u>Uniformisation du vocabulaire technique employé par le personnel infirmier ;</u>	☒
B) Renforcement de la sécurité du patient ;	☐
C) <u>Évaluation et amélioration de la qualité des soins prodigués ;</u>	☒
D) <u>Amélioration de l'encodage informatisé des données de santé.</u>	☒

2) Le diagnostic infirmier :

A) <u>Signifie l'énoncé d'un jugement clinique ;</u>	☒
B) Est un outil de suivi thérapeutique ;	☐
C) <u>Sert de base pour choisir les interventions de soins ;</u>	☒
D) Est un outil d'évaluation de l'efficacité des soins.	☐

3) Le projet de soins :

A) <u>Fait suite à l'analyse des données recueillies sur un patient ;</u>	☒
B) <u>Consiste à établir un plan d'actions formalisé par un plan de soins ;</u>	☒
C) Est synonyme de la planification des soins ;	☐
D) Est un outil d'évaluation de la démarche des soins.	☐

4) Le plan de soins est un outil qui permet de communiquer :

A) <u>Les problèmes diagnostiqués chez le patient ;</u>	☒
B) <u>Les objectifs d'interventions infirmières ;</u>	☒
C) La démarche de l'évaluation des soins ;	☐
D) Les modalités d'amélioration de la qualité des soins.	☐

5) La méthode des soins infirmiers :

A) <u>Englobe les techniques et les procédures de soins infirmiers ;</u>	☒
B) <u>Fournit les consignes précises pour l'application d'une activité de soins ;</u>	☒
C) <u>Décrit la technique à suivre et les ressources pour appliquer l'activité de soins ;</u>	☒
D) Déterminer les conditions à respecter pour l'accomplissement de l'activité de soins.	☐

6) Le protocole des soins infirmiers a pour but de :

A) <u>Assurer une intervention appropriée face aux problèmes relevant des soins ;</u>	☒
B) <u>Encadrer la pratique clinique infirmière ;</u>	☒
C) <u>Déterminer une conduite à tenir pour résoudre un problème de soins ;</u>	☒
D) Clarifier les rôles et responsabilités des intervenants en soins.	☐

7) Critères de gravités des accidents d'exposition au sang sont :

A) <u>La blessure cutanée secondaire à l'accident est profonde ;</u>	☒
B) <u>La charge virale du patient source au moment de l'accident est élevée ;</u>	☒
C) <u>L'aiguille est de gros calibre ;</u>	☒
D) Le contact avec le sang est de courte durée.	☐

8) L'intérêt d'une centralisation de la stérilisation est de :

A) <u>Assurer la continuité et la reproductivité des procédures ;</u>	☒
B) <u>Regrouper les moyens et les compétences ;</u>	☒
C) Assurer l'efficacité de la stérilisation ;	☐
D) <u>Organiser les locaux et les circuits de manière rationnelle.</u>	☒

9) Le bilan biologique de suivi des accidents d'exposition au sang avec exposition aux VIH, VHB, VHC est fait :

A) <u>Immédiatement après l'accident ;</u>	☒
B) <u>Après 15 jours de l'accident ;</u>	☒
C) Au 20 ^{ème} jour après l'accident ;	☐
D) <u>Pendant le 3^{ème} mois.</u>	☒

10) Les principaux facteurs favorisant les infections associées aux soins sont :

A) Le climat ;	☐
B) <u>Le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène ;</u>	☒
C) <u>Une architecture non adaptée ;</u>	☒
D) <u>Une mauvaise organisation du travail.</u>	☒

11) Quel est le moment idéal de prise de la chimioprophylaxie après un accident d'exposition au sang :

A) <u>5 minutes ;</u>	☒
B) 4 heures ;	☐
C) 48 heures ;	☐
D) 7 jours.	☐

12) L'isolement septique :

A) <u>Visé à protéger les autres patients du service ;</u>	☒
B) Visé à protéger les patients immunodéprimés ;	☐
C) <u>Exige une chambre individuelle ;</u>	☒
D) <u>Peut se faire en salle commune.</u>	☒

13) Les différentes branches de l'épidémiologie sont :

A) <u>L'épidémiologie descriptive ;</u>	☒
B) <u>L'épidémiologie étiologique ;</u>	☒
C) <u>L'épidémiologie analytique ;</u>	☒
D) <u>L'épidémiologie d'évaluation.</u>	☒

14) Les études épidémiologiques :

A) <u>Ont pour objectif la prévention des problèmes de santé ;</u>	☒
B) <u>S'intéressent à un groupe d'individu ;</u>	☒
C) S'intéressent à l'individu ;	☐
D) <u>Sont souvent réalisées sur un échantillon de la population cible.</u>	☒

15) Les champs d'application des études épidémiologiques sont :

A) <u>L'épidémiologie de la population ;</u>	☒
B) <u>L'épidémiologie clinique ;</u>	☒
C) L'épidémiologie thérapeutique ;	☐
D) L'épidémiologie opérationnelle.	☐

16) Les objectifs de l'épidémiologie sont :

A) <u>La surveillance ;</u>	☒
B) <u>L'investigation ;</u>	☒
C) <u>La recherche ;</u>	☒
D) <u>L'évaluation.</u>	☒

17) Les différents types d'étude épidémiologiques sont :

A) <u>Les études expérimentales ;</u>	☒
B) <u>Les études analytiques ;</u>	☒
C) <u>Les études de cohorte ;</u>	☒
D) <u>Les études cas témoin.</u>	☒

18) Les études de prévalence et de l'incidence font partie de :

A) Les études expérimentales ;	☐
B) <u>Les études non expérimentales ;</u>	☒
C) Les études de cohorte ;	☐
D) Les études analytiques.	☐

19) L'article 24 de la loi cadre n°34-09, stipule que le SROS détermine par province ou préfecture, entre autre :

A) <u>L'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante ;</u>	☒
B) L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante ;	☐
C) <u>La projection des équipements biomédicaux lourds ainsi que leur répartition territoriale ;</u>	☒
D) <u>Les projections des effectifs des ressources humaines.</u>	☒

20) L'éthique est basée sur les valeurs suivantes :

A) <u>La dignité ;</u>	☒
B) La liberté ;	☐
C) <u>L'autonomie ;</u>	☒
D) L'honnêteté intellectuelle.	☐

21) Les principes de l'éthique sont :

A) <u>La bienfaisance ;</u>	☒
B) <u>La non-malfaisance ;</u>	☒
C) <u>L'autonomie ;</u>	☒
D) La solidarité.	☐

22) Les différents types de la douleur sont :

A) <u>La douleur nociceptive ;</u>	☒
B) <u>La douleur neurogène ;</u>	☒
C) <u>La douleur psychogène ;</u>	☒
D) La douleur mixte.	☐

23) Les bénéfices du leadership sont :

A) <u>Meilleure coordination des processus de l'établissement ;</u>	☒
B) <u>Amélioration de la communication au de l'établissement ;</u>	☒
C) <u>Développement et amélioration de la capacité de fournir les résultats escomptés ;</u>	☒
D) Amélioration de l'image de l'établissement.	☐

24) L'article 3 de la loi cadre n°34-09, stipule que les actions de l'Etat en matière de santé portent sur :

A) <u>Les domaines de préventions contre les risques menaçant la santé ;</u>	☒
B) <u>La promotion de modes de vie sains ;</u>	☒
C) L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé ;	☐
D) <u>Le contrôle sanitaire.</u>	☒

25) Les échelles unidimensionnelles de l'évaluation de la douleur sont :

A) <u>Echelle verbale simple ;</u>	☒
B) <u>Echelle numérique ;</u>	☒
C) <u>Echelle visuelle analogique ;</u>	☒
D) Echelle comportementale.	☐

26) La classification des antalgiques selon l'OMS se fait en :

A) Deux paliers ;	☐
B) <u>Trois paliers ;</u>	☒
C) Quatre paliers ;	☐
D) Cinq paliers.	☐

27) Selon la classification de l'OMS, les anti-inflammatoire non-stéroïdiens sont classés :

A) <u>Le palier un ;</u>	☒
B) Le palier cinq ;	☐
C) Le palier quatre ;	☐
D) Aucun de ces paliers.	☐

28) Parmi les principes de management de la qualité il y a :

A) <u>Orientation du patient ;</u>	☒
B) Implication du patient ;	☐
C) <u>Prise de décision fondée sur des preuves ;</u>	☒
D) <u>Management des relations avec les parties intéressées.</u>	☒

29) L'accès à la couverture sanitaire universelle repose sur les dimensions suivantes :

A) <u>L'accessibilité physique ;</u>	☒
B) <u>L'efficacité des services ;</u>	☒
C) <u>L'acceptabilité ;</u>	☒
D) <u>L'accès financière.</u>	☒

30) L'amélioration au sein d'un établissement de santé permet de :

A) <u>Conserver les niveaux de performance actuels ;</u>	☒
B) <u>Réagir à toute variation du contexte interne et externe ;</u>	☒
C) <u>Créer de nouvelles opportunités ;</u>	☒
D) Assurer la confiance des parties intéressées.	☐

31) Le SROS est un outil de :

A) <u>Planification de l'offre de soins ;</u>	☒
B) <u>Organisation de l'offre de soins ;</u>	☒
C) Accréditation de l'offre de soins ;	☐
D) Evaluation de l'offre de soins.	☐

32) Le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) La direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies ;	☐
C) <u>La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;</u>	☒
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

33) Le centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc relève de :

A) Secrétariat général du Ministère de la Santé ;	☐
B) <u>La direction de l'épidémiologie et lutte contre les maladies ;</u>	☒
C) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
D) La direction médicaments et la pharmacie.	☐

34) Le plan santé 2025 prévoit :

A) <u>L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé ;</u>	☒
B) <u>Le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies ;</u>	☒
C) Le renforcement du système de sécurité ;	☐
D) <u>L'amélioration de la gouvernance, l'optimisation et l'utilisation des ressources.</u>	☒

35) L'Institut National d'Hygiène relève de :

A) <u>La direction de d'épidémiologie et lutte contre les maladies ;</u>	☒
B) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
C) La direction médicaments et la pharmacie ;	☐
D) La direction de la population.	☐

36) Les niveaux la planification sont :

A) <u>Le niveau normatif ;</u>	☒
B) <u>Le niveau stratégique ;</u>	☒
C) <u>Le niveau tactique ;</u>	☒
D) Le niveau intermédiaire.	☐

37) La planification normative :

A) <u>C'est l'orientation générale d'un organisme ;</u>	☒
B) Représente un plan d'action concret pour réaliser des objectifs ;	☐
C) <u>Vise le changement de valeurs pour atteindre certains grands objectifs ;</u>	☒
D) <u>Porte sur le long terme.</u>	☒

38) Le but de la planification en santé est de :

A) Faire le diagnostic organisationnel ;	☐
B) <u>Assurer l'adéquation entre l'offre et le besoin ;</u>	☒
C) <u>Réguler l'offre de soins sur le territoire national ;</u>	☒
D) Mettre en œuvre une politique sanitaire.	☐

39) Les prévisions du plan santé 2025, on note :

A) <u>La stratégie nationale de la santé des personnes âgées et des migrants ;</u>	☒
B) Le plan « Maroc sans hépatite virale B » ;	☐
C) <u>Le plan national de procréation médicalement assistée ;</u>	☒
D) <u>Le programme national des maladies rares et orphelines.</u>	☒

40) Parmi les priorités du Ministère de la Santé, décrite dans le plan santé 2025 on cite :

A) L'augmentation de la capacité litière nationale ;	☒
B) Le réaménagement des structures hospitalières existantes ;	☒
C) Dotation des hôpitaux en équipements lourds ;	☒
D) L'encouragement de nouveaux modes d'hospitalisation non-conventionnelle.	☒

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: إطار القابلات الاختبار الأول المدة: ساعتان المعامل : 2
(دورة 16 دجنبر 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

Dans une maison d'accouchement vous recevez une femme, Mme Nawal 38 ans, enceinte en travail accompagnée de son mari sa belle-mère et sa mère.

Mme Nawal refuse d'accoucher en position gynécologique, elle préfère la position accroupie comme elle a fait pour ces 3 accouchements précédents à sa maison. La sage-femme ne peut pas concevoir un accouchement dans cette position chose qu'elle explique à la femme et à ses proches, pour qu'ils peuvent convaincre Mme Nawal mais cette dernière refuse toujours. Le mari fait alors pression sur sa femme qui enfin accouche en position gynécologique.

1) La décision prise par la sage-femme concernant la position de l'accouchement de la sage-femme :

A) Respect de l'autonomie de la patiente ;	☐
B) Porte atteinte au secret professionnel ;	☐
C) Porte atteinte au principe de consentement libre et éclairé ;	☐
D) Respecte tous les aspects éthiques des soins.	☐

L'accouchement par voie basse de Mme Nawal est réalisé après 8h de travail avec épisiotomie d'un nouveau-né de sexe féminin poids 3,500 Kg APGAR 10/10 : une aspiration est réalisée pour le nouveau-né par la sage-femme à la 1^{ère} minute. Durant les 2h suivant l'accouchement les constantes de la patiente sont normales, saignement à 600 cc.

2) L'accouchement réalisé respecte la composante de la qualité de soins de :

A) Justification ;	☐
B) Explication ;	☐
C) Efficacité ;	☐
D) Innocuité.	☐

3) Un problème éthique est :

A) Une situation qui implique un conflit de valeurs ;	☐
B) Une situation qui implique un conflit d'intérêt ;	☐
C) Une situation où il y a manque de matériel de soins ;	☐
D) Ne peut être résolu qu'après recours à la justice.	☐

4) La confidentialité des données personnelles a comme fondement :

A) L'autonomie de la personne ;	☐
B) Le respect de la vie privée ;	☐
C) Le maintien de la relation soignant soigné ;	☐
D) Le maintien de la confiance entre le soignant et le soigné.	☐

5) Comment appelle-t-on l'ensemble des devoirs et des règles qui régissent une profession, la conduite de ceux l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ?

A) Conscience professionnelle ;	☐
B) Ethique professionnelle ;	☐
C) Déontologie ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte :

A) La sage-femme est tenue à l'obligation de moyen ;	☐
B) La sage-femme est tenue à l'obligation de la réussite de ses actes ;	☐
C) La sage-femme doit assister sa parturiente lors de ses souffrances ;	☐
D) La sage-femme est tenue au secret professionnel.	☐

7) Pour une sage-femme en fonction, l'encadrement des apprenants et de ses collègues sur le lieu d'exercice :

A) Est une obligation réglementaire ;	☐
B) Une action strictement volontaire ;	☐
C) Est une responsabilité uniquement éthique ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

8) Selon le décret n°2.04.535 28 Septembre 2017, la sage-femme à la fonction de :

A) Donner des prestations et des conseils pour la promotion de la santé ;	☐
B) Faire le suivi postnatal de la mère, du nouveau-né et du nourrisson ;	☐
C) Remplir les actes de naissance conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;	☐
D) Détecter précocement les risques et les complications pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement.	☐

9) La santé peut être considérée dans sa dimension :

A) Mentale ;	☐
B) Physique ;	☐
C) Spirituelle ;	☐
D) Emotionnelle.	☐

10) Les soins palliatifs :

A) Sont des soins donnés à une personne en phase évolutive ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle ;	☐
B) Visent à soulager la douleur de la personne ;	☐
C) Assure le confort physique du patient ;	☐
D) Vise à soutenir l'entourage de la personne malade.	☐

11) Les étapes de construction d'une démarche de recherche :

A) Répondent à un ordre chronologique ;	☐
B) Sont indépendants les uns des autres ;	☐
C) Sont liées les uns des autres ;	☐
D) Commencent par la formulation de la question centrale.	☐

12) Un nouveau-né en salle de naissance né en état de mort apparente, les efforts de réanimation se sont révélés infructueux et la décision de l'équipe de soins en concertation avec les parents était de passer aux soins palliatifs. Ces soins consistent à :

A) Bien l'envelopper et lui mettre un bonnet ;	☐
B) Limiter les sources de lumière et de bruit ;	☐
C) Administrer la vitamine ;	☐
D) Administrer le collyre et faire les soins du cordon.	☐

13) Un laboratoire de recherche :

A) Est uniquement un lieu aménagé pour pratiquer la recherche ;	☐
B) Est un regroupement de chercheurs partageant les mêmes centres d'intérêt ;	☐
C) Se décline en équipes de chercheurs travaillant sur une même thématique ;	☐
D) Se décline uniquement en locaux annexes selon l'équipe de chercheurs.	☐

14) La décision d'entrer dans une démarche de soins palliatifs nécessite :

A) Quatre temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle, l'évaluation de l'obstination, la décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;	☐
B) Trois temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle, la décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;	☐
C) Deux temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

15) Le projet de fin d'étude (PFE) dans la formation sage-femme :

A) Est l'équivalent d'un travail de thèse ;	☐
B) Est un exercice d'initiations à la démarche de recherche ;	☐
C) Vise l'initialisation d'une compréhension et à terme d'une pratique de la recherche ;	☐
D) Vise le plus souvent, la compréhension ou l'explication d'un questionnement à partir d'une situation professionnelle.	☐

16) Réfléchissez à la phrase suivante : dans un pays en développement nommé X, le réseau hospitalier est surdimensionné et concentré dans les grandes villes il absorbe une grande proportion des ressources disponibles dans ces conditions laquelle des remarques ci-dessus est correcte ?

A) Le réseau hospitalier du pays X souffre d'une grave pénurie de ressource ;	☐
B) Les hôpitaux existants doivent être remis en état et dotés d'équipements modernes ;	☐
C) Le secteur de la santé du pays X souffre d'une allocation des ressources très inefficaces ;	☐
D) Les grands hôpitaux constituent nécessairement les principaux prestataires de soins dans les villes.	☐

17) La recherche documentaire permet :

A) De travailler les problématiques ;	☐
B) De construire des connaissances ;	☐
C) D'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion ;	☐
D) De choisir la méthode de recherche.	☐

18) Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), les objectifs d'un système de santé sont :

A) L'amélioration de la santé ;	☐
B) La protection contre les risques financiers et sociaux ;	☐
C) L'amélioration des conditions sociopolitiques ;	☐
D) L'amélioration de l'efficacité.	☐

19) Dans la stratégie de santé, assurer la garde résidentielle dans toutes les maternités hospitalières régionale et provinciale « est une mesure qui figure dans l'action qui concerne :

A) Responsabilisation des centres de santé avec module d'accouchement sur la santé des mères dans leur territoire de desserte ;	☐
B) Amélioration de la prise en charge des complications obstétricales ;	☐
C) Consolidation de la politique de l'exemption des soins obstétricaux et néonataux d'urgence ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

20) Les objectifs de développement durable concernant :

A) Trois dimensions de développement ;	☐
B) Quatre dimensions de développement ;	☐
C) Cinq dimensions de développement ;	☐
D) Six dimensions de développement.	☐

21) L'organisation de la santé au Maroc intègre la dimension territoriale pour :

A) Faciliter la responsabilité territoriale et politique sur la santé ;	☐
B) Garantir une offre de soins équilibrée et équitable ;	☐
C) Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ;	☐
D) Garantir une offre de soins urgente.	☐

22) La région sanitaire :

A) Est composée de deux ou plusieurs préfectures et province sanitaire ;	☐
B) Garanti l'offre de soin uniquement du premier niveau ;	☐
C) Elle peut abriter des ressources, des installations des équipements ou des établissements de santé à vocation interrégionales ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

23) Dans le système de santé au Maroc, les hôpitaux sont classés :

A) Selon leur performance ;	☐
B) Selon l'orientation technique ou spécialité ;	☐
C) La capacité d'accueil ;	☐
D) Niveau d'intervention ou niveau de recours.	☐

24) RISUM veut dire :

A) Réseau initial des soins d'urgence médicale ;	☐
B) Régime initial des soins d'urgence médicale ;	☐
C) Réseau intégré des soins d'urgence au Maroc ;	☐
D) Réseau intégré des soins d'urgence médicale.	☐

25) Dans une maternité hospitalière, au moment de sectionner le cordon ombilical la chute d'un nouveau-né de la table d'accouchement est considérée comme :

A) Un évènement indésirable lié aux soins ;	☐
B) Un incident ;	☐
C) Accident ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

26) L'approche par les compétences forme un étudiant qui :

A) Répète ce qu'a dit l'enseignant ;	☐
B) Fait des arrangements personnels avec les savoirs quand il fait des synthèses ;	☐
C) Confronté aux situations de soin, il en tire des leçons pour lui et les autres ;	☐
D) Recherche l'efficacité.	☐

27) Deux jours après cet évènement, que doit faire le service de la maternité :

A) Prendre des mesures correctives en premier lieux ;	☐
B) Analyser cet évènement pour prévenir sa survenue dans le futur ;	☐
C) Estimer la fréquence de l'évènement ;	☐
D) Estimer les conséquences de l'évènement.	☐

28) Ainsi six personnes du service de la maternité sont chargées de réaliser cette tâche. Ce groupe de personnes est appelé :

A) Cycle qualité ;	☐
B) Cercle qualité ;	☐
C) Assurance qualité ;	☐
D) Commission d'audit externe.	☐

29) Cette action qu'entreprend le service de la maternité entre dans le cadre de :

A) La démarche qualité ;	☐
B) La gestion des risques ;	☐
C) Hygiène hospitalière ;	☐
D) L'audit externe.	☐

30) Le groupe chargé de cette activité va utiliser comme outil :

A) Le diagramme de gant ;	☐
B) Le diagramme d'Ichikawa ;	☐
C) La spirale des priorités ;	☐
D) La méthode des cinq pourquoi.	☐

31) Dans un service de suite de couche, on décide de faire une évaluation, en théorie une évaluation est :

A) Une opération continue pour collecter régulièrement des données pour s'assurer se déroule comme prévu ;	☐
B) Un système de vérification pour s'assurer de l'exécution du travail, pour déceler les erreurs et apporter des remèdes ;	☐
C) Une opération de collecte de données pour apporter un jugement de valeur sur une intervention ou sur l'une de ses composantes dans le but de prise de décision ;	☐
D) Une opération continue d'amélioration.	☐

32) Dans l'approche par les compétences, durant l'évaluation des apprentissages :

A) L'enseignant cherche la conformité des apprentissages aux contenus du programme ;	☐
B) On utilise la mise en œuvre réfléchie de la méthode face aux imprévus ;	☐
C) L'étudiant fait la démonstration de ses apprentissages ;	☐
D) On utilise les devoirs sur table, qcm, épreuves de mémorisation, etc.	☐

33) L'évaluation dans ce service de suite de couche portera sur l'évolution de l'épisiotomie chez les primipares. Il s'agit alors d'une :

A) Evaluation de procédure ;	☐
B) Evaluation de résultat ;	☐
C) Evaluation de structure ;	☐
D) Evaluation de moyen.	☐

34) A ce stade de la démarche ou la population est choisie les étapes qui suivent sont par ordre :

A) a) recueil des données, b) élaboration de l'instrument de mesure. c) présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre ;	☐
B) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données. c) élaboration de l'instrument de mesure d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre ;	☐
C) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données c) élaboration de l'instrument de mesure d) décision de mise en œuvre. e) élaboration du plan de changement ;	☐
D) a.) élaboration de l'instrument de mesure. b) recueil des données. c) présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre.	☐

35) Un plan d'urgence hospitalier (PUH) :

A) Sert à faire face à des événements catastrophiques qui affectent l'hôpital ;	☐
B) Offre des mesures d'urgence matérielles et organisationnelles ;	☐
C) Sert à intervenir au niveau de l'établissement ;	☐
D) La situation d'urgence pouvant survenir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital.	☐

36) Un plan de suivi sert à :

A) Faire l'auto-évaluation ;	☐
B) Suivre des activités pour améliorer la qualité ;	☐
C) Identifier des obstacles et problème ;	☐
D) Résoudre les problèmes et les dysfonctionnements.	☐

37) Parmi les propositions suivantes sur la planification, quelle(s) est (sont) celle(s) qui n'est (sont) par exacte(s) :

A) L'approche normative trace les grandes orientations et vise le court terme ;	☐
B) L'approche stratégique ce sont des décisions des priorités d'action et le choix entre les différentes orientations ;	☐
C) L'approche tactile ou structurelle vise le long terme ;	☐
D) L'approche opérationnelle est la mise en œuvre des choix et des programmes.	☐

38) L'approche rationnelle dans la planification est :

A) Basée sur des méthodes logiques, objectives et quantitatives ;	☐
B) Ne tient pas souvent compte des contraintes de la faisabilité ;	☐
C) Dépendante de la programmation ;	☐
D) Se dit et se veut influencée par les éléments politiques.	☐

39) Dans un centre de santé, vous faites partie de l'équipe chargée de faire une planification pour améliorer l'état de santé des femmes enceintes et en suite de couche de votre région. Vous allez dans ce cas réaliser une planification :

A) Quantitative ;	☐
B) Qualitative ;	☐
C) A la fois Quantitative et Qualitative ;	☐
D) Toutes les prépositions précédentes sont fausses.	☐

40) La planification dans le domaine de la santé est un processus :

A) Itératif ;	☐
B) Cyclique ;	☐
C) Rotatoire ;	☐
D) Continu.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة

الإطار: إطار القابلات الاختبار الأول المدة: ساعتان المعامل : 2
(دورة 16 دجنبر 2018)

Correction proposée :

Dans une maison d'accouchement vous recevez une femme, Mme Nawal 38 ans, enceinte en travail accompagnée de son mari sa belle-mère et sa mère.

Mme Nawal refuse d'accoucher en position gynécologique, elle préfère la position accroupie comme elle a fait pour ces 3 accouchements précédents à sa maison. La sage-femme ne peut pas concevoir un accouchement dans cette position chose qu'elle explique à la femme et à ses proches, pour qu'ils peuvent convaincre Mme Nawal mais cette dernière refuse toujours. Le mari fait alors pression sur sa femme qui enfin accouche en position gynécologique.

1) La décision prise par la sage-femme concernant la position de l'accouchement de la sage-femme :

A) Respect de l'autonomie de la patiente ;	☐
B) Porte atteinte au secret professionnel ;	☐
C) <u>Porte atteinte au principe de consentement libre et éclairé ;</u>	☒
D) Respecte tous les aspects éthiques des soins.	☐

L'accouchement par voie basse de Mme Nawal est réalisé après 8h de travail avec épisiotomie d'un nouveau-né de sexe féminin poids 3,500 Kg APGAR 10/10 : une aspiration est réalisée pour le nouveau-né par la sage-femme à la 1^{ère} minute. Durant les 2h suivant l'accouchement les constantes de la patiente sont normales, saignement à 600 cc.

2) L'accouchement réalisé respecte la composante de la qualité de soins de :

A) Justification ;	☐
B) Explication ;	☐
C) <u>Efficacité ;</u>	☒
D) <u>Innocuité.</u>	☒

3) Un problème éthique est :

A) <u>Une situation qui implique un conflit de valeurs ;</u>	☒
B) Une situation qui implique un conflit d'intérêt ;	☐
C) Une situation où il y a manque de matériel de soins ;	☐
D) Ne peut être résolu qu'après recours à la justice.	☐

4) La confidentialité des données personnelles a comme fondement :

A) L'autonomie de la personne ;	☐
B) <u>Le respect de la vie privée ;</u>	☒
C) <u>Le maintien de la relation soignant soigné ;</u>	☒
D) <u>Le maintien de la confiance entre le soignant et le soigné.</u>	☒

5) Comment appelle-t-on l'ensemble des devoirs et des règles qui régissent une profession, la conduite de ceux l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ?

A) Conscience professionnelle ;	☐
B) Ethique professionnelle ;	☐
C) <u>Déontologie ;</u>	☒
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte :

A) <u>La sage-femme est tenue à l'obligation de moyen ;</u>	☒
B) La sage-femme est tenue à l'obligation de la réussite de ses actes ;	☐
C) La sage-femme doit assister sa parturiente lors de ses souffrances ;	☐
D) La sage-femme est tenue au secret professionnel.	☐

7) Pour une sage-femme en fonction, l'encadrement des apprenants et de ses collègues sur le lieu d'exercice :

A) <u>Est une obligation réglementaire ;</u>	☒
B) Une action strictement volontaire ;	☐
C) Est une responsabilité uniquement éthique ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

8) Selon le décret n°2.04.535 28 Septembre 2017, la sage-femme à la fonction de :

A) <u>Donner des prestations et des conseils pour la promotion de la santé ;</u>	☒
B) <u>Faire le suivi postnatal de la mère, du nouveau-né et du nourrisson ;</u>	☒
C) <u>Remplir les actes de naissance conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;</u>	☒
D) <u>Détecter précocement les risques et les complications pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement.</u>	☒

9) La santé peut être considérée dans sa dimension :

A) <u>Mentale ;</u>	☒
B) <u>Physique ;</u>	☒
C) Spirituelle ;	☐
D) Emotionnelle.	☐

10) Les soins palliatifs :

A) <u>Sont des soins donnés à une personne en phase évolutive ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle ;</u>	☒
B) <u>Visent à soulager la douleur de la personne ;</u>	☒
C) <u>Assure le confort physique du patient ;</u>	☒
D) <u>Visent à soutenir l'entourage de la personne malade.</u>	☒

11) Les étapes de construction d'une démarche de recherche :

A) <u>Répondent à un ordre chronologique ;</u>	☒
B) Sont indépendants les uns des autres ;	☐
C) <u>Sont liées les uns des autres ;</u>	☒
D) Commencent par la formulation de la question centrale.	☐

12) Un nouveau-né en salle de naissance né en état de mort apparente, les efforts de réanimation se sont révélés infructueux et la décision de l'équipe de soins en concertation avec les parents était de passer aux soins palliatifs. Ces soins consistent à :

A) <u>Bien l'envelopper et lui mettre un bonnet ;</u>	☒
B) <u>Limitier les sources de lumière et de bruit ;</u>	☒
C) Administrer la vitamine ;	☐
D) Administrer le collyre et faire les soins du cordon.	☐

13) Un laboratoire de recherche :

A) Est uniquement un lieu aménagé pour pratiquer la recherche ;	☐
B) <u>Est un regroupement de chercheurs partageant les mêmes centres d'intérêt ;</u>	☒
C) <u>Se décline en équipes de chercheurs travaillant sur une même thématique ;</u>	☒
D) Se décline uniquement en locaux annexes selon l'équipe de chercheurs.	☐

14) La décision d'entrer dans une démarche de soins palliatifs nécessite :

A) Quatre temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle, l'évaluation de l'obstination, la décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;	☐
B) <u>Trois temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle, la décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;</u>	☒
C) Deux temps importants : l'identification d'une obstination déraisonnable avérée ou potentielle puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

15) Le projet de fin d'étude (PFE) dans la formation sage-femme :

A) Est l'équivalent d'un travail de thèse ;	☐
B) <u>Est un exercice d'initiations à la démarche de recherche ;</u>	☒
C) <u>Vise l'initialisation d'une compréhension et à terme d'une pratique de la recherche ;</u>	☒
D) <u>Vise le plus souvent, la compréhension ou l'explication d'un questionnement à partir d'une situation professionnelle.</u>	☒

16) Réfléchissez à la phrase suivante : dans un pays en développement nommé X, le réseau hospitalier est surdimensionné et concentré dans les grandes villes il absorbe une grande proportion des ressources disponibles dans ces conditions laquelle des remarques ci-dessus est correcte ?

A) Le réseau hospitalier du pays X souffre d'une grave pénurie de ressource ;	☐
B) Les hôpitaux existants doivent être remis en état et dotés d'équipements modernes ;	☐
C) Le secteur de la santé du pays X souffre d'une allocation des ressources très inefficaces ;	☐
D) <u>Les grands hôpitaux constituent nécessairement les principaux prestataires de soins dans les villes.</u>	☒

17) La recherche documentaire permet :

A) <u>De travailler les problématiques ;</u>	☒
B) <u>De construire des connaissances ;</u>	☒
C) <u>D'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion ;</u>	☒
D) De choisir la méthode de recherche.	☐

18) Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), les objectifs d'un système de santé sont :

A) <u>L'amélioration de la santé ;</u>	☒
B) <u>La protection contre les risques financiers et sociaux ;</u>	☒
C) L'amélioration des conditions sociopolitiques ;	☐
D) <u>L'amélioration de l'efficience.</u>	☒

19) Dans la stratégie de santé, assurer la garde résidentielle dans toutes les maternités hospitalières régionale et provinciale « est une mesure qui figure dans l'action qui concerne :

A) Responsalisation des centres de santé avec module d'accouchement sur la santé des mères dans leur territoire de desserte ;	☐
B) <u>Amélioration de la prise en charge des complications obstétricales ;</u>	☒
C) Consolidation de la politique de l'exemption des soins obstétricaux et néonataux d'urgent ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

20) Les objectifs de développement durable concernant :

A) <u>Trois dimensions de développement ;</u>	☒
B) Quatre dimensions de développement ;	☐
C) Cinq dimensions de développement ;	☐
D) Six dimensions de développement.	☐

21) L'organisation de la santé au Maroc intégré la dimension territoriale pour :

A) <u>Faciliter la responsabilité territoriale et politique sur la santé ;</u>	☒
B) <u>Garantir une offre de soins équilibrée et équitable ;</u>	☒
C) <u>Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ;</u>	☒
D) Garantir une offre de soins urgente.	☐

22) La région sanitaire :

A) <u>Est composée de deux ou plusieurs préfectures et province sanitaire ;</u>	☒
B) Garanti l'offre de soin uniquement du premier niveau ;	☐
C) <u>Elle peut abriter des ressources, des installations des équipements ou des établissements de santé à vocation interrégionales ;</u>	☒
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

23) Dans le système de santé au Maroc, les hôpitaux sont classés :

A) Selon leur performance ;	☐
B) <u>Selon l'orientation technique ou spécialité ;</u>	☒
C) <u>La capacité d'accueil ;</u>	☒
D) <u>Niveau d'intervention ou niveau de recours.</u>	☒

24) RISUM veut dire :

A) Réseau initial des soins d'urgence médicale ;	☐
B) Régime initial des soins d'urgence médicale ;	☐
C) Réseau intégré des soins d'urgence au Maroc ;	☐
D) <u>Réseau intégré des soins d'urgence médicale.</u>	☒

25) Dans une maternité hospitalière, au moment de sectionner le cordon ombilical la chute d'un nouveau-né de la table d'accouchement est considérée comme :

A) Un évènement indésirable lié aux soins ;	☐
B) Un incident ;	☐
C) Accident ;	☐
D) <u>Toutes les propositions précédentes sont justes.</u>	☒

26) L'approche par les compétences forme un étudiant qui :

A) Répète ce qu'a dit l'enseignant ;	☐
B) <u>Fait des arrangements personnels avec les savoirs quand il fait des synthèses ;</u>	☒
C) <u>Confronté aux situations de soin, il en tire des leçons pour lui et les autres ;</u>	☒
D) <u>Recherche l'efficacité.</u>	☒

27) Deux jours après cet évènement, que doit faire le service de la maternité :

A) <u>Prendre des mesures correctives en premier lieux ;</u>	☒
B) Analyser cet évènement pour prévenir sa survenue dans le futur ;	☐
C) Estimer la fréquence de l'évènement ;	☐
D) Estimer les conséquences de l'évènement.	☐

28) Ainsi six personnes du service de la maternité sont chargées de réaliser cette tâche. Ce groupe de personnes est appelé :

A) Cycle qualité ;	☐
B) <u>Cercle qualité ;</u>	☒
C) Assurance qualité ;	☐
D) Commission d'audit externe.	☐

29) Cette action qu'entreprend le service de la maternité entre dans le cadre de :

A) La démarche qualité ;	☐
B) <u>La gestion des risques ;</u>	☒
C) Hygiène hospitalière ;	☐
D) L'audit externe.	☐

30) Le groupe chargé de cette activité va utiliser comme outil :

A) Le diagramme de gant ;	☐
B) <u>Le diagramme d'Ichikawa ;</u>	☒
C) La spirale des priorités ;	☐
D) <u>La méthode des cinq pourquoi.</u>	☒

31) Dans un service de suite de couche, on décide de faire une évaluation, en théorie une évaluation est :

A) Une opération continue pour collecter régulièrement des données pour s'assurer se déroule comme prévu ;	☐
B) Un système de vérification pour s'assurer de l'exécution du travail, pour déceler les erreurs et apporter des remèdes ;	☐
C) <u>Une opération de collecte de données pour apporter un jugement de valeur sur une intervention ou sur l'une de ses composantes dans le but de prise de décision ;</u>	☒
D) Une opération continue d'amélioration.	☐

32) Dans l'approche par les compétences, durant l'évaluation des apprentissages :

A) L'enseignant cherche la conformité des apprentissages aux contenus du programme ;	☐
B) <u>On utilise la mise en œuvre réfléchie de la méthode face aux imprévus ;</u>	☒
C) <u>L'étudiant fait la démonstration de ses apprentissages ;</u>	☒
D) On utilise les devoirs sur table, qcm, épreuves de mémorisation, etc.	☐

33) L'évaluation dans ce service de suite de couche portera sur l'évolution de l'épisiotomie chez les primipares. Il s'agit alors d'une :

A) <u>Evaluation de procédure ;</u>	☒
B) Evaluation de résultat ;	☐
C) Evaluation de structure ;	☐
D) Evaluation de moyen.	☐

34) A ce stade de la démarche ou la population est choisie les étapes qui suivent sont par ordre :

A) a) recueil des données, b) élaboration de l'instrument de mesure. c) présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre ;	☐
B) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données. c) élaboration de l'instrument de mesure d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre ;	☐
C) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données c) élaboration de l'instrument de mesure d) décision de mise en œuvre. e) élaboration du plan de changement ;	☐
D) <u>a.) élaboration de l'instrument de mesure. b) recueil des données. c) présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de changement. e) décision de mise en œuvre.</u>	☒

35) Un plan d'urgence hospitalier (PUH) :

A) <u>Sert à faire face à des événements catastrophiques qui affectent l'hôpital ;</u>	☒
B) <u>Offre des mesures d'urgence matérielles et organisationnelles ;</u>	☒
C) <u>Sert à intervenir au niveau de l'établissement ;</u>	☒
D) <u>La situation d'urgence pouvant survenir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital.</u>	☒

36) Un plan de suivi sert à :

A) <u>Faire l'auto-évaluation ;</u>	☒
B) <u>Suivre des activités pour améliorer la qualité ;</u>	☒
C) <u>Identifier des obstacles et problème ;</u>	☒
D) Résoudre les problèmes et les dysfonctionnements.	☐

37) Parmi les propositions suivantes sur la planification, quelle(s) est (sont) celle(s) qui n'est (sont) par exacte(s) :

A) <u>L'approche normative trace les grandes orientations et vise le court terme ;</u>	☒
B) L'approche stratégique ce sont des décisions des priorités d'action et le choix entre les différentes orientations ;	☐
C) <u>L'approche tactile ou structurelle vise le long terme ;</u>	☒
D) L'approche opérationnelle est la mise en œuvre des choix et des programmes.	☐

38) L'approche rationnelle dans la planification est :

A) <u>Basée sur des méthodes logiques, objectives et quantitatives ;</u>	☒
B) <u>Ne tient pas souvent compte des contraintes de la faisabilité ;</u>	☒
C) Dépendante de la programmation ;	☐
D) Se dit et se veut influencée par les éléments politiques.	☐

39) Dans un centre de santé, vous faites partie de l'équipe chargée de faire une planification pour améliorer l'état de santé des femmes enceintes et en suite de couche de votre région. Vous allez dans ce cas réaliser une planification :

A) Quantitative ;	☐
B) <u>Qualitative ;</u>	☒
C) A la fois Quantitative et Qualitative ;	☐
D) Toutes les prépositions précédentes sont fausses.	☐

40) La planification dans le domaine de la santé est un processus :

A) <u>Itératif ;</u>	☒
B) <u>Cyclique ;</u>	☒
C) <u>Rotatoire ;</u>	☒
D) <u>Continu.</u>	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 10 يونيو 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les piliers du plan de santé 2025, on trouve :

A) Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources ;	☐
B) Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires ;	☐
C) Organiser l'offre de soins national ;	☐
D) Renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé.	☐

2) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

A) Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire ;	☐
B) Leur(s) conjoint(s) ;	☐
C) Leurs parents ;	☐
D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus.	☐

3) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Réseau des établissements hospitaliers des forces armées royales ;	☐
C) Réseau des établissements médico-sociaux publics ;	☐
D) Réseau intégré des soins d'urgences médicales.	☐

4) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

A) La population en situation de pauvreté et de vulnérabilité ;	☐
B) Seulement la population en situation de pauvreté ;	☐
C) Seulement la population en situation de vulnérabilité ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

5) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

A) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité ;	☐
B) Sont approuvés par les arrêtés du ministre de la santé ;	☐
C) Sont établis par les directions régionales de la santé concernées ;	☐
D) Sont établis pour une période de trois ans.	☐

6) Parmi les attributions de la direction régionale de santé :

A) L'élaboration des plans d'action concernant l'état de santé au niveau de la province/préfecture ;	☐
B) La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires ;	☐
C) La gestion des ressources humaines ;	☐
D) La protection de la santé publique et la veille sanitaire.	☐

7) L'offre publique de soins en mode mobile est composée des réseaux suivants :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau hospitalier ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

8) La stratégie du Ministère de la santé accorde une importance à la population spécifique, on désigne par cette population :

A) La population carcérale ;	☐
B) Les migrants ;	☐
C) Les nouveau-nés ;	☐
D) Les personnes âgées.	☐

9) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

A) Les centres d'hémodialyse ;	☐
B) Les centres de soins palliatifs ;	☐
C) Les centres de transfusion ;	☐
D) Les centres régionaux d'oncologie.	☐

10) Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par :

A) Centre de référence ;	☐
B) Clinique de jour ;	☐
C) Hôpital de proximité ;	☐
D) Pôle d'excellence.	☐

11) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

A) Les centres d'addictologie ;	☐
B) Les centres de consultations spécialisées ;	☐
C) Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires ;	☐
D) Les laboratoires de santé publique.	☐

12) Les urgences médico-hospitalières complète (UMH-C) sont assurées par :

A) Les centres hospitaliers interrégionaux ;	☐
B) Les centres hospitaliers provinciaux ;	☐
C) Les centres hospitaliers préfectoraux ;	☐
D) Les centres hospitaliers régionaux.	☐

13) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) Epidémie ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

14) Font partie du système national de santé marocain :

A) La médecine traditionnelle ;	☐
B) Le secteur privé ;	☐
C) Les services de santé relevant des collectivités locales ;	☐
D) Les services des FAR.	☐

15) L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément :

A) Aux orientations de l'OMS ;	☐
B) Aux schémas régionaux de l'offre de soins ;	☐
C) A l'organisation hospitalière ;	☐
D) A la carte sanitaire.	☐

16) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) est un :

A) Moyen de mobilisation et de responsabilisation des acteurs ;	☐
B) Outil de management participatif ;	☐
C) Outil de planification ;	☐
D) Projets des professionnels de l'hôpital.	☐

17) Le territoire de santé est constitué par :

A) La circonscription sanitaire ;	☐
B) La délégation sanitaire ;	☐
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) Le territoire de santé interrégional.	☐

18) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une :

A) Responsabilité de l'état et de la société ;	☐
B) Responsabilité des citoyens ;	☐
C) Responsabilité des citoyens et de l'état ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

19) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé comprennent :

A) La direction de la planification et des ressources financières ;	☐
B) La direction de la population ;	☐
C) La direction de lutte contre les maladies ;	☐
D) La direction des ressources humaines et contentieux.	☐

20) Les principes du système de santé marocain :

A) L'adoption de l'approche genre en matière de service de santé ;	☐
B) L'égalité d'accès aux soins ;	☐
C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;	☐
D) La solidarité.	☐

21) Les objectifs du développement durable (ODD) :

A) Six sont liés indirectement à la santé ;	☐
B) Sont au nombre de 15 ;	☐
C) Sont au nombre de 17 ;	☐
D) Trois sont liés directement à la santé.	☐

22) Le Plan Santé 2025 cible les nouveaux programmes suivants :

A) L'hépatite virale B, l'hypothyroïdie et la prévention des maladies cardiovasculaires ;	☐
B) L'hépatite virale C, la prévention des maladies cardiovasculaires et la surdité chez l'enfant ;	☐
C) L'hépatite virale C, le diabète et l'obésité ;	☐
D) Les maladies rares, l'insuffisance rénale chronique terminale et la procréation médicalement assistée.	☐

23) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

A) Caravanes médicales spécialisées ;	☐
B) Hôpitaux mobiles ;	☐
C) Unités médicales mobiles ;	☐
D) Visites à domicile.	☐

24) Les fonctions de soins d'urgences médicales sont :

A) Au nombre de 14 fonctions ;	☐
B) Au nombre de 15 fonctions ;	☐
C) Au nombre de 16 fonctions ;	☐
D) Au nombre de 17 fonctions.	☐

25) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

A) L'observatoire régional de la santé ;	☐
B) Le service de l'approvisionnement ;	☐
C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance ;	☐
D) Le service des ressources humaines.	☐

26) L'assurance maladie obligatoire des étudiants (AMO-E) est gérée par :

A) L'ANAM ;	☐
B) La CNOPS ;	☐
C) La CNSS ;	☐
D) Le Ministère de la santé.	☐

27) Les composantes de la couverture médicale de base (CMB) sont :

A) L'AMI ;	☐
B) L'AMO ;	☐
C) La CNOPS ;	☐
D) Le RAMED.	☐

28) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

A) Disponibilité des médicaments essentiels ;	☐
B) Espérance de vie à la naissance ;	☐
C) Taux d'accouchement en milieu surveillé ;	☐
D) Taux de mortalité maternelle.	☐

29) On entend par prestations d'hôpital de jour :

A) Les prestations de soins de santé primaires qui peuvent être rendues dans la journée ;	☐
B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues 24/24 ;	☐
C) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée avec hébergement ;	☐
D) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée sans hébergement.	☐

30) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale (ENPSF) 2018, le ratio de la mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) est de :

A) 70,1 ;	☐
B) 71,3 ;	☐
C) 72,6 ;	☐
D) 73,8.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 10 يونيو 2018)

Correction proposée :

1) Parmi les piliers du plan de santé 2025, on trouve :

A) <u>Améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources ;</u>	☒
B) Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires ;	☐
C) Organiser l'offre de soins national ;	☐
D) Renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé.	☐

2) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

A) <u>Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire ;</u>	☒
B) <u>Leur(s) conjoint(s) ;</u>	☒
C) Leurs parents ;	☐
D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus.	☐

3) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

A) <u>Réseau des établissements de soins de santé primaires ;</u>	☒
B) Réseau des établissements hospitaliers des forces armées royales ;	☐
C) <u>Réseau des établissements médico-sociaux publics ;</u>	☒
D) <u>Réseau intégré des soins d'urgences médicales.</u>	☒

4) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

A) La population en situation de pauvreté et de vulnérabilité ;	☐
B) Seulement la population en situation de pauvreté ;	☐
C) <u>Seulement la population en situation de vulnérabilité ;</u>	☒
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

5) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

A) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité ;	☐
B) <u>Sont approuvés par les arrêtés du ministre de la santé ;</u>	☒
C) <u>Sont établis par les directions régionales de la santé concernées ;</u>	☒
D) Sont établis pour une période de trois ans.	☐

6) Parmi les attributions de la direction régionale de santé :

A) L'élaboration des plans d'action concernant l'état de santé au niveau de la province/préfecture ;	☐
B) <u>La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires ;</u>	☒
C) <u>La gestion des ressources humaines ;</u>	☒
D) <u>La protection de la santé publique et la veille sanitaire.</u>	☒

7) L'offre publique de soins en mode mobile est composée des réseaux suivants :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau hospitalier ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) <u>Aucune proposition n'est juste.</u>	☒

8) La stratégie du Ministère de la santé accorde une importance à la population spécifique, on désigne par cette population :

A) <u>La population carcérale ;</u>	☒
B) <u>Les migrants ;</u>	☒
C) Les nouveau-nés ;	☐
D) <u>Les personnes âgées.</u>	☒

9) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

A) Les centres d'hémodialyse ;	☐
B) <u>Les centres de soins palliatifs ;</u>	☒
C) <u>Les centres de transfusion ;</u>	☒
D) Les centres régionaux d'oncologie.	☐

10) Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par :

A) Centre de référence ;	☐
B) Clinique de jour ;	☐
C) <u>Hôpital de proximité ;</u>	☒
D) Pôle d'excellence.	☐

11) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

A) Les centres d'addictologie ;	☐
B) Les centres de consultations spécialisées ;	☐
C) <u>Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires ;</u>	☒
D) <u>Les laboratoires de santé publique.</u>	☒

12) Les urgences médico-hospitalières complète (UMH-C) sont assurées par :

A) Les centres hospitaliers interrégionaux ;	☐
B) Les centres hospitaliers provinciaux ;	☐
C) Les centres hospitaliers préfectoraux ;	☐
D) <u>Les centres hospitaliers régionaux.</u>	☒

13) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) <u>Epidémie ;</u>	☒
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

14) Font partie du système national de santé marocain :

A) <u>La médecine traditionnelle ;</u>	☒
B) <u>Le secteur privé ;</u>	☒
C) <u>Les services de santé relevant des collectivités locales ;</u>	☒
D) <u>Les services des FAR.</u>	☒

15) L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément :

A) Aux orientations de l'OMS ;	☐
B) <u>Aux schémas régionaux de l'offre de soins ;</u>	☒
C) A l'organisation hospitalière ;	☐
D) <u>A la carte sanitaire.</u>	☒

16) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) est un :

A) <u>Moyen de mobilisation et de responsabilisation des acteurs ;</u>	☒
B) <u>Outil de management participatif ;</u>	☒
C) <u>Outil de planification ;</u>	☒
D) Projets des professionnels de l'hôpital.	☐

17) Le territoire de santé est constitué par :

A) <u>La circonscription sanitaire ;</u>	☒
B) La délégation sanitaire ;	☐
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) <u>Le territoire de santé interrégional.</u>	☒

18) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une :

A) <u>Responsabilité de l'état et de la société ;</u>	☒
B) Responsabilité des citoyens ;	☐
C) Responsabilité des citoyens et de l'état ;	☐
D) Aucune proposition n'est juste.	☐

19) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé comprennent :

A) <u>La direction de la planification et des ressources financières ;</u>	☒
B) <u>La direction de la population ;</u>	☒
C) La direction de lutte contre les maladies ;	☐
D) La direction des ressources humaines et contentieux.	☐

20) Les principes du système de santé marocain :

A) <u>L'adoption de l'approche genre en matière de service de santé ;</u>	☒
B) <u>L'égalité d'accès aux soins ;</u>	☒
C) <u>L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;</u>	☒
D) <u>La solidarité.</u>	☒

21) Les objectifs du développement durable (ODD) :

A) Six sont liés indirectement à la santé ;	☐
B) Sont au nombre de 15 ;	☐
C) <u>Sont au nombre de 17 ;</u>	☒
D) Trois sont liés directement à la santé.	☐

22) Le Plan Santé 2025 cible les nouveaux programmes suivants :

A) L'hépatite virale B, l'hypothyroïdie et la prévention des maladies cardiovasculaires ;	☐
B) <u>L'hépatite virale C, la prévention des maladies cardiovasculaires et la surdité chez l'enfant ;</u>	☒
C) L'hépatite virale C, le diabète et l'obésité ;	☐
D) <u>Les maladies rares, l'insuffisance rénale chronique terminale et la procréation médicalement assistée.</u>	☒

23) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

A) <u>Caravanes médicales spécialisées ;</u>	☒
B) <u>Hôpitaux mobiles ;</u>	☒
C) <u>Unités médicales mobiles ;</u>	☒
D) <u>Visites à domicile.</u>	☒

24) Les fonctions de soins d'urgences médicales sont :

A) Au nombre de 14 fonctions ;	☐
B) Au nombre de 15 fonctions ;	☐
C) <u>Au nombre de 16 fonctions ;</u>	☒
D) Au nombre de 17 fonctions.	☐

25) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

A) <u>L'observatoire régional de la santé ;</u>	☒
B) Le service de l'approvisionnement ;	☐
C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance ;	☐
D) Le service des ressources humaines.	☐

26) L'assurance maladie obligatoire des étudiants (AMO-E) est gérée par :

A) L'ANAM ;	☐
B) <u>La CNOPS ;</u>	☒
C) La CNSS ;	☐
D) Le Ministère de la santé.	☐

27) Les composantes de la couverture médicale de base (CMB) sont :

A) L'AMI ;	☐
B) <u>L'AMO ;</u>	☒
C) La CNOPS ;	☐
D) <u>Le RAMED.</u>	☒

28) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

A) Disponibilité des médicaments essentiels ;	☐
B) <u>Espérance de vie à la naissance ;</u>	☒
C) Taux d'accouchement en milieu surveillé ;	☐
D) <u>Taux de mortalité maternelle.</u>	☒

29) On entend par prestations d'hôpital de jour :

A) Les prestations de soins de santé primaires qui peuvent être rendues dans la journée ;	☐
B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues 24/24 ;	☐
C) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée avec hébergement ;	☐
D) <u>Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendues dans la journée sans hébergement.</u>	☒

30) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale (ENPSF) 2018, le ratio de la mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) est de :

A) 70,1 ;	☐
B) 71,3 ;	☐
C) <u>72,6 ;</u>	☒
D) 73,8.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 18 مارس 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) Le centre d'addictologie ;	☐
B) Centre national de radioprotection ;	☐
C) Centre national antipoison et de pharmacovigilance ;	☐
D) Institut national d'hygiène.	☐

2) Selon de la rapport santé en chiffres 2014, l'Esperance de Vie à la Naissance au Maroc est de :

A) 76,5 ans ;	☐
B) 79,4 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) 75,4 ans.	☐

3) On entend par filière de soins :

A) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients.	☐

4) La direction régionale de la santé est composée des services suivants :

A) Service de l'offre de soins ;	☐
B) Service de santé publique ;	☐
C) Service des ressources humaines et du contentieux ;	☐
D) Service administratif et économique.	☐

5) Les soins de santé de base (primaire) :

A) Sont des soins préventifs seulement ;	☐
B) Sont assurés au niveau du réseau hospitalier ;	☐
C) Sont des soins préventifs curatifs et promotionnels ;	☐
D) Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé.	☐

6) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique et mental ;	☐
B) Physique, mental et social ;	☐
C) Physique et social ;	☐
D) Physique.	☐

7) Filière de soins :

A) Premier contact représenté par le médecin généraliste pour le secteur privé ;	☐
B) Organisation non hiérarchisée ;	☐
C) Une organisation horizontale de la prise en charge des patients ;	☐
D) Recours aux soins selon la nature de la morbidité.	☐

8) Les objectifs d'un système de santé sont :

A) Améliorer l'efficacité ;	☐
B) Assurer l'accès équitable et rationnel aux médicaments essentiels, vaccins et technologies de qualité ;	☐
C) Améliorer la santé de population ;	☐
D) Répondre aux attentes des gens.	☐

9) Dans la déclaration millénaire pour le développement :

A) 4 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
B) 2 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
C) 5 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

10) L'objectif de l'économie de santé est de :

A) Recherche la meilleure utilisation des ressources ;	☐
B) Contrôler des agents économiques ;	☐
C) Faire des économies ;	☐
D) Diminuer les dépenses.	☐

11) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de :

A) 94,5 % ;	☐
B) 92,5 % ;	☐
C) 95,5 % ;	☐
D) 93,5 %.	☐

12) La première cause de la mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les maladies transmissibles ;	☐
B) La tuberculose et les maladies respiratoires ;	☐
C) Les cancers ;	☐
D) Les maladies cardio-vasculaires.	☐

13) L'AMO est gérée par :

A) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur public ;	☐
B) La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale pour le secteur privé ;	☐
C) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur privé ;	☐
D) La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale pour le secteur public.	☐

14) Le réseau des établissement médico-sociaux comprend :

A) Centre des soins palliatifs ;	☐
B) Centre d'addictologie ;	☐
C) Centre de soins de suite et de convalescence ;	☐
D) Espace « santé-jeunes ».	☐

15) La circonscription sanitaire :

A) Peut-être rurale ou urbaine ;	☐
B) Correspond à l'aire de desserte d'un centre de santé ;	☐
C) Peut-être découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;	☐
D) Représente le territoire de base dans le découpage sanitaire.	☐

16) Le centre de santé rural du premier niveau :

A) Est place sous la responsabilité d'un médecin généraliste ;	☐
B) Est place sous la responsabilité d'un infirmier major ;	☐
C) Est l'établissement de soins de santé primaire de premier contact en milieux rural ;	☐
D) N'offre que les prestations de sante préventives et promotionnelles.	☐

17) En 2014 :

A) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 1000 naissances vivantes ;	☐
C) L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans ;	☐
D) Le taux de mortalité maternelle est de 112 décès/ 100.00 naissance vivantes.	☐

18) Lesquelles des structures suivantes ne font pas partie du secteur privé à but non lucratif :

A) Les hôpitaux des Forces Armées Royales ;	☐
B) Les établissements du croissant rouge marocain ;	☐
C) Les ligues et fondation ;	☐
D) Les cliniques et cabinets médicaux.	☐

19) Le premier financeur du RAMED est représenté par :

A) Les ménages ;	☐
B) Le Ministère de la Santé ;	☐
C) L'Etat ;	☐
D) Les collectivités locales.	☐

20) Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés :

A) En 9 services ;	☐
B) En 7 services ;	☐
C) En 6 services ;	☐
D) En 8 services.	☐

21) Lequel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) Le plan stratégique provincial ;	☐
B) Le budget programme ;	☐
C) Le plan stratégique régional ;	☐
D) Les plans d'effectifs.	☐

22) Lesquels des outils suivants ne font pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) Le plan stratégique provincial ;	☐
B) Le budget programme ;	☐
C) Le plan stratégique régional ;	☐
D) Le pole des affaires professionnelles.	☐

23) La source principale de financement du ministère de la santé est représentée par :

A) La coopération internationale ;	☐
B) Le budget de l'Etat ;	☐
C) Les ménages ;	☐
D) Les assurances et mutuelles.	☐

24) Le projet d'établissement hospitalier comprend entre autre les projets suivants :

A) Projet technique ;	☐
B) Projet administratif ;	☐
C) Projet social ;	☐
D) Projet managérial.	☐

25) La part la plus importante (47%) des dépenses du ministère de la santé en 2010 est allouée :

A) Aux hôpitaux ;	☐
B) À l'administration centrale et locale ;	☐
C) Au Réseau de soins de santé de base (RSSB) ;	☐
D) Aux instituts, centres et laboratoires nationaux.	☐

26) Le régime d'assistance médicale couvre des prestations médicalement requises suivants :

A) Articles de prothèse et d'orthèse ;	☐
B) Les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale ;	☐
C) Les interventions de chirurgie plastique et esthétique ;	☐
D) Dispositions médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux.	☐

27) La carte sanitaire est un outil législatif de :

A) L'organisation des établissements de soins primaires ;	☐
B) L'organisation des services de soins ;	☐
C) L'organisation des établissements hospitaliers ;	☐
D) L'organisation de l'offre de soins.	☐

28) Les missions des services des réseaux des établissements de santé sont :

A) La coordination des activités du RISUM ;	☐
B) La coordination des activités des différents réseaux ;	☐
C) La mise en place des mesures nécessaires au respect de la filière des soins ;	☐
D) La planification, l'encadrement, la supervision, l'évaluation et le contrôle du RESSP.	☐

29) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) 3 réseaux ;	☐
B) 6 réseaux ;	☐
C) 8 réseaux ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

30) Les services déconcentrés (extérieurs) du Ministère de la santé sont représentés par :

A) L'inspection Générale ;	☐
B) Directions régionales de la santé ;	☐
C) Secrétariat Général ;	☐
D) Délégations Préfectorales ou provinciales.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار الأول

المدة : ساعتان العامل : 2

(دورة 18 مارس 2018)

Correction proposée :

- 1) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) Le centre d'addictologie ;	☐
B) <u>Centre national de radioprotection ;</u>	☒
C) <u>Centre national antipoison et de pharmacovigilance ;</u>	☒
D) <u>Institut national d'hygiène.</u>	☒

- 2) Selon de la rapport santé en chiffres 2014, l'Esperance de Vie à la Naissance au Maroc est de :

A) 76,5 ans ;	☐
B) 79,4 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) <u>75,4 ans.</u>	☒

- 3) On entend par filière de soins :

A) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) <u>Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients.</u>	☒

4) La direction régionale de la santé est composée des services suivants :

A) <u>Service de l'offre de soins ;</u>	☒
B) <u>Service de santé publique ;</u>	☒
C) <u>Service des ressources humaines et du contentieux ;</u>	☒
D) Service administratif et économique.	☐

5) Les soins de santé de base (primaire) :

A) Sont des soins préventifs seulement ;	☐
B) Sont assurés au niveau du réseau hospitalier ;	☐
C) <u>Sont des soins préventifs curatifs et promotionnels ;</u>	☒
D) <u>Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé.</u>	☒

6) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique et mental ;	☐
B) <u>Physique, mental et social ;</u>	☒
C) Physique et social ;	☐
D) Physique.	☐

7) Filière de soins :

A) <u>Premier contact représenté par le médecin généraliste pour le secteur privé ;</u>	☒
B) Organisation non hiérarchisée ;	☐
C) Une organisation horizontale de la prise en charge des patients ;	☐
D) <u>Recours aux soins selon la nature de la morbidité.</u>	☒

8) Les objectifs d'un système de santé sont :

A) <u>Améliorer l'efficacité ;</u>	☒
B) Assurer l'accès équitable et rationnel aux médicaments essentiels, vaccins et technologies de qualité ;	☐
C) <u>Améliorer la santé de population ;</u>	☒
D) <u>Répondre aux attentes des gens.</u>	☒

9) Dans la déclaration millénaire pour le développement :

A) 4 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
B) 2 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
C) 5 parmi 8 objectifs concernant directement la santé ;	☐
D) <u>Aucune réponse n'est juste.</u>	☒

10) L'objectif de l'économie de santé est de :

A) <u>Recherche la meilleure utilisation des ressources ;</u>	☒
B) Contrôler des agents économiques ;	☐
C) Faire des économies ;	☐
D) Diminuer les dépenses.	☐

11) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de :

A) 94,5 % ;	☐
B) 92,5 % ;	☐
C) 95,5 % ;	☐
D) <u>93,5 %.</u>	☒

12) La première cause de la mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les maladies transmissibles ;	☐
B) La tuberculose et les maladies respiratoires ;	☐
C) Les cancers ;	☐
D) <u>Les maladies cardio-vasculaires.</u>	☒

13) L'AMO est gérée par :

A) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur public ;	☐
B) La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale pour le secteur privé ;	☐
C) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur privé ;	☐
D) <u>La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale pour le secteur public.</u>	☒

14) Le réseau des établissement médico-sociaux comprend :

A) <u>Centre des soins palliatifs ;</u>	☒
B) <u>Centre d'addictologie ;</u>	☒
C) Centre de soins de suite et de convalescence ;	☐
D) <u>Espace « santé-jeunes ».</u>	☒

15) La circonscription sanitaire :

A) <u>Peut-être rurale ou urbaine ;</u>	☒
B) Correspond à l'aire de desserte d'un centre de santé ;	☐
C) <u>Peut-être découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;</u>	☒
D) <u>Représente le territoire de base dans le découpage sanitaire.</u>	☒

16) Le centre de santé rural du premier niveau :

A) <u>Est place sous la responsabilité d'un médecin généraliste ;</u>	☒
B) Est place sous la responsabilité d'un infirmier major ;	☐
C) <u>Est l'établissement de soins de santé primaire de premier contact en milieux rural ;</u>	☒
D) N'offre que les prestations de sante préventives et promotionnelles.	☐

17) En 2014 :

A) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 1000 naissances vivantes ;	☐
C) <u>L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans ;</u>	☒
D) Le taux de mortalité maternelle est de 112 décès/ 100.00 naissance vivantes.	☐

18) Lesquelles des structures suivantes ne font pas partie du secteur privé à but non lucratif :

A) <u>Les hôpitaux des Forces Armées Royales ;</u>	☒
B) Les établissements du croissant rouge marocain ;	☐
C) Les ligues et fondation ;	☐
D) <u>Les cliniques et cabinets médicaux.</u>	☒

19) Le premier financeur du RAMED est représenté par :

A) Les ménages ;	☐
B) Le Ministère de la Santé ;	☐
C) <u>L'Etat ;</u>	☒
D) Les collectivités locales.	☐

20) Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés :

A) En 9 services ;	☐
B) En 7 services ;	☐
C) En 6 services ;	☐
D) <u>En 8 services.</u>	☒

21) Lequel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) <u>Le plan stratégique provincial ;</u>	☒
B) Le budget programme ;	☐
C) Le plan stratégique régional ;	☐
D) Les plans d'effectifs.	☐

22) Lesquels des outils suivants ne font pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) <u>Le plan stratégique provincial ;</u>	☒
B) Le budget programme ;	☐
C) Le plan stratégique régional ;	☐
D) <u>Le pole des affaires professionnelles.</u>	☒

23) La source principale de financement du ministère de la santé est représentée par :

A) La coopération internationale ;	☐
B) <u>Le budget de l'Etat ;</u>	☒
C) Les ménages ;	☐
D) Les assurances et mutuelles.	☐

24) Le projet d'établissement hospitalier comprend entre autre les projets suivants :

A) <u>Projet technique ;</u>	☐
B) <u>Projet administratif ;</u>	☐
C) <u>Projet social ;</u>	☒
D) <u>Projet managérial.</u>	☒

25) La part la plus importante (47%) des dépenses du ministère de la santé en 2010 est allouée :

A) <u>Aux hôpitaux ;</u>	☒
B) <u>À l'administration centrale et locale ;</u>	☐
C) <u>Au Réseau de soins de santé de base (RSSB) ;</u>	☐
D) <u>Aux instituts, centres et laboratoires nationaux.</u>	☐

26) Le régime d'assistance médicale couvre des prestations médicalement requises suivants :

A) <u>Articles de prothèse et d'orthèse ;</u>	☒
B) <u>Les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale ;</u>	☒
C) <u>Les interventions de chirurgie plastique et esthétique ;</u>	☐
D) <u>Dispositions médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux.</u>	☒

27) La carte sanitaire est un outil législatif de :

A) <u>L'organisation des établissements de soins primaires ;</u>	☐
B) <u>L'organisation des services de soins ;</u>	☐
C) <u>L'organisation des établissements hospitaliers ;</u>	☐
D) <u>L'organisation de l'offre de soins.</u>	☒

28) Les missions des services des réseaux des établissements de santé sont :

A) <u>La coordination des activités du RISUM ;</u>	☒
B) <u>La coordination des activités des différents réseaux ;</u>	☐
C) <u>La mise en place des mesures nécessaires au respect de la filière des soins ;</u>	☐
D) <u>La planification, l'encadrement, la supervision, l'évaluation et le contrôle du RESSP.</u>	☒

29) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) 3 réseaux ;	☐
B) 6 réseaux ;	☐
C) 8 réseaux ;	☐
D) <u>Aucune réponse n'est juste.</u>	☒

30) Les services déconcentrés (extérieurs) du Ministère de la santé sont représentés par :

A) L'inspection Générale ;	☐
B) <u>Directions régionales de la santé ;</u>	☒
C) Secrétariat Général ;	☐
D) <u>Délégations Préfectorales ou provinciales.</u>	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - وجدة -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 09 دجنبر 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé sont au nombre de :

A) Quatre ;	☐
B) Six ;	☐
C) Huit ;	☐
D) Dix.	☐

2) En 2018, les régions sanitaires du Maroc sont au nombre de :

A) 16 ;	☐
B) 14 ;	☐
C) 12 ;	☐
D) 8.	☐

3) Au Maroc, le nombre de CHU est de :

A) Trois ;	☐
B) Quatre ;	☐
C) Cinq ;	☐
D) Six.	☐

4) Le texte régissant le corps des infirmiers et techniciens de santé prévoit des catégories de cadre qui sont au nombre de :

A) Deux ;	☐
B) Trois ;	☐
C) Quatre ;	☐
D) Cinq.	☐

5) Le cadre des infirmiers comprend les catégories suivantes :

A) Les infirmiers polyvalents ;	☐
B) Les infirmiers en psychiatrie ;	☐
C) Les sages-femmes ;	☐
D) Les techniciens de laboratoire.	☐

6) Le système de santé est constitué :

A) Des institutions seulement ;	☐
B) Des ressources ;	☐
C) Des actions ;	☐
D) Des institutions, des ressources et des actions.	☐

7) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de réseaux d'établissement de santé qui sont au nombre de :

A) Deux réseaux ;	☐
B) Trois réseaux ;	☐
C) Quatre réseaux ;	☐
D) Cinq réseaux.	☐

8) L'offre de soins comporte :

A) Des ressources humaines ;	☐
B) Des infrastructures sanitaires publiques ;	☐
C) Des infrastructures sanitaires publiques et privées ;	☐
D) Les moyens pour produire des prestations et des services.	☐

9) Le SROS signifie :

A) Service des réseaux des organisation sanitaire ;	☐
B) Schéma régional de l'offre de soins ;	☐
C) Schéma du réseau de l'organisation des services ;	☐
D) Service régional de l'offre des services.	☐

10) Le SROS est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins élaboré au niveau :

A) Provincial ;	☐
B) Régional ;	☐
C) Inter-régional ;	☐
D) National.	☐

11) Le SROS est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins établi :

A) Chaque année ;	☐
B) Chaque 2 ans ;	☐
C) Chaque 3 ans ;	☐
D) Chaque 5 ans.	☐

12) L'organisation de l'offre de soins au niveau d'une région s'effectue conformément :

A) Aux orientations de l'UNICF ;	☐
B) A la carte sanitaire ;	☐
C) Au SROS ;	☐
D) Au PEH.	☐

13) Les initiales du terme « PEH » signifie :

A) Programme des établissements hospitaliers ;	☐
B) Projet d'établissement hospitalier ;	☐
C) Projet d'économie hospitalier ;	☐
D) Programme d'évaluation des soins hospitaliers.	☐

14) Le PEH est un document obligatoire pour :

A) L'hôpital de proximité ;	☐
B) L'hôpital provincial ;	☐
C) L'hôpital régional ;	☐
D) Tous les hôpitaux publics.	☐

15) Le PEH est :

A) Un document qui définit le bilan des réalisations de l'hôpital ;	☐
B) Un outil de planification des ressources humains ;	☐
C) Un inventaire des équipements ;	☐
D) Un document qui définit les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical, des soins infirmiers de la formation, de la gestion et du système d'information.	☐

16) Le ou les établissements qui ne font pas partis du réseau des soins de santé primaires sont :

A) Le centre de soins palliatifs ;	☐
B) Le centre de santé urbain de 2ème niveau ;	☐
C) Le centre de référence de santé reproductive ;	☐
D) Les centres d'hémodialyse.	☐

17) Le ou les établissements qui font partis du réseau hospitalier sont :

A) Le centre d'hémodialyse ;	☐
B) Le centre de référence ;	☐
C) Le centre de transfusion sanguine ;	☐
D) Le centre de diagnostic.	☐

18) Les structures spécialisées d'appui au réseau des Etablissements des Soins de Santé primaires sont :

A) Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR) ;	☐
B) Les centres de diagnostic et de Traitement des Maladies respiratoires (CDTMR) ;	☐
C) Les laboratoires de santé publique (LSP) ;	☐
D) Le centre de soins palliatifs.	☐

19) Le CHU est un hôpital :

A) De proximité ;	☐
B) Régional ;	☐
C) Inter-régional ;	☐
D) National.	☐

20) Au Maroc, l'hôpital qui fournit les prestations d'urgence médicale hospitalière de base, de pédiatrie, d'obstétrique, de chirurgie générale et de médecine générale est un hôpital :

A) De proximité ;	☐
B) Régional ;	☐
C) Inter-régional ;	☐
D) National.	☐

21) On appelle prestation de l'hôpital du jour :

A) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée au niveau des urgences ;	☐
B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée avec hébergement ;	☐
C) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée sans hébergement ;	☐
D) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies 24 sur 24.	☐

22) On appelle ALD :

A) Appelle Légal Durable ;	☐
B) Affection de Longue Durée ;	☐
C) Accord Légal du Dépistage ;	☐
D) Association de Lutte contre le Diabète.	☐

23) Qu'appelle-on « ANAM » :

A) Agence nationale d'assurance maladie ;	☐
B) Agence nationale d'affection médicale ;	☐
C) Association nationale des affections mentales ;	☐
D) Assurance nationale des affections mentales.	☐

24) Selon le décret de 2015, le réseau hospitalier est composé de :

A) Des hôpitaux préfectoraux et provinciaux ;	☐
B) Des hôpitaux psychiatriques ;	☐
C) Des centres d'hémodialyse ;	☐
D) Des centres de référence pour la santé reproductive.	☐

25) L'opération « KARAMA » est l'une des réalisations du ministère de la santé au Maroc pour la période 2012 -2016, elle a consisté en :

A) La prise en charge des urgences médicales pré-hospitalières ;	☐
B) La couverture sanitaire des zones sinistrées par les intempéries et les zones enclavées ;	☐
C) La prise en charge de la santé mentale et psychiatrique ;	☐
D) La prise en charge des ALD.	☐

26) La prévention secondaire a pour objectif la réduction de :

A) L'incidence ;	☐
B) La prévalence ;	☐
C) Les effets néfastes de l'incapacité ;	☐
D) Les trois.	☐

27) Un dispositif de soins palliatifs est mis en place au Maroc pour la prise en charge des maladies atteints de :

A) Maladies mentales et psychiatriques ;	☐
B) Maladies cancéreuses ;	☐
C) Maladies de longues durées ;	☐
D) Maladies épidémiologiques.	☐

28) Les soins palliatifs sont fournis par :

A) Des médecins spécialistes ;	☐
B) Une équipe pluridisciplinaire ;	☐
C) De personnel infirmier seulement ;	☐
D) Des guérisseurs traditionnels.	☐

29) Parmi les hépatites suivantes, quelles sont celles transmises par le sang :

A) Hépatite A ;	☐
B) Hépatite B ;	☐
C) Hépatite C ;	☐
D) Hépatite E.	☐

30) L'espérance de vie à la naissance au Maroc est de :

A) 60 ans ;	☐
B) 65 ans ;	☐
C) 70 ans ;	☐
D) 75 ans.	☐

31) L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2015 est de :

A) Un ;	☐
B) Deux ;	☐
C) Trois ;	☐
D) Quatre.	☐

32) L'accouchement en milieu surveillé est celui qui survient dans :

A) Les CHU ;	☐
B) Les cliniques privées ;	☐
C) Toutes les structures de santé ;	☐
D) A domicile.	☐

33) Dans le cadre de la stratégie nationale de nutrition, le ministère de la santé a organisé la semaine nationale de promotion de l'allaitement maternel, dont laquelle l'OMS et l'UNICEF ont recommandé :

A) La mise au sein précoce ;	☐
B) L'alimentation diversifiée durant les 6 premiers mois ;	☐
C) L'usage des biberons et des tétines ;	☐
D) L'allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers mois.	☐

34) Le premier cancer au Maroc est :

A) Le cancer des poumons ;	☐
B) Le cancer de la prostate ;	☐
C) Le cancer du sein ;	☐
D) Le cancer de l'ovaire.	☐

35) Le ministère de la santé à l'instar de nombreux pays dans le monde, a lancé du 22 Octobre au 22 Novembre 2018, une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage sous le slogan « faites-vous dépister ... N'hésitez-pas ! » cette campagne intéresse :

A) La tuberculose pulmonaire ;	☐
B) Le cancer du sein ;	☐
C) L'insuffisance rénale;	☐
D) La cataracte.	☐

36) Les maladies cibles de la vaccination au Maroc sont :

A) La diarrhée ;	☐
B) La rougeole ;	☐
C) L'hépatite virale C ;	☐
D) La tuberculose.	☐

37) Les vaccinations préconisées durant le premier mois aux enfants au Maroc :

A) BCG ;	☐
B) VPO ;	☐
C) DTC ;	☐
D) HBN.	☐

38) La première cause de mortalité générale au Maroc est :

A) L'empoisonnement ;	☐
B) Les maladies de l'appareil circulatoire ;	☐
C) Les maladies infectieuses ;	☐
D) Les maladies digestives.	☐

39) On appelle infection nosocomiale :

A) Une infection d'origine nasale ;	☐
B) Une infection dont le malade est déjà porteur lors de son hospitalisation ;	☐
C) Une infection absente à l'entrée du patient qui apparaît au moins 48h après l'admission ;	☐
D) Une infection véhiculée en permanence par la population.	☐

40) Le conseil d'administration est un organe de gestion des :

A) Hôpitaux provinciaux ;	☐
B) Hôpitaux régionaux ;	☐
C) CHU ;	☐
D) Aucune réponse.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - وجدة -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 09 دجنبر 2018)

Correction proposée :

- 1) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé sont au nombre de :

A) Quatre ;	☐
B) Six ;	☐
C) <u>Huit</u> ;	☒
D) Dix.	☐

- 2) En 2018, les régions sanitaires du Maroc sont au nombre de :

A) 16 ;	☐
B) 14 ;	☐
C) <u>12</u> ;	☒
D) 8.	☐

- 3) Au Maroc, le nombre de CHU est de :

A) Trois ;	☐
B) Quatre ;	☐
C) <u>Cinq</u> ;	☒
D) Six.	☐

- 4) Le texte régissant le corps des infirmiers et techniciens de santé prévoit des catégories de cadre qui sont au nombre de :

A) Deux ;	☐
B) Trois ;	☐
C) Quatre ;	☐
D) <u>Cinq</u> .	☒

5) Le cadre des infirmiers comprend les catégories suivantes :

A) <u>Les infirmiers polyvalents ;</u>	☒
B) <u>Les infirmiers en psychiatrie ;</u>	☒
C) Les sages-femmes ;	☐
D) Les techniciens de laboratoire.	☐

6) Le système de santé est constitué :

A) Des institutions seulement ;	☐
B) Des ressources ;	☐
C) Des actions ;	☐
D) <u>Des institutions, des ressources et des actions.</u>	☒

7) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de réseaux d'établissement de santé qui sont au nombre de :

A) Deux réseaux ;	☐
B) Trois réseaux ;	☐
C) <u>Quatre réseaux ;</u>	☒
D) Cinq réseaux.	☐

8) L'offre de soins comporte :

A) <u>Des ressources humaines ;</u>	☒
B) Des infrastructures sanitaires publiques ;	☐
C) <u>Des infrastructures sanitaires publiques et privées ;</u>	☒
D) <u>Les moyens pour produire des prestations et des services.</u>	☒

9) Le SROS signifie :

A) Service des réseaux des organisation sanitaire ;	☐
B) <u>Schéma régional de l'offre de soins ;</u>	☒
C) Schéma du réseau de l'organisation des services ;	☐
D) Service régional de l'offre des services.	☐

10) Le SROS est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins élaboré au niveau :

A) Provincial ;	☐
B) <u>Régional ;</u>	☒
C) Inter-régional ;	☐
D) National.	☐

11) Le SROS est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins établi :

A) Chaque année ;	☐
B) Chaque 2 ans ;	☐
C) Chaque 3 ans ;	☐
D) <u>Chaque 5 ans.</u>	☒

12) L'organisation de l'offre de soins au niveau d'une région s'effectue conformément :

A) Aux orientations de l'UNICF ;	☐
B) <u>A la carte sanitaire ;</u>	☒
C) <u>Au SROS ;</u>	☒
D) Au PEH.	☐

13) Les initiales du terme « PEH » signifie :

A) Programme des établissements hospitaliers ;	☐
B) <u>Projet d'établissement hospitalier ;</u>	☒
C) Projet d'économie hospitalier ;	☐
D) Programme d'évaluation des soins hospitaliers.	☐

14) Le PEH est un document obligatoire pour :

A) L'hôpital de proximité ;	☐
B) L'hôpital provincial ;	☐
C) L'hôpital régional ;	☐
D) <u>Tous les hôpitaux publics.</u>	☒

15) Le PEH est :

A) <u>Un document qui définit le bilan des réalisations de l'hôpital ;</u>	☒
B) <u>Un outil de planification des ressources humains ;</u>	☒
C) <u>Un inventaire des équipements ;</u>	☒
D) <u>Un document qui définit les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical, des soins infirmiers de la formation, de la gestion et du système d'information.</u>	☒

16) Le ou les établissements qui ne font pas partis du réseau des soins de santé primaires sont :

A) <u>Le centre de soins palliatifs ;</u>	☒
B) Le centre de santé urbain de 2 ^{ème} niveau ;	☐
C) <u>Le centre de référence de santé reproductive ;</u>	☒
D) <u>Les centres d'hémodialyse.</u>	☒

17) Le ou les établissements qui font partis du réseau hospitalier sont :

A) <u>Le centre d'hémodialyse ;</u>	☒
B) Le centre de référence ;	☐
C) Le centre de transfusion sanguine ;	☐
D) Le centre de diagnostic.	☐

18) Les structures spécialisées d'appui au réseau des Etablissements des Soins de Santé primaires sont :

A) <u>Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR) ;</u>	☒
B) <u>Les centres de diagnostic et de Traitement des Maladies respiratoires (CDTMR) ;</u>	☒
C) <u>Les laboratoires de santé publique (LSP) ;</u>	☒
D) Le centre de soins palliatifs.	☐

19) Le CHU est un hôpital :

A) De proximité ;	☐
B) Régional ;	☐
C) <u>Inter-régional ;</u>	☒
D) <u>National.</u>	☒

20) Au Maroc, l'hôpital qui fournit les prestations d'urgence médicale hospitalière de base, de pédiatrie, d'obstétrique, de chirurgie générale et de médecine générale est un hôpital :

A) <u>De proximité ;</u>	☒
B) Régional ;	☐
C) Inter-régional ;	☐
D) National.	☐

21) On appelle prestation de l'hôpital du jour :

A) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée au niveau des urgences ;	☐
B) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée avec hébergement ;	☐
C) <u>Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée sans hébergement ;</u>	☒
D) Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies 24 sur 24.	☐

22) On appelle ALD :

A) Appelle Légal Durable ;	☐
B) <u>Affection de Longue Durée ;</u>	☒
C) Accord Légal du Dépistage ;	☐
D) Association de Lutte contre le Diabète.	☐

23) Qu'appelle-on « ANAM » :

A) <u>Agence nationale d'assurance maladie ;</u>	☒
B) Agence nationale d'affection médicale ;	☐
C) Association nationale des affections mentales ;	☐
D) Assurance nationale des affections mentales.	☐

24) Selon le décret de 2015, le réseau hospitalier est composé de :

A) <u>Des hôpitaux préfectoraux et provinciaux ;</u>	☒
B) <u>Des hôpitaux psychiatriques ;</u>	☒
C) <u>Des centres d'hémodialyse ;</u>	☒
D) Des centres de référence pour la santé reproductive.	☐

25) L'opération « KARAMA » est l'une des réalisations du ministère de la santé au Maroc pour la période 2012 -2016, elle a consisté en :

A) La prise en charge des urgences médicales pré-hospitalières ;	☐
B) La couverture sanitaire des zones sinistrées par les intempéries et les zones enclavées ;	☐
C) <u>La prise en charge de la santé mentale et psychiatrique ;</u>	☒
D) La prise en charge des ALD.	☐

26) La prévention secondaire a pour objectif la réduction de :

A) L'incidence ;	☐
B) <u>La prévalence ;</u>	☒
C) Les effets néfastes de l'incapacité ;	☐
D) Les trois.	☐

27) Un dispositif de soins palliatifs est mis en place au Maroc pour la prise en charge des maladies atteints de :

A) Maladies mentales et psychiatriques ;	☐
B) <u>Maladies cancéreuses ;</u>	☒
C) Maladies de longues durées ;	☐
D) Maladies épidémiologiques.	☐

28) Les soins palliatifs sont fournis par :

A) Des médecins spécialistes ;	☐
B) <u>Une équipe pluridisciplinaire ;</u>	☒
C) De personnel infirmier seulement ;	☐
D) Des guérisseurs traditionnels.	☐

29) Parmi les hépatites suivantes, quelles sont celles transmises par le sang :

A) Hépatite A ;	☐
B) <u>Hépatite B ;</u>	☒
C) <u>Hépatite C ;</u>	☒
D) Hépatite E.	☐

30) L'espérance de vie à la naissance au Maroc est de :

A) 60 ans ;	☐
B) 65 ans ;	☐
C) 70 ans ;	☐
D) <u>75 ans.</u>	☒

31) L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2015 est de :

A) Un ;	☐
B) <u>Deux ;</u>	☒
C) Trois ;	☐
D) Quatre.	☐

32) L'accouchement en milieu surveillé est celui qui survient dans :

A) <u>Les CHU ;</u>	☒
B) <u>Les cliniques privées ;</u>	☒
C) Toutes les structures de santé ;	☐
D) A domicile.	☐

33) Dans le cadre de la stratégie nationale de nutrition, le ministère de la santé a organisé la semaine nationale de promotion de l'allaitement maternel, dont laquelle l'OMS et l'UNICEF ont recommandé :

A) <u>La mise au sein précoce ;</u>	☒
B) L'alimentation diversifiée durant les 6 premiers mois ;	☐
C) L'usage des biberons et des tétines ;	☐
D) <u>L'allaitement exclusif au sein durant les 6 premiers mois.</u>	☒

34) Le premier cancer au Maroc est :

A) Le cancer des poumons ;	☐
B) Le cancer de la prostate ;	☐
C) <u>Le cancer du sein ;</u>	☒
D) Le cancer de l'ovaire.	☐

35) Le ministère de la santé à l'instar de nombreux pays dans le monde, a lancé du 22 Octobre au 22 Novembre 2018, une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage sous le slogan « faites-vous dépister ... N'hésitez-pas ! » cette campagne intéresse :

A) La tuberculose pulmonaire ;	☐
B) <u>Le cancer du sein ;</u>	☒
C) L'insuffisance rénale;	☐
D) La cataracte.	☐

36) Les maladies cibles de la vaccination au Maroc sont :

A) La diarrhée ;	☐
B) <u>La rougeole ;</u>	☒
C) L'hépatite virale C ;	☐
D) <u>La tuberculose.</u>	☒

37) Les vaccinations préconisées durant le premier mois aux enfants au Maroc :

A) <u>BCG.;</u>	☒
B) <u>VPO.;</u>	☒
C) DTC ;	☐
D) <u>HBN.</u>	☒

38) La première cause de mortalité générale au Maroc est :

A) L'empoisonnement ;	☐
B) <u>Les maladies de l'appareil circulatoire ;</u>	☒
C) Les maladies infectieuses ;	☐
D) Les maladies digestives.	☐

39) On appelle infection nosocomiale :

A) Une infection d'origine nasale ;	☐
B) Une infection dont le malade est déjà porteur lors de son hospitalisation ;	☐
C) <u>Une infection absente à l'entrée du patient qui apparait au moins 48h après l'admission ;</u>	☒
D) Une infection véhiculée en permanence par la population.	☐

40) Le conseil d'administration est un organe de gestion des :

A) Hôpitaux provinciaux ;	☐
B) Hôpitaux régionaux ;	☐
C) <u>CHU</u> ;	☒
D) Aucune réponse.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - مراكش -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 25 نونبر 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les objectifs d'un système de santé visent :

A) La définition des priorités sanitaires nationales ;	☐
B) L'identification des besoins sanitaires de la population ;	☐
C) L'élaboration de la stratégie sectorielle.	☐

2) Le taux de mortalité infantile au Maroc est de :

A) 28,4 pour 1000 naissances vivantes ;	☐
B) 28,6 pour 1000 naissances vivantes ;	☐
C) 28,8 pour 1000 naissances vivantes.	☐

3) Les principes fondamentaux du système de Santé au Maroc concourent essentiellement à :

A) Allonger l'espérance de vie des citoyens ;	☐
B) Améliorer la qualité de vie des citoyens ;	☐
C) Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays ;	☐

4) Les bénéficiaires d'une gratuité partielle du RAMED représentent :

A) 4,2 millions de personnes en situation de vulnérabilité ;	☐
B) 4,4 millions de personnes en situation de vulnérabilité ;	☐
C) 4,5 millions de personnes en situation de vulnérabilité.	☐

5) La naissance du système de santé au Maroc a eu lieu :

A) En avril 1958 ;	☐
B) En avril 1959 ;	☐
C) En avril 1960.	☐

6) La naissance et le développement du système de santé au Maroc a connu :

A) Deux grandes périodes ;	☐
B) Quatre grandes périodes ;	☐
C) Trois grandes périodes ;	☐

7) Le terme « santé » peut être défini comme étant :

A) Un état complet de bien-être physique, mental et social ;	☐
B) Un état dynamique de bien-être physique, mental, spirituel et social ;	☐
C) Un état d'équilibre et d'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine.	☐

8) Les systèmes de santé existent à travers le monde :

A) Le système de prévoyance sociale et de solidarité nationale ;	☐
B) Le système de service national de santé ;	☐
C) Le système d'assistance publique ;	☐
D) Le système d'assurance maladie.	☐

9) L'accessibilité aux soins peut être de plusieurs ordres, lesquels :

A) Culturelle et fonctionnelle ;	☐
B) Physique et économique ;	☐
C) Réglementaire et organisationnelle.	☐

10) L'implication de la couverture sanitaire signifie :

A) Une accessibilité à ce service ;	☐
B) Une disponibilité du service ;	☐
C) Une utilisation effective du service.	☐

11) Il serait impossible de formuler un plan national de santé sans tenir compte de certaines priorités, lesquelles :

A) La priorité de certaines régions de pays ;	☐
B) La priorité de certains groupes sociaux ou groupe d'âge ;	☐
C) La priorité de certains secteurs publics et problèmes ;	☐
D) La priorité de solidarité nationale et de prévoyance sociale.	☐

12) La couverture médicale s'articule autour des axes suivants :

A) La couverture médicale complémentaire ;	☐
B) La couverture médicale de base ;	☐
C) La couverture médicale sociale et de solidarité nationale.	☐

13) La 1^{ère} conférence nationale sur la santé a eu lieu :

A) En avril 1958 ;	☐
B) En avril 1959 ;	☐
C) En avril 1960.	☐

14) Les bénéficiaires éligibles de facto représentent :

A) 159.000 personnes ;	☐
B) 160.000 personnes ;	☐
C) 161.000 personnes.	☐

15) Un système de santé remplit quatre fonctions principales :

A) Culturelle et fonctionnelle ;	☐
B) Organisationnelle et prestataire ;	☐
C) Réglementaire et financière.	☐

16) En vue de promouvoir la santé, le système de santé doit être :

A) Accessible, acceptable et équitable ;	☐
B) Global, efficace et efficient ;	☐
C) Planifiable, évaluable et modifiable.	☐

17) En 2012, le coût du RAMED pour l'Etat est d'environ :

A) 3,0 milliards de dirhams ;	☐
B) 3,3 milliards de dirhams ;	☐
C) 3,5 milliards de dirhams.	☐

18) Le taux de mortalité maternelle au Maroc est de :

A) 109 pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
B) 110 pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
C) 12 pour 100 000 naissances vivantes.	☐

19) L'organisation et le développement du système de santé au Maroc permet :

A) L'amélioration des conditions psychophysiques et socioéconomiques individuelles et collectives ;	☐
B) L'amélioration du bien-être individuel et collectif ;	☐
C) L'augmentation de la productibilité.	☐

20) Le Ministère de la Santé au Maroc a défini les actions du système de santé pour :

A) Améliorer le bien-être physique, mental et social des individus et des collectivités ;	☐
B) Produire des prestations de qualité ;	☐
C) Réduire les disparités régionales en matière de la couverture sanitaire.	☐

21) L'AMO (assurance maladie obligatoire) est gérée par :

A) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;	☐
B) La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ;	☐
C) Le RAMED (Régime d'assistance médicale aux économiquement démunies).	☐

22) L'AMO (assurance maladie obligatoire) est instauré au profit :

A) Des pensionnés des secteurs public et privé ;	☐
B) Des personnes démunies non couvertes par un régime ;	☐
C) Des salariés actifs des secteurs publics et privés.	☐

23) La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base (AMO et RAMED), que permet-elle :

A) L'amélioration de l'accès aux soins ;	☐
B) L'amélioration du financement de la santé ;	☐
C) La gratuité des soins ;	☐
D) La réduction de la contribution directe des ménages.	☐

24) Combien de système de santé existe-t-il à travers le monde :

A) Deux types de systèmes de santé ;	☐
B) Quatre types de systèmes de santé ;	☐
C) Trois types de système de santé.	☐

25) L'objectif final de la santé publique étant :

A) D'assurer à la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de sa santé ;	☐
B) D'organiser les services médicaux et infirmiers en vue de diagnostic et de traitement des maladies ;	☐
C) De permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et la longévité.	☐

26) Par le moyen d'une action collective concertée la santé publique vise :

A) La lutte contre les maladies qui présentent une incidence sociale ;	☐
B) L'assainissement du milieu ;	☐
C) L'enseignement à l'individu des règles d'asepsie d'antisepsie.	☐

27) La carte sanitaire constitue le cadre légal du développement du système national de santé. Elle doit :

A) Avoir un aspect accréditatif ;	☐
B) Avoir un aspect descriptif ;	☐
C) Avoir un aspect prospectif.	☐

28) La dépense de l'Etat dans le financement de la santé en 2010 était de :

A) 44,4 % ;	☐
B) 48,4 % ;	☐
C) 50,4 %.	☐

29) Parmi les principes suivants, quels sont ceux pris pour la réalisation des objectifs fondamentaux de la santé :

A) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;	☐
B) La globalité et la gradation des soins ;	☐
C) La responsabilité de l'Etat de la santé de population.	☐

30) La démographie marocaine se caractérise par une population très jeune :

A) Environ 27% de la population à moins de 15 ans ;	☐
B) Environ 28% de la population à moins de 15 ans ;	☐
C) Environ 29% de la population à moins de 15 ans.	☐

31) Pour le secteur privé, l'organisme gestionnaire de l'AMO (Assurance Maladie Obligatoire) est :

A) L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie) ;	☐
B) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale) ;	☐
C) La CNSS (Caisse Nationale de la sécurité sociale).	☐

32) À l'issue de la 1ère conférence nationale sur la santé, deux déclarations ont eu lieu, lesquelles ?

A) La santé de la nation incombe à l'Etat et à la société ;	☐
B) « La santé de la nation incombe à l'Etat » ;	☐
C) « Le Ministère de la santé publique doit assurer la conception et la réalisation du système de santé ».	☐

33) Pour le secteur public, l'organisme gestionnaire de l'AMO (assurance maladie obligatoire) est :

A) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;	☐
B) L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie) ;	☐
C) La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).	☐

34) La dépense globale de santé (DGS) en 2010 est de :

A) 46,8 milliards de Dirhams ;	☐
B) 47,8 milliards de Dirhams ;	☐
C) 48,8 milliards de Dirhams.	☐

35) Le RAMED (Régime d'Assistance Médicale aux économiquement Démunis) concerne :

A) 27,7 % de la population marocaine ;	☐
B) 28,0 % de la population marocaine ;	☐
C) 82,2 % de la population marocaine.	☐

36) La répartition de la population Marocaine par milieu est de :

A) 42% en milieu rural ;	☐
B) 43% en milieu urbain ;	☐
C) 57% en milieu rural ;	☐
D) 58% en milieu urbain.	☐

37) Les plans opérationnels de développement qui se sont succédés ont eu comme priorité :

A) La formation médicale et infirmière et l'organisation de l'offre de soins ;	☐
B) La lutte contre les épidémies ;	☐
C) La stratégie de couverture sanitaire.	☐

38) La santé publique peut être définie comme étant :

A) Un art d'améliorer la santé ;	☐
B) Une démarche de prolonger la vie ;	☐
C) Une science de prévenir les maladies.	☐

39) Pour le RAMED, l'organisme gestionnaire est :

A) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;	☐
B) La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ;	☐
C) L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie).	☐

40) L'allongement de l'espérance de vie au Maroc est de :

A) 73,9 ans pour le sexe féminin ;	☐
B) 74,8 ans en moyenne ;	☐
C) 75,6 pour le sexe masculin.	☐

41) La santé est un état d'équilibre qui exige la satisfaction des besoins fondamentaux et l'ajustement à l'environnement. Quel abord peut-on donner à cette définition :

A) Un abord d'adaptation ;	☐
B) Un abord fonctionnel ;	☐
C) Un abord perceptuel.	☐

42) Dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, le système de santé adopté est :

A) Le système de prévoyance sociale et de solidarité nationale ;	☐
B) Le système de service national de santé ;	☐
C) Le système d'assistance publique ;	☐
D) Le système d'assurance maladie.	☐

43) Pour atteindre ses objectifs, le système de santé doit :

A) Développer une politique de recherche sanitaire ;	☐
B) Planifier l'offre de soins ;	☐
C) Surveiller et évaluer l'efficacité et l'efficacité du système.	☐

44) Les bénéficiaires d'une gratuité totale du RAMED représentent :

A) 4,0 millions de personnes en situation de pauvreté ;	☐
B) 4,1 millions de personnes en situation de pauvreté ;	☐
C) 4,2 millions de personnes en situation de pauvreté.	☐

45) Le service de santé est un service public qui peut être défini comme :

A) Une activité assurée par une collectivité publique ;	☐
B) Une activité d'intérêt général ;	☐
C) Une activité soumise à un régime juridique spécial.	☐

46) La population Marocaine est de :

A) 33,8 millions d'habitants ;	☐
B) 94,2 millions d'habitants ;	☐
C) 34,6 millions d'habitants.	☐

47) Combien de plan opérationnel de développement se sont succédés après cette 1ère conférence :

A) Cinq plans opérationnels de développement se sont succédés ;	☐
B) Quatre plans opérationnels de développement se sont succédés ;	☐
C) Trois plans opérationnels de développement se sont succédés.	☐

48) La population mondiale couverte par le système d'assurance maladie est de :

A) 17% ;	☐
B) 18% ;	☐
C) 19%.	☐

49) La dépense des ménages dans le financement de la santé en 2010 était de :

A) 49,6 % ;	☐
B) 50,6% ;	☐
C) 51,6%.	☐

50) L'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 0,2 enfants par femme ;	☐
B) 2.1 enfants par femme ;	☐
C) 2,2 enfants par femme ;	☐
D) 2,3 enfants par femme.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس - مراكش

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 25 نونبر 2018)

Correction proposée :

1) Les objectifs d'un système de santé visent :

A) La définition des priorités sanitaires nationales ;	☒
B) L'identification des besoins sanitaires de la population ;	☒
C) L'élaboration de la stratégie sectorielle.	☒

2) Le taux de mortalité infantile au Maroc est de :

A) 28,4 pour 1000 naissances vivantes ;	☐
B) 28,6 pour 1000 naissances vivantes ;	☐
C) 28,8 pour 1000 naissances vivantes.	☒

3) Les principes fondamentaux du système de Santé au Maroc concourent essentiellement à :

A) Allonger l'espérance de vie des citoyens ;	☐
B) Améliorer la qualité de vie des citoyens ;	☒
C) Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays ;	☐

4) Les bénéficiaires d'une gratuité partielle du RAMED représentent :

A) 4,2 millions de personnes en situation de vulnérabilité ;	☐
B) 4,4 millions de personnes en situation de vulnérabilité ;	☐
C) 4,5 millions de personnes en situation de vulnérabilité.	☒

5) La naissance du système de santé au Maroc a eu lieu :

A) En avril 1958 ;	☐
B) En avril 1959 ;	☒
C) En avril 1960.	☐

6) La naissance et le développement du système de santé au Maroc a connu :

A) Deux grandes périodes ;	☐
B) Quatre grandes périodes ;	☐
C) <u>Trois grandes périodes ;</u>	☒

7) Le terme « santé » peut être défini comme étant :

A) <u>Un état complet de bien-être physique, mental et social ;</u>	☒
B) Un état dynamique de bien-être physique, mental, spirituel et social ;	☐
C) Un état d'équilibre et d'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine.	☐

8) Les systèmes de santé existent à travers le monde :

A) Le système de prévoyance sociale et de solidarité nationale ;	☐
B) <u>Le système de service national de santé ;</u>	☒
C) <u>Le système d'assistance publique ;</u>	☒
D) <u>Le système d'assurance maladie.</u>	☒

9) L'accessibilité aux soins peut être de plusieurs ordres, lesquels :

A) Culturelle et fonctionnelle ;	☐
B) <u>Physique et économique ;</u>	☒
C) <u>Réglementaire et organisationnelle.</u>	☒

10) L'implication de la couverture sanitaire signifie :

A) <u>Une accessibilité à ce service ;</u>	☒
B) Une disponibilité du service ;	☐
C) Une utilisation effective du service.	☐

11) Il serait impossible de formuler un plan national de santé sans tenir compte de certaines priorités, lesquelles :

A) <u>La priorité de certaines régions de pays ;</u>	☒
B) <u>La priorité de certains groupes sociaux ou groupe d'âge ;</u>	☒
C) <u>La priorité de certains secteurs publics et problèmes ;</u>	☒
D) <u>La priorité de solidarité nationale et de prévoyance sociale.</u>	☒

12) La couverture médicale s'articule autour des axes suivants :

A) La couverture médicale complémentaire ;	☐
B) <u>La couverture médicale de base ;</u>	☒
C) <u>La couverture médicale sociale et de solidarité nationale.</u>	☒

13) La 1^{ère} conférence nationale sur la santé a eu lieu :

A) En avril 1958 ;	☐
B) <u>En avril 1959 ;</u>	☒
C) En avril 1960.	☐

14) Les bénéficiaires éligibles de facto représentent :

A) 159.000 personnes ;	☐
B) <u>160.000 personnes ;</u>	☒
C) 161.000 personnes.	☐

15) Un système de santé remplit quatre fonctions principales :

A) Culturelle et fonctionnelle ;	☐
B) <u>Organisationnelle et prestataire ;</u>	☒
C) <u>Réglementaire et financière.</u>	☒

16) En vue de promouvoir la santé, le système de santé doit être :

A) <u>Accessible, acceptable et équitable ;</u>	☒
B) Global, efficace et efficient ;	☐
C) <u>Planifiable, évaluable et modifiable.</u>	☒

17) En 2012, le coût du RAMED pour l'Etat est d'environ :

A) <u>3,0 milliards de dirhams ;</u>	☒
B) 3,3 milliards de dirhams ;	☐
C) 3,5 milliards de dirhams.	☐

18) Le taux de mortalité maternelle au Maroc est de :

A) 109 pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
B) 110 pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
C) <u>12 pour 100 000 naissances vivantes.</u>	☒

19) L'organisation et le développement du système de santé au Maroc permet :

A) <u>L'amélioration des conditions psychophysiques et socioéconomiques individuelles et collectives ;</u>	☒
B) <u>L'amélioration du bien-être individuel et collectif ;</u>	☒
C) L'augmentation de la productibilité.	☐

20) Le Ministère de la Santé au Maroc a défini les actions du système de santé pour :

A) <u>Améliorer le bien-être physique, mental et social des individus et des collectivités ;</u>	☒
B) <u>Produire des prestations de qualité ;</u>	☒
C) <u>Réduire les disparités régionales en matière de la couverture sanitaire.</u>	☒

21) L'AMO (assurance maladie obligatoire) est gérée par :

A) <u>La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;</u>	☒
B) <u>La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ;</u>	☒
C) Le RAMED (Régime d'assistance médicale aux économiquement démunies).	☐

22) L'AMO (assurance maladie obligatoire) est instauré au profit :

A) <u>Des pensionnés des secteurs public et privé ;</u>	☒
B) Des personnes démunies non couvertes par un régime ;	☐
C) <u>Des salariés actifs des secteurs publics et privés.</u>	☒

23) La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base (AMO et RAMED), que permet-elle :

A) <u>L'amélioration de l'accès aux soins ;</u>	☒
B) L'amélioration du financement de la santé ;	☐
C) <u>La gratuité des soins ;</u>	☒
D) La réduction de la contribution directe des ménages.	☐

24) Combien de système de santé existe-t-il à travers le monde :

A) Deux types de systèmes de santé ;	☐
B) Quatre types de systèmes de santé ;	☐
C) <u>Trois types de système de santé.</u>	☒

25) L'objectif final de la santé publique étant :

A) D'assurer à la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de sa santé ;	☐
B) <u>D'organiser les services médicaux et infirmiers en vue de diagnostic et de traitement des maladies ;</u>	☒
C) De permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et la longévité.	☐

26) Par le moyen d'une action collective concertée la santé publique vise :

A) <u>La lutte contre les maladies qui présentent une incidence sociale ;</u>	☒
B) <u>L'assainissement du milieu ;</u>	☒
C) L'enseignement à l'individu des règles d'asepsie d'antisepsie.	☐

27) La carte sanitaire constitue le cadre légal du développement du système national de santé. Elle doit :

A) Avoir un aspect accréditatif ;	☐
B) Avoir un aspect descriptif ;	☐
C) <u>Avoir un aspect prospectif.</u>	☒

28) La dépense de l'Etat dans le financement de la santé en 2010 était de :

A) <u>44,4 % ;</u>	☒
B) 48,4 % ;	☐
C) 50,4 %.	☐

29) Parmi les principes suivants, quels sont ceux pris pour la réalisation des objectifs fondamentaux de la santé :

A) <u>L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;</u>	☒
B) <u>La globalité et la gradation des soins ;</u>	☒
C) La responsabilité de l'Etat de la santé de population.	☐

30) La démographie marocaine se caractérise par une population très jeune :

A) Environ 27% de la population à moins de 15 ans ;	☐
B) <u>Environ 28% de la population à moins de 15 ans ;</u>	☒
C) Environ 29% de la population à moins de 15 ans.	☐

31) Pour le secteur privé, l'organisme gestionnaire de l'AMO (Assurance Maladie Obligatoire) est :

A) L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie) ;	☐
B) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale) ;	☐
C) <u>La CNSS (Caisse Nationale de la sécurité sociale).</u>	☒

32) À l'issue de la 1ère conférence nationale sur la santé, deux déclarations ont eu lieu, lesquelles ?

A) La santé de la nation incombe à l'Etat et à la société ;	☐
B) <u>« La santé de la nation incombe à l'Etat » ;</u>	☒
C) <u>« Le Ministère de la santé publique doit assurer la conception et la réalisation du système de santé ».</u>	☒

33) Pour le secteur public, l'organisme gestionnaire de l'AMO (assurance maladie obligatoire) est :

A) <u>La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;</u>	☒
B) L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie) ;	☐
C) La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).	☐

34) La dépense globale de santé (DGS) en 2010 est de :

A) 46,8 milliards de Dirhams ;	☐
B) <u>47,8 milliards de Dirhams ;</u>	☒
C) 48,8 milliards de Dirhams.	☐

35) Le RAMED (Régime d'Assistance Médicale aux économiquement Démunis) concerne :

A) 27,7 % de la population marocaine ;	☐
B) <u>28,0 % de la population marocaine ;</u>	☒
C) 82,2 % de la population marocaine.	☐

36) La répartition de la population Marocaine par milieu est de :

A) <u>42% en milieu rural ;</u>	☒
B) 43% en milieu urbain ;	☐
C) 57% en milieu rural ;	☐
D) <u>58% en milieu urbain.</u>	☒

37) Les plans opérationnels de développement qui se sont succédés ont eu comme priorité :

A) La formation médicale et infirmière et l'organisation de l'offre de soins ;	☐
B) <u>La lutte contre les épidémies ;</u>	☒
C) La stratégie de couverture sanitaire.	☐

38) La santé publique peut être définie comme étant :

A) <u>Un art d'améliorer la santé ;</u>	☒
B) <u>Une démarche de prolonger la vie ;</u>	☒
C) <u>Une science de prévenir les maladies.</u>	☒

39) Pour le RAMED, l'organisme gestionnaire est :

A) La CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale) ;	☐
B) La CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ;	☐
C) <u>L'ANAM (Agence Nationale de l'Assurance Maladie).</u>	☒

40) L'allongement de l'espérance de vie au Maroc est de :

A) 73,9 ans pour le sexe féminin ;	☐
B) <u>74,8 ans en moyenne ;</u>	☒
C) 75,6 pour le sexe masculin.	☐

41) La santé est un état d'équilibre qui exige la satisfaction des besoins fondamentaux et l'ajustement à l'environnement. Quel abord peut-on donner à cette définition :

A) <u>Un abord d'adaptation ;</u>	☒
B) Un abord fonctionnel ;	☐
C) Un abord perceptuel.	☐

42) Dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, le système de santé adopté est :

A) Le système de prévoyance sociale et de solidarité nationale ;	☐
B) Le système de service national de santé ;	☐
C) Le système d'assistance publique ;	☐
D) <u>Le système d'assurance maladie.</u>	☒

43) Pour atteindre ses objectifs, le système de santé doit :

A) <u>Développer une politique de recherche sanitaire ;</u>	☒
B) <u>Planifier l'offre de soins ;</u>	☒
C) <u>Surveiller et évaluer l'efficacité et l'efficience du système.</u>	☒

44) Les bénéficiaires d'une gratuité totale du RAMED représentent :

A) <u>4,0 millions de personnes en situation de pauvreté ;</u>	☒
B) 4,1 millions de personnes en situation de pauvreté ;	☐
C) 4,2 millions de personnes en situation de pauvreté.	☐

45) Le service de santé est un service public qui peut être défini comme :

A) <u>Une activité assurée par une collectivité publique ;</u>	☒
B) <u>Une activité d'intérêt général ;</u>	☒
C) <u>Une activité soumise à un régime juridique spécial.</u>	☒

46) La population Marocaine est de :

A) <u>33,8 millions d'habitants ;</u>	☒
B) 94,2 millions d'habitants ;	☐
C) 34,6 millions d'habitants.	☐

47) Combien de plan opérationnel de développement se sont succédés après cette 1ère conférence :

A) <u>Cinq plans opérationnels de développement se sont succédés ;</u>	☒
B) Quatre plans opérationnels de développement se sont succédés ;	☐
C) Trois plans opérationnels de développement se sont succédés.	☐

48) La population mondiale couverte par le système d'assurance maladie est de :

A) 17% ;	☐
B) 18% ;	☐
C) <u>19%.</u>	☒

49) La dépense des ménages dans le financement de la santé en 2010 était de :

A) 49,6 % ;	☐
B) 50,6% ;	☐
C) <u>51,6%.</u>	☒

50) L'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 0,2 enfants par femme ;	☐
B) 2.1 enfants par femme ;	☐
C) <u>2,2 enfants par femme ;</u>	☒
D) 2,3 enfants par femme.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 22 أبريل 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui définit le système national de santé :

A) L'ensemble des moyens mis en place pour améliorer la santé d'une population ;	☐
B) L'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières ainsi que les institutions et les activités destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population ;	☐
C) La politique d'un pays pour améliorer la santé de sa population ;	☐
D) La stratégie nationale d'amélioration de la santé de la population.	☐

2) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie du secteur public, laquelle :

A) Pharmacies d'officines ;	☐
B) Réseau de soins de santé de base ;	☐
C) Réseau hospitalier public ;	☐
D) Services de santé des FAR.	☐

3) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, laquelle :

A) Conception et réalisation des programmes de lutte contre les maladies ;	☐
B) Contrôle de la qualité des laboratoires de biologie relevant du ministère ;	☐
C) Surveillance épidémiologique de la population ;	☐
D) Établissement des bilans des activités des hôpitaux.	☐

4) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, laquelle :

A) Contribution à l'élaboration de la stratégie du département en matière de soins ambulatoires ;	☐
B) Contrôle sanitaire des denrées alimentaires ;	☐
C) Définition des programmes de formation en urgentologie ;	☐
D) Définition des stratégies de restructuration des services des urgences.	☐

5) Indiquer parmi les produits suivants celui qui ne fait pas partie des antiseptiques :

A) L'alcool à 700 ;	☐
B) L'eau de javel ;	☐
C) La Bétadine moussante ;	☐
D) Le dakin.	☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition de l'infection nosocomiale (IN) :

A) Infection absente à l'admission et survenue 48 heures après une hospitalisation ;	☐
B) Infection survenue 24 heures après une hospitalisation ;	☐
C) Infection survenue lors ou à la suite d'une prise en charge ;	☐
D) Infection survenue à domicile.	☐

7) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des principales missions d'un centre hospitalier universitaire, laquelle :

A) Assurer l'enseignement clinique universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique ;	☐
B) Assurer la vaccination des pèlerins ;	☐
C) Concourir à la réalisation des objectifs fixés par le ministère de santé ;	☐
D) Mener les travaux de recherche médicale et en soins infirmiers.	☐

8) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie de l'offre publique de soins en mode fixe, laquelle :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau des établissements médico-sociaux ;	☐
C) Le réseau hospitalier ;	☐
D) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale.	☐

9) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des facteurs favorisant les infections nosocomiales, laquelle :

A) Actes invasifs : Pose d'un cathéter, sondage urinaire ;	☐
B) Age : avant 1 an et après 65 ans ;	☐
C) L'immunodépression ;	☐
D) Respect des bonnes pratiques de soins.	☐

10) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des hôpitaux classés selon la capacité d'accueil, laquelle ?

A) L'hôpital SEGMA (service de l'état géré de manière autonome) ;	☐
B) L'hôpital local ;	☐
C) L'hôpital provincial ;	☐
D) Le centre hospitalier universitaire.	☐

11) Parmi les secteurs suivants constituant le système national de santé, un ne fait pas partie des secteurs formels, lequel :

A) Privé à but lucratif ;	☐
B) Privé à but non lucratif ;	☐
C) Public ;	☐
D) Traditionnel.	☐

12) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des structures nationales d'appui au réseau hospitalier, laquelle ?

A) La direction régionale de santé ;	☐
B) Le centre national antipoison et de pharmacovigilance ;	☐
C) Le centre national de radioprotection ;	☐
D) Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie.	☐

13) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des prestations de soins et services en mode mobile, laquelle :

A) Hôpitaux mobiles ;	☐
B) Les centres de santé urbains ;	☐
C) Unités médicales mobiles ;	☐
D) Visite à domicile.	☐

14) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des modes de couverture sanitaire, laquelle ?

A) Mode fixe ;	☐
B) Mode mixte ;	☐
C) Mode mobile ;	☐
D) Mode participatif (action communautaire).	☐

15) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des principales fonctions d'un hôpital, laquelle :

A) Dispensation des prestations de diagnostic ;	☐
B) Enquête autour des cas de tuberculose ;	☐
C) Hébergement des malades ;	☐
D) Traitement et soins d'urgence.	☐

16) Parmi les structures suivantes, une ne fait pas partie du secteur privé à but non lucratif, laquelle ?

A) Bureau municipaux et communaux d'hygiène ;	☐
B) Cabinets dentaires et laboratoires d'analyse des mutuelles ;	☐
C) Hôpitaux et établissements de soins de la CNSS ;	☐
D) La caisse nationale des œuvres de prévoyance sociale (CNOPS).	☐

17) Parmi les définitions suivantes de la santé, cocher celle de l'OMS :

A) Absence d'infirmité ;	☐
B) Absence de maladie ;	☐
C) L'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, cet équilibre exige la satisfaction des besoins fondamentaux ;	☐
D) État dynamique de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité.	☐

18) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de l'administration centrale du ministère de santé, laquelle ?

A) Coordination de toutes les activités sanitaires dans la région ;	☐
B) Planification de l'offre de soins ;	☐
C) Régulation et coordination du développement du secteur ;	☐
D) Élaboration des priorités sanitaires nationales et de la stratégie sectorielle.	☐

19) Vous êtes victime d'un accident d'exposition au sang (AES) Par piqure d'aiguille, Quel est le geste à faire en premier après l'accident ?

A) Déclarer l'accident au service concerné ;	☐
B) Faire le suivi sérologique ;	☐
C) Faire saigner la blessure ;	☐
D) Laver immédiatement à l'eau et au savon, puis rincer.	☐

20) Vous êtes victime d'une projection de liquide biologique sur le visage, quel est le geste à faire en premier ?

A) Appeler en urgence le CLIN ;	☐
B) Appeler le service de santé au travail ;	☐
C) Effectuer un rinçage abondant du visage du sérum ou à l'eau ;	☐
D) S'informer sur le statut sérologique du patient.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 22 أبريل 2018)

Correction proposée :

1) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui définit le système national de santé :

A) L'ensemble des moyens mis en place pour améliorer la santé d'une population ;	☐
B) <u>L'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières ainsi que les institutions et les activités destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population ;</u>	☒
C) La politique d'un pays pour améliorer la santé de sa population ;	☐
D) La stratégie nationale d'amélioration de la santé de la population.	☐

2) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie du secteur public, laquelle :

A) <u>Pharmacies d'officines ;</u>	☒
B) Réseau de soins de santé de base ;	☐
C) Réseau hospitalier public ;	☐
D) Services de santé des FAR.	☐

3) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, laquelle :

A) <u>Conception et réalisation des programmes de lutte contre les maladies ;</u>	☒
B) Contrôle de la qualité des laboratoires de biologie relevant du ministère ;	☐
C) Surveillance épidémiologique de la population ;	☐
D) Établissement des bilans des activités des hôpitaux.	☐

4) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, laquelle :

A) Contribution à l'élaboration de la stratégie du département en matière de soins ambulatoires ;	☐
B) <u>Contrôle sanitaire des denrées alimentaires ;</u>	☒
C) Définition des programmes de formation en urgentologie ;	☐
D) Définition des stratégies de restructuration des services des urgences.	☐

5) Indiquer parmi les produits suivants celui qui ne fait pas partie des antiseptiques :

A) L'alcool à 700 ;	☐
B) <u>L'eau de javel ;</u>	☒
C) La Bétadine moussante ;	☐
D) Le dakin.	☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition de l'infection nosocomiale (IN) :

A) <u>Infection absente à l'admission et survenue 48 heures après une hospitalisation ;</u>	☒
B) Infection survenue 24 heures après une hospitalisation ;	☐
C) Infection survenue lors ou à la suite d'une prise en charge ;	☐
D) Infection survenue à domicile.	☐

7) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des principales missions d'un centre hospitalier universitaire, laquelle :

A) Assurer l'enseignement clinique universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique ;	☐
B) <u>Assurer la vaccination des pèlerins ;</u>	☒
C) Concourir à la réalisation des objectifs fixés par le ministère de santé ;	☐
D) Mener les travaux de recherche médicale et en soins infirmiers.	☐

8) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie de l'offre publique de soins en mode fixe, laquelle :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau des établissements médico-sociaux ;	☐
C) Le réseau hospitalier ;	☐
D) <u>Le réseau intégré des soins d'urgence médicale.</u>	☒

9) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des facteurs favorisant les infractions nosocomiales, laquelle :

A) Actes invasifs : Pose d'un cathéter, sondage urinaire ;	☐
B) Age : avant 1 an et après 65 ans ;	☐
C) L'immunodépression ;	☐
D) <u>Respect des bonnes pratiques de soins.</u>	☒

10) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des hôpitaux classés selon la capacité d'accueil, laquelle ?

A) L'hôpital SEGMA (service de l'état géré de manière autonome) ;	☐
B) <u>L'hôpital local ;</u>	☒
C) L'hôpital provincial ;	☐
D) Le centre hospitalier universitaire.	☐

11) Parmi les secteurs suivants constituant le système national de santé, un ne fait pas partie des secteurs formels, lequel :

A) Privé à but lucratif ;	☐
B) Privé à but non lucratif ;	☐
C) Public ;	☐
D) <u>Traditionnel.</u>	☒

12) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des structures nationales d'appui au réseau hospitalier, laquelle ?

A) <u>La direction régionale de santé ;</u>	☒
B) Le centre national antipoison et de pharmacovigilance ;	☐
C) Le centre national de radioprotection ;	☐
D) Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie.	☐

13) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des prestations de soins et services en mode mobile, laquelle :

A) Hôpitaux mobiles ;	☐
B) <u>Les centres de santé urbains ;</u>	☒
C) Unités médicales mobiles ;	☐
D) Visite à domicile.	☐

14) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des modes de couverture sanitaire, laquelle ?

A) Mode fixe ;	☐
B) <u>Mode mixte ;</u>	☒
C) Mode mobile ;	☐
D) Mode participatif (action communautaire).	☐

15) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des principales fonctions d'un hôpital, laquelle :

A) Dispensation des prestations de diagnostic ;	☐
B) <u>Enquête autour des cas de tuberculose ;</u>	☒
C) Hébergement des malades ;	☐
D) Traitement et soins d'urgence.	☐

16) Parmi les structures suivantes, une ne fait pas partie du secteur privé à but non lucratif, laquelle ?

A) <u>Bureau municipaux et communaux d'hygiène ;</u>	☒
B) Cabinets dentaires et laboratoires d'analyse des mutuelles ;	☐
C) Hôpitaux et établissements de soins de la CNSS ;	☐
D) La caisse nationale des œuvres de prévoyance sociale (CNOPS).	☐

17) Parmi les définitions suivantes de la santé, cocher celle de l'OMS :

A) Absence d'infirmité ;	☐
B) Absence de maladie ;	☐
C) L'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, cet équilibre exige la satisfaction des besoins fondamentaux ;	☐
D) <u>État dynamique de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité.</u>	☒

18) Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des attributions de l'administration centrale du ministère de santé, laquelle ?

A) <u>Coordination de toutes les activités sanitaires dans la région ;</u>	☒
B) Planification de l'offre de soins ;	☐
C) Régulation et coordination du développement du secteur ;	☐
D) Élaboration des priorités sanitaires nationales et de la stratégie sectorielle.	☐

19) Vous êtes victime d'un accident d'exposition au sang (AES) Par pique d'aiguille, Quel est le geste à faire en premier après l'accident ?

A) Déclarer l'accident au service concerné ;	☐
B) Faire le suivi sérologique ;	☐
C) Faire saigner la blessure ;	☐
D) <u>Laver immédiatement à l'eau et au savon, puis rincer.</u>	☒

20) Vous êtes victime d'une projection de liquide biologique sur le visage, quel est le geste à faire en premier ?

A) Appeler en urgence le CLIN ;	☐
B) Appeler le service de santé au travail ;	☐
C) <u>Effectuer un rincage abondant du visage du sérum ou à l'eau ;</u>	☒
D) S'informer sur le statut sérologique du patient.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا - الرباط -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 29 أبريل 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La filière de soins est :

A) Une organisation transversale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients.	☐

2) Le(s) quel(s) de ces choix ne rentre pas dans la composition de l'offre de soins :

A) Le Territoire sanitaire ;	☐
B) Les Infrastructures et installations de santé relevant du secteur public et du secteur privé ;	☐
C) La carte sanitaire ;	☐
D) Le schéma régional de l'offre de soins.	☐

3) L'offre publique de soins en mode fixe est assurée par :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau établissements hospitaliers ;	☐
C) Le réseau des hôpitaux mobiles ;	☐
D) Le réseau des établissements médicaux sociaux.	☐

4) L'offre publique de soins en mode mobile est assurée par :

A) Les établissements médicaux sociaux ;	☐
B) Les caravanes médicales spécialisées ;	☐
C) Les unités médicales mobiles ;	☐
D) Les visites à domicile.	☐

5) La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du :

A) Territoire local ;	☐
B) Territoire régional ;	☐
C) Territoire national ;	☐
D) Secteur sanitaire.	☐

6) La carte sanitaire est établie par l'administration pour une durée de :

A) 5 ans ;	☐
B) 10 ans ;	☐
C) 15 ans ;	☐
D) 20 ans.	☐

7) Le schéma régional de l'offre de soins est établi par la direction régionale pour une période de :

A) 5 ans ;	☐
B) 10 ans ;	☐
C) 15 ans ;	☐
D) 20 ans.	☐

8) La carte sanitaire et le Schéma régional de l'offre de soins ont pour Objet de corriger les déséquilibres de l'offre de soins dans :

A) Le secteur informel ;	☐
B) Le secteur public ;	☐
C) Le secteur privé ;	☐
D) Le secteur public et le privé.	☐

9) L'offre publique soins repose Sur un système de référence et de contre référence :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

10) Les établissements de soins de santé primaires constituent des établissements d'appui aux établissements relevant du réseau hospitalier :

A) Vrai ;	☐
B) Faux.	☐

11) Le réseau des établissements médicaux sociaux comprend :

A) Centres de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthophonie ;	☐
B) Centre antipoison ;	☐
C) Centres d'addictologie ;	☐
D) Centres de soins palliatifs.	☐

12) Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire (l'AMO) sont :

A) L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) ;	☐
B) La caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) ;	☐
C) La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ;	☐
D) Le ministère santé.	☐

13) Le RAMED est fondé Sur le(s) principe(s) de :

A) La solidarité nationale ;	☐
B) L'assurance sociale ;	☐
C) La Cotisation salariale ;	☐
D) L'assistance sociale.	☐

14) Le RAMED a été généralisé à l'échelon national :

A) En 2008 ;	☐
B) En 2010 ;	☐
C) En 2012 ;	☐
D) En 2014.	☐

15) Pour l'Organisation mondiale de santé (OMS), la santé est :

A) Un état de complet bien-être physique et ne consiste pas Seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;	☐
B) Un état de complet bien-être mental et ne consiste pas seulement en de maladie ou d'infirmité ;	☐
C) Un état de complet bien-être physique et social ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité ;	☐
D) Un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité.	☐

16) Le Financement du RAMED est assuré par :

A) L'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) ;	☐
B) L'Etat ;	☐
C) Les collectivités Locales ;	☐
D) La contribution des Ramedistes.	☐

17) Les prestations de l'hôpital de jour peuvent :

A) Être rendues dans la journée avec hébergement ;	☐
B) Être rendues dans la journée sans hébergement ;	☐
C) Être rendues dans plusieurs journées avec hébergement ;	☐
D) Être rendues dans la journée dans les établissements médico-sociaux.	☐

18) Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine sont des structures spécialisées d'appui au :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Réseau hospitalier ;	☐
C) Réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) Réseau des établissements médico-sociaux.	☐

19) Les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P) sont assurées par :

A) Les services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR) ;	☐
B) Les services médicaux héliportés (HELISMUR) ;	☐
C) Les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ;	☐
D) Les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux.	☐

20) Le Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina a pour missions de :

A) Concourir la réalisation des objectifs fixés en matière de santé publique par l'Etat ;	☐
B) Dispenser des soins médicaux ;	☐
C) Elaborer la stratégie sanitaire de l'Etat ;	☐
D) Effectuer des travaux de recherche médicale.	☐

21) Le panier des soins des Centres hospitaliers régionaux comporte :

A) 15 Spécialités ;	☐
B) 20 Spécialités ;	☐
C) 28 Spécialités ;	☐
D) 40 Spécialités.	☐

22) Le Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina appartient au :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Réseau hospitalier ;	☐
C) Réseau des établissements médico-sociaux ;	☐
D) Structures spécialisées et d'appui.	☐

23) Le contexte national de la mise place de la couverture médicale de s'est fondé sur une :

A) Une transition démocratique spécifique ;	☐
B) Une triple transition épidémiologique, démographique et démocratique spécifique ;	☐
C) Une double transition démographique et démocratique spécifique ;	☐
D) Aucune transition épidémiologique, démographique et démocratique spécifique.	☐

24) Le droit constitutionnel à la santé signifie :

A) Le droit aux services de santé ;	☐
B) Une égalité de traitement et de respect ;	☐
C) Tous les citoyens sont égaux en valeur et en dignité ;	☐
D) L'accord de la collectivité sur une priorité.	☐

25) Les principes de la vigilance sanitaire impliquent :

A) La veille sanitaire ;	☐
B) La sécurité sanitaire ;	☐
C) Les menaces sanitaire ;	☐
D) La couverture sanitaire.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا - الرباط -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 29 أبريل 2018)

Correction proposée :

1) La filière de soins est :

A) Une organisation transversale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) <u>Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients.</u>	☒

2) Le(s) quel(s) de ces choix ne rentre pas dans la composition de l'offre de soins :

A) <u>Le Territoire sanitaire ;</u>	☒
B) Les Infrastructures et installations de santé relevant du secteur public et du secteur privé ;	☐
C) <u>La carte sanitaire ;</u>	☒
D) <u>Le schéma régional de l'offre de soins.</u>	☒

3) L'offre publique de soins en mode fixe est assurée par :

A) <u>Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;</u>	☒
B) <u>Le réseau établissements hospitaliers ;</u>	☒
C) Le réseau des hôpitaux mobiles ;	☐
D) <u>Le réseau des établissements médicaux sociaux.</u>	☒

4) L'offre publique de soins en mode mobile est assurée par :

A) Les établissements médicaux sociaux ;	☐
B) <u>Les caravanes médicales spécialisées ;</u>	☒
C) <u>Les unités médicales mobiles ;</u>	☒
D) <u>Les visites à domicile.</u>	☒

5) La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du :

A) Territoire local ;	☐
B) Territoire régional ;	☐
C) <u>Territoire national ;</u>	☒
D) Secteur sanitaire.	☐

6) La carte sanitaire est établie par l'administration pour une durée de :

A) 5 ans ;	☐
B) <u>10 ans ;</u>	☒
C) 15 ans ;	☐
D) 20 ans.	☐

7) Le schéma régional de l'offre de soins est établi par la direction régionale pour une période de :

A) <u>5 ans ;</u>	☒
B) 10 ans ;	☐
C) 15 ans ;	☐
D) 20 ans.	☐

8) La carte sanitaire et le Schéma régional de l'offre de soins ont pour Objet de corriger les déséquilibres de l'offre de soins dans :

A) Le secteur informel ;	☐
B) Le secteur public ;	☐
C) Le secteur privé ;	☐
D) <u>Le secteur public et le privé.</u>	☒

9) L'offre publique soins repose Sur un système de référence et de contre référence :

A) <u>Vrai ;</u>	☒
B) Faux.	☐

10) Les établissements de soins de santé primaires constituent des établissements d'appui aux établissements relevant du réseau hospitalier :

A) Vrai ;	☐
B) <u>Faux.</u>	☒

11) Le réseau des établissements médicaux sociaux comprend :

A) <u>Centres de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthophonie ;</u>	☒
B) Centre antipoison ;	☐
C) <u>Centres d'addictologie ;</u>	☒
D) <u>Centres de soins palliatifs.</u>	☒

12) Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire (l'AMO) sont :

A) L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) ;	☐
B) <u>La caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS).;</u>	☒
C) <u>La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).;</u>	☒
D) Le ministère santé.	☐

13) Le RAMED est fondé Sur le(s) principe(s) de :

A) <u>La solidarité nationale ;</u>	☒
B) L'assurance sociale ;	☐
C) La Cotisation salariale ;	☐
D) <u>L'assistance sociale.</u>	☒

14) Le RAMED a été généralisé à l'échelon national :

A) En 2008 ;	☐
B) En 2010 ;	☐
C) <u>En 2012.;</u>	☒
D) En 2014.	☐

15) Pour l'Organisation mondiale de santé (OMS), la santé est :

A) Un état de complet bien-être physique et ne consiste pas Seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;	☐
B) Un état de complet bien-être mental et ne consiste pas seulement en de maladie ou d'infirmité ;	☐
C) Un état de complet bien-être physique et social ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité ;	☐
D) <u>Un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité.</u>	☒

16) Le Financement du RAMED est assuré par :

A) L'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) ;	☐
B) <u>L'Etat ;</u>	☒
C) <u>Les collectivités Locales ;</u>	☒
D) <u>La contribution des Ramedistes.</u>	☒

17) Les prestations de l'hôpital de jour peuvent :

A) Être rendues dans la journée avec hébergement ;	☐
B) <u>Être rendues dans la journée sans hébergement ;</u>	☒
C) Être rendues dans plusieurs journées avec hébergement ;	☐
D) Être rendues dans la journée dans les établissements médico-sociaux.	☐

18) Le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine sont des structures spécialisées d'appui au :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) <u>Réseau hospitalier ;</u>	☒
C) Réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) Réseau des établissements médico-sociaux.	☐

19) Les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P) sont assurées par :

A) Les services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR) ;	☐
B) Les services médicaux hélicoptérés (HELISMUR) ;	☐
C) <u>Les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ;</u>	☒
D) Les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux.	☐

20) Le Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina a pour missions de :

A) <u>Concourir la réalisation des objectifs fixés en matière de santé publique par l'Etat ;</u>	☒
B) <u>Dispenser des soins médicaux ;</u>	☒
C) Elaborer la stratégie sanitaire de l'Etat ;	☐
D) <u>Effectuer des travaux de recherche médicale.</u>	☒

21) Le panier des soins des Centres hospitaliers régionaux comporte :

A) 15 Spécialités ;	☐
B) 20 Spécialités ;	☐
C) <u>28 Spécialités ;</u>	☒
D) 40 Spécialités.	☐

22) Le Centre Hospitalo-universitaire Ibn Sina appartient au :

A) Réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) <u>Réseau hospitalier ;</u>	☒
C) Réseau des établissements médico-sociaux ;	☐
D) Structures spécialisées et d'appui.	☐

23) Le contexte national de la mise place de la couverture médicale de s'est fondé sur une :

A) Une transition démocratique spécifique ;	☐
B) <u>Une triple transition épidémiologique, démographique et démocratique spécifique ;</u>	☒
C) Une double transition démographique et démocratique spécifique ;	☐
D) Aucune transition épidémiologique, démographique et démocratique spécifique.	☐

24) Le droit constitutionnel à la santé signifie :

A) <u>Le droit aux services de santé ;</u>	☒
B) <u>Une égalité de traitement et de respect ;</u>	☒
C) <u>Tous les citoyens sont égaux en valeur et en dignité ;</u>	☒
D) <u>L'accord de la collectivité sur une priorité.</u>	☒

25) Les principes de la vigilance sanitaire impliquent :

A) <u>La veille sanitaire ;</u>	☒
B) <u>La sécurité sanitaire ;</u>	☒
C) <u>Les menaces sanitaire ;</u>	☒
D) La couverture sanitaire.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا - الرباط -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 22 أبريل 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les hôpitaux régionaux sont :

A) Des établissements publics administratifs : CHU ;	☐
B) Des établissements érigés en service de l'état géré de manière autonome ;	☐
C) Des établissements gérés en « régie » ;	☐
D) Des établissements gérés d'une manière indéfinie.	☐

2) Les structures d'appui au réseau de soins de santé primaires (de base) sont constituées entre autres par :

A) Le centre de santé ;	☐
B) Le centre de référence de planification familiale ;	☐
C) Le dispensaire ;	☐
D) Le centre de diagnostic polyvalent.	☐

3) Les hôpitaux universitaires sont :

A) Des hôpitaux de proximité ;	☐
B) Des hôpitaux de recours interrégional ou national ;	☐
C) Des hôpitaux de recours provincial ;	☐
D) Des hôpitaux de recours régional.	☐

4) Le centre hospitalo-universitaire est chargé des missions suivantes :

A) Soins ;	☐
B) Formation ;	☐
C) Recherche ;	☐
D) Expertise et innovation.	☐

5) Dans le cadre du système national de santé, les structures de l'offre de soins des mutuelles relèvent du :

A) Secteur privé ;	☐
B) Secteur étatique ;	☐
C) Secteur semi publique ;	☐
D) Secteur de diagnostic polyvalent.	☐

6) Parmi les principes sur lesquels est fondée assurance maladie obligatoire (AMO) :

A) La solidarité nationale au profit de la population démunie ;	☐
B) La contribution au financement à l'assurance maladie ;	☐
C) La mutualité ;	☐
D) L'équité.	☐

7) Les organes d'organisation et de gestion du CHU se composent de :

A) Le conseil d'administration ;	☐
B) Le conseil de gestion ;	☐
C) Le conseil de planification stratégique ;	☐
D) Le comité d'évaluation de la performance.	☐

8) La prévalence est :

A) Mesure la fréquence d'apparition d'une maladie ;	☐
B) Mesure uniquement les anciens cas ;	☐
C) Mesure la présence d'une maladie dans la population à un moment donné ;	☐
D) Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée.	☐

9) L'incidence est :

A) Une évaluation statistique du risque, pour une personne ou une catégorie de personnes, de développer une maladie ;	☐
B) Mesure uniquement les anciens cas ;	☐
C) Mesure la présence d'une maladie dans la population à un moment donné ;	☐
D) Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée.	☐

10) Le régime d'assistance médicale (RAMED), s'applique aux :

A) Travailleurs indépendants ;	☐
B) Personnes exerçant les professions libérales ;	☐
C) Personnes indigents ;	☐
D) Anciens résistants et membre de l'armée de libération.	☐

11) Les hôpitaux hospitalo-universitaire :

A) Un établissement de l'Etat géré de manière autonome ;	☐
B) Un établissement public ;	☐
C) Un établissement d'Etat gérés en régie ;	☐
D) Un établissement public doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière.	☐

12) Parmi les attributions de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires du ministère de santé :

A) La programmation des actions de réhabilitation physique et de gériatrie ;	☐
B) Participation au contrôle de l'application de la réglementation en matière de radioprotection ;	☐
C) Elaboration de la stratégie du ministère en matière des soins ambulatoires ;	☐
D) Contrôle technique et de qualité des médicaments et des spécialités pharmaceutiques.	☐

13) Le taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) au Maroc en 2015 :

A) 44,6 ;	☐
B) 144 ;	☐
C) 72,6 ;	☐
D) 124.	☐

14) La prévention primaire sert à :

A) Réduire l'apparition de nouveaux cas d'une maladie ;	☐
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Diminuer la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) Diminuer l'incidence d'une maladie.	☐

15) Le centre de santé communal est implanté au chef-lieu d'une commune d'une population environ de :

A) 15000 habitants ;	☐
B) 25000 habitants ;	☐
C) 45000 habitants ;	☐
D) 100000 habitants.	☐

16) La maladie du sida peut se transmettre par :

A) La toux et l'éternuement ;	☐
B) Les mains sales ;	☐
C) Les injections ;	☐
D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida après le repas.	☐

17) Le programme nationale d'immunisation cible uniquement la population des :

A) Enfants âgées de 0 à 2 ans ;	☐
B) Enfants âgées de 0 à 5 ans ;	☐
C) Enfants âgées de 0 à 5 ans et femmes âgées de 15 à 45 ans ;	☐
D) Enfants âgées de 0 à 2 ans et femmes âgées de 15 à 45 ans.	☐

18) Dans le processus d'une communication interpersonnel appliquée dans une situation en milieu sanitaire le canal est :

A) Les compétences et les habiletés du professionnel émetteur ;	☐
B) Les caractéristiques psychos sociologiques et culturelles du récepteur ;	☐
C) Les méthodes et /ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour transmettre le message ;	☐
D) Les objectifs fixés pour la séance de communication.	☐

19) Le taux d'infection nosocomial est un indicateur de qualité de :

A) La fonction soin ;	☐
B) La fonction diagnostique ;	☐
C) La fonction hôtellerie ;	☐
D) La fonction gestion.	☐

20) Dans le cadre de la gestion de déchets hospitaliers le personnel paramédical d'un hôpital doit :

A) Etablir un plan de déchets hospitaliers ;	☐
B) Désigner une personne responsable de la gestion des déchets ;	☐
C) S'assurer que les sacs des déchets sont remplis au $\frac{3}{4}$ au niveau de leurs unités de soins ;	☐
D) Analyser les couts liés à la gestion des déchets hospitaliers.	☐

21) La prophylaxie :

A) L'ensemble d'actions entreprises pour éviter l'apparition de la maladie ;	☐
B) L'ensemble des actions entreprises pour éviter la propagation de la maladie ;	☐
C) L'ensemble des actions entreprises pour traiter exclusivement les personnes atteintes de la maladie ;	☐
D) L'ensemble des actions entreprises pour assurer la prévention primaire de la maladie.	☐

22) La première cause de la mortalité au Maroc :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) Les maladies cardio-vasculaires ;	☐
D) La tuberculose.	☐

23) Le nombre des régions du royaume est :

A) 12 régions ;	☐
B) 18 régions ;	☐
C) 9 régions ;	☐
D) 16 régions.	☐

24) L'indice synthétique de fécondation au Maroc en 2015 était de :

A) 1,99 ;	☐
B) 2,49 ;	☐
C) 2,5 ;	☐
D) 3,2.	☐

25) L'espérance de vie à la naissance pour les femmes au Maroc en 2015 était de :

A) 79 ;	☐
B) 74,7 ;	☐
C) 77,4 ;	☐
D) 73.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا - الرباط -

الاختبار الأول المدة : ساعتان

(دورة 22 أبريل 2018)

Correction proposée :

1) Les hôpitaux régionaux sont :

A) Des établissements publics administratifs : CHU ;	☐
B) <u>Des établissements érigés en service de l'état géré de manière autonome ;</u>	☒
C) Des établissements gérés en « régie » ;	☐
D) Des établissements gérés d'une manière indéfinie.	☐

2) Les structures d'appui au réseau de soins de santé primaires (de base) sont constituées entre autres par :

A) Le centre de santé ;	☐
B) <u>Le centre de référence de planification familiale ;</u>	☒
C) Le dispensaire ;	☐
D) <u>Le centre de diagnostic polyvalent.</u>	☒

3) Les hôpitaux universitaires sont :

A) Des hôpitaux de proximité ;	☐
B) <u>Des hôpitaux de recours interrégional ou national ;</u>	☒
C) Des hôpitaux de recours provincial ;	☐
D) Des hôpitaux de recours régional.	☐

4) Le centre hospitalo-universitaire est chargé des missions suivantes :

A) <u>Soins ;</u>	☒
B) <u>Formation ;</u>	☒
C) <u>Recherche ;</u>	☒
D) <u>Expertise et innovation.</u>	☒

5) Dans le cadre du système national de santé, les structures de l'offre de soins des mutuelles relèvent du :

A) Secteur privé ;	☐
B) Secteur étatique ;	☐
C) <u>Secteur semi publique ;</u>	☒
D) Secteur de diagnostic polyvalent.	☐

6) Parmi les principes sur lesquels est fondée assurance maladie obligatoire (AMO) :

A) La solidarité nationale au profit de la population démunie ;	☐
B) <u>La contribution au financement à l'assurance maladie ;</u>	☒
C) <u>La mutualité ;</u>	☒
D) <u>L'équité.</u>	☒

7) Les organes d'organisation et de gestion du CHU se composent de :

A) <u>Le conseil d'administration ;</u>	☒
B) <u>Le conseil de gestion ;</u>	☒
C) Le conseil de planification stratégique ;	☐
D) Le comité d'évaluation de la performance.	☐

8) La prévalence est :

A) Mesure la fréquence d'apparition d'une maladie ;	☐
B) Mesure uniquement les anciens cas ;	☐
C) <u>Mesure la présence d'une maladie dans la population à un moment donné ;</u>	☒
D) <u>Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée.</u>	☒

9) L'incidence est :

A) Une évaluation statistique du risque, pour une personne ou une catégorie de personnes, de développer une maladie ;	☐
B) Mesure uniquement les anciens cas ;	☐
C) <u>Mesure la présence d'une maladie dans la population à un moment donné ;</u>	☒
D) Représente le nombre de cas d'une maladie qui survient dans une population pendant une période donnée.	☐

10) Le régime d'assistance médicale (RAMED), s'applique aux :

A) Travailleurs indépendants ;	☐
B) Personnes exerçant les professions libérales ;	☐
C) <u>Personnes indigents ;</u>	☒
D) Anciens résistants et membre de l'armée de libération.	☐

11) Les hôpitaux hospitalo-universitaire :

A) Un établissement de l'Etat géré de manière autonome ;	☐
B) Un établissement public ;	☐
C) Un établissement d'Etat gérés en régie ;	☐
D) <u>Un établissement public doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière.</u>	☒

12) Parmi les attributions de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires du ministère de santé :

A) La programmation des actions de réhabilitation physique et de gériatrie ;	☐
B) Participation au contrôle de l'application de la réglementation en matière de radioprotection ;	☐
C) <u>Elaboration de la stratégie du ministère en matière des soins ambulatoires ;</u>	☒
D) Contrôle technique et de qualité des médicaments et des spécialités pharmaceutiques.	☐

13) Le taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes) au Maroc en 2015 :

A) 44,6 ;	☐
B) 144 ;	☐
C) <u>72,6 ;</u>	☒
D) 124.	☐

14) La prévention primaire sert à :

A) <u>Réduire l'apparition de nouveaux cas d'une maladie ;</u>	☒
B) Réduire la durée d'une maladie ;	☐
C) Diminuer la prévalence des incapacités chroniques ;	☐
D) <u>Diminuer l'incidence d'une maladie.</u>	☒

15) Le centre de santé communal est implanté au chef-lieu d'une commune d'une population environ de :

A) 15000 habitants ;	☐
B) 25000 habitants ;	☐
C) <u>45000 habitants ;</u>	☒
D) 100000 habitants.	☐

16) La maladie du sida peut se transmettre par :

A) La toux et l'éternuement ;	☐
B) Les mains sales ;	☐
C) <u>Les injections ;</u>	☒
D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida après le repas.	☐

17) Le programme nationale d'immunisation cible uniquement la population des :

A) Enfants âgées de 0 à 2 ans ;	☐
B) <u>Enfants âgées de 0 à 5 ans ;</u>	☒
C) Enfants âgées de 0 à 5 ans et femmes âgées de 15 à 45 ans ;	☐
D) Enfants âgées de 0 à 2 ans et femmes âgées de 15 à 45 ans.	☐

18) Dans le processus d'une communication interpersonnel appliquée dans une situation en milieu sanitaire le canal est :

A) Les compétences et les habiletés du professionnel émetteur ;	☐
B) Les caractéristiques psychos sociologiques et culturelles du récepteur ;	☐
C) <u>Les méthodes et /ou les moyens utilisés par le professionnel de santé pour transmettre le message ;</u>	☒
D) Les objectifs fixés pour la séance de communication.	☐

19) Le taux d'infection nosocomial est un indicateur de qualité de :

A) <u>La fonction soin ;</u>	☒
B) La fonction diagnostique ;	☐
C) La fonction hôtellerie ;	☐
D) La fonction gestion.	☐

20) Dans le cadre de la gestion de déchets hospitaliers le personnel paramédical d'un hôpital doit :

A) Etablir un plan de déchets hospitaliers ;	☐
B) Désigner une personne responsable de la gestion des déchets ;	☐
C) <u>S'assurer que les sacs des déchets sont remplis au $\frac{3}{4}$ au niveau de leurs unités de soins ;</u>	☒
D) Analyser les couts liés à la gestion des déchets hospitaliers.	☐

21) La prophylaxie :

A) <u>L'ensemble d'actions entreprises pour éviter l'apparition de la maladie ;</u>	☒
B) <u>L'ensemble des actions entreprises pour éviter la propagation de la maladie ;</u>	☒
C) L'ensemble des actions entreprises pour traiter exclusivement les personnes atteintes de la maladie ;	☐
D) <u>L'ensemble des actions entreprises pour assurer la prévention primaire de la maladie.</u>	☒

22) La première cause de la mortalité au Maroc :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) <u>Les maladies cardio-vasculaires ;</u>	☒
D) La tuberculose.	☐

23) Le nombre des régions du royaume est :

A) <u>12 régions ;</u>	☒
B) 18 régions ;	☐
C) 9 régions ;	☐
D) 16 régions.	☐

24) L'indice synthétique de fécondation au Maroc en 2015 était de :

A) <u>1,99 ;</u>	☒
B) <u>2,49 ;</u>	☒
C) 2,5 ;	☐
D) 3,2.	☐

25) L'espérance de vie à la naissance pour les femmes au Maroc en 2015 était de :

A) 79 ;	☐
B) 74,7 ;	☐
C) 77,4 ;	☒
D) 73.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي - فاس -

المدة : ساعتان الاختبار الأول

(دورة 18 مارس 2018)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Quels sont les principes du système de santé Marocain :

A) La solidarité ;	☐
B) La responsabilisation de la population ;	☐
C) L'adoption de l'approche genre ;	☐
D) La complémentarité intersectorielle.	☐

2) Parmi les forces du système Marocain de santé :

A) La réduction de l'incidence de certaines maladies transmissibles ;	☐
B) L'accroissement de la couverture par les prestations des programmes sanitaires ;	☐
C) L'adéquation entre l'offre et la demande des services de santé ;	☐
D) Le développement de la capacité de formation du personnel de santé.	☐

3) Les affections de longue durée (ALD) comprennent :

A) Les néphropathies chroniques graves et syndrome néphrotique primitif ;	☐
B) Traumatismes crâniens invalidants avec séquelles ;	☐
C) Le diabète insulino-dépendant et non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ;	☐
D) Les accidents vasculaires cérébraux invalidant.	☐

4) L'offre de soins comprend :

A) L'infrastructure sanitaire publique ;	☐
B) L'infrastructure sanitaire privée ;	☐
C) Les ressources humaines ;	☐
D) Les installations de santé publiques et privées.	☐

5) Les composants du RISUM sont :

A) Les services des urgences hospitaliers ;	☐
B) Le service d'assistance médicale urgente ;	☐
C) Le centre d'enseignement des soins d'urgence ;	☐
D) Les transports médicaux privés.	☐

6) La lutte contre la mortalité néonatale suppose :

A) Le renforcement des équipements des structures d'accouchement ;	☐
B) La définition des filières de soins en néonatalogie ;	☐
C) La documentation de l'état de santé de tout nouveau-né sur le carnet de santé de l'enfant ;	☐
D) Le renforcement de la consultation postnatale ;	☐
E) Le renforcement de la communication autour du plan d'action.	☐

7) La qualité organisationnelle des soins se réfère à :

A) L'intégration ;	☐
B) L'efficience ;	☐
C) La continuité ;	☐
D) La globalité ;	☐
E) L'efficacité.	☐

8) Les fonctions d'un système de santé sont :

A) La production des ressources ;	☐
B) La prestation de service ;	☐
C) La gouvernance ;	☐
D) Le financement.	☐

9) L'état de santé d'une population est le résultat dynamique de l'interaction des facteurs suivants :

A) Les facteurs biologiques ;	☐
B) Les facteurs socio-culturels ;	☐
C) Les modes de vie ;	☐
D) L'organisation du système de soins.	☐

10) Parmi les indicateurs suivants, les indicateurs démographiques sont :

A) L'indice synthétique de fécondité ;	☐
B) Le taux de mortalité infanto-juvénile ;	☐
C) Le taux de prévalence contraceptive ;	☐
D) Les pourcentages des accouchements en milieu surveillé.	☐

11) L'OMS recommande que le budget de la santé publique soit de :

A) 3% de budget total de l'Etat ;	☐
B) 6% de budget total de l'Etat ;	☐
C) 9% de budget total de l'Etat ;	☐
D) 12% de budget total de l'Etat.	☐

12) Le centre de santé urbain de premier niveau assure les prestations suivantes :

A) Les consultations de médecine générales ;	☐
B) Les consultations spécialisées ;	☐
C) Le suivi des maladies chroniques ;	☐
D) Les soins infirmiers.	☐

13) Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée :

A) Epidémie ;	☐
B) Endémie ;	☐
C) Pandémie ;	☐
D) Cas sporadique.	☐

14) La prise en charge de bénéficiaires du RAMED se fait :

A) Uniquement dans les ESSB ;	☐
B) Dans tous les services sanitaires relevant de l'état (ESSB et hôpitaux) ;	☐
C) Dans les hôpitaux publics et privés ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

15) Les services extérieurs du ministère de la santé représentent par :

A) Les directions régionales de la santé ;	☐
B) Les directions centrales ;	☐
C) Les divisions centrales ;	☐
D) Les délégations provinciales de la santé.	☐

16) Le nombre de nouveaux de cancer au Maroc est :

A) Entre 15 mille et 25 mille nouveaux cas ;	☐
B) Entre 20 mille et 30 mille nouveaux cas ;	☐
C) Entre 30 mille et 40 mille nouveaux cas ;	☐
D) Entre 40 mille et 50 mille nouveaux cas.	☐

17) Au Maroc, le programme de dépistage des cancers du sein est basé sur :

A) L'examen clinique des seins et des aires ganglionnaires ;	☐
B) La mammographie ;	☐
C) La mammographie et l'échographie ;	☐
D) La mammographie mobile.	☐

18) Au Maroc, l'incidence de la tuberculose en 2015 est :

A) 120 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
B) 80 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
C) 100 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
D) 84,6 nouveau cas pour 100000 habitants.	☐

19) L'Espérance de vie à la naissance (EVN) :

A) Est le premier indicateur utilisé pour mesurer l'état de santé de la population en général ;	☐
B) En 2015, EVN au Maroc a atteint 75,8 ans ;	☐
C) En général, l'homme a une EVN plus longue ;	☐
D) En général, la femme a une EVN plus longue.	☐

20) Le nombre d'établissements de SSP en 2015 est estimé à :

A) 2 662 ;	☐
B) 2 689 ;	☐
C) 2 792 ;	☐
D) 2 800.	☐

21) Le nombre d'établissements hospitaliers en 2015 est de l'ordre de :

A) 141 ;	☐
B) 160 ;	☐
C) 143 ;	☐
D) 155.	☐

22) En 2015, le ratio Habitants par établissement de SSP est estimé à :

A) 11 943 ;	☐
B) 12 266 ;	☐
C) 13 000 ;	☐
D) 12 260.	☐

23) Le système de santé vise la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants :

A) La solidarité et la responsabilisation de la population ;	☐
B) L'égalité de l'accès aux soins et aux services de santé ;	☐
C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;	☐
D) La complémentarité intra-sectorielle.	☐

24) Les territoires sanitaires sont constitués par :

A) Des circonscriptions sanitaires ;	☐
B) Des provinces sanitaires ;	☐
C) Des préfectures sanitaires ;	☐
D) Des territoires de santé intra régionaux.	☐

25) Le réseau des établissements médico-sociaux publics est composé des :

A) Des espaces « santé-jeunes » ;	☐
B) Centres d'addictologie ;	☐
C) Centres de référence de la santé reproductive ;	☐
D) Centres de soins palliatifs.	☐

26) En épidémiologie, la prévalence concerne :

A) Les nouveaux cas d'une maladie ;	☐
B) Les anciens cas d'une maladie ;	☐
C) Les nouveaux cas et les anciens cas d'une maladie ;	☐
D) Les cas suspects d'une maladie.	☐

27) Le centre de santé urbain niveau 2 a une population de :

A) 25 000 habitants ;	☐
B) 50 000 habitants ;	☐
C) 15 000 habitants ;	☐
D) 70 000 habitants.	☐

28) Les hôpitaux universitaires sont :

A) Des hôpitaux de proximité ;	☐
B) Des hôpitaux de recours inter-régional ou national ;	☐
C) Des hôpitaux de recours provincial ;	☐
D) Des hôpitaux de recours régional.	☐

29) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale 2011, le taux de mortalité infantile est de :

A) 27/1000 Naissances vivants ;	☐
B) 37/1000 Naissances vivants ;	☐
C) 47/1000 Naissances vivants ;	☐
D) 28,8/1000 Naissances vivants.	☐

30) L'organigramme de la direction régionale de la santé renferme :

A) 4 services et 2 unités ;	☐
B) 7 services et 2 unités ;	☐
C) 6 services et 2 unités ;	☐
D) 8 services et 2 unités.	☐

31) Parmi les structures suivantes, laquelle représente la première source de financement du système national de santé :

A) L'état ;	☐
B) Les ménages (familles) ;	☐
C) Les collectivités locales ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

32) Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont prévues dans le programme national d'immunisation :

A) La tuberculose ;	☐
B) La méningite ;	☐
C) La rougeole ;	☐
D) La typhoïde ;	☐
E) Le tétanos.	☐

33) Les hôpitaux universitaires sont :

A) Une mission de soins, diagnostic, formation et recherche ;	☐
B) Un caractère national ;	☐
C) Un statut particulier ;	☐
D) Un conseil d'administration.	☐

34) En 2015, le taux d'occupation moyen des lits hospitaliers au Maroc est de :

A) 66,6% ;	☐
B) 63,8% ;	☐
C) 64,6% ;	☐
D) 62,2%.	☐

35) Selon la carte sanitaire, les disciplines obligatoires dans un hôpital de proximité sont :

A) Médecine ;	☐
B) Chirurgie ;	☐
C) Gynéco-obstétrique ;	☐
D) Ophtalmologie ;	☐
E) Pédiatrie.	☐

36) La maladie du Sida peut se transmettre par :

A) La toux et l'éternuement ;	☐
B) Les mains sales ;	☐
C) Les injections ;	☐
D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida.	☐

37) On peut classer les hôpitaux publics selon :

A) Le mode de gestion ;	☐
B) La capacité litière ;	☐
C) La gamme des prestations et la nature d'équipement ;	☐
D) Le champ d'action et le niveau des prestations.	☐

38) La première cause de mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) Les maladies cardio-vasculaires ;	☐
D) La tuberculose et les maladies respiratoires.	☐

39) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) Epidémie ;	☐
D) Cas sporadique.	☐

40) La mortalité périnatale est définie par les décès survenus entre les intervalles suivants :

A) De la naissance à une semaine exacte ;	☐
B) D'une semaine à un mois ;	☐
C) D'un mois à une année ;	☐
D) De la naissance à une année.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار المرضى وإطار تقني الصحة

المركز الاستشفائي الجامعي - فاس -

المدة : ساعتان الاختبار الأول

(دورة 18 مارس 2018)

Correction proposée :

1) Quels sont les principes du système de santé Marocain :

A) <u>La solidarité ;</u>	☒
B) <u>La responsabilisation de la population ;</u>	☒
C) <u>L'adoption de l'approche genre ;</u>	☒
D) <u>La complémentarité intersectorielle.</u>	☒

2) Parmi les forces du système Marocain de santé :

A) <u>La réduction de l'incidence de certaines maladies transmissibles ;</u>	☒
B) <u>L'accroissement de la couverture par les prestations des programmes sanitaires ;</u>	☒
C) <u>L'adéquation entre l'offre et la demande des services de santé ;</u>	☐
D) <u>Le développement de la capacité de formation du personnel de santé.</u>	☒

3) Les affections de longue durée (ALD) comprennent :

A) <u>Les néphropathies chroniques graves et syndrome néphrotique primitif ;</u>	☒
B) <u>Traumatismes crâniens invalidants avec séquelles ;</u>	☐
C) <u>Le diabète insulino-dépendant et non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ;</u>	☒
D) <u>Les accidents vasculaires cérébraux invalidant.</u>	☒

4) L'offre de soins comprend :

A) <u>L'infrastructure sanitaire publique ;</u>	☒
B) <u>L'infrastructure sanitaire privée ;</u>	☒
C) <u>Les ressources humaines ;</u>	☒
D) <u>Les installations de santé publiques et privées.</u>	☒

5) Les composants du RISUM sont :

A) <u>Les services des urgences hospitaliers ;</u>	☒
B) <u>Le service d'assistance médicale urgente ;</u>	☒
C) <u>Le centre d'enseignement des soins d'urgence ;</u>	☒
D) Les transports médicaux privés.	☐

6) La lutte contre la mortalité néonatale suppose :

A) <u>Le renforcement des équipements des structures d'accouchement ;</u>	☒
B) <u>La définition des filières de soins en néonatalogie ;</u>	☒
C) La documentation de l'état de santé de tout nouveau-né sur le carnet de santé de l'enfant ;	☐
D) Le renforcement de la consultation postnatale ;	☐
E) <u>Le renforcement de la communication autour du plan d'action.</u>	☒

7) La qualité organisationnelle des soins se réfère à :

A) <u>L'intégration ;</u>	☒
B) L'efficience ;	☐
C) <u>La continuité ;</u>	☒
D) <u>La globalité ;</u>	☒
E) L'efficacité.	☐

8) Les fonctions d'un système de santé sont :

A) <u>La production des ressources ;</u>	☒
B) <u>La prestation de service ;</u>	☒
C) <u>La gouvernance ;</u>	☒
D) <u>Le financement.</u>	☒

9) L'état de santé d'une population est le résultat dynamique de l'interaction des facteurs suivants :

A) <u>Les facteurs biologiques ;</u>	☒
B) <u>Les facteurs socio-culturels ;</u>	☒
C) <u>Les modes de vie ;</u>	☒
D) <u>L'organisation du système de soins.</u>	☒

10) Parmi les indicateurs suivants, les indicateurs démographiques sont :

A) <u>L'indice synthétique de fécondité ;</u>	☒
B) <u>Le taux de mortalité infanto-juvénile ;</u>	☒
C) Le taux de prévalence contraceptive ;	☐
D) Les pourcentages des accouchements en milieu surveillé.	☐

11) L'OMS recommande que le budget de la santé publique soit de :

A) 3% de budget total de l'Etat ;	☐
B) 6% de budget total de l'Etat ;	☐
C) 9% de budget total de l'Etat ;	☐
D) <u>12% de budget total de l'Etat.</u>	☒

12) Le centre de santé urbain de premier niveau assure les prestations suivantes :

A) <u>Les consultations de médecine générales ;</u>	☒
B) Les consultations spécialisées ;	☐
C) <u>Le suivi des maladies chroniques ;</u>	☒
D) <u>Les soins infirmiers.</u>	☒

13) Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée :

A) Epidémie ;	☐
B) Endémie ;	☐
C) <u>Pandémie ;</u>	☒
D) Cas sporadique.	☐

14) La prise en charge de bénéficiaires du RAMED se fait :

A) Uniquement dans les ESSB ;	☐
B) <u>Dans tous les services sanitaires relevant de l'état (ESSB et hôpitaux) ;</u>	☒
C) Dans les hôpitaux publics et privés ;	☐
D) Toutes les réponses sont justes.	☐

15) Les services extérieurs du ministère de la santé représentent par :

A) <u>Les directions régionales de la santé ;</u>	☒
B) Les directions centrales ;	☐
C) Les divisions centrales ;	☐
D) <u>Les délégations provinciales de la santé.</u>	☒

16) Le nombre de nouveaux de cancer au Maroc est :

A) Entre 15 mille et 25 mille nouveaux cas ;	☐
B) Entre 20 mille et 30 mille nouveaux cas ;	☐
C) <u>Entre 30 mille et 40 mille nouveaux cas ;</u>	☒
D) Entre 40 mille et 50 mille nouveaux cas.	☐

17) Au Maroc, le programme de dépistage des cancers du sein est basé sur :

A) <u>L'examen clinique des seins et des aires ganglionnaires ;</u>	☒
B) La mammographie ;	☐
C) La mammographie et l'échographie ;	☐
D) La mammographie mobile.	☐

18) Au Maroc, l'incidence de la tuberculose en 2015 est :

A) 120 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
B) 80 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
C) 100 nouveau cas pour 100000 habitants ;	☐
D) <u>84,6 nouveau cas pour 100000 habitants.</u>	☒

19) L'Espérance de vie à la naissance (EVN) :

A) <u>Est le premier indicateur utilisé pour mesurer l'état de santé de la population en général ;</u>	☒
B) <u>En 2015, EVN au Maroc a atteint 75,8 ans ;</u>	☒
C) En général, l'homme a une EVN plus longue ;	☐
D) <u>En général, la femme a une EVN plus longue.</u>	☒

20) Le nombre d'établissements de SSP en 2015 est estimé à :

A) 2 662 ;	☐
B) 2 689 ;	☐
C) 2 792 ;	☒
D) 2 800.	☐

21) Le nombre d'établissements hospitaliers en 2015 est de l'ordre de :

A) 141 ;	☐
B) 160 ;	☐
C) 143 ;	☐
D) 155.	☒

22) En 2015, le ratio Habitants par établissement de SSP est estimé à :

A) 11 943 ;	☐
B) 12 266 ;	☒
C) 13 000 ;	☐
D) 12 260.	☐

23) Le système de santé vise la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants :

A) La solidarité et la responsabilisation de la population ;	☒
B) L'égalité de l'accès aux soins et aux services de santé ;	☒
C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;	☒
D) La complémentarité intra-sectorielle.	☐

24) Les territoires sanitaires sont constitués par :

A) Des circonscriptions sanitaires ;	☒
B) Des provinces sanitaires ;	☒
C) Des préfectures sanitaires ;	☒
D) Des territoires de santé intra régionaux.	☐

25) Le réseau des établissements médico-sociaux publics est composé des :

A) <u>Des espaces « santé-jeunes » ;</u>	☒
B) <u>Centres d'addictologie ;</u>	☒
C) Centres de référence de la santé reproductive ;	☐
D) <u>Centres de soins palliatifs.</u>	☒

26) En épidémiologie, la prévalence concerne :

A) Les nouveaux cas d'une maladie ;	☐
B) Les anciens cas d'une maladie ;	☐
C) <u>Les nouveaux cas et les anciens cas d'une maladie ;</u>	☒
D) Les cas suspects d'une maladie.	☐

27) Le centre de santé urbain niveau 2 a une population de :

A) 25 000 habitants ;	☐
B) <u>50 000 habitants ;</u>	☒
C) 15 000 habitants ;	☐
D) 70 000 habitants.	☐

28) Les hôpitaux universitaires sont :

A) Des hôpitaux de proximité ;	☐
B) <u>Des hôpitaux de recours inter-régional ou national ;</u>	☒
C) Des hôpitaux de recours provincial ;	☐
D) Des hôpitaux de recours régional.	☐

29) Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale 2011, le taux de mortalité infantile est de :

A) 27/1000 Naissances vivants ;	☐
B) 37/1000 Naissances vivants ;	☐
C) 47/1000 Naissances vivants ;	☐
D) <u>28,8/1000 Naissances vivants.</u>	☒

30) L'organigramme de la direction régionale de la santé renferme :

A) 4 services et 2 unités ;	☐
B) 7 services et 2 unités ;	☐
C) 6 services et 2 unités ;	☐
D) <u>8 services et 2 unités.</u>	☒

31) Parmi les structures suivantes, laquelle représente la première source de financement du système national de santé :

A) L'état ;	☐
B) <u>Les ménages (familles) ;</u>	☒
C) Les collectivités locales ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

32) Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont prévues dans le programme national d'immunisation :

A) <u>La tuberculose ;</u>	☒
B) La méningite ;	☐
C) <u>La rougeole ;</u>	☒
D) La typhoïde ;	☐
E) <u>Le tétanos.</u>	☒

33) Les hôpitaux universitaires sont :

A) <u>Une mission de soins, diagnostic, formation et recherche ;</u>	☒
B) <u>Un caractère national ;</u>	☒
C) <u>Un statut particulier ;</u>	☒
D) <u>Un conseil d'administration.</u>	☒

34) En 2015, le taux d'occupation moyen des lits hospitaliers au Maroc est de :

A) 66,6% ;	☐
B) <u>63,8% ;</u>	☒
C) 64,6% ;	☐
D) 62,2%.	☐

35) Selon la carte sanitaire, les disciplines obligatoires dans un hôpital de proximité sont :

A) <u>Médecine ;</u>	☒
B) <u>Chirurgie ;</u>	☒
C) Gynéco-obstétrique ;	☐
D) Ophtalmologie ;	☐
E) <u>Pédiatrie.</u>	☒

36) La maladie du Sida peut se transmettre par :

A) La toux et l'éternuement ;	☐
B) Les mains sales ;	☐
C) <u>Les injections ;</u>	☒
D) Le couvert utilisé par un malade atteint du sida.	☐

37) On peut classer les hôpitaux publics selon :

A) <u>Le mode de gestion ;</u>	☒
B) <u>La capacité litière ;</u>	☒
C) <u>La gamme des prestations et la nature d'équipement ;</u>	☒
D) <u>Le champ d'action et le niveau des prestations.</u>	☒

38) La première cause de mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) <u>Les maladies cardio-vasculaires ;</u>	☒
D) La tuberculose et les maladies respiratoires.	☐

39) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) <u>Epidémie ;</u>	☒
D) Cas sporadique.	☐

40) La mortalité périnatale est définie par les décès survenus entre les intervalles suivants :

A) De la naissance à une semaine exacte ;	☒
B) D'une semaine à un mois ;	☐
C) D'un mois à une année ;	☐
D) De la naissance à une année.	☐



2017

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

(دورة 22 أكتوبر 2017)

المدة : 3 ساعات

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) recouvre trois dimensions :

A) L'accès équitable pour toute la population ;	☐
B) L'accès équitable pour la population démunie ;	☐
C) La disponibilité des services de santé de qualité ;	☐
D) La protection financière.	☐

2) Les sources de financement du RAMED sont constituées :

A) Du budget du Ministère de la Santé ;	☐
B) De la contribution des collectivités territoriales ;	☐
C) De la contribution de la population éligible en situation de pauvreté ;	☐
D) De la contribution de la population éligible en situation de vulnérabilité.	☐

3) Selon le rapport d'évaluation des fonctions essentielles de santé publique au Maroc de 2016, les orientations et interventions stratégiques pour le renforcement de la santé publique au Maroc sont :

A) Élaboration d'un système de surveillance intégrée des maladies et des facteurs de risque ;	☐
B) Promotion des favorables à la santé à travers le principe de la santé dans toutes les politiques ;	☐
C) Elaboration d'une politique de médicaments avec promotion de l'utilisation des médicaments génériques ;	☐
D) Renforcement des capacités de la santé publique en termes de ressources humaines.	☐

4) La transition dans le domaine de la santé au Maroc se caractérise par :

A) La croissance démographique ;	☐
B) L'augmentation de l'espérance de vie ;	☐
C) L'émergence des maladies transmissibles ;	☐
D) La diminution du taux de fécondité.	☐

5) La surveillance épidémiologique est un processus permanent qui permet :

A) La collecte des données pertinentes relatives aux événements de santé ;	☐
B) La priorisation des problèmes de santé ;	☐
C) La fabrication des indicateurs à partir des données collectées ;	☐
D) L'élaboration des plans de riposte.	☐

6) Parmi les indicateurs de mesure de l'état de santé suivant, quel est celui qui inclut la notion temps et la notion du risque :

A) L'indice ;	☐
B) La proportion ;	☐
C) Le taux ;	☐
D) Le Ratio.	☐

7) Les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir une couverture universelle de santé sont :

A) La disponibilité des ressources suffisantes ;	☐
B) La gouvernance du système national de santé ;	☐
C) L'utilisation efficiente et équitable des ressources ;	☐
D) La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins.	☐

8) L'évaluation des politiques en santé publique vise à :

A) Améliorer l'ensemble du processus de planification ;	☐
B) Elever le niveau de connaissance ;	☐
C) Aider à la décision ;	☐
D) Juger du succès ou de l'échec d'une action.	☐

9) Parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé, on trouve :

A) Taux d’alphabétisation ;	☐
B) Utilisation des services ;	☐
C) Taux d’accroissement de la population ;	☐
D) Disponibilité.	☐

10) Le quel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) Plan stratégique provincial ;	☐
B) Les plans d’effectifs ;	☐
C) Le budget du programme ;	☐
D) Le plan stratégique régional.	☐

11) Parmi les indicateurs démographiques suivants, quels sont ceux dits indicateurs d’état :

A) Indice de vieillissement ;	☐
B) Indice de fécondité ;	☐
C) Espérance de vie ;	☐
D) Pyramide des âges.	☐

12) La prévalence et l’incidence sont des indicateurs de :

A) Mortalité ;	☐
B) Morbidité ;	☐
C) Natalité ;	☐
D) Fécondité.	☐

13) Selon la Loi 34-09 relative au système de santé et l’offre de soins, les responsabilités de l’Etat dans la réalisation des objectifs et des principes du système de santé sont :

A) La formation et la formation continue des ressources humaines ;	☐
B) La disponibilité de sang et des produits sanguins labiles ;	☐
C) La disponibilité et la qualité des médicaments et des produits pharmaceutiques ;	☐
D) La protection de l’environnement.	☐

14) Les instances prévues par la Loi 34-09 pour améliorer la gouvernance du système sont :

A) Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;	☐
B) Un comité national d'éthique et de recherche ;	☐
C) Des commissions régionales et provinciales de l'offre de soins ;	☐
D) Un comité national de veille et de sécurité sanitaire.	☐

15) En milieu urbain, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale (RAMed) sont définis comme suit :

A) Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30 % ;	☐
B) Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 40 % ;	☐
C) Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 11 ;	☐
D) Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 DH par personne composant le ménage.	☐

16) Les principales contraintes de la santé au Maroc sont :

A) Les difficultés d'accès aux soins ;	☐
B) L'importance des paiements directs des ménages ;	☐
C) La pénurie aiguë en Ressources Humaines ;	☐
D) L'importance des paiements de l'Etat.	☐

17) Les nouveaux défis liés à la santé au Maroc sont :

A) La sécurité sanitaire nationale ;	☐
B) La prévention et la prise en charge des maladies transmissibles ;	☐
C) La couverture universelle de la santé ;	☐
D) La maîtrise des déterminants sociaux de la santé.	☐

18) En 2010, le ministère de la santé, qui constitue le premier prestataire de soins, est classé comme :

A) Premier bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
B) 2 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
C) 3 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
D) 4 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé.	☐

19) Pour Garantir l'accès équitable aux services de santé, certaines actions ont été entreprises par le ministère de sante, il s'agit de :

A) Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu urbain ;	☐
B) La maîtrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration intersectorielle ;	☐
C) La revalorisation de la médecine alternative et traditionnelle ;	☐
D) Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé.	☐

20) Dans le réseau intégré soins d'urgences médicales, les urgences médico-hospitalières de base sont assurées par :

A) Hôpitaux de proximité ;	☐
B) Centres Hospitaliers Provinciaux ;	☐
C) Centres Hospitaliers Préfectoraux ;	☐
D) Centres Hospitaliers universitaires.	☐

21) L'organisation des soins médicaux d'urgence définit le recours la filière des urgences médicales selon :

A) Deux niveaux ;	☐
B) Trois niveaux ;	☐
C) Quatre niveaux ;	☐
D) Aucune des propositions précédentes n'est juste.	☐

22) Les urgences médicales de proximité faisant partie du Réseau Intégré des urgences Médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :

A) Les gestes de premiers secours ;	☐
B) Les gestes de réanimation ;	☐
C) Le diagnostic de détresse vitale ;	☐
D) La transfusion.	☐

23) Les champs de l'évaluation de la qualité des soins sont :

A) L'évaluation des résultats ;	☐
B) L'évaluation des ressources ;	☐
C) L'évaluation des procédures ;	☐
D) L'évaluation mixte.	☐

24) Le renforcement de la couverture sanitaire mobile en milieu rurale consiste en :

A) Mise en œuvre du plan national des campagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires ;	☐
B) Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile (CMS et EM) ;	☐
C) Renforcement du plateau technique des unités hospitalières ;	☐
D) Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire fixe.	☐

25) Selon la stratégie ministérielle de la santé 2012/2016, l'amélioration de prise en charge des urgences médicales consiste en :

A) Le développement du système d'information des urgences ;	☐
B) L'encouragement de la recherche et de l'expertise en évaluation dans le domaine de la médecine d'urgence ;	☐
C) Le renforcement des effectifs des Ressources Humaines exerçant dans les filiales de soins ;	☐
D) Le développement des Centres d'Enseignement des Soins d'Urgences (CESU).	☐

26) Les résultats attendus du plan national de prévention et du contrôle du cancer dans le domaine de prévention est de :

A) Réduire de 20% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
B) Réduire de 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
C) Réduire de 40% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
D) Réduire de 50% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux.	☐

27) Les mesures prises pour lutter contre la mortalité néonatale sont :

A) La mise à niveau de 20 structures de néonatalogie ;	☐
B) La définition des filières de soins en néonatalogie ;	☐
C) La veille à la disponibilité de l'équipement requis par niveau de prise en charge néonatale ;	☐
D) La création pour chaque région d'une unité de soins intensifs en néonatalogie.	☐

28) Pour promouvoir la promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire il est préconisé :

A) Elaboration et mise en place d'un plan d'éducation nutritionnelle au niveau des établissements scolaires et universitaires ;	☐
B) Renforcement de la composante nutrition dans le Cours d'enseignement primaire en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale ;	☐
C) Instauration de normes pour améliorer la qualité des au niveau des cantines scolaires et universitaires ;	☐
D) Gestion des bénéficiaires des cantines scolaires et universitaires.	☐

29) La promotion de la maternité sans risque préconise :

A) L'instauration de la gratuité des examens biologiques des femmes enceintes ;	☐
B) La révision des suppléments préventifs de la femme enceinte en fer et en acide folique et autres micronutriments ;	☐
C) L'augmentation des taux de césariennes ;	☐
D) L'obligation du dépistage VIH chez les femmes enceintes.	☐

30) Le renforcement des programmes préventifs en faveur de l'enfant passe par :

A) Le Renforcement de la stratégie d'élimination de la poliomyélite ;	☐
B) Le Renforcement de la disponibilité des vaccins et introduction du vaccin tétravalent à la place du vaccin pentavalent ;	☐
C) L'évaluation et l'amélioration de la gestion de la chaîne de froid et des équipements ;	☐
D) Assurer le suivi et évaluer la mise en des stratégies nationales d'élimination et d'éradication des maladies cibles.	☐

31) Une région sanitaire :

A) Est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires ;	☐
B) Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral ;	☐
C) Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral et les prestations du 1 ^{er} niveau seulement ;	☐
D) Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral et les prestations du 2 ^{ème} niveau ;	☐

32) La stratégie du plan national de prévention et du contrôle de cancer repose sur les domaines suivants :

A) La prévention ;	☐
B) La détection précoce ;	☐
C) Les soins de base et les soins palliatifs ;	☐
D) La prise en charge diagnostique et thérapeutique.	☐

33) Plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région. Il comprend deux étapes :

A) Une étape de formulation politique ;	☐
B) Une étape de formulation stratégique ;	☐
C) Une étape de formulation tactique ;	☐
D) Une étape d'analyse de situation.	☐

34) Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des :

A) Centres dits espace « santé jeune » ;	☐
B) Centres de soins palliatifs ;	☐
C) Centres d'appareillage orthopédique ;	☐
D) Centre de transfusion.	☐

35) Pour la création et l'implantation d'un centre hospitalier régional ce dernier :

A) Doit desservir au moins quatre régions sanitaires ;	☐
B) Doit couvrir une population minimale de 200.000 habitants ;	☐
C) Doit couvrir une population minimale de 70.000 habitants ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.	☐

36) Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) doit préciser sur la base de la carte sanitaire et des caractéristiques de la région sanitaire concernée :

A) Les prévisions relatives au nombre et aux lieux d'implantation ;	☐
B) Les prévisions relatives aux besoins en ressources humaines et leur répartition ;	☐
C) Les prévisions relatives aux besoins en équipement biomédicaux lourds et leur répartition ;	☐
D) Le projet d'établissement au niveau de chaque hôpital.	☐

37) La commission nationale de l'offre de soins :

A) A pour mission de donner son avis sur la carte sanitaire ;	☐
B) Est présidée par le Wali de la région ;	☐
C) Comprend parmi ses membres un représentant du haut-commissariat au plan ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

38) Le conseil des infirmiers et des infirmières (CII) d'un hôpital :

A) Est chargé des affaires disciplinaires du personnel paramédical ;	☐
B) Est composé des infirmier(e)s chefs aux départements et des infirmier(e)s chefs aux services ;	☐
C) Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux ;	☐
D) Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.	☐

39) L'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins :

A) Conséquences en termes des résultats et la satisfaction des patients ;	☐
B) Conséquences en termes des ressources consommées par le soin ;	☐
C) Conséquences en termes des recettes engendrées par le soin ;	☐
D) Conséquences en termes d'efficacité du soin.	☐

40) Un réseau coordonné de soins :

A) Est une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) La prise en charge se fait au sein du même territoire ;	☐
C) Vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire ;	☐
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

41) Les principales actions communautaires au Maroc sont :

A) SAMU Obstétrical Rural ;	☐
B) Dar Al Oumouma (DAO) ;	☐
C) Éducation parentale ;	☐
D) Initiative à base communautaire basée sur les volontaires communautaires.	☐

42) Chaque préfecture ou province sanitaire :

A) Est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;	☐
B) Est découpée en deux ou plusieurs circonscription sanitaire ;	☐
C) Prodiges des prestations de soins de santé primaires ;	☐
D) Prodiges des prestations de soins de santé de réhabilitation.	☐

43) Un centre de santé de 2ème niveau offre :

A) Les soins de consultations de médecine générale ;	☐
B) Les soins de consultations de gynécologie ;	☐
C) Les examens d'échographie obstétricale ;	☐
D) Les soins obstétricaux d'urgence de base.	☐

44) Les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par :

A) Les centres hospitaliers préfectoraux ;	☐
B) Les centres hospitaliers provinciaux ;	☐
C) Les centres hospitaliers régionaux ;	☐
D) Les centres hospitaliers interrégionaux.	☐

45) Les hôpitaux sont classés par catégorie selon :

A) La capacité d'accueil ;	☐
B) Les objectifs du projet d'établissement ;	☐
C) Le mode de gestion ou statut ;	☐
D) L'orientation technique ou spécialisée.	☐

46) Les hôpitaux en régie :

A) Sont dans une situation d'indépendance statutaire et financière du ministère de la santé ;	☐
B) Sont dans situation de dépendance statutaire et financière du ministère de la santé ;	☐
C) Dispose d'une personnalité morale ;	☐
D) Leurs ressources financières sont des crédits délégués par le département sur le budget général.	☐

47) Les hôpitaux de recours régional :

A) Sont implantés au chef-lieu de la région ;	☐
B) Sont le premier niveau de référence pour les soins de santé primaires ;	☐
C) Sont dotés d'un plateau technique spécifique ;	☐
D) Leur air d'influence s'étend à l'ensemble du pays.	☐

48) Lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital :

A) Comité d'établissement ;	☐
B) Comité d'accréditation et démarche qualité ;	☐
C) Comité de suivi et évaluation ;	☐
D) Comité de gestion du centre hospitalier.	☐

49) Parmi les approches en santé publique, on trouve :

A) Approche pluridisciplinaire ;	☐
B) Approche multisectorielle ;	☐
C) Approche verticale par problème de santé ;	☐
D) Approche horizontale par maladie.	☐

50) La filière soins :

A) Est un outil pour garantir la continuité et la coordination des soins ;	☐
B) Permet d'éviter la sur-utilisation des services de santé ;	☐
C) Facilite l'accès aux soins ;	☐
D) Est un préalable pour la mise en place des protocoles thérapeutiques.	☐

51) Le Maroc connaît une modification majeure de son profil épidémiologique, caractérisée par une augmentation la charge des maladies non transmissibles, qui représentent :

A) 75% de tous les décès ;	☐
B) 65% de tous les décès ;	☐
C) 34% de tous les décès ;	☐
D) 55% de tous les décès.	☐

52) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) :

A) Couvre une période de 2 à 3 ans ;	☐
B) Est un outil de planification stratégique et de communication ;	☐
C) Facilite le développement d'une vision et l'engagement des professionnels et des gestionnaires autour d'objectifs communs ;	☐
D) Est un moyen pour orienter les soins vers la population.	☐

53) Les fonctions appui essentielles de santé publique sont :

A) La gouvernance en santé ;	☐
B) La recherche en santé publique ;	☐
C) La préparation et riposte de santé publique aux situations d'urgence ;	☐
D) La communication et mobilisation sociale.	☐

54) Le système d'évaluation de l'OMS des systèmes de santé repose sur indicateurs suivants :

A) L'inégalité (ou disparité) de santé dans la population ;	☐
B) La réactivité du système de santé ;	☐
C) Le niveau de santé ;	☐
D) La distribution de la réactivité dans la population.	☐

55) Les pathologies qui constituent une priorité dans le programme 2017-2021 du Ministère de la santé :

A) SIDA, Maladies cardiovasculaires et cécité ;	☐
B) Hépatite B. diabète type 1 et maladies génétiques ;	☐
C) Surdit��, maladies cardiovasculaires et h��patite C ;	☐
D) Diab��te, Asthme et maladies mentales.	☐

56) Sont incluses dans le des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base :

A) Les actes param��dicaux ;	☐
B) L'hom��opathie ;	☐
C) Les prestations de soins �� l'��tranger ;	☐
D) Les interventions de chirurgie esth��tique.	☐

57) La formulation du projet d'établissement repose sur deux logiques :

A) Une logique de projet ;	☐
B) Une logique fonctionnelle ;	☐
C) Une logique professionnelle ;	☐
D) Une logique de qualité.	☐

58) L'économie de santé a pour objectif de :

A) Diminuer les dépenses ;	☐
B) Identifier les besoins non satisfaits et grandissants ;	☐
C) Une allocation adéquate des ressources ;	☐
D) Evaluer l'efficacité des traitements et interventions.	☐

59) Parmi les facteurs suivants, lequel ne favorise pas la continuité des soins :

A) L'adoption d'une approche empathique avec le patient ;	☐
B) Le paiement direct du coût de la prestation par le patient ;	☐
C) La multiplicité des intervenants ;	☐
D) L'intégration des soins.	☐

60) La réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 comporte la cible :

A) Réduire de un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2020 ;	☐
B) Réduire de un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030 ;	☐
C) Diminuer de moitié la mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030 ;	☐
D) Diminuer de moitié la mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

(دورة 22 أكتوبر 2017)

المدة : 3 ساعات

Correction proposée :

1) La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) recouvre trois dimensions :

A) <u>L'accès équitable pour toute la population ;</u>	☒
B) L'accès équitable pour la population démunie ;	☐
C) <u>La disponibilité des services de santé de qualité ;</u>	☒
D) <u>La protection financière.</u>	☒

2) Les sources de financement du RAMED sont constituées :

A) Du budget du Ministère de la Santé ;	☐
B) <u>De la contribution des collectivités territoriales ;</u>	☒
C) De la contribution de la population éligible en situation de pauvreté ;	☐
D) <u>De la contribution de la population éligible en situation de vulnérabilité.</u>	☒

3) Selon le rapport d'évaluation des fonctions essentielles de santé publique au Maroc de 2016, les orientations et interventions stratégiques pour le renforcement de la santé publique au Maroc sont :

A) <u>Élaboration d'un système de surveillance intégrée des maladies et des facteurs de risque ;</u>	☒
B) <u>Promotion des favorables à la santé à travers le principe de la santé dans toutes les politiques ;</u>	☒
C) Elaboration d'une politique de médicaments avec promotion de l'utilisation des médicaments génériques ;	☐
D) <u>Renforcement des capacités de la santé publique en termes de ressources humaines.</u>	☒

4) La transition dans le domaine de la santé au Maroc se caractérise par :

A) <u>La croissance démographique ;</u>	☒
B) <u>L'augmentation de l'espérance de vie ;</u>	☒
C) L'émergence des maladies transmissibles ;	☐
D) <u>La diminution du taux de fécondité.</u>	☒

5) La surveillance épidémiologique est un processus permanent qui permet :

A) <u>La collecte des données pertinentes relatives aux événements de santé ;</u>	☒
B) <u>La priorisation des problèmes de santé ;</u>	☒
C) La fabrication des indicateurs à partir des données collectées ;	☐
D) <u>L'élaboration des plans de riposte.</u>	☒

6) Parmi les indicateurs de mesure de l'état de santé suivant, quel est celui qui inclut la notion temps et la notion du risque :

A) L'indice ;	☐
B) La proportion ;	☐
C) <u>Le taux ;</u>	☒
D) Le Ratio.	☐

7) Les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir une couverture universelle de santé sont :

A) La disponibilité des ressources suffisantes ;	☐
B) <u>La gouvernance du système national de santé ;</u>	☒
C) L'utilisation efficiente et équitable des ressources ;	☐
D) <u>La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins.</u>	☒

8) L'évaluation des politiques en santé publique vise à :

A) <u>Améliorer l'ensemble du processus de planification ;</u>	☒
B) Elever le niveau de connaissance ;	☐
C) <u>Aider à la décision ;</u>	☒
D) <u>Juger du succès ou de l'échec d'une action.</u>	☒

9) Parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé, on trouve :

A) Taux d'alphabétisation ;	☐
B) <u>Utilisation des services ;</u>	☒
C) Taux d'accroissement de la population ;	☐
D) <u>Disponibilité.</u>	☒

10) Le quel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique :

A) <u>Plan stratégique provincial ;</u>	☒
B) Les plans d'effectifs ;	☐
C) Le budget du programme ;	☐
D) Le plan stratégique régional.	☐

11) Parmi les indicateurs démographiques suivants, quels sont ceux dits indicateurs d'état :

A) <u>Indice de vieillissement ;</u>	☒
B) Indice de fécondité ;	☐
C) Espérance de vie ;	☐
D) <u>Pyramide des âges.</u>	☒

12) La prévalence et l'incidence sont des indicateurs de :

A) Mortalité ;	☐
B) <u>Morbidité ;</u>	☒
C) Natalité ;	☐
D) Fécondité.	☐

13) Selon la Loi 34-09 relative au système de santé et l'offre de soins, les responsabilités de l'Etat dans la réalisation des objectifs et des principes du système de santé sont :

A) <u>La formation et la formation continue des ressources humaines ;</u>	☒
B) <u>La disponibilité de sang et des produits sanguins labiles ;</u>	☒
C) <u>La disponibilité et la qualité des médicaments et des produits pharmaceutiques ;</u>	☒
D) La protection de l'environnement.	☐

14) Les instances prévues par la Loi 34-09 pour améliorer la gouvernance du système sont :

A) <u>Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;</u>	☒
B) Un comité national d'éthique et de recherche ;	☐
C) Des commissions régionales et provinciales de l'offre de soins ;	☐
D) <u>Un comité national de veille et de sécurité sanitaire.</u>	☒

15) En milieu urbain, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale (RAMed) sont définis comme suit :

A) Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30 % ;	☐
B) Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 40 % ;	☐
C) <u>Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 11 ;</u>	☒
D) <u>Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 DH par personne composant le ménage.</u>	☒

16) Les principales contraintes de la santé au Maroc sont :

A) <u>Les difficultés d'accès aux soins ;</u>	☒
B) <u>L'importance des paiements directs des ménages ;</u>	☒
C) <u>La pénurie aigue en Ressources Humaines ;</u>	☒
D) L'importance des paiements de l'Etat.	☐

17) Les nouveaux défis liés à la santé au Maroc sont :

A) <u>La sécurité sanitaire nationale ;</u>	☒
B) La prévention et la prise en charge des maladies transmissibles ;	☐
C) La couverture universelle de la santé ;	☐
D) <u>La maîtrise des déterminants sociaux de la santé.</u>	☒

18) En 2010, le ministère de la santé, qui constitue le premier prestataire de soins, est classé comme :

A) Premier bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
B) 2 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
C) <u>3^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;</u>	☒
D) 4 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé.	☐

19) Pour Garantir l'accès équitable aux services de santé, certaines actions ont été entreprises par le ministère de sante, il s'agit de :

A) Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu urbain ;	☐
B) <u>La maitrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration intersectorielle ;</u>	☒
C) La revalorisation de la médecine alternative et traditionnelle ;	☐
D) <u>Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé.</u>	☒

20) Dans le réseau intégré soins d'urgences médicales, les urgences médico-hospitalières de base sont assurées par :

A) Hôpitaux de proximité ;	☐
B) <u>Centres Hospitaliers Provinciaux ;</u>	☒
C) <u>Centres Hospitaliers Préfectoraux ;</u>	☒
D) Centres Hospitaliers universitaires.	☐

21) L'organisation des soins médicaux d'urgence définit le recours la filière des urgences médicales selon :

A) Deux niveaux ;	☐
B) <u>Trois niveaux ;</u>	☒
C) Quatre niveaux ;	☐
D) Aucune des propositions précédentes n'est juste.	☐

22) Les urgences médicales de proximité faisant partie du Réseau Intégré des urgences Médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :

A) <u>Les gestes de premiers secours ;</u>	☒
B) Les gestes de réanimation ;	☐
C) <u>Le diagnostic de détresse vitale ;</u>	☒
D) La transfusion.	☐

23) Les champs de l'évaluation de la qualité des soins sont :

A) <u>L'évaluation des résultats ;</u>	☒
B) <u>L'évaluation des ressources ;</u>	☒
C) <u>L'évaluation des procédures ;</u>	☒
D) <u>L'évaluation mixte.</u>	☒

24) Le renforcement de la couverture sanitaire mobile en milieu rurale consiste en :

A) <u>Mise en œuvre du plan national des campagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires ;</u>	☒
B) <u>Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile (CMS et EM) ;</u>	☒
C) Renforcement du plateau technique des unités hospitalières ;	☐
D) Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire fixe.	☐

25) Selon la stratégie ministérielle de la santé 2012/2016, l'amélioration de prise en charge des urgences médicales consiste en :

A) <u>Le développement du système d'information des urgences ;</u>	☒
B) <u>L'encouragement de la recherche et de l'expertise en évaluation dans le domaine de la médecine d'urgence ;</u>	☒
C) <u>Le renforcement des effectifs des Ressources Humaines exerçant dans les filières de soins ;</u>	☒
D) <u>Le développement des Centres d'Enseignement des Soins d'Urgences (CESU).</u>	☒

26) Les résultats attendus du plan national de prévention et du contrôle du cancer dans le domaine de prévention est de :

A) Réduire de 20% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
B) <u>Réduire de 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;</u>	☒
C) Réduire de 40% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
D) Réduire de 50% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux.	☐

27) Les mesures prises pour lutter contre la mortalité néonatale sont :

A) <u>La mise à niveau de 20 structures de néonatalogie ;</u>	☒
B) <u>La définition des filières de soins en néonatalogie ;</u>	☒
C) <u>La veille à la disponibilité de l'équipement requis par niveau de prise en charge néonatale ;</u>	☒
D) <u>La création pour chaque région d'une unité de soins intensifs en néonatalogie.</u>	☒

28) Pour promouvoir la promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire il est préconisé :

A) <u>Elaboration et mise en place d'un plan d'éducation nutritionnelle au niveau des établissements scolaires et universitaires ;</u>	☒
B) <u>Renforcement de la composante nutrition dans le Cours d'enseignement primaire en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale ;</u>	☒
C) <u>Instauration de normes pour améliorer la qualité des au niveau des cantines scolaires et universitaires ;</u>	☒
D) Gestion des bénéficiaires des cantines scolaires et universitaires.	☐

29) La promotion de la maternité sans risque préconise :

A) <u>L'instauration de la gratuité des examens biologiques des femmes enceintes ;</u>	☒
B) <u>La révision des suppléments préventive de la femme enceinte en fer et en acide folique et autres micronutriments ;</u>	☒
C) <u>L'augmentation des taux de césariennes ;</u>	☒
D) L'obligation du dépistage VIH chez les femmes enceintes.	☐

30) Le renforcement des programmes préventifs en faveur de l'enfant passe par :

A) Le Renforcement de la stratégie d'élimination de la poliomyélite ;	☐
B) <u>Le Renforcement de la disponibilité des vaccins et introduction du vaccin tétravalent à la place du vaccin pentavalent ;</u>	☒
C) <u>L'évaluation et l'amélioration de la gestion de la chaîne de froid et des équipements ;</u>	☒
D) <u>Assurer le suivi et évaluer la mise en des stratégies nationales d'élimination et d'éradication des maladies cibles.</u>	☒

31) Une région sanitaire :

A) <u>Est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires ;</u>	☒
B) Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral ;	☐
C) Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral et les prestations du 1 ^{er} niveau seulement ;	☐
D) <u>Permet l'offre de soins uniquement pour des prestations du niveau provincial et préfectoral et les prestations du 2^{ème} niveau ;</u>	☒

32) La stratégie du plan national de prévention et du contrôle de cancer repose sur les domaines suivants :

A) <u>La prévention ;</u>	☒
B) <u>La détection précoce ;</u>	☒
C) Les soins de base et les soins palliatifs ;	☐
D) <u>La prise en charge diagnostique et thérapeutique.</u>	☒

33) Plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région. Il comprend deux étapes :

A) Une étape de formulation politique ;	☐
B) <u>Une étape de formulation stratégique ;</u>	☒
C) <u>Une étape de formulation tactique ;</u>	☒
D) Une étape d'analyse de situation.	☐

34) Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des :

A) <u>Centres dits espace « santé jeune » ;</u>	☒
B) <u>Centres de soins palliatifs ;</u>	☒
C) <u>Centres d'appareillage orthopédique ;</u>	☒
D) Centre de transfusion.	☐

35) Pour la création et l'implantation d'un centre hospitalier régional ce dernier :

A) Doit desservir au moins quatre régions sanitaires ;	☐
B) Doit couvrir une population minimale de 200.000 habitants ;	☐
C) Doit couvrir une population minimale de 70.000 habitants ;	☐
D) <u>Toutes les propositions précédentes sont fausses.</u>	☒

36) Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) doit préciser sur la base de la carte sanitaire et des caractéristiques de la région sanitaire concernée :

A) <u>Les prévisions relatives au nombre et aux lieux d'implantation ;</u>	☒
B) <u>Les prévisions relatives aux besoins en ressources humaines et leur répartition ;</u>	☒
C) <u>Les prévisions relatives aux besoins en équipement biomédicaux lourd et leur répartition ;</u>	☒
D) Le projet d'établissement au niveau de chaque hôpital.	☐

37) La commission nationale de l'offre de soins :

A) A pour mission de donner son avis sur la carte sanitaire ;	☒
B) Est présidée par le Wali de la région ;	☐
C) <u>Comprend parmi ses membres un représentant du haut-commissariat au plan ;</u>	☒
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

38) Le conseil des infirmiers et des infirmières (CII) d'un hôpital :

A) Est chargé des affaires disciplinaires du personnel paramédical ;	☐
B) <u>Est composé des infirmier(e)s chefs aux départements et des infirmier(e)s chefs aux services ;</u>	☒
C) <u>Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux ;</u>	☒
D) <u>Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.</u>	☒

39) L'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins :

A) <u>Conséquences en termes des résultats et la satisfaction des patients ;</u>	☒
B) Conséquences en termes des ressources consommées par le soin ;	☐
C) Conséquences en termes des recettes engendrées par le soin ;	☐
D) <u>Conséquences en termes d'efficacité du soin.</u>	☒

40) Un réseau coordonné de soins :

A) Est une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) <u>La prise en charge se fait au sein du même territoire ;</u>	☒
C) <u>Vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire ;</u>	☒
D) Toutes les propositions précédentes sont justes.	☐

41) Les principales actions communautaires au Maroc sont :

A) <u>SAMU Obstétrical Rural ;</u>	☒
B) <u>Dar Al Oumouma (DAO) ;</u>	☒
C) <u>Éducation parentale ;</u>	☒
D) <u>Initiative à base communautaire basée sur les volontaires communautaires.</u>	☒

42) Chaque préfecture ou province sanitaire :

A) Est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;	☐
B) <u>Est découpée en deux ou plusieurs circonscription sanitaire ;</u>	☒
C) <u>Prodigue des prestations de soins de santé primaires ;</u>	☒
D) <u>Prodigue des prestations de soins de santé de réhabilitation.</u>	☒

43) Un centre de santé de 2ème niveau offre :

A) <u>Les soins de consultations de médecine générale ;</u>	☒
B) Les soins de consultations de gynécologie ;	☐
C) <u>Les examens d'échographie obstétricale ;</u>	☒
D) <u>Les soins obstétricaux d'urgence de base.</u>	☒

44) Les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par :

A) Les centres hospitaliers préfectoraux ;	☐
B) Les centres hospitaliers provinciaux ;	☐
C) <u>Les centres hospitaliers régionaux ;</u>	☒
D) <u>Les centres hospitaliers interrégionaux.</u>	☒

45) Les hôpitaux sont classés par catégorie selon :

A) <u>La capacité d'accueil ;</u>	☒
B) Les objectifs du projet d'établissement ;	☐
C) <u>Le mode de gestion ou statut ;</u>	☒
D) <u>L'orientation technique ou spécialisée.</u>	☒

46) Les hôpitaux en régie :

A) Sont dans une situation d'indépendance statutaire et financière du ministère de la santé ;	☐
B) <u>Sont dans situation de dépendance statutaire et financière du ministère de la santé ;</u>	☒
C) Dispose d'une personnalité morale ;	☐
D) <u>Leurs ressources financières sont des crédits délégués par le département sur le budget général.</u>	☒

47) Les hôpitaux de recours régional :

A) <u>Sont implantés au chef-lieu de la région ;</u>	☒
B) Sont le premier niveau de référence pour les soins de santé primaires ;	☐
C) <u>Sont dotés d'un plateau technique spécifique ;</u>	☒
D) Leur air d'influence s'étend à l'ensemble du pays.	☐

48) Lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital :

A) Comité d'établissement ;	☐
B) <u>Comité d'accréditation et démarche qualité ;</u>	☒
C) Comité de suivi et évaluation ;	☐
D) Comité de gestion du centre hospitalier.	☐

49) Parmi les approches en santé publique, on trouve :

A) <u>Approche pluridisciplinaire ;</u>	☒
B) Approche multisectorielle ;	☐
C) <u>Approche verticale par problème de santé ;</u>	☒
D) Approche horizontale par maladie.	☐

50) La filière soins :

A) <u>Est un outil pour garantir la continuité et la coordination des soins ;</u>	☒
B) <u>Permet d'éviter la sur-utilisation des services de santé ;</u>	☒
C) <u>Facilite l'accès aux soins ;</u>	☒
D) <u>Est un préalable pour la mise en place des protocoles thérapeutiques.</u>	☒

51) Le Maroc connaît une modification majeure de son profil épidémiologique, caractérisée par une augmentation la charge des maladies non transmissibles, qui représentent :

A) <u>75% de tous les décès ;</u>	☒
B) 65% de tous les décès ;	☐
C) 34% de tous les décès ;	☐
D) 55% de tous les décès.	☐

52) Le projet d'établissement hospitalier (PEH) :

A) Couvre une période de 2 à 3 ans ;	☐
B) <u>Est un outil de planification stratégique et de communication ;</u>	☒
C) <u>Facilite le développement d'une vision et l'engagement des professionnels et des gestionnaires autour d'objectifs communs ;</u>	☒
D) <u>Est un moyen pour orienter les soins vers la population.</u>	☒

53) Les fonctions appui essentielles de santé publique sont :

A) <u>La gouvernance en santé ;</u>	☒
B) <u>La recherche en santé publique ;</u>	☒
C) La préparation et riposte de santé publique aux situations d'urgence ;	☐
D) <u>La communication et mobilisation sociale.</u>	☒

54) Le système d'évaluation de l'OMS des systèmes de santé repose sur indicateurs suivants :

A) <u>L'inégalité (ou disparité) de santé dans la population ;</u>	☒
B) <u>La réactivité du système de santé ;</u>	☒
C) <u>Le niveau de santé ;</u>	☒
D) <u>La distribution de la réactivité dans la population.</u>	☒

55) Les pathologies qui constituent une priorité dans le programme 2017-2021 du Ministère de la santé :

A) SIDA, Maladies cardiovasculaires et cécité ;	☐
B) Hépatite B. diabète type 1 et maladies génétiques ;	☐
C) <u>Surdit�, maladies cardiovasculaires et h�patite C ;</u>	☒
D) Diab�te, Asthme et maladies mentales.	☐

56) Sont incluses dans le des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base :

A) <u>Les actes param�dicaux ;</u>	☒
B) L'hom�opathie ;	☐
C) <u>Les prestations de soins � l'�tranger ;</u>	☒
D) Les interventions de chirurgie esth�tique.	☐

57) La formulation du projet d'établissement repose sur deux logiques :

A) <u>Une logique de projet ;</u>	☒
B) Une logique fonctionnelle ;	☐
C) <u>Une logique professionnelle ;</u>	☒
D) Une logique de qualité.	☐

58) L'économie de santé a pour objectif de :

A) Diminuer les dépenses ;	☐
B) <u>Identifier les besoins non satisfaits et grandissants ;</u>	☒
C) <u>Une allocation adéquate des ressources ;</u>	☒
D) <u>Evaluer l'efficacité des traitements et interventions.</u>	☒

59) Parmi les facteurs suivants, lequel ne favorise pas la continuité des soins :

A) L'adoption d'une approche empathique avec le patient ;	☐
B) <u>Le paiement direct du coût de la prestation par le patient ;</u>	☒
C) La multiplicité des intervenants ;	☐
D) L'intégration des soins.	☐

60) La réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 comporte la cible :

A) Réduire de un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2020 ;	☐
B) <u>Réduire de un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030 ;</u>	☒
C) Diminuer de moitié la mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030 ;	☐
D) <u>Diminuer de moitié la mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles d'ici 2030.</u>	☒

مباراة الولوج سلك الماستر تخصص بيداغوجية علوم التمريض وتقنيات
الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

(دورة 24 شتنبر 2017)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de :

A) Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé ;	☐
B) Faire un usage optimal des ressources ;	☐
C) Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous ;	☐
D) Mettre en place des stratégies.	☐

2) Parmi les dimensions de la qualité en santé, figurent :

A) L'innocuité des soins ;	☐
B) La performance du système ;	☐
C) L'accessibilité aux soins ;	☐
D) La réactivité et l'empathie.	☐

3) Un soin efficace se caractérise par :

A) Continuité ;	☐
B) Intégration ;	☐
C) Globalité ;	☐
D) Efficience.	☐

4) Les fonctions d'un système de santé sont :

A) Prestation de services ;	☐
B) Financement ;	☐
C) Gouvernance ;	☐
D) Évaluation.	☐

5) Le territoire de santé est constitué de :

A) La délégation sanitaire ;	☐
B) La circonscription sanitaire ;	☐
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) Le territoire de santé inter régional.	☐

6) Le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants :

A) Projet immobilier ;	☐
B) Projet technique ;	☐
C) Projet financier ;	☐
D) Projet médical.	☐

7) Les caractéristiques de la planification :

A) Elle concerne le passé et le futur ;	☐
B) Elle est créative ;	☐
C) C'est un processus dynamique et continue ;	☐
D) Elle obéit aux orientations stratégiques.	☐

8) Lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital :

A) Comité d'établissement ;	☐
B) Comité d'accréditation et démarche qualité ;	☐
C) Comité de suivi et évaluation ;	☐
D) Comité de gestion du centre hospitalier.	☐

9) Le conseil des infirmiers et des infirmières (CII) d'un hôpital :

A) Est chargé des affaires disciplinaires du personnel paramédical ;	☐
B) Est composé des infirmier(e)s chefs aux départements et des infirmier(e)s chefs aux services ;	☐
C) Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux ;	☐
D) Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.	☐

10) Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes :

A) Analyse de la situation ;	☐
B) Fixation des objectifs ;	☐
C) Détermination des priorités ;	☐
D) Évaluation des ressources.	☐

11) Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés :

A) En 6 départements cliniques et 3 services ;	☐
B) En 5 départements cliniques et 3 services ;	☐
C) En 6 départements cliniques et 2 services ;	☐
D) En 5 départements cliniques et 3 services.	☐

12) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

A) Les centres d'addictologie ;	☐
B) Les centres d'hémodialyse ;	☐
C) Les centres de soins palliatifs ;	☐
D) Les centres régionaux d'oncologie.	☐

13) Les structures d'appui des établissements de soins de santé primaires sont :

A) Les centres de diagnostic et du traitement des maladies cardiaques ;	☐
B) Les centres de référence pour la santé des jeunes ;	☐
C) Les centres de référence pour la santé reproductive ;	☐
D) Les laboratoires de santé publique.	☐

14) Dans le réseau intégré des soins d'urgence médicales :

A) Les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par les centres hospitaliers interrégionaux ;	☐
B) Les urgences médico-hospitalières spécialisées sont assurées par les centres hospitaliers régionaux ;	☐
C) Les urgences médicales de proximité sont assurées par les centre de santé de premier niveau ;	☐
D) Les urgences médico-hospitalières de base sont assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux.	☐

15) Le centre de santé rural de premier niveau :

A) Assure le suivi de la santé de mère et de l'enfant et des maladies chroniques ;	☐
B) Est l'établissement de soins de santé primaires de premier contact en milieu rural ;	☐
C) Est placé sous la responsabilité d'un infirmier ;	☐
D) Offre les prestations d'urgences médicales de proximité.	☐

16) L'état de santé d'une population est le résultat dynamique de l'interaction des facteurs suivants :

A) L'organisation du système de soins ;	☐
B) Les facteurs biologiques ;	☐
C) Les facteurs socio-culturels ;	☐
D) Les modes de vie.	☐

17) Parmi les approches en santé publique, on trouve :

A) Approche pluridisciplinaire ;	☐
B) Approche multisectorielle ;	☐
C) Approche verticale par problème de santé ;	☐
D) Approche horizontale par maladie.	☐

18) Dans le processus de planification, les critères de priorisation d'un problème sont :

A) La gravité ;	☐
B) La pertinence ;	☐
C) La spécificité ;	☐
D) La vulnérabilité.	☐

19) Parmi les indicateurs suivants, les indicateurs démographiques sont :

A) L'indice synthétique de fécondité ;	☐
B) Le taux de mortalité infanto-juvénile ;	☐
C) Le taux de prévalence contraceptive ;	☐
D) Les pourcentages des accouchements en milieu surveillé.	☐

20) Le but de la couverture sanitaire universelle en matière de santé est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé sans concourir de difficultés :

A) Financières ;	☐
B) Logistiques ;	☐
C) Personnelles ;	☐
D) Professionnelles.	☐

21) L'OMS recommande que le budget de la santé publique soit de :

A) 12% du Budget total de l'état ;	☐
B) 3% du Budget total de l'état ;	☐
C) 6% du Budget total de l'état ;	☐
D) 9% du Budget total de l'état.	☐

22) Les politiques, les stratégies et les plans sanitaires nationaux permettent de :

A) Prendre en considération les déterminants sociaux de la santé ;	☐
B) Produire des plans directifs s'adressant au seul secteur public ;	☐
C) Prévoir une budgétisation réaliste, un suivi et une évaluation rigoureuses ;	☐
D) Renforcer les systèmes de santé par l'intermédiaire des soins de santé primaires.	☐

23) L'objectif de développement durable (ODD) le plus pertinent pour la santé est l'ODD 3 qui est :

A) Assurer la couverture médicale pour les 2/3 de la population ;	☐
B) Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ;	☐
C) Promouvoir les soins de santé primaires ;	☐
D) Réduire le taux d'incidence de la tuberculose de 70%.	☐

24) Selon la loi cadre n 34-09, le système de santé est régi par 05 principes dont :

A) L'adoption de l'approche genre en matière des services de santé ;	☐
B) L'égalité d'accès aux soins et services de santé ;	☐
C) L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;	☐
D) La complémentarité intersectorielle.	☐

25) La mise en œuvre des principes du système de santé incombe principalement :

A) Au conseil de l'ordre des médecins ;	☐
B) Au ministère de la santé ;	☐
C) Au organismes de prévoyance sociale ;	☐
D) A l'Etat.	☐

26) La performance d'un système de santé dépend :

A) De l'effectif des ressources humaines de leurs compétences et des ressources matérielles ;	☐
B) Des ressources matérielles et de la motivation du personnel ;	☐
C) De la connaissance des compétences de la motivation et de la distribution du personnel chargé d'organiser et de fournir des prestations ;	☐
D) De l'infrastructure et de la distribution du personnel.	☐

27) Selon la loi cadre 34-09, le modèle du système de soins au Maroc est :

A) Décentralisé, orienté sur la prise en charge des maladies chroniques ;	☐
B) Hiérarchisé, régionalisé et fondé sur la santé communautaire ;	☐
C) Pyramidal, intégré, hiérarchisé et fondé sur les soins de santé primaires ;	☐
D) Transversal et fondé sur les soins ambulatoires et hospitaliers.	☐

28) La carte sanitaire a pour objectif :

A) L'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé ;	☐
B) La bonne gouvernance des établissements de soins ;	☐
C) La détermination du cadre le plus approprié pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins ;	☐
D) La maîtrise et l'organisation quantitative et qualitative de l'offre de soins.	☐

29) Les fonctions d'un système de santé selon l'OMS (2007) sont :

A) L'information ;	☐
B) La complémentarité intersectorielle ;	☐
C) La production des ressources humaines ;	☐
D) Le financement.	☐

30) L'organisation de soins doit intégrer la dimension territoriale pour :

A) Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ;	☐
B) Répondre à une approche ascendante ;	☐
C) Répondre à une approche descendante ;	☐
D) Faciliter la responsabilité territoriale et politique en matière de santé.	☐

31) Une filière de soins est :

A) Une organisation horizontale et verticale de prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une prise en charge des patients par le médecin relevant du secteur public ;	☐
D) Une prise en charge des patients par le médecin généraliste ou le médecin traitant relevant du secteur public ou privé.	☐

32) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

A) L'observatoire régionale de la santé ;	☐
B) Le service de l'approvisionnement et de la pharmacie ;	☐
C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance ;	☐
D) Le service des ressources humaines.	☐

33) L'offre publique de soins en mode mobile est composé des réseaux suivants :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau hospitalier ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

34) L'offre de soins dans le secteur privé est composée des :

A) Cabinets de médecine dentaire ;	☐
B) Cliniques de jour ;	☐
C) Espaces "santé de jeunes" ;	☐
D) Hôpitaux de proximité.	☐

35) Les directions de l'administration centrale de Ministère de la santé comprennent :

A) La direction de l'information et de la communication ;	☐
B) La direction de l'informatique et des méthodes ;	☐
C) La direction de la planification et des ressources financières ;	☐
D) La direction des ressources humaines et contentieux.	☐

36) Selon la sixième enquête nationale sur la population et la santé familiale 2017, le nombre des décès maternels est :

A) En diminution avec 72,6 décès maternels sur 100.000 naissances vivantes en 2017 contre 112 en 2010 ;	☐
B) En diminution avec 92 décès maternels sur 100.000 naissances vivantes en 2017 contre 112 en 2010 ;	☐
C) En diminution seulement en milieu urbain.	☐
D) Stable entre 2010 et 2017.	☐

37) Les pathologies qui constituent une priorité dans le programme 2017-2021 du Ministère de la Santé sont :

A) VIH, maladies cardio-vasculaires et cécité ;	☐
B) Hépatite B, diabète de type 1 et maladies génétiques ;	☐
C) Surdit��, maladies cardio-vasculaires et h��patite C ;	☐
D) Tuberculose, Asthme et maladies mentales.	☐

38) La strat  gie sectorielle du Ministère de la sant   2017-2021 comprend les axes suivants :

A) La concr��tisation de l'approche servicielle du secteur de la sant�� ;	☐
B) La lutte contre les affections de longue dur��e ;	☐
C) La poursuite des chantiers de r��formes ;	☐
D) Le d��veloppement des ressources humaines.	☐

39) L'assurance maladie obligatoire (AMO) des   tudiants est g  r  e par :

A) L'ANAM ;	☐
B) La CNOPS ;	☐
C) La CNSS ;	☐
D) Un assureur priv��.	☐

40) Les instances de concertation en matière de santé sont constituées par :

A) Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;	☐
B) Un comité national de veille et de sécurité sanitaire ;	☐
C) Un conseil national consultatif de la santé ;	☐
D) Une commission régionale de coordination entre le secteur public et le secteur privé.	☐

41) Le centre de santé urbain de premier niveau assure les prestations suivantes :

A) Le suivi des maladies chroniques ;	☐
B) Les consultations de médecine générale ;	☐
C) Les consultations spécialisées ;	☐
D) Les soins infirmiers.	☐

42) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

A) Les centres de diagnostic et du traitement des maladies respiratoires ;	☐
B) Les centres de consultation spécialisé ;	☐
C) Les centres d'addictologie ;	☐
D) Les laboratoires de santé publique.	☐

43) Les dispositions du décret d'application de la loi cadre n°34-09 ne s'appliquent pas aux :

A) Bureaux communaux d'hygiène ;	☐
B) Centres d'hémodialyse ;	☐
C) Structures hospitalières relevant des CHU ;	☐
D) Structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques.	☐

44) On entend par installation de santé :

A) Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle ;	☐
B) Le lieu où sont dispensés des soins de santé par des personnes qualifiées ;	☐
C) Le lieu où sont dispensés des soins de santé par un professionnel ;	☐
D) Le lieu où sont dispensés des soins de santé.	☐

45) Les objectifs du développement durable (ODD) sont :

A) Six sont liés indirectement à la santé ;	☐
B) Sont au nombre de 15 ;	☐
C) Sont au nombre de 17 ;	☐
D) Trois sont liés directement à la santé.	☐

46) Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) :

A) Comporte un plan d'effectif ;	☐
B) Est outil de planification stratégique ;	☐
C) Est synonyme de la carte sanitaire ;	☐
D) Est un outil de régulation de l'offre de soins.	☐

47) Les composantes de la couverture médicale de base sont :

A) l'AMI ;	☐
B) l'AMO ;	☐
C) CNOPS ;	☐
D) RAMED.	☐

48) Parmi les missions de l'administration centrale de Ministère de la santé figurent :

A) L'élaboration d'une politique sur la recherche et le développement ;	☐
B) La définition des priorités sanitaires nationales ;	☐
C) La gestion des ressources humaines ;	☐
D) La mise en œuvre de la politique de santé au niveau des régions.	☐

49) La déclaration du gouvernement 2017-2021 prévoit :

A) La réduction de la mortalité infantile de 27 à 20 pour 1000 naissances vivantes en 2021 ;	☐
B) L'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires de 60% à 100% en 2021 ;	☐
C) L'amélioration de l'accès aux services sanitaires de base de 27% à 50% en 2021 ;	☐
D) L'amélioration de l'accès aux services sanitaires de base de de 60% à 90% en 2021.	☐

**50) L'hôpital constitue un élément intégré dans le système national de santé.
Parmi ses missions :**

A) Appui aux soins de santé de base ;	☐
B) L'assistance médico-sociale ;	☐
C) L'enseignement et la formation ;	☐
D) La recherche et l'expertise.	☐

51) Font partie du système national de santé Marocain :

A) La médecine traditionnelle ;	☐
B) Le secteur privé ;	☐
C) Les services de santé relevant des collectivités locales ;	☐
D) Les services des FAR.	☐

52) Le régime d'assistance médicale (RAMED) est :

A) Destiné aux bénéficiaires de droit et sur demande ;	☐
B) Fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale ;	☐
C) L'un des deux régimes de la couverture médicale de base selon la loi 65-00 ;	☐
D) Lancé en 2008 dans l'ensemble du territoire marocain.	☐

53) Le renforcement de l'approche servicielle constitue par :

A) L'amélioration des conditions et de la qualité de l'accueil dans les établissements de santé ;	☐
B) L'amélioration de la santé mobile dans le milieu rural ;	☐
C) L'amélioration de la santé de la population vulnérable ;	☐
D) La généralisation du régime de l'assistance sociale.	☐

54) Dans le cadre l'engagement du Maroc pour atteindre les ODD vers 2030, le Ministère de la santé s'engage à lancer de nouveaux programmes à savoir :

A) Le programme de lutte contre l'hépatite virale ;	☐
B) Le programme de lutte contre la surdité ;	☐
C) Le programme de lutte contre les maladies non transmissibles ;	☐
D) Le programme national des urgences.	☐

55) Le Maroc connaît une modification majeure de son profile épidémiologique caractérisée par une augmentation de la charge des maladies non transmissibles qui représente actuellement :

A) 34% de tous les décès ;	☐
B) 55% de tous les décès ;	☐
C) 65% de tous les décès ;	☐
D) 75% de tous les décès.	☐

56) La transition épidémiologique nationale se caractérise par :

A) L'augmentation de l'espérance de vie ;	☐
B) La diminution du ratio de mortalité maternelle ;	☐
C) La diminution du taux de fécondité ;	☐
D) La régression des maladies non transmissibles.	☐

57) Les fonctions d'appui essentielles de santé publique sont :

A) La communication et mobilisation sociale ;	☐
B) La gouvernance en santé ;	☐
C) La préparation et riposte en santé publique aux situations d'urgence ;	☐
D) La recherche en santé publique.	☐

58) Le système d'évaluation de l'OMS appliqué aux systèmes de santé repose sur les indicateurs suivants :

A) La distribution de la réactivité dans la population ;	☐
B) La réactivité de système de santé ;	☐
C) Le niveau de la santé ;	☐
D) Les inégalités (ou disparités) de santé dans la population.	☐

59) Sont inclus aux champs des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base :

A) L'homéopathie ;	☐
B) Les actes paramédicaux ;	☐
C) Les interventions de chirurgie esthétique ;	☐
D) Les prestations de soins à l'étranger.	☐

60) Selon le rapport "Santé en chiffre 2015", le ratio habitant par infirmier du secteur public (hors CHU) est estimé à :

A) 1109 ;	☐
B) 1122 ;	☐
C) 1134 ;	☐
D) 1339.	☐

**مباراة الولوج سلك الماستر تخصص بيداغوجية علوم التمريض وتقنيات
الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة**

(دورة 24 شتنبر 2017)

Correction proposée :

- 1) La performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de :

A) <u>Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé ;</u>	☒
B) <u>Faire un usage optimal des ressources ;</u>	☒
C) <u>Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous ;</u>	☒
D) Mettre en place des stratégies.	☐

- 2) Parmi les dimensions de la qualité en santé, figurent :

A) <u>L'innocuité des soins ;</u>	☒
B) <u>La performance du système ;</u>	☒
C) L'accessibilité aux soins ;	☐
D) <u>La réactivité et l'empathie.</u>	☒

- 3) Un soin efficace se caractérise par :

A) <u>Continuité ;</u>	☒
B) <u>Intégration ;</u>	☒
C) <u>Globalité ;</u>	☒
D) Efficience.	☐

- 4) Les fonctions d'un système de santé sont :

A) <u>Prestation de services ;</u>	☒
B) <u>Financement ;</u>	☒
C) <u>Gouvernance ;</u>	☒
D) Évaluation.	☐

5) Le territoire de santé est constitué de :

A) La délégation sanitaire ;	☐
B) <u>La circonscription sanitaire ;</u>	☒
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) <u>Le territoire de santé inter régional.</u>	☒

6) Le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants :

A) Projet immobilier ;	☐
B) Projet technique ;	☐
C) Projet financier ;	☐
D) <u>Projet médical.</u>	☒

7) Les caractéristiques de la planification :

A) Elle concerne le passé et le futur ;	☐
B) <u>Elle est créative ;</u>	☒
C) <u>C'est un processus dynamique et continue ;</u>	☒
D) <u>Elle obéit aux orientations stratégiques.</u>	☒

8) Lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital :

A) Comité d'établissement ;	☐
B) <u>Comité d'accréditation et démarche qualité ;</u>	☒
C) Comité de suivi et évaluation ;	☐
D) Comité de gestion du centre hospitalier.	☐

9) Le conseil des infirmiers et des infirmières (CII) d'un hôpital :

A) Est chargé des affaires disciplinaires du personnel paramédical ;	☐
B) <u>Est composé des infirmier(e)s chefs aux départements et des infirmier(e)s chefs aux services ;</u>	☒
C) <u>Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux ;</u>	☒
D) <u>Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.</u>	☒

10) Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes :

A) <u>Analyse de la situation ;</u>	☒
B) <u>Fixation des objectifs ;</u>	☒
C) <u>Détermination des priorités ;</u>	☒
D) <u>Évaluation des ressources.</u>	☒

11) Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés :

A) <u>En 6 départements cliniques et 3 services ;</u>	☒
B) En 5 départements cliniques et 3 services ;	☐
C) En 6 départements cliniques et 2 services ;	☐
D) En 5 départements cliniques et 3 services.	☐

12) Les établissements qui ne font pas partie du réseau hospitalier sont :

A) <u>Les centres d'addictologie ;</u>	☒
B) Les centres d'hémodialyse ;	☐
C) <u>Les centres de soins palliatifs ;</u>	☒
D) Les centres régionaux d'oncologie.	☐

13) Les structures d'appui des établissements de soins de santé primaires sont :

A) Les centres de diagnostic et du traitement des maladies cardiaques ;	☐
B) Les centres de référence pour la santé des jeunes ;	☐
C) <u>Les centres de référence pour la santé reproductive ;</u>	☒
D) <u>Les laboratoires de santé publique.</u>	☒

14) Dans le réseau intégré des soins d'urgence médicales :

A) <u>Les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par les centres hospitaliers interrégionaux ;</u>	☒
B) <u>Les urgences médico-hospitalières spécialisées sont assurées par les centres hospitaliers régionaux ;</u>	☒
C) Les urgences médicales de proximité sont assurées par les centre de santé de premier niveau ;	☐
D) <u>Les urgences médico-hospitalières de base sont assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux.</u>	☒

15) Le centre de santé rural de premier niveau :

A) <u>Assure le suivi de la santé de mère et de l'enfant et des maladies chroniques ;</u>	☒
B) <u>Est l'établissement de soins de santé primaires de premier contact en milieu rural ;</u>	☒
C) Est placé sous la responsabilité d'un infirmier ;	☐
D) Offre les prestations d'urgences médicales de proximité.	☐

16) L'état de santé d'une population est le résultat dynamique de l'interaction des facteurs suivants :

A) <u>L'organisation du système de soins ;</u>	☒
B) <u>Les facteurs biologiques ;</u>	☒
C) <u>Les facteurs socio-culturels ;</u>	☒
D) <u>Les modes de vie.</u>	☒

17) Parmi les approches en santé publique, on trouve :

A) <u>Approche pluridisciplinaire ;</u>	☒
B) <u>Approche multisectorielle ;</u>	☒
C) <u>Approche verticale par problème de santé ;</u>	☒
D) <u>Approche horizontale par maladie.</u>	☒

18) Dans le processus de planification, les critères de priorisation d'un problème sont :

A) <u>La gravité ;</u>	☒
B) La pertinence ;	☐
C) La spécificité ;	☐
D) <u>La vulnérabilité.</u>	☒

19) Parmi les indicateurs suivants, les indicateurs démographiques sont :

A) <u>L'indice synthétique de fécondité ;</u>	☒
B) <u>Le taux de mortalité infanto-juvénile ;</u>	☒
C) Le taux de prévalence contraceptive ;	☐
D) Les pourcentages des accouchements en milieu surveillé.	☐

20) Le but de la couverture sanitaire universelle en matière de santé est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé sans concourir de difficultés :

A) <u>Financières ;</u>	☒
B) Logistiques ;	☐
C) Personnelles ;	☐
D) Professionnelles.	☐

21) L'OMS recommande que le budget de la santé publique soit de :

A) <u>12% du Budget total de l'état ;</u>	☒
B) 3% du Budget total de l'état ;	☐
C) 6% du Budget total de l'état ;	☐
D) 9% du Budget total de l'état.	☐

22) Les politiques, les stratégies et les plans sanitaires nationaux permettent de :

A) <u>Prendre en considération les déterminants sociaux de la santé ;</u>	☒
B) <u>Produire des plans directifs s'adressant au seul secteur public ;</u>	☒
C) Prévoir une budgétisation réaliste, un suivi et une évaluation rigoureuses ;	☐
D) <u>Renforcer les systèmes de santé par l'intermédiaire des soins de santé primaires.</u>	☒

23) L'objectif de développement durable (ODD) le plus pertinent pour la santé est l'ODD 3 qui est :

A) <u>Assurer la couverture médicale pour les 2/3 de la population ;</u>	☒
B) Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ;	☐
C) Promouvoir les soins de santé primaires ;	☐
D) Réduire le taux d'incidence de la tuberculose de 70%.	☐

24) Selon la loi cadre n 34-09, le système de santé est régi par 05 principes dont :

A) <u>L'adoption de l'approche genre en matière des services de santé ;</u>	☒
B) <u>L'égalité d'accès aux soins et services de santé ;</u>	☒
C) <u>L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;</u>	☒
D) <u>La complémentarité intersectorielle.</u>	☒

25) La mise en œuvre des principes du système de santé incombe principalement :

A) Au conseil de l'ordre des médecins ;	☐
B) Au ministère de la santé ;	☐
C) Au organismes de prévoyance sociale ;	☐
D) <u>A l'Etat.</u>	☒

26) La performance d'un système de santé dépend :

A) <u>De l'effectif des ressources humaines de leurs compétences et des ressources matérielles ;</u>	☒
B) <u>Des ressources matérielles et de la motivation du personnel ;</u>	☒
C) <u>De la connaissance des compétences de la motivation et de la distribution du personnel chargé d'organiser et de fournir des prestations ;</u>	☒
D) <u>De l'infrastructure et de la distribution du personnel.</u>	☒

27) Selon la loi cadre 34-09, le modèle du système de soins au Maroc est :

A) Décentralisé, orienté sur la prise en charge des maladies chroniques ;	☐
B) Hiérarchisé, régionalisé et fondé sur la santé communautaire ;	☐
C) <u>Pyramidal, intégré, hiérarchisé et fondé sur les soins de santé primaires ;</u>	☒
D) Transversal et fondé sur les soins ambulatoires et hospitaliers.	☐

28) La carte sanitaire a pour objectif :

A) <u>L'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé ;</u>	☒
B) La bonne gouvernance des établissements de soins ;	☐
C) <u>La détermination du cadre le plus approprié pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins ;</u>	☒
D) <u>La maîtrise et l'organisation quantitative et qualitative de l'offre de soins.</u>	☒

29) Les fonctions d'un système de santé selon l'OMS (2007) sont :

A) <u>L'information ;</u>	☒
B) La complémentarité intersectorielle ;	☐
C) <u>La production des ressources humaines ;</u>	☒
D) <u>Le financement.</u>	☒

30) L'organisation de soins doit intégrer la dimension territoriale pour :

A) <u>Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ;</u>	☒
B) Répondre à une approche ascendante ;	☐
C) Répondre à une approche descendante ;	☐
D) <u>Faciliter la responsabilité territoriale et politique en matière de santé.</u>	☒

31) Une filière de soins est :

A) Une organisation horizontale et verticale de prise en charge des patients ;	☐
B) <u>Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;</u>	☒
C) Une prise en charge des patients par le médecin relevant du secteur public ;	☐
D) <u>Une prise en charge des patients par le médecin généraliste ou le médecin traitant relevant du secteur public ou privé.</u>	☒

32) Les services d'une direction régionale de la santé comprennent :

A) <u>L'observatoire régionale de la santé ;</u>	☒
B) Le service de l'approvisionnement et de la pharmacie ;	☐
C) Le service de l'offre de soins et des équipements et de maintenance ;	☐
D) Le service des ressources humaines.	☐

33) L'offre publique de soins en mode mobile est composé des réseaux suivants :

A) Le réseau des établissements de soins de santé primaires ;	☐
B) Le réseau hospitalier ;	☐
C) Le réseau intégré des soins d'urgence médicale ;	☐
D) <u>Aucune réponse n'est juste.</u>	☒

34) L'offre de soins dans le secteur privé est composée des :

A) <u>Cabinets de médecine dentaire ;</u>	☒
B) Cliniques de jour ;	☐
C) Espaces "santé de jeunes" ;	☐
D) Hôpitaux de proximité.	☐

35) Les directions de l'administration centrale de Ministère de la santé comprennent :

A) La direction de l'information et de la communication ;	☐
B) La direction de l'informatique et des méthodes ;	☐
C) <u>La direction de la planification et des ressources financières ;</u>	☒
D) La direction des ressources humaines et contentieux.	☐

36) Selon la sixième enquête nationale sur la population et la santé familiale 2017, le nombre des décès maternels est :

A) <u>En diminution avec 72,6 décès maternels sur 100.000 naissances vivantes en 2017 contre 112 en 2010 ;</u>	☒
B) En diminution avec 92 décès maternels sur 100.000 naissances vivantes en 2017 contre 112 en 2010 ;	☐
C) En diminution seulement en milieu urbain.	☐
D) Stable entre 2010 et 2017.	☐

37) Les pathologies qui constituent une priorité dans le programme 2017-2021 du Ministère de la Santé sont :

A) VIH, maladies cardio-vasculaires et cécité ;	☐
B) Hépatite B, diabète de type 1 et maladies génétiques ;	☐
C) <u>Surdit��, maladies cardio-vasculaires et h��patite C ;</u>	☒
D) Tuberculose, Asthme et maladies mentales.	☐

38) La strat  gie sectorielle du Minist  re de la sant   2017-2021 comprend les axes suivants :

A) <u>La concr��tisation de l'approche servicielle du secteur de la sant�� ;</u>	☒
B) La lutte contre les affections de longue dur��e ;	☐
C) <u>La poursuite des chantiers de r��formes ;</u>	☒
D) <u>Le d��veloppement des ressources humaines.</u>	☒

39) L'assurance maladie obligatoire (AMO) des   tudiants est g  r  e par :

A) L'ANAM ;	☐
B) <u>La CNOPS ;</u>	☒
C) La CNSS ;	☐
D) Un assureur priv��.	☐

40) Les instances de concertation en matière de santé sont constituées par :

A) Un comité national d'évaluation et d'accréditation ;	☐
B) <u>Un comité national de veille et de sécurité sanitaire ;</u>	☒
C) <u>Un conseil national consultatif de la santé ;</u>	☒
D) <u>Une commission régionale de coordination entre le secteur public et le secteur privé.</u>	☒

41) Le centre de santé urbain de premier niveau assure les prestations suivantes :

A) <u>Le suivi des maladies chroniques ;</u>	☒
B) <u>Les consultations de médecine générale ;</u>	☒
C) Les consultations spécialisées ;	☐
D) <u>Les soins infirmiers.</u>	☒

42) Les établissements de soins de santé primaires sont appuyés par :

A) <u>Les centres de diagnostic et du traitement des maladies respiratoires ;</u>	☒
B) Les centres de consultation spécialisé ;	☐
C) Les centres d'addictologie ;	☐
D) <u>Les laboratoires de santé publique.</u>	☒

43) Les dispositions du décret d'application de la loi cadre n°34-09 ne s'appliquent pas aux :

A) <u>Bureaux communaux d'hygiène ;</u>	☒
B) Centres d'hémodialyse ;	☐
C) Structures hospitalières relevant des CHU ;	☐
D) <u>Structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques.</u>	☒

44) On entend par installation de santé :

A) <u>Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle ;</u>	☒
B) Le lieu où sont dispensés des soins de santé par des personnes qualifiées ;	☐
C) Le lieu où sont dispensés des soins de santé par un professionnel ;	☐
D) Le lieu où sont dispensés des soins de santé.	☐

45) Les objectifs du développement durable (ODD) sont :

A) Six sont liés indirectement à la santé ;	☐
B) Sont au nombre de 15 ;	☐
C) <u>Sont au nombre de 17 ;</u>	☒
D) Trois sont liés directement à la santé.	☐

46) Le schéma régional de l'offre de soins (SROS) :

A) Comporte un plan d'effectif ;	☐
B) <u>Est outil de planification stratégique ;</u>	☒
C) Est synonyme de la carte sanitaire ;	☐
D) Est un outil de régulation de l'offre de soins.	☐

47) Les composantes de la couverture médicale de base sont :

A) l'AMI ;	☐
B) <u>l'AMO ;</u>	☒
C) CNOPS ;	☐
D) RAMED.	☐

48) Parmi les missions de l'administration centrale de Ministère de la santé figurent :

A) L'élaboration d'une politique sur la recherche et le développement ;	☐
B) <u>La définition des priorités sanitaires nationales ;</u>	☒
C) La gestion des ressources humaines ;	☐
D) La mise en œuvre de la politique de santé au niveau des régions.	☐

49) La déclaration du gouvernement 2017-2021 prévoit :

A) <u>La réduction de la mortalité infantile de 27 à 20 pour 1000 naissances vivantes en 2021 ;</u>	☒
B) <u>L'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires de 60% à 100% en 2021 ;</u>	☒
C) L'amélioration de l'accès aux services sanitaires de base de 27% à 50% en 2021 ;	☐
D) L'amélioration de l'accès aux services sanitaires de base de de 60% à 90% en 2021.	☐

50) L'hôpital constitue un élément intégré dans le système national de santé.
Parmi ses missions :

A) <u>Appui aux soins de santé de base ;</u>	☒
B) <u>L'assistance médico-sociale ;</u>	☒
C) <u>L'enseignement et la formation ;</u>	☒
D) <u>La recherche et l'expertise.</u>	☒

51) Font partie du système national de santé Marocain :

A) <u>La médecine traditionnelle ;</u>	☒
B) <u>Le secteur privé ;</u>	☒
C) <u>Les services de santé relevant des collectivités locales ;</u>	☒
D) <u>Les services des FAR.</u>	☒

52) Le régime d'assistance médicale (RAMED) est :

A) <u>Destiné aux bénéficiaires de droit et sur demande ;</u>	☒
B) <u>Fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale ;</u>	☒
C) <u>L'un des deux régimes de la couverture médicale de base selon la loi 65-00 ;</u>	☒
D) Lancé en 2008 dans l'ensemble du territoire marocain.	☐

53) Le renforcement de l'approche servicielle constitue par :

A) <u>L'amélioration des conditions et de la qualité de l'accueil dans les établissements de santé ;</u>	☒
B) <u>L'amélioration de la santé mobile dans le milieu rural ;</u>	☒
C) <u>L'amélioration de la santé de la population vulnérable ;</u>	☒
D) La généralisation du régime de l'assistance sociale.	☐

54) Dans le cadre l'engagement du Maroc pour atteindre les ODD vers 2030, le Ministère de la santé s'engage à lancer de nouveaux programmes à savoir :

A) <u>Le programme de lutte contre l'hépatite virale ;</u>	☒
B) <u>Le programme de lutte contre la surdité ;</u>	☒
C) <u>Le programme de lutte contre les maladies non transmissibles ;</u>	☒
D) <u>Le programme national des urgences.</u>	☒

55) Le Maroc connaît une modification majeure de son profile épidémiologique caractérisée par une augmentation de la charge des maladies non transmissibles qui représente actuellement :

A) 34% de tous les décès ;	☐
B) 55% de tous les décès ;	☐
C) 65% de tous les décès ;	☐
D) 75% de tous les décès.	☒

56) La transition épidémiologique nationale se caractérise par :

A) L'augmentation de l'espérance de vie ;	☒
B) La diminution du ratio de mortalité maternelle ;	☒
C) La diminution du taux de fécondité ;	☒
D) La régression des maladies non transmissibles.	☐

57) Les fonctions d'appui essentielles de santé publique sont :

A) La communication et mobilisation sociale ;	☒
B) La gouvernance en santé ;	☒
C) La préparation et riposte en santé publique aux situations d'urgence ;	☐
D) La recherche en santé publique.	☒

58) Le système d'évaluation de l'OMS appliqué aux systèmes de santé repose sur les indicateurs suivants :

A) La distribution de la réactivité dans la population ;	☒
B) La réactivité de système de santé ;	☒
C) Le niveau de la santé ;	☒
D) Les inégalités (ou disparités) de santé dans la population.	☒

59) Sont inclus aux champs des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base :

A) L'homéopathie ;	☐
B) Les actes paramédicaux ;	☒
C) Les interventions de chirurgie esthétique ;	☐
D) Les prestations de soins à l'étranger.	☐

60) Selon le rapport "Santé en chiffre 2015", le ratio habitant par infirmier du secteur public (hors CHU) est estimé à :

A) 1109 ;	☐
B) 1122 ;	☐
C) 1134 ;	☐
D) 1339.	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 28 ماي 2017)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique ;	☐
B) Physique et social ;	☐
C) Physique et mental ;	☐
D) Physique, mental et social.	☐

2) Les soins de santé de base (primaire) :

A) Sont des soins préventifs seulement ;	☐
B) Sont assurés au niveau du réseau hospitalier ;	☐
C) Sont des soins préventifs curatifs et promotionnels ;	☐
D) Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé.	☐

3) Au Maroc, l'offre de soin est assurée par :

A) Le secteur public ;	☐
B) Le secteur privé ;	☐
C) Le secteur public et le secteur traditionnel ;	☐
D) Le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel.	☐

4) Le premier financeur du système de santé au Maroc :

A) Les ménages ;	☐
B) Les mutuelles ;	☐
C) L'Etat ;	☐
D) Les collectivités locales.	☐

5) Selon de la rapport santé en chiffres 2014, l'Espérance de Vie à la Naissance au Maroc est de :

A) 76,5 ans ;	☐
B) 79,4 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) 75,4 ans.	☐

6) Lequel des services suivants ne fait pas partie de la direction régionale de la santé :

A) Service de l'offre de soins ;	☐
B) Service administratif et technique ;	☐
C) Service des ressources humains et contentieux ;	☐
D) Service des ressources financières, de la logistique et partenariat.	☐

7) On entend par filière de soins :

A) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients.	☐

8) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) L'institut national d'hygiène ;	☐
B) Le centre national antipoison et de pharmacovigilance ;	☐
C) Les centres d'addictologie ;	☐
D) Le centre national de Radioprotection.	☐

9) Les centres hospitaliers inter-régionaux sont :

A) Des hôpitaux SEGMA (service d'Etat géré de manière autonome) ;	☐
B) Des hôpitaux en régie ;	☐
C) Des hôpitaux du niveau tertiaire ;	☐
D) Des hôpitaux privés.	☐

10) La durée d'admission au régime d'assistance médicale des personnes reconnues éligibles est :

A) Un an ;	☐
B) Deux ans ;	☐
C) Trois ans ;	☐
D) Quatre ans.	☐

11) Le régime d'assistance médicale couvre des prestations médicalement requises suivants :

A) Analyse de biologie médicale ;	☐
B) Radiologie et imagerie médicale ;	☐
C) chirurgie plastique et esthétique ;	☐
D) orthodontie pour les enfants.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 28 ماي 2017)

Correction proposée :

1) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique ;	☐
B) Physique et social ;	☐
C) Physique et mental ;	☐
D) <u>Physique, mental et social.</u>	☒

2) Les soins de santé de base (primaire) :

A) Sont des soins préventifs seulement ;	☐
B) Sont assurés au niveau du réseau hospitalier ;	☐
C) <u>Sont des soins préventifs curatifs et promotionnels ;</u>	☐
D) <u>Représentent le premier contact des individus avec le système national de santé.</u>	☒

3) Au Maroc, l'offre de soin est assurée par :

A) <u>Le secteur public ;</u>	☒
B) <u>Le secteur privé ;</u>	☒
C) Le secteur public et le secteur traditionnel ;	☐
D) Le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel.	☐

4) Le premier financeur du système de santé au Maroc :

A) <u>Les ménages ;</u>	☒
B) Les mutuelles ;	☐
C) L'Etat ;	☐
D) Les collectivités locales.	☐

5) Selon de la rapport santé en chiffres 2014, l'Esperance de Vie à la Naissance au Maroc est de :

A) 76,5 ans ;	☐
B) 79,4 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) <u>75,4 ans.</u>	☒

6) Lequel des services suivants ne fait pas partie de la direction régionale de la santé :

A) Service de l'offre de soins ;	☐
B) <u>Service administratif et technique ;</u>	☒
C) Service des ressources humains et contentieux ;	☐
D) Service des ressources financières, de la logistique et partenariat.	☐

7) On entend par filière de soins :

A) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) <u>Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients.</u>	☒

8) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) <u>L'institut national d'hygiène ;</u>	☒
B) <u>Le centre national antipoison et de pharmacovigilance ;</u>	☒
C) Les centres d'addictologie ;	☐
D) <u>Le centre national de Radioprotection.</u>	☒

9) Les centres hospitaliers inter-régionaux sont :

A) Des hôpitaux SEGMA (service d'Etat géré de manière autonome) ;	☐
B) Des hôpitaux en régie ;	☐
C) <u>Des hôpitaux du niveau tertiaire ;</u>	☒
D) Des hôpitaux privés.	☐

10) La durée d'admission au régime d'assistance médicale des personnes reconnues éligibles est :

A) Un an ;	☐
B) Deux ans ;	☐
C) <u>Trois ans ;</u>	☒
D) Quatre ans.	☐

11) Le régime d'assistance médicale couvre des prestations médicalement requises suivants :

A) <u>Analyse de biologie médicale ;</u>	☒
B) <u>Radiologie et imagerie médicale ;</u>	☒
C) chirurgie plastique et esthétique ;	☐
D) <u>orthodontie pour les enfants.</u>	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار المشترك

(دورة 12 فبراير 2017)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La direction régionale de la sante comporte les unités suivantes :

A) Unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie ;	☐
B) Unité régionale de communication et information ;	☐
C) Unité régionale d'équipement et de la maintenance ;	☐
D) Unité régionale de santé publique.	☐

2) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique et mental ;	☐
B) Physique, mental et social ;	☐
C) Physique et social ;	☐
D) Physique.	☐

3) En 2014 :

A) Le taux de mortalité est de 220 décès/ 100.000 naissance vivantes ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 10.000 naissances vivantes ;	☐
C) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
D) L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans.	☐

4) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

A) Réseau de soins de santé primaires ;	☐
B) Réseau des établissements médico-sociaux publics ;	☐
C) Réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
D) Réseau des établissements hospitalier relevant des forces armes royales.	☐

5) La circonscription sanitaire :

A) Peut-être rurale ;	☐
B) Peut-être urbaine ;	☐
C) Est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

6) Le réseau des soins de santé primaire est constitué des établissements suivants :

A) Les dispensaires ruraux lorsqu'ils existent ;	☐
B) Les centres de santé ruraux et urbains de premier niveau ;	☐
C) Les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ;	☐
D) Les centres de santé ruraux et urbains de troisième niveau.	☐

7) Lesquelles des prestations suivantes ne font pas partie du centre de santé urbain de premier niveau :

A) Les consultations de médecine générale ;	☐
B) Les consultations de santé mentale ;	☐
C) Les soins infirmiers ;	☐
D) Les soins bucco-dentaires.	☐

8) Quel est le premier financeur du système de santé au Maroc :

A) L'Etat ;	☐
B) Les ménages ;	☐
C) Les collectivités locales ;	☐
D) Les mutuelles.	☐

9) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) Les centres d'addictologie ;	☐
B) Le Centre national de radioprotection ;	☐
C) Le Centre national antipoison et de pharmacovigilance ;	☐
D) L'Institut national d'hygiène.	☐

10) Lesquelles des prestations suivantes ne sont pas dispensées par le centre hospitalier provincial ou préfectoral :

A) Ophtalmologie ;	☐
B) Chirurgie maxillo-faciale ;	☐
C) Oto-rhino-laryngologie ;	☐
D) Réanimation néonatale.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة الاختبار المشترك

(دورة 12 فبراير 2017)

Correction proposée :

1) La direction régionale de la sante comporte les unités suivantes :

A) <u>Unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie ;</u>	☒
B) <u>Unité régionale de communication et information ;</u>	☒
C) Unité régionale d'équipement et de la maintenance ;	☐
D) Unité régionale de santé publique.	☐

2) Selon l'OMS la santé est un état complet de bien être :

A) Physique et mental ;	☐
B) <u>Physique, mental et social ;</u>	☒
C) Physique et social ;	☐
D) Physique.	☐

3) En 2014 :

A) Le taux de mortalité est de 220 décès/ 100.000 naissance vivantes ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 10.000 naissances vivantes ;	☐
C) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
D) <u>L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans.</u>	☒

4) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des réseaux suivants :

A) <u>Réseau de soins de santé primaires ;</u>	☒
B) <u>Réseau des établissements médico-sociaux publics ;</u>	☒
C) <u>Réseau intégré des soins d'urgences médicales ;</u>	☒
D) Réseau des établissements hospitalier relevant des forces armes royales.	☐

5) La circonscription sanitaire :

A) <u>Peut-être rurale ;</u>	☒
B) <u>Peut-être urbaine ;</u>	☒
C) <u>Est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;</u>	☒
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

6) Le réseau des soins de santé primaire est constitué des établissements suivants :

A) <u>Les dispensaires ruraux lorsqu'ils existent ;</u>	☒
B) <u>Les centres de santé ruraux et urbains de premier niveau ;</u>	☒
C) <u>Les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ;</u>	☒
D) Les centres de santé ruraux et urbains de troisième niveau.	☐

7) Lesquelles des prestations suivantes ne font pas partie du centre de santé urbain de premier niveau :

A) Les consultations de médecine générale ;	☐
B) <u>Les consultations de santé mentale ;</u>	☒
C) Les soins infirmiers ;	☐
D) <u>Les soins bucco-dentaires.</u>	☒

8) Quel est le premier financeur du système de santé au Maroc :

A) L'Etat ;	☐
B) <u>Les ménages ;</u>	☒
C) Les collectivités locales ;	☐
D) Les mutuelles.	☐

9) Les structures d'appui du réseau hospitalier sont constituées des établissements suivants :

A) Les centres d'addictologie ;	☐
B) <u>Le Centre national de radioprotection ;</u>	☒
C) <u>Le Centre national antipoison et de pharmacovigilance ;</u>	☒
D) <u>L'Institut national d'hygiène.</u>	☒

10) Lesquelles des prestations suivantes ne sont pas dispensées par le centre hospitalier provincial ou préfectoral :

A) Ophtalmologie ;	☐
B) <u>Chirurgie maxillo-faciale ;</u>	☒
C) Oto-rhino-laryngologie ;	☐
D) <u>Réanimation néonatale.</u>	☒



2016

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضين وتقني الصحة

(دورة 09 أكتوبر 2016)

المدة : 3 ساعات

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La performance d'un système de financement de santé se mesure à sa capacité de :

A) Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé ;	☐
B) Faire un usage optimal des ressources ;	☐
C) Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous ;	☐
D) Mettre en place des stratégies.	☐

2) Parmi les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé :

A) L'importance du prépaiement ;	☐
B) Le degré de répartition du risque financier ;	☐
C) La qualité des services ;	☐
D) La subvention des pauvres.	☐

3) Les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont :

A) Les couts directs ;	☐
B) La population ;	☐
C) Les services ;	☐
D) Les stratégies.	☐

4) La durée moyenne de séjour (DMS) est un indicateur de performance hospitalière qui renseigne sur :

A) La productivité ;	☐
B) La qualité des soins ;	☐
C) L'attractivité de l'hôpital ;	☐
D) La satisfaction des clients.	☐

5) Parmi les objectifs de l'économie de la santé :

A) Réduire les dépenses en santé ;	☐
B) Contrôler les agents économiques ;	☐
C) Rechercher la meilleure utilisation des ressources ;	☐
D) Proposer des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.	☐

6) Le cout peut se définir en étant :

A) L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service en plus de l'usure des immobilisations nécessaires à cette production ;	☐
B) L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service pendant un moment ;	☐
C) Résultante de la confrontation de deux forces contraires l'offre et la demande en plus de l'obsolescence des immobilisations des deux forces ;	☐
D) Prix fixé par l'institution pour un produit pour des raisons économiques et sociales.	☐

7) Les comptes nationaux de la santé :

A) Incluent toutes les parties jouant un rôle dans le financement ;	☐
B) Approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national ;	☐
C) Fournissent des estimations approximatives ;	☐
D) Ils sont axés autour des sources de financement.	☐

8) Parmi les dimensions de la qualité en santé :

A) L'innocuité des soins ;	☐
B) La performance du système ;	☐
C) L'accessibilité aux soins ;	☐
D) La réactivité et l'empathie.	☐

9) Parmi les approches de résolution des problèmes pour l'amélioration de la qualité :

A) Résolution individuelle de problème ;	☐
B) Résolution systématique de problème en équipe ;	☐
C) Résolution institutionnelle de problème ;	☐
D) Amélioration des processus.	☐

10) L'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité doit :

A) La source d'information sur le problème ;	☐
B) Évoquer la fréquence du problème ;	☐
C) Indiquer la solution du problème ;	☐
D) Mentionner la cause du problème.	☐

11) Les catégories des déterminants de la santé :

A) Mode de vie ;	☐
B) Environnement ;	☐
C) Organisation des soins ;	☐
D) Technologie médicale.	☐

12) L'intégration des soins est :

A) Une intégration dans le temps et dans l'espace ;	☐
B) Une intégration dans le temps et dans l'espace et des services ;	☐
C) Une intégration dans l'espace et des services ;	☐
D) Une intégration dans le temps et des services.	☐

13) Un rapport ou le numérateur est compris dans le dénominateur pendant un temps donné est :

A) Indice ;	☐
B) Ratio ;	☐
C) Taux ;	☐
D) Proportion.	☐

14) Les études épidémiologiques sont classées selon :

A) L'élément de départ ;	☐
B) Le temps ;	☐
C) L'objectif de l'étude ;	☐
D) Les moyens d'investigation.	☐

15) Une étude transversale est une étude épidémiologique :

A) De prévalence ;	☐
B) S'intéresse aux conditions passées du groupe étudié ;	☐
C) Prospective ;	☐
D) Donne des informations généralisables.	☐

16) Les fonctions d'un système de santé :

A) Prestation de services ;	☐
B) Financement ;	☐
C) Gouvernance ;	☐
D) Évaluation.	☐

17) La prévalence est le nombre de :

A) Nouveau cas survenus dans une population à risque pendant un intervalle de temps ;	☐
B) Nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné ;	☐
C) Taux de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée ;	☐
D) Nombre de cas existant dans une population donnée.	☐

18) L'efficacité exprime :

A) Le rapport des résultats d'un programme ou d'une action de santé aux moyens engagés ;	☐
B) L'effet désiré d'un programme ou d'une action de santé sur la réduction d'un problème de santé ;	☐
C) Le degré de réalisation des objectifs et cibles prédéterminées d'un programme ;	☐
D) L'effet global d'un programme ou d'une action de santé sur le développement sanitaire.	☐

19) Le taux de létalité est :

A) Le nombre de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique ;	☐
B) Proportion de décès dans une population pendant une période définie ;	☐
C) Proportion de décès pour sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée ;	☐
D) Nombre de décès pour cause donnée pendant une période donnée.	☐

20) Parmi les domaines d'action prioritaires qui contribuent à réaliser l'objectif de l'OMS relatif au « vieillissement en bonne santé » :

A) Harmoniser les systèmes de santé aux besoins de la population ;	☐
B) Développer les systèmes de soins spécifiques ;	☐
C) Créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées ;	☐
D) Améliorer l'évaluation, les méthodes de surveillance et la compréhension.	☐

21) Un soin efficace se caractérise par :

A) Continuité ;	☐
B) Intégration ;	☐
C) Globalité ;	☐
D) Efficience.	☐

22) Les caractéristiques d'un service de soins sont :

A) Décentralisation, permanence, polyvalence ;	☐
B) Décentralisation, efficience, accessibilité ;	☐
C) Spécificité, efficacité, permanence ;	☐
D) Décentralisation, polyvalence, proximité.	☐

23) Les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé :

A) La disponibilité des ressources suffisantes ;	☐
B) L'utilisation efficiente et équitable des ressources ;	☐
C) La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins ;	☐
D) La gouvernance du système national de santé.	☐

24) L'évaluation des politiques en santé publique vise à :

A) Apporter des solutions ;	☐
B) Juger du succès ou de l'échec d'une action ;	☐
C) Aider à la solution ;	☐
D) Améliorer l'ensemble du processus de planification.	☐

25) Parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé, on trouve :

A) Disponibilité ;	☐
B) Taux d'accroissement ;	☐
C) Utilisation des services ;	☐
D) Taux de recouvrement.	☐

26) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

A) Taux de mortalité maternelle ;	☐
B) Disponibilité des médicaments essentiels ;	☐
C) Taux d'accouchement en milieu surveillé ;	☐
D) Espérance de vie à la naissance.	☐

27) La santé communautaire :

A) Fait partie intégrante de la santé publique ;	☐
B) Peut-être populationnelle et individuelle ;	☐
C) Est liées à un ensemble de facteurs démographiques, géographiques, sociaux ;	☐
D) Est fondée sur le principe de « faire pour » les gens.	☐

28) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées, par ordre décroissant, pour :

A) Achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers, soins ambulatoires ;	☐
B) Achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires, soins hospitaliers ;	☐
C) Soins hospitaliers, achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires ;	☐
D) Soins ambulatoires, achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers.	☐

29) Les acteurs impliqués dans le diagnostic communautaire sont :

A) La population/communauté ;	☐
B) Les agents de développement/médiateurs ;	☐
C) Les professionnels et les experts ;	☐
D) L'individu.	☐

30) La caisse nationale des organismes de prévoyance sociale gère l'AMO pour :

A) Les étudiants ;	☐
B) Les anciennes victimes des violations des droits de l'homme ;	☐
C) Les anciens membres de la résistance ;	☐
D) Les agents de l'autorité et les Imams des mosquées.	☐

31) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses des ménages, ont été consacrées, par ordre décroissant, pour les prestations suivantes :

A) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, consultations médicales, hospitalisation, analyses médicales ;	☐
B) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, analyses médicales, consultations médicales ;	☐
C) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, consultations médicales, analyses médicales ;	☐
D) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, analyses médicales, hospitalisation, consultations médicales.	☐

32) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses de la coopération internationale ont été orientées essentiellement vers :

A) L'équipement ;	☐
B) L'investissement ;	☐
C) L'expertise ;	☐
D) Médicaments et biens médicaux.	☐

33) Les trois causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonataux survenus les 48 premières heures de la vie sont :

A) Les anomalies liées à une brièveté de la gestation ;	☐
B) L'hypoxie intra-utérine ;	☐
C) Le diabète gestationnel ;	☐
D) Les infections spécifiques de la période périnatale.	☐

34) Le plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021 comprend :

A) 4 axes et 17 mesures ;	☐
B) 5 axes et 21 mesures ;	☐
C) 6 axes et 20 mesures ;	☐
D) 7 axes et 23 mesures.	☐

35) Parmi les axes du plan d'action national sur la santé et le handicap 2015- 2021, on trouve :

A) Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat ;	☐
B) La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation ;	☐
C) Le renforcement de la participation communautaire ;	☐
D) La recherche.	☐

36) Selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la commission nationale de l'offre de soins est assuré par :

A) L'inspection générale ;	☐
B) La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;	☐
C) La direction de la réglementation et du contentieux ;	☐
D) Le secrétariat général.	☐

37) La commission régionale de l'offre de soins :

A) Est présidée par le directeur régional de la santé de la région concernée ou son représentant ;	☐
B) Est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant ;	☐
C) Est présidée par le président du conseil de la région de la région concernée ou son représentant ;	☐
D) Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la santé de la région concernée.	☐

38) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

A) Sont établis par les directions régionales de la santé concernées ;	☐
B) Sont établis pour une période de trois ans ;	☐
C) Sont approuvés par des arrêtés du ministre de la santé ;	☐
D) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité.	☐

39) Selon le décret de la carte sanitaire, la carte sanitaire :

A) Est établie pour une période de dix ans ;	☐
B) Doit être évaluée tous les cinq ans ;	☐
C) Est établie par arrêté du ministre de la santé ;	☐
D) Doit être évaluée tous les trois ans.	☐

40) Les fonctions de soins d'urgence médicales sont :

A) Au nombre de 14 fonctions ;	☐
B) Au nombre de 15 fonctions ;	☐
C) Au nombre de 16 fonctions ;	☐
D) Au nombre de 17 fonctions.	☐

41) Les principaux axes du plan national pour la prise en charge des urgences médicales sont :

A) Amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières ;	☐
B) La réorganisation et la restructuration de la prise en charge des urgences médicales hospitalières ;	☒
C) Renforcement du partenariat public-privé et public-public ;	☒
D) Tous les réponses sont justes.	☐

42) Parmi les services d'information et d'orientation aux citoyens :

A) ALLO SAMU 121 ;	☐
B) ALLO surveillance épidémiologique ;	☐
C) ALLO intoxication ;	☐
D) Sihati.	☐

43) Les facteurs de risque reconnus par l'OMS comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes sont :

A) La consommation du tabac ;	☐
B) L'usage nocif de l'alcool ;	☐
C) L'alimentation malsaine ;	☐
D) Le manque d'activité physique et la sédentarité.	☐

44) Le dépistage sélectif du diabète dans les établissements de soins de santé primaires se fait au profit de :

A) Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA ;	☐
B) Femmes avec antécédents de diabète gestationnel ;	☐
C) Personnes avec hyperthyroïdie ;	☐
D) Personnes âgées de plus de 45 ans.	☐

45) Dans le programme de lutte antituberculeuse la définition de cas se classe selon :

A) Le site anatomique ;	☐
B) La résistance aux médicaments ;	☐
C) Le statut par rapport au VIH ;	☐
D) L'antécédent de traitement anti bacillaire.	☐

46) La direction régionale de la santé est composée de :

A) Service de ressources humaines et contentieux ;	☐
B) Service des ressources financières ;	☐
C) Unité d'approvisionnement ;	☐
D) Unité de formation et de communication.	☐

47) Le territoire de santé est constitué de :

A) La délégation sanitaire ;	☐
B) La circonscription sanitaire ;	☐
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) Le territoire de santé inter-régional.	☐

48) Lequel des établissements de santé suivants ne fait pas partie du réseau hospitalier :

A) Hôpital psychiatrique ;	☐
B) Centre d'hémodialyse ;	☐
C) Hôpital provincial d'oncologie ;	☐
D) Hôpital régional.	☐

49) Le réseau hospitalier est appuyé par :

A) Centre d'addictologie ;	☐
B) Centre de soins palliatifs ;	☐
C) Centre national de radioprotection ;	☐
D) Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie.	☐

50) Les établissements médico-sociaux publics :

A) Offrent des prestations de soins sans hébergement ;	☐
B) Sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés ;	☐
C) Font partie du réseau hospitalier ;	☐
D) Assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades.	☐

51) Quelle que soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau, il dispense les prestations suivantes :

A) Le suivi des malades chroniques ;	☐
B) L'assistance de l'accouchement ;	☐
C) La réalisation des examens d'échographie obstétricale ;	☐
D) Les consultations de santé mentale.	☐

52) Les fonctions essentielles de santé publique sont au nombre de :

A) 4 fonctions ;	☐
B) 6 fonctions ;	☐
C) 8 fonctions ;	☐
D) 9 fonctions.	☐

53) Le livre blanc « pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé » élaboré à l'occasion de la 2^{ème} conférence nationale sur la santé (Juillet 2013) a identifié :

A) 3 axes et 9 chantiers pour la réforme ;	☐
B) 5 axes et 9 chantiers pour la réforme ;	☐
C) 3 axes et 10 chantiers pour la réforme ;	☐
D) 6 axes et 10 chantiers pour la réforme.	☐

54) Parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie :

A) Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires ;	☐
B) Disponibilité des médicaments et biens médicaux ;	☐
C) Accessibilité aux soins ;	☐
D) Garantie d'un personnel suffisant et compétent.	☐

55) En santé publique, on évalue :

A) La pertinence de l'action ;	☐
B) L'impact de l'action ;	☐
C) L'accessibilité de l'action ;	☐
D) La cohérence de l'action.	☐

56) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soin, le droit à la protection de la santé est une :

A) Responsabilité des citoyens ;	☐
B) Responsabilité des citoyens et de l'Etat ;	☐
C) Responsabilité de l'Etat et de la société ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

57) Le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants :

A) Projet immobilier ;	☐
B) Projet technique ;	☐
C) Projet financier ;	☐
D) Projet médical.	☐

58) Selon la portée de la démarche, la planification est :

A) Tactique ;	☐
B) Pragmatique ;	☐
C) Populationnelle ;	☐
D) Opérationnelle.	☐

59) Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes :

A) Analyse de la situation ;	☐
B) Fixation des objectifs ;	☐
C) Détermination des priorités ;	☐
D) Évaluation des ressources.	☐

60) Les caractéristiques de la planification :

A) Concerne le passé et le futur ;	☐
B) Créative ;	☐
C) Processus dynamique et continue ;	☐
D) Obéit aux orientations stratégiques.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

(دورة 09 أكتوبر 2016)

المدة : 3 ساعات

Correction proposée :

- 1) La performance d'un système de financement de santé se mesure à sa capacité de :

A) <u>Générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé ;</u>	☒
B) <u>Faire un usage optimal des ressources ;</u>	☒
C) Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous ;	☐
D) <u>Mettre en place des stratégies.</u>	☒

- 2) Parmi les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé :

A) <u>L'importance du prépaiement ;</u>	☒
B) <u>Le degré de répartition du risque financier ;</u>	☒
C) La qualité des services ;	☐
D) <u>La subvention des pauvres.</u>	☒

- 3) Les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont :

A) <u>Les couts directs ;</u>	☒
B) <u>La population ;</u>	☒
C) <u>Les services ;</u>	☒
D) Les stratégies.	☐

4) La durée moyenne de séjour (DMS) est un indicateur de performance hospitalière qui renseigne sur :

A) <u>La productivité ;</u>	☒
B) La qualité des soins ;	☐
C) L'attractivité de l'hôpital ;	☐
D) La satisfaction des clients.	☐

5) Parmi les objectifs de l'économie de la santé :

A) Réduire les dépenses en santé ;	☐
B) Contrôler les agents économiques ;	☐
C) <u>Rechercher la meilleure utilisation des ressources ;</u>	☒
D) <u>Proposer des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé.</u>	☒

6) Le cout peut se définir en étant :

A) <u>L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service en plus de l'usure des immobilisations nécessaires à cette production ;</u>	☐
B) L'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou service pendant un moment ;	☐
C) Résultante de la confrontation de deux forces contraires l'offre et la demande en plus de l'obsolescence des immobilisations des deux forces ;	☐
D) Prix fixé par l'institution pour un produit pour des raisons économiques et sociales.	☐

7) Les comptes nationaux de la santé :

A) <u>Incluent toutes les parties jouant un rôle dans le financement ;</u>	☒
B) Approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national ;	☐
C) Fournissent des estimations approximatives ;	☐
D) <u>Ils sont axés autour des sources de financement.</u>	☒

8) Parmi les dimensions de la qualité en santé :

A) <u>L'innocuité des soins ;</u>	☒
B) <u>La performance du système ;</u>	☒
C) L'accessibilité aux soins ;	☐
D) <u>La réactivité et l'empathie.</u>	☒

9) Parmi les approches de résolution des problèmes pour l'amélioration de la qualité :

A) Résolution individuelle de problème ;	☐
B) <u>Résolution systématique de problème en équipe ;</u>	☒
C) <u>Résolution institutionnelle de problème ;</u>	☒
D) Amélioration des processus.	☐

10) L'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité doit :

A) <u>La source d'information sur le problème ;</u>	☒
B) <u>Évoquer la fréquence du problème ;</u>	☒
C) Indiquer la solution du problème ;	☐
D) <u>Mentionner la cause du problème.</u>	☒

11) Les catégories des déterminants de la santé :

A) <u>Mode de vie ;</u>	☒
B) <u>Environnement ;</u>	☒
C) <u>Organisation des soins ;</u>	☒
D) Technologie médicale.	☐

12) L'intégration des soins est :

A) Une intégration dans le temps et dans l'espace ;	☐
B) <u>Une intégration dans le temps et dans l'espace et des services ;</u>	☒
C) Une intégration dans l'espace et des services ;	☐
D) Une intégration dans le temps et des services.	☐

13) Un rapport ou le numérateur est compris dans le dénominateur pendant un temps donné est :

A) Indice ;	☐
B) Ratio ;	☐
C) <u>Taux ;</u>	☒
D) Proportion.	☐

14) Les études épidémiologiques sont classées selon :

A) <u>L'élément de départ ;</u>	☒
B) Le temps ;	☐
C) <u>L'objectif de l'étude ;</u>	☒
D) <u>Les moyens d'investigation.</u>	☒

15) Une étude transversale est une étude épidémiologique :

A) <u>De prévalence ;</u>	☒
B) S'intéresse aux conditions passées du groupe étudié ;	☐
C) Prospective ;	☐
D) Donne des informations généralisables.	☐

16) Les fonctions d'un système de santé :

A) <u>Prestation de services ;</u>	☒
B) <u>Financement ;</u>	☒
C) <u>Gouvernance ;</u>	☒
D) Évaluation.	☐

17) La prévalence est le nombre de :

A) Nouveau cas survenus dans une population à risque pendant un intervalle de temps ;	☐
B) <u>Nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné ;</u>	☒
C) Taux de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée ;	☐
D) Nombre de cas existant dans une population donnée.	☐

18) L'efficacité exprime :

A) Le rapport des résultats d'un programme ou d'une action de santé aux moyens engagés ;	☐
B) L'effet désiré d'un programme ou d'une action de santé sur la réduction d'un problème de santé ;	☐
C) <u>Le degré de réalisation des objectifs et cibles prédéterminées d'un programme ;</u>	☒
D) L'effet global d'un programme ou d'une action de santé sur le développement sanitaire.	☐

19) Le taux de létalité est :

A) Le nombre de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique ;	☐
B) Proportion de décès dans une population pendant une période définie ;	☐
C) <u>Proportion de décès pour sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée ;</u>	☒
D) Nombre de décès pour cause donnée pendant une période donnée.	☐

20) Parmi les domaines d'action prioritaires qui contribuent à réaliser l'objectif de l'OMS relatif au « vieillissement en bonne santé » :

A) Harmoniser les systèmes de santé aux besoins de la population ;	☐
B) <u>Développer les systèmes de soins spécifiques ;</u>	☒
C) <u>Créer des environnements facilitateurs pour les personnes âgées ;</u>	☒
D) <u>Améliorer l'évaluation, les méthodes de surveillance et la compréhension.</u>	☒

21) Un soin efficace se caractérise par :

A) <u>Continuité ;</u>	☒
B) <u>Intégration ;</u>	☒
C) <u>Globalité ;</u>	☒
D) Efficience.	☐

22) Les caractéristiques d'un service de soins sont :

A) <u>Décentralisation, permanence, polyvalence ;</u>	☒
B) Décentralisation, efficience, accessibilité ;	☐
C) Spécificité, efficacité, permanence ;	☐
D) Décentralisation, polyvalence, proximité.	☐

23) Les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé :

A) <u>La disponibilité des ressources suffisantes ;</u>	☒
B) <u>L'utilisation efficiente et équitable des ressources ;</u>	☒
C) <u>La dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont besoin de soins ;</u>	☒
D) La gouvernance du système national de santé.	☐

24) L'évaluation des politiques en santé publique vise à :

A) Apporter des solutions ;	☐
B) <u>Juger du succès ou de l'échec d'une action ;</u>	☒
C) <u>Aider à la solution ;</u>	☒
D) <u>Améliorer l'ensemble du processus de planification.</u>	☒

25) Parmi les indicateurs de la prestation de soins de santé, on trouve :

A) <u>Disponibilité ;</u>	☒
B) Taux d'accroissement ;	☐
C) <u>Utilisation des services ;</u>	☒
D) Taux de recouvrement.	☐

26) Parmi les indicateurs de l'état de santé, on trouve :

A) <u>Taux de mortalité maternelle ;</u>	☒
B) Disponibilité des médicaments essentiels ;	☐
C) Taux d'accouchement en milieu surveillé ;	☐
D) <u>Espérance de vie à la naissance.</u>	☒

27) La santé communautaire :

A) <u>Fait partie intégrante de la santé publique ;</u>	☒
B) Peut-être populationnelle et individuelle ;	☐
C) <u>Est liées à un ensemble de facteurs démographiques, géographiques, sociaux ;</u>	☒
D) Est fondée sur le principe de « faire pour » les gens.	☐

28) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les ressources mobilisées par le système national de santé sont consacrées, par ordre décroissant, pour :

A) Achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers, soins ambulatoires ;	☐
B) Achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires, soins hospitaliers ;	☐
C) Soins hospitaliers, achats des médicaments et biens médicaux, soins ambulatoires ;	☐
D) <u>Soins ambulatoires, achats des médicaments et biens médicaux, soins hospitaliers.</u>	☒

29) Les acteurs impliqués dans le diagnostic communautaire sont :

A) <u>La population/communauté ;</u>	☒
B) <u>Les agents de développement/médiateurs ;</u>	☒
C) <u>Les professionnels et les experts ;</u>	☒
D) L'individu.	☐

30) La caisse nationale des organismes de prévoyance sociale gère l'AMO pour :

A) <u>Les étudiants ;</u>	☒
B) <u>Les anciennes victimes des violations des droits de l'homme ;</u>	☒
C) Les anciens membres de la résistance ;	☐
D) Les agents de l'autorité et les Imams des mosquées.	☐

31) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses des ménages, ont été consacrées, par ordre décroissant, pour les prestations suivantes :

A) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, consultations médicales, hospitalisation, analyses médicales ;	☐
B) <u>Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, analyses médicales, consultations médicales ;</u>	☒
C) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, hospitalisation, consultations médicales, analyses médicales ;	☐
D) Pharmacies et fournisseurs de biens médicaux, analyses médicales, hospitalisation, consultations médicales.	☐

32) Selon les comptes nationaux de la santé 2010, les dépenses de la coopération internationale ont été orientées essentiellement vers :

A) L'équipement ;	☐
B) <u>L'investissement ;</u>	☒
C) L'expertise ;	☐
D) Médicaments et biens médicaux.	☐

33) Les trois causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonataux survenus les 48 premières heures de la vie sont :

A) <u>Les anomalies liées à une brièveté de la gestation ;</u>	☒
B) <u>L'hypoxie intra-utérine ;</u>	☒
C) Le diabète gestationnel ;	☐
D) <u>Les infections spécifiques de la période périnatale.</u>	☒

34) Le plan d'action national sur la santé et le handicap 2015-2021 comprend :

A) 4 axes et 17 mesures ;	☐
B) 5 axes et 21 mesures ;	☐
C) <u>6 axes et 20 mesures ;</u>	☒
D) 7 axes et 23 mesures.	☐

35) Parmi les axes du plan d'action national sur la santé et le handicap 2015- 2021, on trouve :

A) <u>Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat ;</u>	☒
B) <u>La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation ;</u>	☒
C) Le renforcement de la participation communautaire ;	☐
D) <u>La recherche.</u>	☒

36) Selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la commission nationale de l'offre de soins est assuré par :

A) L'inspection générale ;	☐
B) <u>La direction des hôpitaux et des soins ambulatoires ;</u>	☒
C) La direction de la réglementation et du contentieux ;	☐
D) Le secrétariat général.	☐

37) La commission régionale de l'offre de soins :

A) Est présidée par le directeur régional de la santé de la région concernée ou son représentant ;	☐
B) <u>Est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant ;</u>	☒
C) Est présidée par le président du conseil de la région de la région concernée ou son représentant ;	☐
D) <u>Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la santé de la région concernée.</u>	☒

38) Selon le décret de la carte sanitaire, les schémas régionaux de l'offre de soins :

A) <u>Sont établis par les directions régionales de la santé concernées ;</u>	☒
B) Sont établis pour une période de trois ans ;	☐
C) <u>Sont approuvés par des arrêtés du ministre de la santé ;</u>	☒
D) Ne peuvent être révisés qu'après la fin de la période de leur validité.	☐

39) Selon le décret de la carte sanitaire, la carte sanitaire :

A) <u>Est établie pour une période de dix ans ;</u>	☒
B) <u>Doit être évaluée tous les cinq ans ;</u>	☒
C) <u>Est établie par arrêté du ministre de la santé ;</u>	☒
D) Doit être évaluée tous les trois ans.	☐

40) Les fonctions de soins d'urgence médicales sont :

A) Au nombre de 14 fonctions ;	☐
B) Au nombre de 15 fonctions ;	☐
C) <u>Au nombre de 16 fonctions ;</u>	☒
D) Au nombre de 17 fonctions.	☐

41) Les principaux axes du plan national pour la prise en charge des urgences médicales sont :

A) Amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières ;	☐
B) <u>La réorganisation et la restructuration de la prise en charge des urgences médicales hospitalières ;</u>	☒
C) <u>Renforcement du partenariat public-privé et public-public ;</u>	☒
D) Tous les réponses sont justes.	☐

42) Parmi les services d'information et d'orientation aux citoyens :

A) ALLO SAMU 121 ;	☐
B) <u>ALLO surveillance épidémiologique ;</u>	☒
C) <u>ALLO intoxication ;</u>	☒
D) <u>Sihati.</u>	☒

43) Les facteurs de risque reconnus par l'OMS comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes sont :

A) <u>La consommation du tabac ;</u>	☒
B) L'usage nocif de l'alcool ;	☐
C) <u>L'alimentation malsaine ;</u>	☒
D) <u>Le manque d'activité physique et la sédentarité.</u>	☒

44) Le dépistage sélectif du diabète dans les établissements de soins de santé primaires se fait au profit de :

A) <u>Personnes en surpoids ou obèses avec ou sans HTA ;</u>	☒
B) <u>Femmes avec antécédents de diabète gestationnel ;</u>	☒
C) Personnes avec hyperthyroïdie ;	☐
D) <u>Personnes âgées de plus de 45 ans.</u>	☒

45) Dans le programme de lutte antituberculeuse la définition de cas se classe selon :

A) <u>Le site anatomique ;</u>	☒
B) La résistance aux médicaments ;	☐
C) <u>Le statut par rapport au VIH ;</u>	☒
D) <u>L'antécédent de traitement anti bacillaire.</u>	☒

46) La direction régionale de la santé est composée de :

A) <u>Service de ressources humaines et contentieux ;</u>	☒
B) Service des ressources financières ;	☐
C) Unité d'approvisionnement ;	☐
D) Unité de formation et de communication.	☐

47) Le territoire de santé est constitué de :

A) La délégation sanitaire ;	☐
B) <u>La circonscription sanitaire ;</u>	☒
C) Le centre hospitalier universitaire ;	☐
D) <u>Le territoire de santé inter-régional.</u>	☒

48) Lequel des établissements de santé suivants ne fait pas partie du réseau hospitalier :

A) Hôpital psychiatrique ;	☐
B) Centre d'hémodialyse ;	☐
C) <u>Hôpital provincial d'oncologie ;</u>	☒
D) Hôpital régional.	☐

49) Le réseau hospitalier est appuyé par :

A) Centre d'addictologie ;	☐
B) Centre de soins palliatifs ;	☐
C) <u>Centre national de radioprotection ;</u>	☒
D) Centre provincial de transfusion sanguine et d'hématologie.	☐

50) Les établissements médico-sociaux publics :

A) Offrent des prestations de soins sans hébergement ;	☐
B) <u>Sont créés en partenariat avec les acteurs publics ou privés ;</u>	☒
C) Font partie du réseau hospitalier ;	☐
D) Assurent la prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des malades.	☐

51) Quelle que soit l'implantation du centre de santé rural du deuxième niveau, il dispense les prestations suivantes :

A) <u>Le suivi des malades chroniques ;</u>	☒
B) L'assistance de l'accouchement ;	☐
C) <u>La réalisation des examens d'échographie obstétricale ;</u>	☒
D) Les consultations de santé mentale.	☐

52) Les fonctions essentielles de santé publique sont au nombre de :

A) 4 fonctions ;	☐
B) 6 fonctions ;	☐
C) <u>8 fonctions ;</u>	☒
D) 9 fonctions.	☐

53) Le livre blanc « pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé » élaboré à l'occasion de la 2^{ième} conférence nationale sur la santé (Juillet 2013) a identifié :

A) <u>3 axes et 9 chantiers pour la réforme ;</u>	☒
B) 5 axes et 9 chantiers pour la réforme ;	☐
C) 3 axes et 10 chantiers pour la réforme ;	☐
D) 6 axes et 10 chantiers pour la réforme.	☐

54) Parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie :

A) <u>Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires ;</u>	☒
B) Disponibilité des médicaments et biens médicaux ;	☐
C) <u>Accessibilité aux soins ;</u>	☒
D) <u>Garantie d'un personnel suffisant et compétent.</u>	☒

55) En santé publique, on évalue :

A) La pertinence de l'action ;	☐
B) <u>L'impact de l'action ;</u>	☒
C) L'accessibilité de l'action ;	☐
D) La cohérence de l'action.	☐

56) Selon la loi 34-09 sur le système de santé et l'offre de soin, le droit à la protection de la santé est une :

A) Responsabilité des citoyens ;	☐
B) Responsabilité des citoyens et de l'Etat ;	☐
C) <u>Responsabilité de l'Etat et de la société ;</u>	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

57) Le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants :

A) Projet immobilier ;	☐
B) Projet technique ;	☐
C) Projet financier ;	☐
D) <u>Projet médical.</u>	☒

58) Selon la portée de la démarche, la planification est :

A) <u>Tactique ;</u>	☒
B) Pragmatique ;	☐
C) Populationnelle ;	☐
D) <u>Opérationnelle.</u>	☒

59) Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes :

A) <u>Analyse de la situation ;</u>	☒
B) <u>Fixation des objectifs ;</u>	☒
C) Détermination des priorités ;	☐
D) <u>Évaluation des ressources.</u>	☒

60) Les caractéristiques de la planification :

A) Concerne le passé et le futur ;	☐
B) <u>Créative ;</u>	☒
C) <u>Processus dynamique et continue ;</u>	☒
D) <u>Obéit aux orientations stratégiques.</u>	☒

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 25 شتنبر 2016)

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La direction régionale de la sante est composée des services suivants :

A) Service de sante publique ;	☐
B) Service administratif et économique ;	☐
C) Service des ressources humaines et du contentieux ;	☐
D) Service de l'offre de soins.	☐

2) En plus des services, Chaque direction régionale de sante comporte :

A) Une unité régionale ;	☐
B) Deux unités régionales ;	☐
C) Trois unités régionales ;	☐
D) Quatre unités régionales.	☐

3) La délégation provinciale/préfecture du Ministère de la sante comporte les services suivants :

A) Service des ressources financières, d'équipement et de maintenance ;	☐
B) Service administratif et économique ;	☐
C) Service d'équipement et de maintenance ;	☐
D) Service du réseau des établissements de santé.	☐

4) Les établissements médico-sociaux publics sont :

A) Des établissements qui assurent une prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des maladies ;	☐
B) Des établissements qui assurent une prise en charge médicale avec accompagnement social des personnes à besoins spécifiques ;	☐
C) Des établissements qui assurent une prise en charge médicale avec accompagnement social des personnes en fin de vie ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

5) On entend par filière de soins :

A) Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients.	☐

6) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) Deux réseaux d'établissements de santé ;	☐
B) Trois réseaux d'établissements de santé ;	☐
C) Quatre réseaux d'établissements de santé ;	☐
D) Cinq réseaux d'établissements de santé.	☐

7) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

A) Visites à domicile ;	☐
B) Unités médicales mobiles ;	☐
C) Caravanes médicales spécialises ;	☐
D) Hôpitaux mobiles.	☐

8) L'offre de soins d'urgence est organisée en :

A) Urgence médicales de proximité ;	☐
B) Urgence pre-hospitalières ;	☐
C) Urgence hospitalières ;	☐
D) Urgence medico-hospitalières.	☐

9) La circonscription sanitaire :

A) Représente le territoire de base dans le découpage sanitaire ;	☐
B) Peut-être rural ou urbaine ;	☐
C) Peut-être découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;	☐
D) Correspond à l'aire de desserte d'un centre de santé.	☐

10) Le centre de sante rural de premier niveau :

A) Est place sous la responsabilité d'un médecin généraliste ;	☐
B) Est place sous la responsabilité d'un infirmier major ;	☐
C) Est l'établissement de soins de santé primaire de premier contact en milieux rural ;	☐
D) N'offre que les prestations de sante préventives et promotionnelles.	☐

11) Le centre de sante rural de premier niveau offre les prestations suivantes :

A) Les consultations de médecine générale ;	☐
B) Les soins infirmiers ;	☐
C) Les examens d'échographie obstétricale ;	☐
D) Le suivi de la sante de la mère et de l'enfant.	☐

12) Le réseau hospitalier est compose, entre autres des établissements de santé suivants :

A) Des hôpitaux psychiatriques ;	☐
B) Des centres d'hémodialyse ;	☐
C) Des centres de transfusion ;	☐
D) Des centres régionaux d'oncologie.	☐

13) Les établissements relevant du réseau hospitalier sont organisés selon les territoires de sante en :

A) Hôpitaux locaux (proximité) ;	☐
B) Centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux ;	☐
C) Les centres hospitaliers régionaux ;	☐
D) Les centres hospitaliers interrégionaux.	☐

14) Les prestations de soins hospitalières de premier niveau sont dispensées par :

A) Hôpitaux locaux (proximité) ;	☐
B) Centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux ;	☐
C) Les centres hospitaliers régionaux ;	☐
D) Les centres hospitaliers interrégionaux.	☐

15) L'assurance maladie obligatoire est gérée par :

A) La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale pour le secteur public ;	☐
B) La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale pour le secteur privé ;	☐
C) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur public ;	☐
D) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur privé.	☐

16) Le Régime d'assistance médicale (RAMED) est géré par :

A) La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale ;	☐
B) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur ;	☐
C) L'agence Nationale d'Assurance maladie ;	☐
D) Le Ministère de la Sante.	☐

17) La contribution partielle annuelle de la population en situation de vulnérabilité et bénéficiaire du RAMED est fixée à :

A) 120 Dhs par personne et par an dans la limites d'un plafond de 600 Dhs par ménage quel que soit l'effectif des personnes le composant ;	☐
B) 600 Dhs par ménage et par an quel que soit la taille du ménage ;	☐
C) 100 Dhs par personne et par an dans la limite d'un plafond de 600 Dh par ménage quel que soit l'effectif des personnes le composant ;	☐
D) 500 Dhs par ménage et par an quel que soit la taille du ménage.	☐

18) Le premier financeur du RAMED est représenté par :

A) L'Etat ;	☐
B) Les ménages ;	☐
C) Les collectivités locales ;	☐
D) Le Ministère de la Sante.	☐

19) Lesquelles des structures suivantes ne font pas partie du secteur privé à but non lucratif :

A) Les établissements du croissant rouge marocaine ;	☐
B) Les cliniques et cabinets médicaux ;	☐
C) Les ligues et fondation ;	☐
D) Les hôpitaux des Forces Armées Royales.	☐

20) En 2014 :

A) Le taux de mortalité maternelle est de 112 décès/ 10.000 naissance vivantes ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 1000 naissances vivantes ;	☐
C) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
D) L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 25 شتنبر 2016)

Correction proposée :

1) La direction régionale de la sante est composée des services suivants :

A) <u>Service de sante publique ;</u>	☒
B) Service administratif et économique ;	☐
C) <u>Service des ressources humaines et du contentieux ;</u>	☒
D) <u>Service de l'offre de soins.</u>	☒

2) En plus des services, Chaque direction régionale de sante comporte :

A) Une unité régionale ;	☐
B) <u>Deux unités régionales ;</u>	☒
C) Trois unités régionales ;	☐
D) Quatre unités régionales.	☐

3) La délégation provinciale/préfecture du Ministère de la sante comporte les services suivants :

A) Service des ressources financières, d'équipement et de maintenance ;	☐
B) <u>Service administratif et économique ;</u>	☒
C) Service d'équipement et de maintenance ;	☐
D) <u>Service du réseau des établissements de santé.</u>	☒

4) Les établissements médico-sociaux publics sont :

A) Des établissements qui assurent une prise en charge médicale et chirurgicale avec accompagnement social des maladies ;	☐
B) <u>Des établissements qui assurent une prise en charge médicale avec accompagnement social des personnes à besoins spécifiques ;</u>	☒
C) Des établissements qui assurent une prise en charge médicale avec accompagnement social des personnes en fin de vie ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

5) On entend par filière de soins :

A) <u>Une organisation verticale hiérarchisée de prise en charge des patients ;</u>	☒
B) Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients.	☐

6) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) Deux réseaux d'établissements de santé ;	☐
B) Trois réseaux d'établissements de santé ;	☐
C) <u>Quatre réseaux d'établissements de santé ;</u>	☒
D) Cinq réseaux d'établissements de santé.	☐

7) Les prestations de soins et services en mode mobile peuvent être effectuées au moyen de :

A) <u>Visites à domicile ;</u>	☒
B) <u>Unités médicales mobiles ;</u>	☒
C) <u>Caravanes médicales spécialises ;</u>	☒
D) <u>Hôpitaux mobiles.</u>	☒

8) L'offre de soins d'urgence est organisée en :

A) <u>Urgence médicales de proximité ;</u>	☒
B) <u>Urgence pre-hospitalières ;</u>	☒
C) Urgence hospitalières ;	☐
D) <u>Urgence medico-hospitalières.</u>	☒

9) La circonscription sanitaire :

A) <u>Représente le territoire de base dans le découpage sanitaire ;</u>	☒
B) <u>Peut-être rural ou urbaine ;</u>	☒
C) <u>Peut-être découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires ;</u>	☒
D) Correspond à l'aire de desserte d'un centre de santé.	☐

10) Le centre de sante rural de premier niveau :

A) <u>Est place sous la responsabilité d'un médecin généraliste ;</u>	☒
B) Est place sous la responsabilité d'un infirmier major ;	☐
C) <u>Est l'établissement de soins de santé primaire de premier contact en milieux rural ;</u>	☒
D) N'offre que les prestations de sante préventives et promotionnelles.	☐

11) Le centre de sante rural de premier niveau offre les prestations suivantes :

A) <u>Les consultations de médecine générale ;</u>	☒
B) <u>Les soins infirmiers ;</u>	☒
C) Les examens d'échographie obstétricale ;	☐
D) <u>Le suivi de la sante de la mère et de l'enfant.</u>	☒

12) Le réseau hospitalier est compose, entre autres des établissements de santé suivants :

A) <u>Des hôpitaux psychiatriques ;</u>	☒
B) <u>Des centres d'hémodialyse ;</u>	☒
C) Des centres de transfusion ;	☐
D) Des centres régionaux d'oncologie.	☒

13) Les établissements relevant du réseau hospitalier sont organisés selon les territoires de sante en :

A) Hôpitaux locaux (proximité) ;	☐
B) <u>Centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux ;</u>	☒
C) <u>Les centres hospitaliers régionaux ;</u>	☒
D) <u>Les centres hospitaliers interrégionaux.</u>	☒

14) Les prestations de soins hospitalières de premier niveau sont dispensées par :

A) <u>Hôpitaux locaux (proximité) ;</u>	☒
B) <u>Centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux ;</u>	☒
C) Les centres hospitaliers régionaux ;	☐
D) Les centres hospitaliers interrégionaux.	☐

15) L'assurance maladie obligatoire est gérée par :

A) <u>La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale pour le secteur public ;</u>	☒
B) La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale pour le secteur privé ;	☐
C) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur public ;	☐
D) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur privé.	☐

16) Le Régime d'assistance médicale (RAMED) est géré par :

A) La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance Sociale ;	☐
B) La Caisse Nationale de Solidarité Sociale pour le secteur ;	☐
C) <u>L'agence Nationale d'Assurance maladie ;</u>	☒
D) Le Ministère de la Sante.	☐

17) La contribution partielle annuelle de la population en situation de vulnérabilité et bénéficiaire du RAMED est fixée à :

A) <u>120 Dhs par personne et par an dans la limites d'un plafond de 600 Dhs par ménage quel que soit l'effectif des personnes le composant ;</u>	☒
B) 600 Dhs par ménage et par an quel que soit la taille du ménage ;	☐
C) 100 Dhs par personne et par an dans la limite d'un plafond de 600 Dh par ménage quel que soit l'effectif des personnes le composant ;	☐
D) 500 Dhs par ménage et par an quel que soit la taille du ménage.	☐

18) Le premier financeur du RAMED est représenté par :

A) <u>L'Etat ;</u>	☒
B) Les ménages ;	☐
C) Les collectivités locales ;	☐
D) Le Ministère de la Sante.	☐

19) Lesquelles des structures suivantes ne font pas partie du secteur privé à but non lucratif :

A) Les établissements du croissant rouge marocaine ;	☐
B) <u>Les cliniques et cabinets médicaux ;</u>	☒
C) Les ligues et fondation ;	☐
D) <u>Les hôpitaux des Forces Armées Royales.</u>	☒

20) En 2014 :

A) Le taux de mortalité maternelle est de 112 décès/ 10.000 naissance vivantes ;	☐
B) Le taux de mortalité infantile est de 41 décès/ 1000 naissances vivantes ;	☐
C) L'indice synthétique de fécondité est de 2,5 enfants par femme ;	☐
D) <u>L'espérance de vie à la naissance est de 75,5 ans.</u>	☒



2015

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

(دورة 04 أكتوبر 2015)

المدة : 3 ساعات

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) Les temps de la planification stratégique sont :

A) Le temps politique ;	☐
B) Le temps stratégique ;	☐
C) Le temps empirique ;	☐
D) Le temps tactique.	☐

2) Lequel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique ?

A) Les plans d'effectifs ;	☐
B) Le budget programme ;	☐
C) Le plan stratégique provincial ;	☐
D) Le plan stratégique régional.	☐

3) En milieu urbain, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale (RAMED) sont définis comme suit :

A) Avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30% ;	☐
B) Avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 40% ;	☐
C) Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 Dhs par personne composant le ménage ;	☐
D) Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 11.	☐

4) Le projet d'établissement hospitalier comprend entre autres les projets suivants :

A) Projet managérial ;	☐
B) Projet social ;	☐
C) Projet technique ;	☐
D) Projet administratif.	☐

5) Lesquels des pôles suivants ne font pas partie des pôles de gestion d'un centre hospitalier ?

A) Le pôle des affaires médicales ;	☐
B) Le pôle des affaires professionnelles ;	☐
C) Le pôle des affaires administratives ;	☐
D) Le pôle des affaires sociales.	☐

6) Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés :

A) En six départements cliniques et trois services ;	☐
B) En cinq départements cliniques et trois services ;	☐
C) En six départements cliniques et deux services ;	☐
D) En cinq départements cliniques et trois services.	☐

7) La carte sanitaire est un outil législatif de :

A) L'organisation des services de soins ;	☐
B) L'organisation de l'offre de soins ;	☐
C) L'organisation des établissements hospitaliers ;	☐
D) L'organisation des établissements de soins primaires.	☐

8) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

A) Les personnes qui ne sont assujettis à aucun régime d'assurance maladie obligatoire ;	☐
B) Leur(s) conjoint(s) ;	☐
C) Leurs parents ;	☐
D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus.	☐

9) Sont admis de droit au bénéfice de l'assistance médicale (RAMED) totale :

A) Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats et hospices ;	☐
B) Les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;	☐
C) Les personnes sans domicile fixe ;	☐
D) Les anciens membres de la résistance.	☐

10) Le régime d'assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes :

A) Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux ;	☐
B) Les interventions de chirurgie plastique et esthétique ;	☐
C) Les articles de prothèse et d'orthèse ;	☐
D) Les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale.	☐

11) En 2010, la part des soins ambulatoires dans la dépense du système national de santé est classée :

A) En 1 ^{er} rang ;	☐
B) En 2 ^{ème} rang ;	☐
C) En 3 ^{ème} rang ;	☐
D) En 4 ^{ème} rang.	☐

12) En 2010, le ministère de la santé, qui constitue le premier prestataire de soins, est classé comme ?

A) 1 ^{er} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
B) 2 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
C) 3 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
D) 4 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé.	☐

13) Les fonctions de soins médico-hospitalières complètes sont au nombre de :

A) 7 fonctions ;	☐
B) 12 fonctions ;	☐
C) 16 fonctions ;	☐
D) 19 fonctions.	☐

14) La moitié des dépenses des ménages par prestataire pour l'année 2010 est effectuée auprès ?

A) Des cabinets et cliniques privées ;	☐
B) Des pharmacies et des fournisseurs de soins en terme d'achat des médicaments et des biens médicaux ;	☐
C) Des hôpitaux publics ;	☐
D) des établissements de soins de santé de base.	☐

15) La source principale de financement des activités du ministère de la santé est représentée par ?

A) Les ménages ;	☐
B) Le budget de l'État ;	☐
C) Les assurances et mutuelles ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

16) La part la plus importante (47%) des dépenses du ministère de la santé en 2010 est allouée :

A) Au réseau de soins de santé de base (RSSB) ;	☐
B) Aux hôpitaux ;	☐
C) Aux instituts, centres et laboratoires nationaux (ICLN ;)	☐
D) à l'administration centrale et locale.	☐

17) Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base le 18 Aout 2005 :

A) La CNOPS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit ;	☐
B) La CNSS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit ;	☐
C) La CNOPS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit ;	☐
D) La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit.	☐

18) La couverture médicale du personnel du secteur public est assurée essentiellement par des sociétés mutualistes, fédérées au sein de la CNOPS et qui sont au nombre de :

A) Six (6) ;	☐
B) Sept (7) ;	☐
C) Huit (8) ;	☐
D) Neuf (9).	☐

19) La filière de soins est une organisation :

A) Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
B) Verticale non hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
C) Horizontale hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
D) Horizontale non hiérarchisée de prise en charge des patients.	☐

20) L'évaluation quantitative des soins utilise les indicateurs suivants :

A) L'analyse du rapport cout/efficacité ;	☐
B) L'analyse du rapport cout/efficience ;	☐
C) L'analyse du rapport cout/utilité ;	☐
D) L'analyse du rapport cout/bénéfice.	☐

21) L'analyse du coût ou de minimisation du coût tend à déterminer :

A) La qualité des ressources consommées par une pathologie donnée ;	☐
B) La quantité des ressources consommées par une pathologie donnée ;	☐
C) La quantités des recettes engendrées par une pathologie donnée ;	☐
D) La quantités des soins offerts pour une pathologie donnée.	☐

22) En milieu rural, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale sont définis comme suit :

A) Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage ;	☐
B) Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 6 ;	☐
C) Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 60 par personne composant le ménage ;	☐
D) Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 5.	☐

23) L'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins :

A) Conséquences en termes des résultats et la satisfaction des patients ;	☐
B) Conséquences en termes des ressources consommées par le soin ;	☐
C) Conséquences en termes des recettes engendrées par le soin ;	☐
D) Conséquences en termes d'efficacité du soin.	☐

24) L'évaluation de la qualité des soins englobe :

A) L'évaluation des procédures ;	☐
B) L'évaluation des résultats ;	☐
C) L'évaluation des ressources ;	☐
D) L'évaluation mixte.	☐

25) Dans la déclaration du Millénaire pour le développement :

A) Deux parmi huit objectifs concernent directement la santé ;	☐
B) Trois parmi huit objectifs concernent directement la santé ;	☐
C) Quatre parmi huit objectifs concernent directement la santé ;	☐
D) Cinq parmi huit objectifs concernent directement la santé.	☐

26) Le réseau coordonné des soins est une organisation :

A) Verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) Horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients.	☐

27) Dans le programme du gouvernement 2012-2016, le secteur de la santé se trouve interpellé de façon directe à travers l'axe réservé à :

A) La « garantie de l'accès aux médicaments » ;	☐
B) La « garantie de l'accès aux soins » ;	☐
C) La « moralisation du secteur de santé » ;	☐
D) La « couverture médicale de base ».	☐

28) La formulation stratégique du plan sectoriel de la santé pour la période 2012-2016 repose sur la ou les approches complémentaires suivantes :

A) Une approche fondée sur les droits ;	☐
B) Une approche de démocratie sanitaire ;	☐
C) Une approche fondée sur les obligations ;	☐
D) Une approche de renforcement du système de santé.	☐

29) Le plan de réorganisation et de développement des urgences médicales au Maroc comporte :

A) 3 objectifs et 8 mesures ;	☐
B) 3 objectifs et 10 mesures ;	☐
C) 4 objectifs et 8 mesures ;	☐
D) 4 objectifs et 10 mesures.	☐

30) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 2,15 ;	☐
B) 2,59 ;	☐
C) 2,75 ;	☐
D) 3,20.	☐

31) La 1ère cause de mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) Les maladies cardiovasculaires ;	☐
D) La tuberculose et les maladies respiratoires.	☐

32) Selon la stratégie sectorielle de santé 2012-2016, le développement de la santé en milieu rural repose sur les actions suivantes :

A) Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe ;	☐
B) Renforcement de la couverture sanitaire mobile ;	☐
C) Renforcement de la couverture sanitaire par point de contact ;	☐
D) Développement de la participation communautaire.	☐

33) Dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma régional de l'offre de soins, la création et l'implantation des infrastructures relevant du réseau de soins de santé primaire, en milieu urbain, doit répondre aux besoins de la population selon les critères suivants :

A) Un centre de santé urbain de 1 ^{er} niveau pour une population minimale de desserte de 15000 habitants ;	☐
B) Un centre de santé urbain de 1 ^{er} niveau pour une population minimale de desserte de 25000 habitants ;	☐
C) Un centre de santé urbain de 2 ^{ème} niveau pour une population minimale de desserte de 25000 habitants ;	☐
D) Un centre de santé urbain de 2 ^{ème} niveau pour une population minimale de desserte de 50000 habitants.	☐

34) Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé :

A) En deux niveaux ;	☐
B) En trois niveaux ;	☐
C) En quatre niveaux ;	☐
D) En cinq niveaux.	☐

35) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, l'espérance de vie à la naissance au Maroc :

A) 75,4 ans ;	☐
B) 76,5 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) 79,4 ans.	☐

36) En souscrivant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, le Maroc s'est engagé à réduire, à l'horizon 2015 :

A) De deux tiers la mortalité maternelle et de trois quarts la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;	☐
B) De moitié la mortalité maternelle et de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;	☐
C) De trois quarts la mortalité maternelle et de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;	☐
D) De trois quarts la mortalité maternelle et de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans.	☐

37) La consommation moyenne mensuelle est une méthode d'estimation des besoins en :

A) Produits pharmaceutiques ;	☐
B) Matériel médico-technique ;	☐
C) Ressources humaines ;	☐
D) Ressources financières.	☐

38) Lequel des axes stratégiques suivants ne fait pas partie de la stratégie sectorielle de santé 2012-2016 :

A) Amélioration de l'accès aux soins et de l'organisation des services ;	☐
B) Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques ;	☐
C) Développement du contrôle des maladies transmissibles ;	☐
D) Amélioration de la gouvernance du système de santé.	☐

39) Les urgences médico-hospitalières de base représentent :

A) Le 1 ^{er} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
B) Le 2 ^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
C) Le 3 ^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
D) Le 4 ^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales.	☐

40) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, le taux d'occupation moyen des hôpitaux publics est de :

A) 61,6% ;	☐
B) 62,6% ;	☐
C) 63,6% ;	☐
D) 64,6%.	☐

41) Selon la stratégie sectorielle de santé 2012-2016 :

A) Trois provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;	☐
B) Quatre provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;	☐
C) Cinq provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;	☐
D) Six provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux.	☐

42) Les résultats attendus du plan national de prévention et du contrôle du cancer dans le domaine de prévention est de :

A) Réduire de 20% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
B) Réduire de 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
C) Réduire de 40% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
D) Réduire de 50% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux.	☐

43) Dans le découpage sanitaire national, les territoires de santé sont :

A) Des circonscriptions sanitaires ;	☐
B) Des préfectures et provinces sanitaires ;	☐
C) Des régions sanitaires ;	☐
D) Des structures centrales.	☐

44) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

A) Seulement la population en situation de vulnérabilité ;	☐
B) Seulement la population en situation de pauvreté ;	☐
C) la population en situation de pauvreté et de vulnérabilité ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

45) Lequel/lesquels des établissements suivants ne fait/ne font pas partie du réseau hospitalier :

A) Centre d'hémodialyse ;	☐
B) Hôpitaux psychiatriques ;	☐
C) Centres régionaux de rééducation ;	☐
D) Centres régionaux d'oncologie.	☐

46) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) Deux réseaux d'établissements de santé ;	☐
B) Trois réseaux d'établissements de santé ;	☐
C) Quatre réseaux d'établissements de santé ;	☐
D) Cinq réseaux d'établissements de santé.	☐

47) Selon le rapport santé en chiffres 2014, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de :

A) 92,5% ;	☐
B) 93,5% ;	☐
C) 94,5% ;	☐
D) 95,5%.	☐

48) Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgences médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :

A) Les gestes de réanimation ;	☐
B) Les gestes de premiers secours ;	☐
C) La transfusion ;	☐
D) Le diagnostic de détresse vitale.	☐

49) Selon le rapport santé en chiffres 2014, la durée moyenne des hôpitaux publics est de :

A) Trois jours ;	☐
B) Quatre jours ;	☐
C) Cinq jours ;	☐
D) Six jours.	☐

50) Les résultats attendus du plan national de prévention et de contrôle du cancer dans le domaine de prise en charge diagnostique et thérapeutique est de :

A) Guérir 30% des patients pris en charge ;	☐
B) Guérir 40% des patients pris en charge ;	☐
C) Guérir 50% des patients pris en charge ;	☐
D) Guérir 60% des patients pris en charge.	☐

51) En 2013, le budget global du Ministère de la Santé représente :

A) 1,1% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
B) 1,2% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
C) 1,3% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
D) 1,4% du produit intérieur brut (PIB).	☐

52) En 2010, les dépenses globales de santé ont atteint :

A) 43,7% milliards de Dhs ;	☐
B) 45,7% milliards de Dhs ;	☐
C) 47,7% milliards de Dhs ;	☐
D) 49,7% milliards de Dhs.	☐

53) Selon les comptes nationaux 2010, les paiements directs des ménages ont représenté :

A) 53,6% des dépenses des ménages pour la santé ;	☐
B) 54,7% des dépenses des ménages pour la santé ;	☐
C) 57,3% des dépenses des ménages pour la santé ;	☐
D) 61,3% des dépenses des ménages pour la santé.	☐

54) Les maladies non transmissibles représentent :

A) 52% de la charge de morbidité générale ;	☐
B) 54% de la charge de morbidité générale ;	☐
C) 56% de la charge de morbidité générale ;	☐
D) 58% de la charge de morbidité générale.	☐

55) La stratégie du plan national de prévention et de contrôle de cancer repose sur les domaines suivants :

A) La prévention ;	☐
B) La détection précoce ;	☐
C) La prise en charge diagnostique et thérapeutique ;	☐
D) Les soins de base et les soins palliatifs.	☐

56) Le financement du régime d'assistance médicale (RAMED) est assuré par :

A) L'Etat (76%), les collectivités locales (19%), la cotisation des bénéficiaires (5%) ;	☐
B) L'Etat (74%), les collectivités locales (21%), la cotisation des bénéficiaires (5%) ;	☐
C) L'Etat (74%), les collectivités locales (20%), la cotisation des bénéficiaires (6%) ;	☐
D) L'Etat (75%), les collectivités locales (19%), la cotisation des bénéficiaires (6%).	☐

57) Le régime d'assistance médicale (RAMED) cible la couverture de :

A) 7,5 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;	☐
B) 8 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;	☐
C) 8,5 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;	☐
D) 9 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.	☐

58) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins(SROS) :

A) Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins ;	☐
B) Est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances ;	☐
C) Définit les besoins en infrastructures , en moyens et en activités de soins ;	☐
D) Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins.	☐

59) L'élaboration du Schéma Régional de l'Offre de Soins repose sur les principes suivants :

A) La globalité ;	☐
B) L'intégration ;	☐
C) La fiabilité ;	☐
D) L'accessibilité.	☐

60) Le processus théorique d'élaboration du Schéma Régional de l'Offre de Soins peut être résumé en trois étapes essentielles, qui sont :

A) L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations ;	☐
B) La mobilisation des ressources ;	☐
C) La fixation des priorités ;	☐
D) La détermination des mesures à prendre.	☐

61) La formulation du projet d'établissement repose sur deux logiques :

A) Une logique professionnelle ;	☐
B) Une logique fonctionnelle ;	☐
C) Une logique de qualité ;	☐
D) Une logique de projet.	☐

62) Le plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région, il comprend :

A) Une étape d'analyse de situation ;	☐
B) Une étape de formulation politique ;	☐
C) Une étape de formulation tactique ;	☐
D) Une étape de formulation stratégique.	☐

63) Le plan régional de couverture sanitaire a pour objectif de déterminer :

A) La répartition géographique des infrastructures et des équipements lourds de santé ;	☐
B) La répartition géographique des ressources humaines ;	☐
C) Les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs ;	☐
D) La répartition des activités et prestations de soins dans les infrastructures.	☐

64) Le plan d'action 2012-2016 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale se fixe pour objectifs d'ici 2016 de :

A) Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
B) Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1000 naissances vivantes ;	☐
C) Réduire la mortalité maternelle de 112 à 40 décès pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
D) Réduire la mortalité néonatale de 19 à 10 pour 1.000 naissances vivantes.	☐

65) Le projet d'établissement hospitalier :

A) Est un outil de planification stratégique et de communication ;	☐
B) Facilite le développement d'une vision et l'engagement des professionnels et des gestionnaires autour d'objectifs communs ;	☐
C) Couvre une période de 2 à 3 ans ;	☐
D) Est un moyen pour orienter les soins vers la population.	☐

66) Le diagnostic hospitalier peut reposer sur trois types d'analyse :

A) Une analyse de morbidité hospitalière ;	☐
B) Une analyse de la performance ;	☐
C) Une analyse opérationnelle ;	☐
D) Une analyse stratégique.	☐

67) Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité :

A) L'efficacité ;	☐
B) La globalité ;	☐
C) L'efficience ;	☐
D) La continuité.	☐

68) Le comité de gestion d'un centre hospitalier régional est présidé par :

A) Le délégué du Ministère de la Santé de la province ou préfecture chef-lieu de la région ;	☐
B) Le directeur régional de la santé ;	☐
C) Le directeur du centre hospitalier de la province ou préfecture chef-lieu de la région ;	☐
D) Un délégué à tour de rôle parmi les délégués des provinces ou préfectures de la région.	☐

69) L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire :

A) Seulement pendant les jours et heures ouvrables ;	☐
B) Pendant toutes les heures des jours ouvrables ;	☐
C) Pendant tous les jours de la semaine ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

70) Parmi les critères de priorisation d'un problème, lequel parmi les suivants n'est pas juste :

A) Fréquence ;	☐
B) Gravité ;	☐
C) Acceptabilité ;	☐
D) Vulnérabilité.	☐

71) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) Epidémie ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

72) Les éléments constitutifs d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont :

A) Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation ;	☐
B) les besoins , les ressources, et les indicateurs d'évaluation ;	☐
C) La vision, la stratégie, les ressources et les modalités d'évaluation ;	☐
D) les stratégies, les ressources et les modalités d'évaluation.	☐

73) Parmi les services suivants, lequel est un service de la direction régionale :

A) Le service de la santé publique et de l'offre de soins ;	☐
B) Le service de la programmation de l'offre de soins et des ressources humaines ;	☐
C) Le service de la programmation de l'offre de soins et des ressources financières ;	☐
D) Le service des ressources humaines et de l'approvisionnement.	☐

74) La couverture sanitaire universelle consiste à :

A) Etendre l'offre et l'accès aux soins ;	☐
B) Améliorer la qualité et la gamme des soins ;	☐
C) Réduire les paiements directs ;	☐
D) Augmenter les ressources.	☐

75) L'objectif de l'économie de santé est de :

A) Faire des économie ;	☐
B) Diminuer les dépenses ;	☐
C) Contrôler les agents économiques ;	☐
D) Rechercher la meilleure utilisation des ressources.	☐

76) Selon le modèle PATHWAY de l'OMS (2011), les déterminants intermédiaires de la santé sont :

A) Les facteurs humains, biologiques, psychologiques et matériels ;	☐
B) Le système de santé ;	☐
C) L'éducation, l'emploi et le revenu ;	☐
D) La gouvernance et politiques sociales.	☐

77) L'enquête nationale de prévalence des troubles mentaux et toxicomanies a montré que la prévalence des troubles dépressifs est de :

A) 26,5% ;	☐
B) 9,6% ;	☐
C) 2% ;	☐
D) 45,2%.	☐

78) Les objectifs du plan national de santé mentale (2013-2016) sont :

A) Promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux ;	☐
B) Assurer une prise en charge équitable, de qualité au profit des personnes avec troubles mentaux ;	☐
C) Améliorer la gouvernance en santé mentale ;	☐
D) Développer le partenariat.	☐

79) Les maladies à notification obligatoire en vertu du règlement sanitaire international 2005 sont :

A) La fièvre jaune ;	☐
B) La polio à virus sauvage ;	☐
C) La méningite ;	☐
D) La variole.	☐

80) La certification est une attestation :

A) De conformité aux exigences spécifiques ;	☐
B) De reconnaissance de compétences ;	☐
C) D'accréditation ;	☐
D) Aucune des propositions n'est vrai.	☐

امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن أطر هيئة المرضى وتقني الصحة

(دورة 04 أكتوبر 2015)

المدة : 3 ساعات

Correction proposée :

1) Les temps de la planification stratégique sont :

A) <u>Le temps politique ;</u>	☒
B) <u>Le temps stratégique ;</u>	☒
C) Le temps empirique ;	☐
D) <u>Le temps tactique.</u>	☒

2) Lequel des outils suivants ne fait pas partie des outils principaux de la planification stratégique ?

A) Les plans d'effectifs ;	☐
B) Le budget programme ;	☐
C) <u>Le plan stratégique provincial ;</u>	☒
D) Le plan stratégique régional.	☐

3) En milieu urbain, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale (RAMED) sont définis comme suit :

A) Avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 30% ;	☐
B) Avoir la qualité de résident dans une commune dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 40% ;	☐
C) <u>Disposer d'un revenu annuel inférieur à 5650 Dhs par personne composant le ménage ;</u>	☒
D) <u>Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 11.</u>	☒

4) Le projet d'établissement hospitalier comprend entre autres les projets suivants :

A) <u>Projet managérial ;</u>	☒
B) <u>Projet social ;</u>	☒
C) Projet technique ;	☐
D) Projet administratif.	☐

5) Lesquels des pôles suivants ne font pas partie des pôles de gestion d'un centre hospitalier ?

A) Le pôle des affaires médicales ;	☐
B) <u>Le pôle des affaires professionnelles ;</u>	☒
C) Le pôle des affaires administratives ;	☐
D) <u>Le pôle des affaires sociales.</u>	☒

6) Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés :

A) <u>En six départements cliniques et trois services ;</u>	☒
B) En cinq départements cliniques et trois services ;	☐
C) En six départements cliniques et deux services ;	☐
D) En cinq départements cliniques et trois services.	☐

7) La carte sanitaire est un outil législatif de :

A) L'organisation des services de soins ;	☐
B) <u>L'organisation de l'offre de soins ;</u>	☒
C) L'organisation des établissements hospitaliers ;	☐
D) L'organisation des établissements de soins primaires.	☐

8) Les bénéficiaires des prestations du régime d'assistance médicale (RAMED) sont :

A) <u>Les personnes qui ne sont assujettis à aucun régime d'assurance maladie obligatoire ;</u>	☒
B) <u>Leur(s) conjoint(s) ;</u>	☒
C) Leurs parents ;	☐
D) Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 24 ans au plus.	☐

9) Sont admis de droit au bénéfice de l'assistance médicale (RAMED) totale :

A) <u>Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats et hospices ;</u>	☒
B) <u>Les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;</u>	☒
C) <u>Les personnes sans domicile fixe ;</u>	☒
D) Les anciens membres de la résistance.	☐

10) Le régime d'assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes :

A) <u>Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux ;</u>	☒
B) Les interventions de chirurgie plastique et esthétique ;	☐
C) <u>Les articles de prothèse et d'orthèse ;</u>	☒
D) <u>Les actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale.</u>	☒

11) En 2010, la part des soins ambulatoires dans la dépense du système national de santé est classée :

A) En 1 ^{er} rang ;	☐
B) <u>En 2^{ème} rang ;</u>	☒
C) En 3 ^{ème} rang ;	☐
D) En 4 ^{ème} rang.	☐

12) En 2010, le ministère de la santé, qui constitue le premier prestataire de soins, est classé comme ?

A) 1 ^{er} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
B) 2 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;	☐
C) <u>3^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé ;</u>	☒
D) 4 ^{ème} bénéficiaire du financement du système national de santé.	☐

13) Les fonctions de soins médico-hospitalières complètes sont au nombre de :

A) 7 fonctions ;	☐
B) 12 fonctions ;	☐
C) <u>16 fonctions ;</u>	☒
D) 19 fonctions.	☐

14) La moitié des dépenses des ménages par prestataire pour l'année 2010 est effectuée auprès ?

A) Des cabinets et cliniques privées ;	☐
B) <u>Des pharmacies et des fournisseurs de soins en terme d'achat des médicaments et des biens médicaux ;</u>	☒
C) Des hôpitaux publics ;	☐
D) des établissements de soins de santé de base.	☐

15) La source principale de financement des activités du ministère de la santé est représentée par ?

A) Les ménages ;	☐
B) <u>Le budget de l'État ;</u>	☒
C) Les assurances et mutuelles ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

16) La part la plus importante (47%) des dépenses du ministère de la santé en 2010 est allouée :

A) Au réseau de soins de santé de base (RSSB) ;	☐
B) <u>Aux hôpitaux ;</u>	☒
C) Aux instituts, centres et laboratoires nationaux (ICLN ;)	☐
D) à l'administration centrale et locale.	☐

17) Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base le 18 Aout 2005 :

A) <u>La CNOPS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit ;</u>	☒
B) La CNSS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants droit ;	☐
C) La CNOPS gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit ;	☐
D) <u>La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) gère le régime de l'assurance obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit.</u>	☒

18) La couverture médicale du personnel du secteur public est assurée essentiellement par des sociétés mutualistes, fédérées au sein de la CNOPS et qui sont au nombre de :

A) Six(6) ;	☐
B) Sept (7) ;	☐
C) <u>Huit (8).;</u>	☒
D) Neuf (9).	☐

19) La filière de soins est une organisation :

A) <u>Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients ;</u>	☒
B) Verticale non hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
C) Horizontale hiérarchisée de prise en charge des patients ;	☐
D) Horizontale non hiérarchisée de prise en charge des patients.	☐

20) L'évaluation quantitative des soins utilise les indicateurs suivants :

A) <u>L'analyse du rapport cout/efficacité ;</u>	☒
B) L'analyse du rapport cout/efficience ;	☐
C) <u>L'analyse du rapport cout/utilité ;</u>	☒
D) <u>L'analyse du rapport cout/bénéfice.</u>	☒

21) L'analyse du coût ou de minimisation du coût tend à déterminer :

A) La qualité des ressources consommées par une pathologie donnée ;	☐
B) <u>La quantité des ressources consommées par une pathologie donnée ;</u>	☒
C) La quantités des recettes engendrées par une pathologie donnée ;	☐
D) La quantités des soins offerts pour une pathologie donnée.	☐

22) En milieu rural, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale sont définis comme suit :

A) <u>Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage ;</u>	☒
B) <u>Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 6.;</u>	☒
C) Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 60 par personne composant le ménage ;	☐
D) Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou égal à 5.	☐

23) L'évaluation qualitative est une analyse de la qualité d'un acte de soins :

A) <u>Conséquences en termes des résultats et la satisfaction des patients ;</u>	☒
B) <u>Conséquences en termes des ressources consommées par le soin ;</u>	☒
C) Conséquences en termes des recettes engendrées par le soin ;	☐
D) <u>Conséquences en termes d'efficacité du soin.</u>	☒

24) L'évaluation de la qualité des soins englobe :

A) L'évaluation des procédures ;	☐
B) <u>L'évaluation des résultats ;</u>	☒
C) <u>L'évaluation des ressources ;</u>	☒
D) L'évaluation mixte.	☐

25) Dans la déclaration du Millénaire pour le développement :

A) Deux parmi huit objectifs concernent directement la santé ;	☐
B) <u>Trois parmi huit objectifs concernent directement la santé ;</u>	☒
C) Quatre parmi huit objectifs concernent directement la santé ;	☐
D) Cinq parmi huit objectifs concernent directement la santé.	☐

26) Le réseau coordonné des soins est une organisation :

A) Verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
B) Verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
C) Horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients ;	☐
D) <u>Horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients.</u>	☒

27) Dans le programme du gouvernement 2012-2016, le secteur de la santé se trouve interpellé de façon directe à travers l'axe réservé à :

A) La « garantie de l'accès aux médicaments » ;	☐
B) <u>La « garantie de l'accès aux soins » ;</u>	☒
C) La « moralisation du secteur de santé » ;	☐
D) La « couverture médicale de base ».	☐

28) La formulation stratégique du plan sectoriel de la santé pour la période 2012-2016 repose sur la ou les approches complémentaires suivantes :

A) <u>Une approche fondée sur les droits ;</u>	☒
B) <u>Une approche de démocratie sanitaire ;</u>	☒
C) Une approche fondée sur les obligations ;	☐
D) <u>Une approche de renforcement du système de santé.</u>	☒

29) Le plan de réorganisation et de développement des urgences médicales au Maroc comporte :

A) 3 objectifs et 8 mesures ;	☐
B) <u>3 objectifs et 10 mesures ;</u>	☒
C) 4 objectifs et 8 mesures ;	☐
D) 4 objectifs et 10 mesures.	☐

30) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, l'indice synthétique de fécondité au Maroc est de :

A) 2,15 ;	☐
B) <u>2,59 ;</u>	☒
C) 2,75 ;	☐
D) 3,20.	☐

31) La 1ère cause de mortalité au Maroc est représentée par :

A) Les cancers ;	☐
B) Les maladies transmissibles ;	☐
C) <u>Les maladies cardiovasculaires ;</u>	☒
D) La tuberculose et les maladies respiratoires.	☐

32) Selon la stratégie sectorielle de santé 2012-2016, le développement de la santé en milieu rural repose sur les actions suivantes :

A) <u>Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe ;</u>	☒
B) <u>Renforcement de la couverture sanitaire mobile ;</u>	☒
C) Renforcement de la couverture sanitaire par point de contact ;	☐
D) <u>Développement de la participation communautaire.</u>	☒

33) Dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma régional de l'offre de soins, la création et l'implantation des infrastructures relevant du réseau de soins de santé primaire, en milieu urbain, doit répondre aux besoins de la population selon les critères suivants :

A) Un centre de santé urbain de 1 ^{er} niveau pour une population minimale de desserte de 15000 habitants ;	☐
B) <u>Un centre de santé urbain de 1^{er} niveau pour une population minimale de desserte de 25000 habitants ;</u>	☒
C) Un centre de santé urbain de 2 ^{ème} niveau pour une population minimale de desserte de 25000 habitants ;	☐
D) <u>Un centre de santé urbain de 2^{ème} niveau pour une population minimale de desserte de 50000 habitants.</u>	☒

34) Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé :

A) En deux niveaux ;	☐
B) <u>En trois niveaux ;</u>	☒
C) En quatre niveaux ;	☐
D) En cinq niveaux.	☐

35) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, l'espérance de vie à la naissance au Maroc :

A) <u>75,4 ans ;</u>	☒
B) 76,5 ans ;	☐
C) 77,3 ans ;	☐
D) 79,4 ans.	☐

36) En souscrivant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, le Maroc s'est engagé à réduire, à l'horizon 2015 :

A) De deux tiers la mortalité maternelle et de trois quarts la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;	☐
B) De moitié la mortalité maternelle et de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;	☐
C) <u>De trois quarts la mortalité maternelle et de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;</u>	☒
D) De trois quarts la mortalité maternelle et de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans.	☐

37) La consommation moyenne mensuelle est une méthode d'estimation des besoins en :

A) <u>Produits pharmaceutiques ;</u>	☒
B) Matériel médico-technique ;	☐
C) Ressources humaines ;	☐
D) Ressources financières.	☐

38) Lequel des axes stratégiques suivants ne fait pas partie de la stratégie sectorielle de santé 2012-2016 :

A) Amélioration de l'accès aux soins et de l'organisation des services ;	☐
B) Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques ;	☐
C) <u>Développement du contrôle des maladies transmissibles ;</u>	☒
D) Amélioration de la gouvernance du système de santé.	☐

39) Les urgences médico-hospitalières de base représentent :

A) Le 1 ^{er} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
B) <u>Le 2^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;</u>	☒
C) Le 3 ^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales ;	☐
D) Le 4 ^{ème} niveau du réseau intégré des soins d'urgences médicales.	☐

40) Selon le rapport de santé en chiffres 2014, le taux d'occupation moyen des hôpitaux publics est de :

A) 61,6% ;	☐
B) 62,6% ;	☐
C) 63,6% ;	☐
D) <u>64,6%.</u>	☒

41) Selon la stratégie sectorielle de santé 2012-2016 :

A) Trois provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;	☐
B) <u>Quatre provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;</u>	☒
C) Cinq provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux ;	☐
D) Six provinces ne disposent pas encore d'hôpitaux.	☐

42) Les résultats attendus du plan national de prévention et du contrôle du cancer dans le domaine de prévention est de :

A) Réduire de 20% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
B) <u>Réduire de 30% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;</u>	☒
C) Réduire de 40% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux ;	☐
D) Réduire de 50% la prévalence des risques comportementaux et environnementaux.	☐

43) Dans le découpage sanitaire national, les territoires de santé sont :

A) <u>Des circonscriptions sanitaires ;</u>	☒
B) <u>Des préfectures et provinces sanitaires ;</u>	☒
C) <u>Des régions sanitaires ;</u>	☒
D) Des structures centrales.	☐

44) Pour les bénéficiaires du RAMED, la contribution concerne :

A) <u>Seulement la population en situation de vulnérabilité ;</u>	☒
B) Seulement la population en situation de pauvreté ;	☐
C) La population en situation de pauvreté et de vulnérabilité ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

45) Lequel/lesquels des établissements suivants ne fait/ne font pas partie du réseau hospitalier :

A) Centre d'hémodialyse ;	☐
B) Hôpitaux psychiatriques ;	☐
C) <u>Centres régionaux de rééducation ;</u>	☒
D) Centres régionaux d'oncologie.	☐

46) L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

A) Deux réseaux d'établissements de santé ;	☐
B) Trois réseaux d'établissements de santé ;	☐
C) <u>Quatre réseaux d'établissements de santé ;</u>	☒
D) Cinq réseaux d'établissements de santé.	☐

47) Selon le rapport santé en chiffres 2014, la couverture vaccinale globale des enfants âgés de 12 à 23 mois est de :

A) 92,5% ;	☐
B) <u>93,5% ;</u>	☒
C) 94,5% ;	☐
D) 95,5%.	☐

48) Les urgences médicales de proximité faisant partie du réseau intégré des soins d'urgences médicales assurent les fonctions d'urgence suivantes :

A) Les gestes de réanimation ;	☐
B) <u>Les gestes de premiers secours ;</u>	☒
C) La transfusion ;	☐
D) <u>Le diagnostic de détresse vitale.</u>	☒

49) Selon le rapport santé en chiffres 2014, la durée moyenne des hôpitaux publics est de :

A) Trois jours ;	☐
B) <u>Quatre jours ;</u>	☒
C) Cinq jours ;	☐
D) Six jours.	☐

50) Les résultats attendus du plan national de prévention et de contrôle du cancer dans le domaine de prise en charge diagnostique et thérapeutique est de :

A) Guérir 30% des patients pris en charge ;	☐
B) Guérir 40% des patients pris en charge ;	☐
C) <u>Guérir 50% des patients pris en charge ;</u>	☒
D) Guérir 60% des patients pris en charge.	☐

51) En 2013, le budget global du Ministère de la Santé représente :

A) 1,1% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
B) 1,2% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
C) 1,3% du produit intérieur brut (PIB) ;	☐
D) <u>1,4% du produit intérieur brut (PIB).</u>	☒

52) En 2010, les dépenses globales de santé ont atteint :

A) 43,7% milliards de Dhs ;	☐
B) 45,7% milliards de Dhs ;	☐
C) <u>47,7% milliards de Dhs ;</u>	☒
D) 49,7% milliards de Dhs.	☐

53) Selon les comptes nationaux 2010, les paiements directs des ménages ont représenté :

A) <u>53,6% des dépenses des ménages pour la santé ;</u>	☒
B) 54,7% des dépenses des ménages pour la santé ;	☐
C) 57,3% des dépenses des ménages pour la santé ;	☐
D) 61,3% des dépenses des ménages pour la santé.	☐

54) Les maladies non transmissibles représentent :

A) 52% de la charge de morbidité générale ;	☐
B) 54% de la charge de morbidité générale ;	☐
C) <u>56% de la charge de morbidité générale ;</u>	☒
D) 58% de la charge de morbidité générale.	☐

55) La stratégie du plan national de prévention et de contrôle de cancer repose sur les domaines suivants :

A) <u>La prévention ;</u>	☒
B) <u>La détection précoce ;</u>	☒
C) <u>La prise en charge diagnostique et thérapeutique ;</u>	☒
D) Les soins de base et les soins palliatifs.	☐

56) Le financement du régime d'assistance médicale (RAMED) est assuré par :

A) L'Etat (76%), les collectivités locales (19%), la cotisation des bénéficiaires (5%) ;	☐
B) L'Etat (74%), les collectivités locales (21%), la cotisation des bénéficiaires (5%) ;	☐
C) L'Etat (74%), les collectivités locales (20%), la cotisation des bénéficiaires (6%) ;	☐
D) <u>L'Etat (75%), les collectivités locales (19%), la cotisation des bénéficiaires (6%).</u>	☒

57) Le régime d'assistance médicale (RAMED) cible la couverture de :

A) 7,5 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;	☐
B) 8 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;	☐
C) <u>8,5 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ;</u>	☒
D) 9 millions de citoyen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.	☐

58) Le Schéma Régional de l'Offre de Soins(SROS) :

A) Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins ;	☐
B) <u>Est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leurs tendances ;</u>	☒
C) <u>Définit les besoins en infrastructures , en moyens et en activités de soins ;</u>	☒
D) Est considéré comme une approche quantitative de régulation de l'offre de soins.	☐

59) L'élaboration du Schéma Régional de l'Offre de Soins repose sur les principes suivants :

A) <u>La globalité ;</u>	☒
B) <u>L'intégration ;</u>	☒
C) La fiabilité ;	☐
D) L'accessibilité.	☐

60) Le processus théorique d'élaboration du Schéma Régional de l'Offre de Soins peut être résumé en trois étapes essentielles, qui sont :

A) <u>L'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations ;</u>	☒
B) <u>La mobilisation des ressources ;</u>	☒
C) La fixation des priorités ;	☐
D) <u>La détermination des mesures à prendre.</u>	☒

61) La formulation du projet d'établissement repose sur deux logiques :

A) <u>Une logique professionnelle ;</u>	☒
B) Une logique fonctionnelle ;	☐
C) Une logique de qualité ;	☐
D) <u>Une logique de projet.</u>	☒

62) Le plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région, il comprend :

A) <u>Une étape d'analyse de situation ;</u>	☒
B) Une étape de formulation politique ;	☐
C) Une étape de formulation tactique ;	☐
D) <u>Une étape de formulation stratégique.</u>	☒

63) Le plan régional de couverture sanitaire a pour objectif de déterminer :

A) La répartition géographique des infrastructures et des équipements lourds de santé ;	☐
B) <u>La répartition géographique des ressources humaines ;</u>	☒
C) <u>Les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs ;</u>	☒
D) La répartition des activités et prestations de soins dans les infrastructures.	☐

64) Le plan d'action 2012-2016 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale se fixe pour objectifs d'ici 2016 de :

A) <u>Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100.000 naissances vivantes ;</u>	☒
B) <u>Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1000 naissances vivantes ;</u>	☒
C) Réduire la mortalité maternelle de 112 à 40 décès pour 100.000 naissances vivantes ;	☐
D) Réduire la mortalité néonatale de 19 à 10 pour 1.000 naissances vivantes.	☐

65) Le projet d'établissement hospitalier :

A) <u>Est un outil de planification stratégique et de communication ;</u>	☒
B) <u>Facilite le développement d'une vision et l'engagement des professionnels et des gestionnaires autour d'objectifs communs ;</u>	☒
C) Couvre une période de 2 à 3 ans ;	☐
D) Est un moyen pour orienter les soins vers la population.	☒

66) Le diagnostic hospitalier peut reposer sur trois types d'analyse :

A) <u>Une analyse de morbidité hospitalière ;</u>	☒
B) <u>Une analyse de la performance ;</u>	☒
C) Une analyse opérationnelle ;	☐
D) <u>Une analyse stratégique.</u>	☒

67) Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité :

A) L'efficacité ;	☐
B) La globalité ;	☐
C) L'efficience ;	☐
D) <u>La continuité.</u>	☒

68) Le comité de gestion d'un centre hospitalier régional est présidé par :

A) <u>Le délégué du Ministère de la Santé de la province ou préfecture chef-lieu de la région ;</u>	☒
B) Le directeur régional de la santé ;	☐
C) Le directeur du centre hospitalier de la province ou préfecture chef-lieu de la région ;	☐
D) Un délégué à tour de rôle parmi les délégués des provinces ou préfectures de la région.	☐

69) L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire :

A) <u>Seulement pendant les jours et heures ouvrables ;</u>	☒
B) Pendant toutes les heures des jours ouvrables ;	☐
C) Pendant tous les jours de la semaine ;	☐
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

70) Parmi les critères de priorisation d'un problème, lequel parmi les suivants n'est pas juste :

A) Fréquence ;	☐
B) Gravité ;	☐
C) <u>Acceptabilité ;</u>	☒
D) Vulnérabilité.	☐

71) Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace est une :

A) Endémie ;	☐
B) Pandémie ;	☐
C) <u>Epidémie ;</u>	☒
D) Aucune réponse n'est juste.	☐

72) Les éléments constitutifs d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont :

A) Les objectifs, les stratégies, les ressources et les indicateurs d'évaluation ;	☐
B) les besoins , les ressources, et les indicateurs d'évaluation ;	☐
C) <u>La vision , la stratégie, les ressources et les modalités d'évaluation ;</u>	☒
D) les stratégies, les ressources et les modalités d'évaluation.	☐

73) Parmi les services suivants, lequel est un service de la direction régionale :

A) <u>Le service de la santé publique et de l'offre de soins ;</u>	☒
B) Le service de la programmation de l'offre de soins et des ressources humaines ;	☐
C) Le service de la programmation de l'offre de soins et des ressources financières ;	☐
D) Le service des ressources humaines et de l'approvisionnement.	☐

74) La couverture sanitaire universelle consiste à :

A) <u>Etendre l'offre et l'accès aux soins ;</u>	☒
B) <u>Améliorer la qualité et la gamme des soins ;</u>	☒
C) <u>Réduire les paiements directes ;</u>	☒
D) <u>Augmenter les ressources.</u>	☒

75) L'objectif de l'économie de santé est de :

A) Faire des économie ;	☐
B) Diminuer les dépenses ;	☐
C) Contrôler les agents économiques ;	☐
D) <u>Rechercher la meilleure utilisation des ressources.</u>	☒

76) Selon le modèle PATHWAY de l'OMS (2011), les déterminants intermédiaires de la santé sont :

A) <u>Les facteurs humains, biologiques, psychologiques et matériels ;</u>	☒
B) Le système de santé ;	☐
C) L'éducation, l'emploi et le revenu ;	☐
D) La gouvernance et politiques sociales.	☐

77) L'enquête nationale de prévalence des troubles mentaux et toxicomanies a montré que la prévalence des troubles dépressifs est de :

A) <u>26,5% ;</u>	☒
B) 9,6% ;	☐
C) 2% ;	☐
D) 45,2%.	☐

78) Les objectifs du plan national de santé mentale (2013-2016) sont :

A) <u>Promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux ;</u>	☒
B) <u>Assurer une prise en charge équitable, de qualité au profit des personnes avec troubles mentaux ;</u>	☒
C) Améliorer la gouvernance en santé mentale ;	☐
D) <u>Développer le partenariat.</u>	☒

79) Les maladies à notification obligatoire en vertu du règlement sanitaire international 2005 sont :

A) La fièvre jaune ;	☐
B) <u>La polio à virus sauvage ;</u>	☒
C) La méningite ;	☐
D) <u>La variole.</u>	☒

80) La certification est une attestation :

A) <u>De conformité aux exigences spécifiques ;</u>	☒
B) De reconnaissance de compétences ;	☐
C) D'accréditation ;	☐
D) Aucune des propositions n'est vrai.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 29 نونبر 2015)

www.ispits.net

Cochez-la ou les bonnes réponses :

1) La direction régionale de santé est composée des services suivants :

A) Le service de la santé publique ;	☐
B) Le service de la programmation, de l'offre de soins et de ressources humaines ;	☐
C) Le service des approvisionnements, des bâtiments, des équipements et de la maintenance ;	☐
D) Le service des ressources financières, de la logistique et du partenariat.	☐

2) Les hôpitaux peuvent être classés selon :

A) Le statut juridique ou selon le mode de gestion ;	☐
B) La gamme de leurs prestations et de la nature de leurs équipements ;	☐
C) Le champ d'action et le niveau de prestations offertes ;	☐
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

3) L'hôpital local (hôpital de proximité) comporte les disciplines suivantes :

A) L'obstétrique ;	☐
B) La psychiatrie ;	☐
C) La pédiatrie ;	☐
D) La chirurgie générale.	☐

4) Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé en trois niveaux qui sont :

A) Les urgences médicales de proximité ;	☐
B) Les urgences médico-hospitalières de proximité ;	☐
C) Les urgences médico-hospitalières de base ;	☐
D) Les urgences médico-hospitalières complètes.	☐

5) La part la plus importante du financement du système national de santé est assurée par :

A) Les paiements directs ;	☐
B) Les ressources fiscales ;	☐
C) La couverture médicale ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

6) L'assurance maladie obligatoire (AMO) :

A) Couvre l'assuré, son conjoint, et ses parents ;	☐
B) Couvre les enfants atteints d'un handicap physique ou mental à vie et sans limite d'âge ;	☐
C) Est gérée par la caisse nationale de sécurité sociale pour les fonctionnaires du secteur public ;	☐
D) Couvre les affections de longue durée et affections lourdes coûteuses.	☐

7) Pour bénéficier du régime d'assistance médicale (RAMED), les bénéficiaires doivent répondre aux critères suivants :

A) Avoir un revenu pondéré supérieur à 3767 DH et inférieures ou égales à 5650 DH par personne et par an pour les personnes en situation de vulnérabilité et résidentes dans le milieu urbain ;	☐
B) Avoir un score patrimonial supérieur à 48 et inférieur à ou égal à 70 pour les personnes en situation de vulnérabilité et résidentes en milieu rural ;	☐
C) Avoir un revenu pondéré inférieur à 3767 DH par personne et par an pour les personnes en situation de pauvreté et résidentes dans le milieu urbain ;	☐
D) Avoir un score patrimonial inférieur à 28 pour les personnes en situation de pauvreté et résidentes en milieu rural.	☐

8) Les établissements du croissant rouge marocain font partie du :

A) Ministère de la Santé ;	☐
B) Secteur public ;	☐
C) Secteur privé à but lucratif ;	☐
D) Secteur privé à but non lucratif.	☐

9) Au Maroc, les dépenses en santé représentent :

A) 4 ,2 % du PIB ;	☐
B) 6,2 % du PIB ;	☐
C) 8,2 % du PIB ;	☐
D) 10,2 % du PIB.	☐

10) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé sont les suivantes :

A) Direction des Ressources Humaines ;	☐
B) Direction des Œuvres Sociales ;	☐
C) Direction de l'Epidémiologie et de lutte contre les Maladies ;	☐
D) Direction de la Planification et de la logistique.	☐

مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة

الاختبار المشترك

(دورة 29 نونبر 2015)

Correction proposée :

1) La direction régionale de santé est composée des services suivants :

A) <u>Le service de la santé publique ;</u>	☒
B) Le service de la programmation, de l'offre de soins et de ressources humaines ;	☐
C) Le service des approvisionnements, des bâtiments, des équipements et de la maintenance ;	☐
D) <u>Le service des ressources financières, de la logistique et du partenariat.</u>	☒

2) Les hôpitaux peuvent être classés selon :

A) <u>Le statut juridique ou selon le mode de gestion ;</u>	☒
B) <u>La gamme de leurs prestations et de la nature de leurs équipements ;</u>	☒
C) <u>Le champ d'action et le niveau de prestations offertes ;</u>	☒
D) Toutes les réponses sont fausses.	☐

3) L'hôpital local (hôpital de proximité) comporte les disciplines suivantes :

A) <u>L'obstétrique ;</u>	☒
B) La psychiatrie ;	☐
C) <u>La pédiatrie ;</u>	☒
D) <u>La chirurgie générale.</u>	☒

4) Le réseau intégré des soins d'urgences médicales (RISUM) est organisé en trois niveaux qui sont :

A) <u>Les urgences médicales de proximité ;</u>	☒
B) Les urgences médico-hospitalières de proximité ;	☐
C) <u>Les urgences médico-hospitalières de base ;</u>	☒
D) <u>Les urgences médico-hospitalières complètes.</u>	☒

5) La part la plus importante du financement du système national de santé est assurée par :

A) <u>Les paiements directs ;</u>	☒
B) Les ressources fiscales ;	☐
C) La couverture médicale ;	☐
D) La coopération internationale.	☐

6) L'assurance maladie obligatoire (AMO) :

A) Couvre l'assuré, son conjoint, et ses parents ;	☐
B) <u>Couvre les enfants atteints d'un handicap physique ou mental à vie et sans limite d'âge ;</u>	☒
C) Est gérée par la caisse nationale de sécurité sociale pour les fonctionnaires du secteur public ;	☐
D) <u>Couvre les affections de longue durée et affections lourdes coûteuses.</u>	☒

7) Pour bénéficier du régime d'assistance médicale (RAMED), les bénéficiaires doivent répondre aux critères suivants :

A) <u>Avoir un revenu pondéré supérieur à 3767 DH et inférieures ou égales à 5650 DH par personne et par an pour les personnes en situation de vulnérabilité et résidentes dans le milieu urbain ;</u>	☒
B) Avoir un score patrimonial supérieur à 48 et inférieur à ou égal à 70 pour les personnes en situation de vulnérabilité et résidentes en milieu rural ;	☐
C) <u>Avoir un revenu pondéré inférieur à 3767 DH par personne et par an pour les personnes en situation de pauvreté et résidentes dans le milieu urbain ;</u>	☒
D) <u>Avoir un score patrimonial inférieur à 28 pour les personnes en situation de pauvreté et résidentes en milieu rural.</u>	☒

8) Les établissements du croissant rouge marocain font partie du :

A) Ministère de la Santé ;	☐
B) Secteur public ;	☐
C) Secteur privé à but lucratif ;	☐
D) <u>Secteur privé à but non lucratif.</u>	☒

9) Au Maroc, les dépenses en santé représentent :

A) 4 ,2 % du PIB ;	☐
B) <u>6,2 % du PIB ;</u>	☒
C) 8,2 % du PIB ;	☐
D) 10,2 % du PIB.	☐

10) Les directions de l'administration centrale du ministère de la santé sont les suivantes :

A) <u>Direction des Ressources Humaines ;</u>	☒
B) Direction des Œuvres Sociales ;	☐
C) <u>Direction de l'Epidémiologie et de lutte contre les Maladies ;</u>	☒
D) Direction de la Planification et de la logistique.	☐



JNAINI HAMZA

📍 Orthoptiste au CHP HASSAN II SETTAT

📞 +2126 66 67 19 67

✉ hamza.jnaini@gmail.com

JE PRÉPARE
JE RÉUSSIS MON CONCOURS !

LA CONNAISSANCE N'A DE SENS QUE PARTAGÉE.

